KƏNAN RƏHİMOV

KƏNAN RƏHİMOV
psixoterapevt

ŞİZOFRENİYA

Cinnət pandemiyası

Ağıl uğrunda mübarizə — bir xəstəliyin tarixi boyunca

Bakı xəstəxanasının ikinci palatasındakı o xəstəyə,
adını heç vaxt bilmədiyim.
Və kömək gözləyən, amma metod alan hər kəsə.

Bakı · 2026

© 2026 Kənan Rəhimov. Bütün hüquqlar qorunur.

Bu nəşrin heç bir hissəsi müəllifin yazılı icazəsi olmadan çoxaldıla bilməz.

Kitab həkim və ya psixoterapevt məsləhətini əvəz etmir.

MÜNDƏRİCAT

Müəllifdən.....1
I HİSSƏ. ELMDƏN ƏVVƏL DƏLİLİK.....8
Fəsil 1. Kəllədə dəlik: neolit cərrahları.....9
Fəsil 2. Cini qovmaq, bədəni öldürmək: ekzorsizm, Bedlam və görünməz dini psixiatriya.....14
Fəsil 3. Dolaşan bətn: qadın diaqnoz kimi.....25
İntermezzo. Cinnət düsturu.....35
II HİSSƏ. DİPLOMLU DƏLİLİK.....39
Fəsil 4. Kraepelin və Bleyler: söz necə yarandı.....40
Fəsil 5. Odla müalicə: malyariyadan sülfozinə qədər.....47
Fəsil 6. Şəkərli diabet dəliliyin müalicəsi kimi: Manfred Zakelin komaları.....57
Fəsil 7. Buz baltasına görə Nobel mükafatı: lobotomiya və onun qiyməti.....64
Fəsil 8. Sovet psixiatriyasının qaranlıq səhifəsi.....75
Fəsil 9. Ququ quşu yuvasının üzərindən uçarkən: bir hekayənin iki tərəfi.....85
Birinci ara səhnə. Palatadan gələn səs.....97
III HİSSƏ. QAYDALARA UYĞUN SƏHV ETMƏK.....99
Fəsil 10. Freyd və psixikanın qüvvələri: psixoanaliz psixozla qarşılaşır.....100
Fəsil 11. Yunq və kollektiv şüursuzluq: psixiatriya miflə qarşılaşdıqda.....110
Fəsil 12. Fenomenoloji məktəb: pasiyent olmağı necə öyrənmək olar.....121
Fəsil 13. Bioloji nəzəriyyələr: beyinə açar axtarışı.....131
Fəsil 14. Beytson və ikiqat bağ: ailə döyüş meydanına çevriləndə.....142

Fəsil 15. Antipsixiatriya: Lainq, Bazalya və hərəkatın sərhədləri 151
Fəsil 16. Biopsixososial model: mozaikanı bir araya gətirmək cəhdi..... 160
Fəsil 17. Hippokratdan Madridə: peşə etikasının doğuşu..... 168
İkinci interlüd. Ana səsi..... 179
IV HİSSƏ. Bugünkü pandemiya: psixobazar..... 181
Fəsil 18. Bu niyə işləyir: möcüzənin anatomiyası..... 182
Fəsil 19. Yeni şamanlar: Bert Hellinger və ailə düzülüşləri..... 189
Fəsil 20. ThetaHealing: Vianna Stibalın vəhyi..... 200
Fəsil 21. Keçmiş həyatlar bazarı: reqressologiya və "müəllif metodları"..... 210
Fəsil 22. Hubbard və dianetika: qondarma xoşbəxtliyin satıcıları..... 220
Fəsil 23. Peşənin öz içində: keyfiyyətə nəzarət olmadıqda..... 229
Üçüncü ara oyun. Xəstənin səsi..... 243
V HİSSƏ. Sərhədsiz Pandemiya..... 245
Fəsil 24. Klinikanın divarlarından kənarda: sərhədsiz formula 246
Fəsil 25. Sosial şəbəkələrdə pandemiya: ekranın kafedraya çevrildiyi zaman..... 254
Fəsil 26. Hüquqi asimmetriya: səssiz razılıq pandemiyası..... 265
VI HİSSƏ. QAYIDIŞ..... 277
Fəsil 27. Bir sağalmanın hekayəsi..... 278
Fəsil 28. Nəticə: əslində kim dəlidir?..... 284
Əlavə. Əsl mütəxəssisi necə ayırd etmək olar..... 294
Ədəbiyyat və mənbələr..... 296
Müəllif və əlaqə haqqında..... 313

Müəllifdən

Kitaba başlamaq üçün üç fakt.

Birinci. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatlarına görə, 2022-ci ildə dünyada təxminən bir milyard insan müxtəlif psixi pozuntularla yaşayırdı. Bir milyard — Yerin hər səkkizinci sakinidir. Nə ürək-damar, nə onkoloji, nə də yoluxucu xəstəliklər belə geniş yayılma göstərmir. Və bu milyard azalmır. Artır.

İkincisi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının (DST) mütəxəssislərinin hesablamalarına görə, ilk növbədə ixtisaslı psixiatrik və psixoterapevtik köməyə ehtiyacı olan insanların təxminən 70%-i bu yardımı ala bilmir. Aşağı və orta gəlirli ölkələrdə bu boşluq 85%-ə çatır. Keyfiyyətli xidmətlərdən məhrum qalan qlobal bazar isə istənilən şeylə — yalnız tibbi yardımla yox, doldurulur.

Üçüncü. Bu boşluğa Hellinger tərəfindən tərtib olunmuş "ailə yerləşdirmələri" ilə məşğul olanlar, "teta-hilinq" tətbiq edənlər, reqressiya mütəxəssisləri, "unikal metodologiyalar"ın müəllifləri, ekstrasenslər, nəsildən-nəslə keçən şəfalılar, "enerji məktəbləri" və "ruhi təcrübələr"in qurucuları axışır. Onların hər biri bir neçə seansda əsl psixoterapiyanın illərlə müalicə etdiyi və əsl psixiatriyanın idarə etdiyi, lakin həmişə müalicə etmədiyi şeydən şəfa vəd edir. Onların hər birinin sosial şəbəkələrdə yüz minlərlə abunəçisi və bu vəd axını üçün ödəniş edən minlərlə minnətdar müştərisi var.

Bu, cinnət pandemiyasıdır. Virus pandemiyalarından fərqli olaraq, elmin qarşı durmaq üçün peyvəndlər və antivirus dərmanlar hazırlaya bildiyi bu pandemiyaya qarşı indiyə qədər heç bir effektiv vasitə icad edilməmişdir. Üstəlik, cəmiyyətin

böyük bir hissəsi, dövlət qurumları və qanunverici orqanlar da daxil olmaqla, onun yayılmasına səssiz razılıq verir.

Bu kitab bizim bunu necə yaşadığımız haqqındadır. Və əslində bu hekayədə kimin dəlilik vəziyyətində olduğu haqqındadır.

2000-ci illərin əvvəllərində Bakıdakı psixonevroloji dispanserdən bir otaqda, heç vaxt unuda bilməyəcəyim bir mənzərənə şahid oldum.

Xəstəyə sülfozin vermək hazırlığı gedirdi. Bu, birinin səhər dişlərini fırçalaması qədər adi bir iş idi. Dərmanı, dəridə kükürdün yağlı məhlulunun daha bərabər paylanması üçün qabnan suda qızdırdılar. İynəni dərinə, hər iki omba və hər iki çiyinə — sözdə "sülfozin xaçı" şəklində vurdular. İynədən sonra xəstənin qırx dərəcəyədək qızdırması, güclü ağrılar hiss etməsi və bir neçə gün hərəkət edə bilməməsi gözlənilirdi. Buna "müalicə" deyirdilər. Buna "piroterapiya" — orqanizmi qızdıraraq mərkəzi sinir sistemini "sarsıtmaq" adını vermişdilər.

Heç bir klinik tədqiqat heç vaşa şizofreniyada sülfozinin effektivliyini təsdiq etməyib. Üstəlik, 2000-ci ilə qədər bütün elm dünyasında bu metod artıq mənasız və qəddar bir üsul kimi rədd edilmişdi. Lakin Bakı, Sankt-Peterburq və digər postsovet məkanlarında onu tətbiq etməyə davam edirdilər — çünki belə olmaq adət idi, çünki belə öyrədilmişdilər, çünki personalda sanki "bir şeylər edirlər" hissi yaranırdı.

Mən gənc həkim idim. Ordada dayanıb baxırdım. Anlayırdım ki, indi baş verəcək şey tibbin əhatəsinə daxil deyil. O anda özümə elə bir sual verdim ki, bu iyirmi ildən artıq vaxtdır məni tərk etmir: həqiqətən bu səhnədə cinnət içərisində olan kimdir?

Halüsinasiyadan əziyyət çəkən xəstə — heç kəs üçün təhlükə törətməyən, ancaq özünə zərər verən bədbəxt kimsədir, ona indi uydurma müalicə üçün bir neçə gün ərzində dözülməz

ağrılar yaşadacaqlar? Yoxsa elmi əsası olmayan metodu illərlə tətbiq edən və onun faydalı olduğuna əmin olan tibb işçiləri?

İndi eyni sualı daha geniş kontekstdə verirəm.

O biri dəli kimdir ki, bağlı psixiatriya şöbəsində otururaq yalnız özünə ziyan vuran səslər eşidir? Yoxsa dəli elə o kəsdir ki, sosial şəbəkədə yüz minlərlə izləyicisi olan hesabından gündəlik "karmanı təmizləmək" müqabilində 45 min rubl istəyir və hər gün onlarla müştəri tapır, bununla belə heç bir dövlət qurumu müdaxilə etməyi lazım bilmir?

Bu kitabla bu suala cavab verməyə çalışıram.

Bu kitabın əsas tezisi:

Psixiatriyada buraxılan səhvlərin tarixi — heç də psixiatriyanın bir elm kimi səhvi deyil.

Bu — elmin pərdəsi altında gizlədilən bəşəriyyətin səhvidir. Yalnız əsl insani cinnətdən sağaldıqdan sonra psixiatriya bəşəriyyətin əqli sağlamlığını qoruyan həqiqətən mühüm bir fənnə çevrilə bilər.

Psixiatriya klinik tədqiqatlara və yoxlanıla bilən üsullara əsaslanan sübut bazalı bir elm kimi yalnız indi, XXI əsrin ilk rübündə, həqiqi mənada formalaşmağa başlayır. Müalicəsiz hesab edilənlərin kəlləsinin deşilməsi, epilepsiya xəstələrindən cinlər qovulması, "isteriya" uğrunda qadınların kastrasiyası, insulin koması, lobotomiya, sülfozin, cəzalandırıcı psixiatriya — bütün bunlar ruhi pozuntular haqqında həqiqi elmin mövcud olmadığı dövrdə baş verib. Bütün bunlar pis niyyətin deyil, axtarışların tarixi idi. Bəşəriyyət anlamadan axtarırdı. Bəşəriyyət bilmədən təcrübə edirdi. Bəşəriyyət ən yaxşı və ən pis niyyətlə eyni vaxtda hərəkət edirdi və çox zaman birinin harada bitdiyini, digərinin harada başladığını fərqləndirmirdi.

Müasir elmi kəskinlikdən uzaq olan istiqamətlər — ailə quruluşları, ThetaHealing, keçmiş həyatlarına qayıdan

terapiya, diametika, psixologiya maskası altında şaman praktikaları — keçmişdəki səhvləri öz əsas ritorik qalxanı kimi istifadə edir. Onlar deyirlər: “Baxın, ‘elmi psixiatriya’ nə edirdi! Qadınları yandırırdı, lobotomiya aparırdı, insanları zəncirlərdə saxlayırdı! Biz isə sadəcə kömək edirik”. Və bu arqument üzərində öz populyarlıqlarını qururlar.

Lakin bu məntiqi təhrifdir.

Lobotomiya, sülfozin və cəza psixiatriyası elmin səhvi deyildi. Onlar özlərini elm kimi göstərən, lakin sübutsuz fərziyyələrə əsaslanan praktikalar idi — eynən bugünkü ailə yerləşdirmələri və teta-hilinq kimi. Fərq yalnız bundadır ki, birinci halda həkim diplomu olan insanlar tətbiq edirdi, ikinci halda isə diplomu olmayanlar. Amma əsas eynidir: sınanmamış, lakin həqiqət elan edilmiş hipotetik fikir.

Buna görə də müasir elmi psixiatriya eyni vaxtda iki şey etməlidir.

Birincisi, keçmişin xətalarını bütün bəşəriyyətin səhvləri kimi qəbul etmək, onları gizlətmədən, bəhanə gətirmədən, eyni zamanda bu səhvlərin də sübuta əsaslanan tibb ideyasına qarşı istifadəsinə icazə verməmək.

İkincisi, elmi olmayan praktikaların “şəfa” və ya “müəllif metodu” kimi müğlak terminlərdən istifadə edərək, sosial şəbəkələrin köməyi və dövlətlərin susqun razılığı ilə insanlara zərər verməsinin qarşısını almaqdır.

Bu kitab psixiatriyaya qarşı deyil. Bu kitab elmi psixiatriya üçündür. Keçmişin səhvlərinə və bugünkünün saxta surətlərinə qarşıdır.

Metod və quruluş haqqında

Kitab altı hissədən ibarət araşdırma kimi qurulmuşdur.

Birinci hissə oxucunu elmi dövrə qədər aparır — insanlığın ilk dəfə dəliliklə üzləşdiyi və ona bir şəkildə cavab verməyə

çalışdığı dövrə. Daş dövrünün trepanasiyası, ekzorsizm kimi yaşayan praktika, "gəzən rahim" və Betti-nin sağlam yumurtalıqlar üzərindəki əməliyyatı. Bu hissə kitabın yazıldığı məqsədlə bitir: dəliliyin tərifi və onun əsr boyu necə təkrarlandığını göstərən düstur. Bu düstur oxucu tərəfindən hər bir fəsildə, hər bir əsrdə özünü göstərəcək.

İkinci hissə ən ağırdır. Burada cinnət düsturu ağ geyimini geyinir. Krepelin və Bleyler xəstəliyə ad verir, lakin müalicəsi yoxdur. Bu boşluğa müxtəlif üsullar axın edir: Vaqner-Yaureqqin piroterapiyası, Zakelin insulin komaları, Moniş və Frimenin lobotomiyası, sovet cəzalandırıcı psixiatriyası, elektrokonvulsiv terapiyanın qaranlıq və işıqlı tarixçəsi. Burada düsturun diplomları, kafedraları və dünyanın peşman olacağı bir Nobel mükafatı var.

Üçüncü hissə — elmin öz kölgəsindən necə fərqlənməyi öyrəndiyi haqqında. Freyd, Yung, fenomenoloji məktəb, bioloji nəzəriyyələr, Beytson, antipisxiatriya, biopsixososial model, peşəkar etikanın doğuluşu. Bu, səhv də daxil olmaqla, fikirlərin tarixidir. Lakin burada ilk dəfə olaraq sərhəd aydın görünür: bəziləri elmin qaydalarına uyğun səhv edirdi — və elm onları düzəltdi; digərləri isə qaydaları ümumiyyətlə tanımırdı.

Dördüncü hissə — bugünkü psixoloji bazar haqqındadır. Bu hissə "bunların necə işlədiyi" ilə bağlı fəsillə açılır — hər bir "möcüzə satıcısı"nın istifadə etdiyi psixikanın yeddi dürük mexanizmi haqqında. Sonra isə özü də bu satıcılar: Hellingerin ailə yerləşdirmələri, ThetaHealing, reqressologiya, dianetika. Və peşə daxilində keyfiyyət nəzarəti uğursuz olduqda nələr baş verdiyi haqqında fəsil — çünki tibb tərəfindən aldatılmış hər bir xəstə onun dublörlərinin müştərisinə çevrilir.

Beşinci hissə pandemiyanı klinika divarlarından kənara çıxarır. Köpəkbalığı qığırdağı "xərçəngə qarşı", bağırsaq serotoninı "depressiyadan", "psixosomatik yeddiliyi", ayinlər və muskalar — həyatın bütün sahələrində cinnət düsturudur, o

cümlədən Bakıdakı öz kabinetimdən müşahidə etdiyim sahələr də. Daha sonra — informasiyanın ötürülmə vasitəsi kimi sosial şəbəkələr və dövlətlərin səssiz razılığı kimi qanuni asimmetriya. Kitabın adı: "Cinnət pandemiyası. Faktlar, adlar, rəqəmlər"

Altıncı hissə — qayıdış. Həqiqi bir sağalma hekayəsi — möcüzəsiz, səhvlərlə, amma nəticə ilə. Və kitabın adına yerləşdirilən sualın cavabı ilə yekun.

Kitabın sonunda oxucunu "Həqiqi mütəxəssisi necə fərqləndirmək olar" praktik çek-list və qırmızı bayraqların siyahısı gözləyir. Əgər dərhal cavaba ehtiyacınız varsa və hekayəyə keçmədən öncə bunu bilmək istəyirsinizsə, bu siyahını ilk növbədə açın: məhz bunun üçün yazılıb.

Kitabın bölmələri arasında xəstələrin və yaxınlarının monoloqlarından ibarət interlyudiyalar səslənir. Onlar mənim təcrübəm əsasında real hekayələr üzərində qurulub; adlar və detallar dəyişdirilib, mahiyyət və intonasiya saxlanılıb. Ruhun ağrısından bəhs edən kitabda yalnız həkimlərin səsi deyil, həm də onların qayğısına qalanların səsləri əks olunmalıdır.

Bəzi xəbərdarlıqlar haqqında

Mən praktik həkim-psixiatr və psixoterapevtəm. Bu kitabda yazdıqlarımın hamısı klinik təcrübəyə və beynəlxalq elmi ədəbiyyatın məlumatlarına əsaslanır. Öz təcrübəmdən nümunələr gətirdiyim hallarda — Bakıdakı 2 nömrəli Klinik Xəstəxanada keçirdiyim internaturadan, Sankt-Peterburqdakı V.M.Bexterev adına İnstitutun klinik ordinaturasından və indiki Bakı praktikamızdan — tibbi ədəbiyyatda qəbul edilmiş anonimləşdirmə üsulundan istifadə edirəm: adlar dəyişdirilib, detallar uyğunlaşdırılıb, iş yeri ümumi şəkildə göstərilib. Lakin hər bir verilmiş hadisənin mahiyyəti — həqiqidir. Bunlar mənim öz gözlərimlə gördüyüm hadisələrdir.

Bu kitabda xüsusi şəxslər — həkimlər, sözdə müalicəçilər, "metodlar"ın müəllifləri haqqında danışılır, onların adları ictimaiyyətə məlumdur və onların ifadələri açıq mənbələrdə sənədləşdirilmişdir. Mən yalnız onların ictimai bəyanatlarına əsaslanıram. Heç bir yerdə şəxsi tənqid sərhədini keçməyə icazə vermirəm; mən metodları, təlimləri və praktikaları tənqid edirəm, insanları özləri kimi deyil. Əgər bu insanlardan hər hansı biri metodunu dəyişdirmək və ya ondan ictimai şəkildə imtina etmək qərarına gəlsə, mən ilk olaraq bunu başa düşəcək və qarşılayacağam.

Mətndə klinik psixiatriyada vacib və dəqiq hesab edilən, lakin gündəlik danışıqda qaba görünə bilən terminlər istifadə olunub: "şizofreniya", "psixoz", "maniya", "demenciya". Bunlar tibbi terminlərdir, heç bir yozum və ya nəzərdə tutma mənası daşımır. Mən onları elmi ədəbiyyatda olduğu kimi — nə yumşaldaraq, nə də nəzərəsalma etmədən işlədirəm.

Və son olaraq. Əgər bu kitabı oxuyursunuzsa və təsvir olunan klinik ssenarilərdən birində özünüzü və ya yaxınlarınızdan birini tanıyırsınızsa, xahiş edirəm yalnız bir şey edin: ixtisaslı mütəxəssisə müraciət edin. Nə "yer qoyucu"ya, nə reqressoloqa, nə də teta-hilerə. Psixiatr və ya klinik psixoloqa. Əgər yaşadığınız şəhərdə ixtisaslı həkim yoxdursa, qonşu şəhərdə, paytaxtda və ya onlayn konsultasiyalar almaq mümkündür. Bu kitab özünü müalicə üçün təlimat deyil. O, saxta müalicəçilərə müraciət etməyin nəyə gətirib çıxara biləcəyini anlatmaq cəhdidir.

Bu kitabı əllərində tutan hər kəsə hörmətlə…

Kenan Rəhimov — psixiatr-psixoterapevt Bakı, 2026

I HİSSƏ. ELMDƏN ƏVVƏL DƏLİLİK

Fəsil 1. Kəllədə dəlik: neolit cərrahları

Elzas. Fransanın Ensisheim kəndi. 1997-ci il. Arxeoloqların kürəkləri torpağın qatlarını səliqə ilə, aramla soyur. Qat-qat. Torpağın qalın örtüyü altında yeddi minilliyin sirri gizlənir. Dərinlikdə bir dəfn var. İçində orta yaşlı bir kişinin kəlləsi yatır. Bu kəllədə iki deşik var: biri alın sümüyündə, digəri təpə sümüyündə. Səliqə ilə deşilib, kənarları mükəmməl təmizdir. Onları kim açıb? Nə üçün? Bu tapmacanın kökləri daş dövrünə uzanır. Cavab sadə və qorxunc dərəcədə konkretdir: hər iki deşik adam hələ sağ ikən açılıb. Bunu sümüyün özü sübut edir — deşiklərin ətrafındakı sümük toxuması bitməyə vaxt tapıb. Bəs bu nə deməkdir? Yalnız bir şey: bu adam sağ qalıb. Sağ qalıb — ibtidai daş alətlə silahlanmış biri onun kəlləsini yardıqdan sonra. Təsəvvür edin: iti daş çılpaq başın təpəsində sürüşür, kəllə tağını xırtıltı ilə yararaq canlı ətə dalır. Qan və açılmış beyinin iyi. Nəfəsi kəsən ağrı. Amma ürək dayanmır. Bu adam sadəcə özünə gəlməyib — o, daha neçə illər yaşayıb.

Yeddi min il əvvəl.

Nə anesteziya. Nə sterillik. Nə antibiotiklər. Nə anatomik atlaslar. Nə də beynin nə olduğu və nə ilə məşğul olduğu barədə anlayış. Buna baxmayaraq — sağ qaldı.

Dünyada belə kəllələrdən — səliqə ilə açılmış və ya kəsilmiş, sağalma izləri olan deşikləri ilə — min beş yüzdən çox tapılıb. Avropa, Asiya, Afrika və Cənubi Amerikadakı neolit və eneolit təbəqələri bizə bu qeyri-adi kolleksiyanı bəxş edib. Arxeoloqların qiymətləndirmələrinə görə, bəzi bölgələrdə tədqiq edilmiş bütün neolit kəllələrinin beş-on faizi trepanasiya izləri daşıyır.

Beş-on faiz! Bu, tək-tük bir təsadüf deyil. Bu, kütləvi təcrübədir.

Daha insanların beyinin quruluşu haqqında ən ufak bir fikir sahibi olmadan əvvəl, atalarımız onu açıb araşdırırdı.

Nə üçün?

Ən yaxşı cavabı bizə fransız həkim və antropoloq Pol Broka verdi. 1867-ci ildə Parisdə keçirilən antropoloqlar konqresində o, amerikalı diplomat Efraim Skvayerin gətirdiyi Peru kəllələri haqqında məruzə təqdim etdi. Perunun Kusko vadisindən tapılmış kəllələrdən birində sağalma izləri olan düzbucaqlı bir dəlik vardı. Broka — müasir nevrologiyanın banilərindən biri, alın payında nitq zonası onun adı ilə adlandırılan həmin şəxs — əvvəlcə buna inanmaq istəmədi. Qədim kəllədə düzbucaqlı dəlik?

Lakin dəlillər toplanmışdı. Sonrakı onilliklər ərzində Broka digər tədqiqatçılarla birlikdə müəyyən etdi ki, trepanasiya onlarla qədim mədəniyyətdə — Perudan Polineziyaya, Şimali Afrikadan Britaniya adalarına qədər — müntəzəm tibbi və ya ritual təcrübə olub. Bəzi cəmiyyətlərdə bu, uşaqlara, bəzilərində əsasən yetkin kişilərə, digərlərində isə daha çox qadınlara edilirdi.

Əməliyyatı bir neçə üsulla aparırdılar. Burğulama — iti çaxmaqdaşı və ya obsidian alətin dairəvi hərəkətləri. Qazıma — canlı sümüyün tədricən yonulması. Kəsmə — bir-birini kəsən dörd kəsik və yaranan sümük kvadratının çıxarılması. Bəs bundan sonra necə sağ qalırdılar? Cavab quru rəqəmlərdə gizlənir. Sağ qalma göstəricisi heyrətamiz idi: bəzi hesablamalara görə, Perunun Parakas mədəniyyətində bu göstərici 75 faizdən yuxarı idi. Yüz nəfərdən yetmiş beşi. Bu faktı bir düşünün. Bu göstərici XX əsrin əvvəllərindəki neyrocərrahiyyə statistikasından daha yüksəkdir, halbuki o dövrdə əməliyyatlar artıq aseptikanın bütün nailiyyətləri ilə aparılırdı.

Amma əsas sual — necə deyil. Əsas sual: nə üçün?

Broka ehtimal etdi və bu hipotez ümumiyyətlə bütün mütəxəssislər tərəfindən qəbul edilir: trepanasiya ruhi xəstəlikləri müalicə etmək cəhdi idi. Epilepsiya. Tutmalar. "Ovdalıq". Qədim insanların baş içinə nüfuz edən pis ruhların təsirindən başqa heç bir şəkildə izah edə bilmədikləri hallar.

Orada pis ruh var — deməli, ona çıxış yolu açmaq lazımdır.

Bu izah absurd görünə bilər. Ancaq oxucudan xahiş edirəm ki, dayanıb düşünsün. Bu məntiq neolit dövründə bitmədi. Bu gün də davam edir.

XX əsrdə Qərb sivilizasiyasının ən mərkəzində, ABŞ və Avropanın universitet klinikalarında lobotomiyanı həyata keçirənlər nə edirdi? Canlı insanların alın paylarına metal çubuqlar soxurdular. Niyə? "Pis düşüncələri yox etmək üçün". Beynə batmış soyuq metal. Və düşüncələrdən məhrum həyat. Sovet psixiatriya xəstəxanalarında isə başqa bir işgəncə üsulu tətbiq olunurdu. Xəstələrə sülfozin iynəsi vururdular. Rəsmi bəhanə? "Sinir sistemini silkələmək". Bədən burulur, içəridən yanırdı. Yaxşı silkələdilər. Latın Amerikasında keşişlər şizofreniya və epilepsiya xəstələrinin üzərinə əyilər, ayinlər oxuyar, cinlər qovardılar. Bu ayinlərin bəziləri isə xəstənin ölümü ilə nəticələnərdi. Ruh bədəni tərk edərdi. Əbədi olaraq. Bakı və Moskva mənzillərində də özünəməxsus bir ritual var idi. "Yerləşdiricilər" və "reqressologlar" müştərilərinə pıçıldayırdılar: "Sənin depressiyan sənin nənənin bağışlanmamış günahıdır. Ata-baba günahı. Nə qədər sadə. Nə qədər dəhşətli."

Onların hamısı neolit dövrünün cərrahının varisləridir — o cərrah ki, ruhu buraxmaq üçün kəllədə deşik açırdı.

Prinsipial fərq yalnız alətdə və söz ehtiyatındadır.

Və bu, kitabımızın əvvəlində başa düşülməsi vacib olan nədir.

Biz qədim təcrübələrə çox vaxt müasir insanın təkəbbürüylə baxırıq. Gülümsəyib deyirik: "Necə də başa düşməyiblər". Elə bilirik ki, bizi onlardan tərəqqi uçurumu ayırır.

Lakin neolit dövründə trepanasiyanın ruhi xəstəliklərə həqiqətən kömək etdiyinə dair heç bir əsaslı sübut yoxdur. Nə o zaman, nə də indi. Xəstələr sağ qalırdı — lakin bu onların daha yaxşı hiss etdiyi demək deyil. Sağ qalmaq — müalicə demək deyil. Cərrahi uğur — terapevtik effekt deyil. Əslində biz yalnız bunu bilirik: kimsə xəstə idi; kimsənin kəlləsi açıldı; kimsə sağ qaldı; lakin bundan sonra əvvəlkindən daha az xəstə olub-olmadığını — bilmirik.

İndi isə — sual. Heç olmasa bircə ciddi araşdırma varmı ki, təsdiq etsin: Hellinger düzümü kliniki baxımdan əhəmiyyətli psixoloji problemləri həqiqətən həll edir? Bir dənə də yox. Heç olmasa bircə araşdırma varmı ki, sübut etsin: Vianna Stibalın ThetaHealing metodu diaqnoz qoyulmuş xəstəlikdən heç olmasa bir nəfəri sağaldıb? Boşluq. Heç olmasa bircə plasebo-nəzarətli araşdırma varmı ki, "keçmiş həyatlara reqressiya"nın effektivliyini sübut etsin? Sıfır. Sükut. Və bu sükutda yalnız kar edici əks-səda eşidilir. O, cavabən geri qayıdır və dəhşətli həqiqəti çılpaqlığı ilə ortaya qoyur: vəd dolu möcüzələrin pərdəsi arxasında sübut yoxluğunun dərin uçurumu açılır.

Cavab həmişə eynidir: yoxdur.

Neolit dövrü əcdadlarımız müəyyən mənada bizimlə bərabər idi. Onlar əziyyət çəkənlərə imkanları çatdığı vasitələrlə kömək etməyə çalışırdılar. Biz də — müasir təcrübələrin xeyli hissəsində — eyni cür davranırıq. Sadəcə alətlərimiz daha mürəkkəb, lüğətimiz isə daha elmi görkəmlidir.

Qədimlərə bir məsələdə haqq vermək lazımdır. Onların haqlı əsası var idi. Beynin nə olduğunu bilmirdilər, psixozun nə olduğunu bilmirdilər, kəllədəki deşiyin şər ruhlara yol açmadığını bilmirdilər — çünki heç bir şər ruh yoxdur. Onlar biliklərinin həddində hərəkət edirdilər. Bu, onların vicdanlı yanılmasıdır.

Müştərinin problemlərini ulu nənəsinin etdirdiyi aborta bağlayan müasir "düzülüşçü"yə nə bəraət qazandıra bilər? Resenziyalı elmi jurnalların minlərlə səhifəsi çoxdan hökmünü vermişkən — metod ölüdür — "ThetaHealing ustası"nın şüurunda hansı səmimi yanılsama hələ də közərə bilər? Girişi beş min rubl olan "hər şeydən şəfa" marafonlarını sırışdıran milyonlu bloqer öz müdafiəsində nə deyəcək?

Onların nəolitik cərrah bəhanəsi yoxdur. Onlarda yalnız bir şey var: vicdansızlıq və həddən artıq tamahkarlıq. Və buna göz yuman cəmiyyətin sükutla razılığı.

Elə həmin Elzas dövründə Ensisheim adamı kəlləsində açılmış iki deşiklə yaşayarkən, onun həmdövrləri mağara divarlarına şəkil çəkir, ölülərini çiçəklərlə dəfn edirdilər. Onlarda artıq ağıl vardı. Artıq onlarda insanı heyvandan fərqləndirən bir şey vardı. Dünya haqqında suallar verir və onlara bacardıqlarınca cavab verməyə çalışırdılar.

Psixiatriyanın tarixi nə Svendborgla, nə də Eskirillə başlayır. Bu tarix kəllədəki bir deşiklə başlayır. İnsanın başqa bir insanın ağlındakı dəliyə səbəb axtarmağa — və bu səbəblə nəsə etməyə ilk cəhdi ilə başlayır.

Növbəti səhifələrdə görəcəyimiz kimi, bəşəriyyət daha çox, lap çox müddət cəhd etməkdə davam etdi. Müxtəlif formalarda. Müxtəlif sözlərlə. Müxtəlif dərəcədə qəddarlıqla. Müxtəlif dərəcədə səadətlə.

Və hələ də cəhd edir.

Əlinizdə tutduğunuz kitab bu yolun hansı mərhələsində olduğumuzu anlamaq cəhdidir. Və kəllədəki deşiklər bir gün nəhayət lazımsız olub-olmaya bilərmi.

Fəsil 2. Cini qovmaq, bədəni öldürmək: ekzorsizm, Bedlam və görünməz dini psixiatriya

1976-cı il iyulun 1-nə keçən gecə Bavariyanın kiçik Klinqenberq şəhərində iyirmi üç yaşlı Annelize Mixel öz yataq otağında vəfat etdi. Vəfat anında çəkisi otuz bir kiloqram idi. Döşəmə üstə dua edərək keçirdiyi yüzlərlə saatdan dizləri əzilmişdi. Dodaqlarında və dilində öz sidiyinin qurumuş izləri var idi; şahidlərin ifadələrinə görə, o, vəfatından az əvvəl onu içməyə çalışmışdı. Anasına dediyi son sözlər belə olmuşdu: "Ana, qorxuram".

Aşkarlama nəticəsində müəyyən edilmiş ölüm səbəbi: tükənmə və susuzlaşma. Birbaşa səbəb: altı ay ərzində qidadan imtina.

Sonradan məhkəmənin müəyyən etdiyi və ilahiyyatçılarla psixiatrların bu gün də mübahisə etdiyi dərin səbəb — yepiskopun təsdiqi ilə iki katolik keşiş tərəfindən onun üzərində keçirilmiş 67 ekzorsizm seansı idi. Hər seans dörd saat davam edirdi. Bütün bu müddət ərzində onu saxlayır, dua edir, çarmıxa çəkilmiş İsanın təsvirlərini göstərir və içində olduğu güman edilən bir neçə şeytan adından — Lütsiferin özü, Kayin, Yəhuda, Neron və nə qədər qəribə səslənsə də, Adolf Hitlerin adından danışırdılar. Seansların nəticələri əsasında ətraflı hesabatlar tərtib olunurdu. Qırx iki saatlıq yazı maqnitofon lentlərində qalmışdı; sonralar məhkəmədə onları səsləndirdilər.

Annelize cinlərə tutulmamışdı.

Annelize temporal pay epilepsiyasından əziyyət çəkirdi — bu diaqnoz ona hələ on altı yaşında, ilk tutması baş verəndə qoyulmuşdu. Sonralar epilepsiyaya psixotik pozğunluq da əlavə olundu. Ona tutmanı azaldan dərmanlar, antipsixotiklər və antidepressantlar təyin edirdilər. Müalicə çətin keçirdi, simptomlar güclənirdi: eşitmə hallüsinasiyaları yaranmışdı, səslər eşitməyə, adi yolkeçənlərin üzündə "şeytani simalar" görməyə başlamışdı. Özünə fiziki zorakılıq göstərir, yeməkdən imtina edir, anasını dişləyir, öz sidiyini içir və böcəklər yeyirdi.

Onun ailəsi dərindən katolik idi. Atası vaxtilə keşişlik təhsili almışdı. Üç xalası rahibə idi. Dərmanlar ailənin gözlədiyi qədər tez təsir etməyəndə ana Anna sadə və tanış bir izaha gəldi: qızım şeytana qapılıb.

Və sonralar iyirminci əsrin ən uğultulu faciələrindən biri — həm də iyirmi birinci əsrin insanları olaraq tomorqraflar, neyrofarmakologiya və sübuta əsaslanan tibb dövründə yaşasaq da, əksəriyyətimizin hələ də dəliliyin ruhların hücumu olduğuna inandığını xatırladan ən acı xatırlatmalardan biri adlandırılacaq hadisə başladı.

Təsəvvür et: sən düşünürsən ki, ekzorsizm Orta əsrlərin tozlu qalığıdır. Turistlər üçün qorxu hekayəsi, ucuz qorxulu filmlərin süjetidir. Unut. Bu, Katolik Kilsəsinin rəsmi, hazırda qüvvədə olan təcrübəsidir. Elə indi. Vatikanın qəlbində Ekzorsistlərin Beynəlxalq Assosiasiyası — Associazione Internazionale degli Esorcisti fəaliyyət göstərir. O, Müqəddəs Taxt-tacın rəsmi tanınmasını alıb. İl — 2014-cü ildir. 1614-cü il deyil. İki min on dördüncü. Ritual "Roma ritualı"nda — Rituale Romanum-da yazılıb. Son redaksiyası 1999-cu ildə, II İohann Pavelin dövründə çıxıb. İndi isə — ən vacibi. Sənədi aç. Sətri tap. Orada açıq şəkildə göstərilib: ekzorsizm mərasimi zamanı ölümlə nəticələnmə mümkündür. İnsan ölür. Fikirləş. Bu, sənəddə nəzərdə tutulub. Bu, manea deyil. Bu, yol verilə bilən

qiymətdir. Niyə? Budur ilahiyyat məntiqi, hərfi mənada: "bədəni itirə bilərik, amma ruhu xilas edərik". Bədən — itirmək. Ruh — xilas etmək. Soyuyan ət, son nəfəs — və əbədiyyət. Tərəzinin bir gözünə bir həyat, o biri gözünə sonsuzluq. Kilsə seçim etdi. Və onu kağızda təsbitlədi.

Annelize Mixel bu məntiqə qurban getdi.

O, öldü, çünki iyirmi üç yaşına qədər — müasir Almaniyada, Avropanın qəlbində, tomoqrafların kifayət qədər olduğu və epilepsiyaya qarşı dərmanların çatdığı bir dövrdə — valideynləri və kilsə çobanları onun epileptik tutmalarını altı şeytanın hücumu saymağa üstünlük verdilər və tibbi müalicəni davam etdirmək yerinə həmin şeytanları qovma mərasimlərini seçdilər.

Məhkəmə bunu səhlənkarlıq nəticəsində ölümlə nəticələnmə saydı. İki keşiş — Arnold Rents və Ernst Alt — altı ay azadlıqdan məhrumetmə cəzasına (sonradan üç il şərti cəzaya) məhkum edildilər. Valideynlər də günahkar bilindilər, lakin cəzadan azad edildilər — "onlar artıq kifayət qədər əziyyət çəkiblər". Bir neçə il sonra katolik kilsəsi onun şeytana tutulduğunu sakitcə etirafdan geri götürdü, onun psixi xəstə olduğu ilə razılaşdı.

Amma artıq gec idi.

Və başa düşməli olduğumuz ən vacib şey budur. O, psixiatriya, farmakologiya və neyrofiziologiya onu xilas etmək üçün bütün alətləri əldə etdikdən sonra dünyasını dəyişdi. O, neolit dövründə, Orta əsrlərdə və ya inkvizisiya çağında deyil, iyirminci əsrin yetmişinci illərində — Almaniyada — rəsmi kilsə iyerarxiyasının icazə verdiyi 67 seansdan sonra dünyasını dəyişdi.

Onun məzarı bu gün də özünü "dünyanın günahlarına görə şəhid" sayanların ziyarətgahı olaraq qalır.

Annelize Mixel hadisəsi tək-tənha deyil. O, aysberqin görünən təpəsidir.

Hər il dünyada onlarla belə hadisə baş verir. Psixi və nevroloji xəstəliklərdən əziyyət çəkən onlarla insan özlərini şəfaçı adlandıranların əlindən həlak olur. Rəqəmləri tədqiqatçılar və jurnalistlər toplayır. Hər birinin arxasında bir ekzorçizm mərasimi dayanır. Rumıniya, 2005-ci il. Tanaku monastırı. Daniel adlı rahib iyirmi üç yaşlı rahibə İrina Korniçini zəncirləyir, ağzına cır-cındır tıxayır və üç gün bu vəziyyətdə qoyur. Məqsəd — "şeytanları qovmaq". Su və hava olmadan üç gün. İrina susuzluqdan və boğulmadan ölür. Miluoki, 2003-cü il. Ana səkkiz yaşlı qızını döyə-döyə öldürür. Qızın autizmi var. Hər şey xarizmatik kilsənin "şəfa seansı" zamanı baş verir. Ana inanır. Ana vurur. Uşaq ölür. London, 2015-ci il. Nənə və xala dörd yaşlı qızı "cinlərdən təmizləmə" mərasimi keçirərək vanna qabında boğurlar. Su. Əllər. Sükut. Üç ölkə. Üç il — 2003, 2005, 2015. Üç mərasim. İrina. Miluokili qız. Londonlu qız. Zəncirlər. Döyülmə. Su. Bu Orta əsrlər deyil. Bu bizim günlərimizdir.

Bunlar yalnız xəbərlərə düşən hallardır. Bəs mətbuatın zəif olduğu, polisin dini icmalardakı cinsi istismarı araşdırmadığı, yaxınların şikayət etmədiyi ölkələrdə neçə belə hal var? Bunu qiymətləndirmək mümkün deyil.

Baxın. Budur qanı donduran bir fakt. Belə mərasimlərin qurbanları demək olar ki, həmişə psixiatrik klinikaların pasiyentləri olur. Günahkarlar deyil. Cinlənmişlər deyil. Xəstələr. İndi isə — zəncir. Dörd həlqə. Hər birini izləyin. Birinci. Şizofreniya. Səslər şüuru içdən parçalayır, şəxsiyyət qırıntılara bölünür — və bu, cinlənmişlik kimi qəbul edilir. İkinci. Ağır depressiya. İnsan susur. Qırtlağı spazma düşür, danışmağı dayandırır. Və bu, "ruh düşkünlüyü" damğası ilə yüklənir. Üçüncü. Epilepsiya. Bədəni qıcolma tutur. Əzələlər avtomatik hərəkətlərlə çırpınır. Və artıq — "şeytan girməsi". Dördüncü. Autizm. Xüsusilə özünü stimullaşdırma ilə. Və bu, "nəcis ruhun təsiri" elan edilir. Dörd diaqnoz. Cahillik imzası ilə imzalanmış dörd ölüm hökmü. Amma ən qorxulusu budur.

Psixi xəstəlik mənəvi bir hadisə kimi qəbul edildikdə — ölümcül bir yerdəyişmə baş verir. Və sonra düzəlməz bir şey olur: xilas edə biləcək kömək gəlmir. Başqa bir şey gəlir.

Müasir ekzorsizmlər — bu, son nöqtədir. Lakin onların təməlində dayanan ideya hər hansı psixiatriya məktəbindən də, ümumiyyətlə, hər hansı tibbdən də qədimdir.

Psixi xəstəliyin insanın xarici qüvvə tərəfindən ələ keçirilməsi olması fikri bütün xristianlıqdan əvvəlki tarix boyu qırmızı xətt kimi keçir. Babil sakinləri uzun cin siyahıları tərtib edirdilər, onların hər biri müəyyən bir "dəlilik" növünə cavabdeh idi. Qədim yunanlar epilepsiyanı bilirdilər, ona "ilahi xəstəlik" (morbus sacer) deyirdilər və tanrıların müdaxiləsinin əlaməti hesab edirdilər. Eramızdan əvvəl beşinci əsrdə Hipokrat ilk dəfə "Müqəddəs xəstəlik haqqında" traktatını yazmağa cəsarət etdi və orada sakit və qətiyyətli şəkildə bildirdi: bu xəstəlik ilahi deyil. O, digər xəstəliklər kimidir, onun beyində yerləşən təbii səbəbi var.

Hippokrat haqlı idi. Lakin onun səsi əks məntiqin minillik xorunda batıb getdi.

Yəhudi-xristian ənənəsində cin tutma ideyası yeni, gərginliklə döyünən bir məna kəsb edir. Əhd-i Cədid mətnləri heç bir şübhə yeri qoymur: İsa dəfələrlə cinləri qovur. Amma kontekstə baxın. Cinlər xəstəlik deyil. Onlar şərin agentləridir. Onlar insanın və Tanrının düşmənləridir. Məntiq qılınc kimi kəsir: əgər içində cin varsa, onu qovmaq zəruridir. Yalnız o zaman şəfa tapacaqsan. İlahiyyat bu ideyanı əsrlər boyu cilalayacaq. Orta əsrlərə gəlib çatanda isə o, hələ mövcud olmayan psixiatriyanın döyünən ürəyinə çevriləcək.

1247-ci ildə Londonda bir müəssisə açıldı. Adı yeddi əsr sonra ingilis dilinə xaos və vəhşiliyin sinonimi kimi daxil olacaqdı: Bedlam. Tam adı — Müqəddəs Məryəm Betleyem Xəstəxanası (Bethlehem Hospital). Əvvəlcə yoxsullar üçün sığınacaq idi, amma artıq XIII əsrin sonlarında burada "dəlilər" —

ailəsi və kilsə icması kömək edə bilmədiyi və ya etmək istəmədiyi adamlar saxlanılmağa başlandı.

Növbəti beş əsr boyu Bedlamda bu adamlarla nələr etdiklərini sakit tonda təsvir etmək demək olar ki, mümkünsüzdür.

Xəstələri zəncirlərdə saxlayırdılar. Palçıq. Soyuq. Buz kimi daş otaqlarda onlar canlı kölgələrə çevrilirdilər. Müalicə sayılan nə idi? Onlara "hamam" qururdular — buzlu suya batırırdılar. Huşunu itirənə qədər saxlayırdılar. Qan almaqla "müalicə edirdilər" — bir seansda bir litr və daha çox qan. Qan çıxırdı, onunla birlikdə həyat da. Dərman otlarından hazırlanmış qarışıqlarla qusma törədirdilər — bədən iflas edənə qədər. Başı tamamilə qırxırdılar. Xardal plasterləri qoyurdular. Guya "beyindən zəhəri çəkmək üçün". Fırlanan stullara bağlayırdılar. Dəli sürətlə fırladırdılar. Guya "qara ödü silkələmək üçün".

XVII əsr. London. Betleyem Xəstəxanası. Bedlam. Tibb tarixində ən qaranlıq tamaşa məhz burada oynanırdı. Girişə — xırda bir sikkə. Şəhərli bu qəpiklərə nə alırdı? Zooparka bilet. Sadəcə qəfəslərdə heyvanların yerinə — insanlar. Barmaqlıqların arxasında xəstələr. Çubuqlarla onları dürtürdülər — eynilə meymunları dürtdükləri kimi. Reaksiya gözləyirdilər. Qəhqəhə çəkirdilər. XVIII əsrə gəlib bu artıq təsadüfi bir məşğuliyyət deyildi. Bu — dəb idi. London orta təbəqəsinin əyləncəsi. Həftəsonu: Bedlama getmək, dəlilərə tamaşa etmək. Sonra — meyxanaya. Bir krujka pivə altında müzakirə etmək.

Yalnız 1770-ci ildə islahatçıların təzyiqi ilə Bedlam qapılarını tamaşaçıların üzünə bağladı. Lakin içəridə saxlanma şəraiti hələ onilliklər boyu dəhşətli olaraq qaldı.

Bütün bunları birləşdirən nə idi? Əsas məntiq. Ruhi xəstə insan — natamam insan. Ona obyekt kimi rəftar etmək olar. Ona əzab vermək olar — qəzəbdən deyil, "müalicə məqsədilə". Onu nümayişə qoya bilərsən. Onun əzabları əsl əzab sayılmır. Çünki o — tamamilə bizdən deyil. O — əsir düşüb.

Lakin iblisə tutulma fikri özünü ən güclü şəkildə sığınacaqlarda deyil, inkvizisiyanın kilsə məhkəmələrində göstərdi.

1486-cı il. Avropa lərzəyə gəldi. Mətbəədən iki dominikanın — Henrix Kramer və Yakob Şprengerin traktatı çıxdı. "Cadıların çəkici". Malleus Maleficarum. Qan haqqında xəbər verən zəng səsi. XV əsrin sonlarından etibarən qitə üç əsrlik ovun içinə qərq oldu. Qaranlıq şəhərləri və kəndləri bürüdü. Qurbanlar? Qırx mindən yüz minə qədər insan. Əksəriyyəti — qadınlar. Onları yataqlarından dartıb çıxarır, "cadugərlik" üstündə tonqallara və dar ağaclarına sürükləyirdilər. Amma əslində onlar kim idi? Cavab tozlu arxivlərdə gizlənib. Qorunub saxlanmış məhkəmə protokolları dəhşətli həqiqəti üzə çıxarır. Edam edilənlərin çoxu cadugər deyildi. Onlar ruhi xəstə idilər. Avropa öz dəlilərini öldürürdü.

Səslər. Boşluqla söhbətlər. Qıcolmalı, qeyri-təbii bədən hərəkətləri. Öz əli ilə vurulmuş yaralar. İnkvizitor üçün cavab bir idi. Şeytanla müqavilənin aydın əlamətləri. Amma bu qorxunc maskanın arxasında əslində kim gizlənirdi? Doğuşdan sonrakı psixozdan əziyyət çəkən qadın. Dəhşət içində körpəsini bir dəyişdirənin — canavar adamın dəyişdirdiyini iddia edirdi. Hökm? Tonqal. Psixomotor avtomatizmlərin ələ keçirdiyi epilepsiya xəstəsi. Tonqal. Demensiyalı yaşlı qadın, anlaşılmaz bir şey mırıldanırdı. Tonqal. Şizofreniyalı və intihara meyilli gənc qız. Tonqal. Alov qalxandan əvvəl "sorgu" olurdu. Çoxsaatlı işgəncələr. Əzab çəkən bədən ağrıdan qışqırırdı. Və o, heç vaxt etmədiyi şeyi boynuna alırdı. Çünki hər hansı başqa cavab — etirafdan fərqli hər hansı ifadə — ona yeni əzablar yağdırırdı. İşgəncələr bədbəxt tamamilə sınana qədər davam edirdi.

İnkvisisiya əslində Avropanın ilk kütləvi psixiatrik xidməti idi. Dəhşətli, zorakı, məhv edən bir xidmət. Amma elə o idi ki, bu gün psixiatrik klinikada müalicə ediləcək insanlarla məşğul olurdu. Tonqal insulin komaya rolunu oynayırdı. İşgəncə — elektroşok rolunu. İctimai edam — institusionalizasiya rolunu.

Odur ki, Fuko və başqa tibb tarixçilərinin psixiatriyanın sosial təcrid aləti kimi yarandığını yazması yalnız yarı həqiqətdir. Psixiatriyadan çox-çox əvvəl bu alət artıq mövcud idi. Onu Kilsə düzəldirdi. Onun alətləri ekzorsizm, qovma, işgəncə, yandırma adlanırdı.

Psixiatriya onun bu funksiyalarını əlindən aldı. Və çoxlu göz yaşları və qanla, yavaş-yavaş onları daha insani bir şeyə çevirməyə çalışdı.

Mən "cəhd etdi" dedim. Çünki vəzifə hələ yerinə yetirilməyib.

Biz Bedləmi və inkvizisiyanı uzaq bir keçmiş kimi düşünürük. Onlar bizə tarixi bir kabus kimi görünür. Amma gəlin həqiqətə üz-üzə baxaq.

1976-cı ildə Klingenberqdə Annelize Mixel 67 ekzorsizmdən sonra aclıqdan öldü. Onun ölümü məhkəmə tərəfindən səhlənkarlıq nəticəsində ölüm kimi qiymətləndirildi.

Bu gün. İyirmi birinci əsr. 2020-ci illər. Orta əsrlərin qalığı kimi görünən şey geri qayıdır. Yeraltında yox, sektant zirzəmilərində yox — rəsmi şəkildə. Katolik kilsəsi 2014-cü ildə Beynəlxalq Ekzorsistlər Assosiasiyasını tanıdı. Tanıdı. Kağız üzərində. Bütün hüquqi nəticələri ilə. Romada kurslar açılıb. Dünyanın hər yerindən keşişlər axışıb gəlir. Təyyarələrlə. Qatarlarla. Avtobuslarla. Partalar arxasında oturub şeytanı qovmağı öyrənirlər. 2016-cı il. Vatikan yeni təlimat yayımlayır. Prosedur yenilənib. Söz-söz. Maddə-maddə. Texniki reqlament kimi. İndi isə — rəqəmlərə baxaq. Son iyirmi ildə katolik dünyasında rəsmi ekzorsizmlərin sayı bir neçə dəfə artıb. Bu, kilsənin özünün verdiyi məlumatdır. Jurnalistlərin yox. Skeptiklərin yox. Kilsənin. Amerika Birləşmiş Ştatları. Yüzdən çox akkreditə olunmuş ekzorsist. Yüz. Fəaliyyət göstərən. Halhazırda. 1990-cı ildə onların sayı on dəfə az idi. Otuz il ərzində on qat artım. Sual sadədir. Əgər şeytan yoxdursa — nə baş verir?

Pravoslav dünyasında mənzərə oxşardır. Rus, rumın, gürcü monastırlarında "otçitka" keçirilir — funksional olaraq ekzorsizmə bənzər ayinlər. Bu ayinlər çoxu şizofreniya, bipolyar pozuntu, epilepsiyadan əziyyət çəkən insanlar üzərində icra olunur. Ailələr belə xəstələri ağsaqqallara, rahiblərə, "uzaqgörənlərə" aparır. Və geri qaytarırlar — bəzən ölü, bəzən daha da pisləşmiş halda.

Protestant pentakostal kilsələrində, xüsusən Latın Amerikasında, Afrikada və postsovet məkanında "şeytandan xilas olma" mərasimləri geniş yayılıb. Minlərlə kilsə. Milyonlarla ibadət edən. İllə ərzində yüz minlərlə "təmizlənmə" ayini. Ənənəvi olaraq heç bir rəsmi statistikaya malik deyillər.

İslam aləmində — "ruqyə", cin tutmuş adamın üstündə Quran oxumaq. Hinduların dünyasında — ruhları qovmaq üçün xüsusi ayinlər. Afrika ənənələrində — "əcdad ruhları" ilə işləyən təbiblər. Hər yerdə eyni şeydir. Psixi xəstə adam həkimə deyil, "ruhları görən" kimsəyə düşür.

Skeptik mənə etiraz edəcək: "Axı pravoslav monastırında Bedlamdakı kimi qandalla döymürlər, inkvizisiyadakı kimi tonqala da qoymurlar. Adamlar özləri gedir. Heç kim onları məcbur etmir".

Bu etiraz cavab tələb edir.

Birinci: "özü gəlir" — həmişə könüllü deyil. Çox vaxt qohumlar psixi xəstə insanı keşişin yanına elə vəziyyətdə gətirir ki, o, məlumatlı razılıq verə bilmir. Elə xəstə olduğu üçün. Annelize Mixel həyatının son aylarında ekzorsizmdən rasional şəkildə imtina edə bilmirdi — onun psixi və fiziki vəziyyəti artıq dönməz şəkildə sarsılmışdı. Amma hüquqi baxımdan bu, "könüllü" sayılırdı.

İkinci. Psixi xəstələr üzərində dini ayinlər — bu, sadəcə mistika deyil. Bu, real tibbi təhlükədir. Mənəvi təzyiq altında dərmanlardan imtina. Saatlarla oruc və ibadətdən fiziki tükənmə. Kollektiv ritualın qızğın atmosferində psixozun

kəskinləşməsi. Bu amillərin hər biri klinik psixiatriya tərəfindən təsdiqlənib. Bəs əslində nə baş verir — şizofreniya xəstəsi, deliryumu dini günah və şeytan mövzusuna sarsılmaz şəkildə fokuslanmış bir xəstə bu ritualın episentrinə düşəndə? Ekzorsizm ona qurtuluş vəd edir. Amma duası ilə bağlanan insanın gözlərinə baxın. Qovma ayinində iştirak ona rahatlıq gətirmir. O, öz deliryumunun təsdiqini alır.

Üçüncüsü — və ən vacibi də budur. Ekzorsizm və müasir ezoterik təcrübələr — eyni quşun iki qanadıdır. O quş ki, heç vaxt uçub getməyib və hələ də müasir psixiatriyanın üzərində süzür.

Şeytan qovan kahin. "ThetaHealing" ustası, "mənfi enerjiləri" kəsib çıxaran. Depressiyanın səbəbini bağışlanmamış nəsil ruhunda axtaran Hellinger üsulu ilə çalışan mütəxəssis. Üç insan. Üç müxtəlif əsr. İlk baxışda uyğunsuz görünən üç ayin. Onları bir araya gətirin. Və qan donduracaq qədər aşkar bir qanunauyğunluq ortaya çıxacaq. Hər üçü eyni paradigmdə işləyir. Elmdən əvvəlki dövrə aid. İnsanın görünməyən qarşısındakı ilk qorxusu qədər qədim olan bir paradigma. Bu nə deməkdir? Onlar üçün bədən — sadəcə bir qabdır. Boş bir qabıq. İçində isə — nəsə var. Maddi olmayan. Xarici. Düşmən. O, xaricdən daxil olub nəzarəti ələ keçirib. İşğalçı kimi. Ətə sancılmış yad bir agent kimi. Lakin bu məntiqin sonunda gizlənən bir sirr var. Bu nəsə çıxarıla bilər. Kəsilə bilər. Qovula bilər. Parazit kimi. Dəri altına batmış tikan kimi. Ayinlərlə.

Hamısı elmi psixiatriyadan eyni dərəcədə uzaqdır. Və hamısı həqiqətən köməyə ehtiyacı olan adam üçün eyni dərəcədə təhlükəlidir.

Bedlamda artıq ekzorsizmlər üzündən bilet satılmır. Amma "Ekstrasenslər döyüşü"ndə televiziya reytinqləri ildən-ilə yüksəlir. İnkvizisiya üzündən artıq cadugərləri yandırmırlar. Amma keçmiş sovet imperiyasının hər yerində "düzənləyici-

lər” falçıları öz “varisləri” elan edib “nəsli təmizləmə” üçün pul alırlar.

Formalar dəyişir. Mahiyyət qalır.

Proloqda qoyduğumuz sual yenidən qayıdır: bu vəziyyətdə kim reallıqla əlaqəni itirmiş durumdadır?

Şizofreniya diaqnozu qoyulmuş, halüsinasiyalar görən, özündən başqa heç kimə zərər verməyən xəstə?

Yoxsa iyirmi birinci əsrdə insanların aclıqdan öldüyü rituallara icazə verən kilsə iyerarxiyası?

Yoxsa belə ayinlərin “möminlərin şəxsi işi” olduğunu sükutla qəbul edən cəmiyyət?

Bu sualın cavabı keşişlərə aid deyil. Bu, psixiatriyaya aiddir. Və cəmiyyətə.

Qorxuram ki, həm biz, həm də onlar hələ də ondan yayınırıq.

Fəsil 3. Dolaşan bətn: qadın diaqnoz kimi

17 avqust 1872-ci il. Corciya, cərrahiyyə otağı. Stolun üstündə — iyirmi üç yaşlı Culiya Ormberq. Qıcolmalar. Çanaq nahiyəsində ağrılar. Və "əqli qarışıqlıqlar" — həkimi belə yazmışdı — aybaşı dövrü ilə birlikdə gəlib gedən. Cərrah Robert Betti skalpeli götürür. Qarın boşluğunu açır və hər iki yumurtalığı çıxarır. Hər ikisini. Sağlam olanları. Nə şiş, nə kista, ən xırda zədə belə yox. Yumurtalıqlar tamam sağlam idi — və elə buna görə də onları kəsib çıxardılar. Çünki onlar işləyirdi. Çünki onlar fəaliyyət göstərirdi. Bettinin məntiqi hökm qədər sadədir. Əgər qadının "dəliliyi" hər ay qanla birlikdə qayıdırsa, deməli, dəliliyin mənbəyi aybaşının özüdür. Deməli, onu bu imkandan məhrum etmək lazımdır. Dövrü dayandırmaq. Süni menopauza yaratmaq. Burmaq.

Sonrakı bir neçə onillikdə dünyanın hər yerində təxminən yüz beş min qadın Robert Bettinin "normal ovariotomiya" adlandırdığı, tibb ictimaiyyətinin isə sonralar "Betti əməliyyatı" dediyi şeyə məruz qaldı. Ölüm nisbəti on faizdən iyirmi beş faizə qədər idi. Bıçaq altına düşən xəstələrin təxminən dörddə biri əməliyyat masasından bir daha qalxmırdı.

İfadələr qeyri-müəyyən idi. Betti üçün əməliyyat tövsiyə olunan diaqnozların siyahısı səhifələrlə uzanırdı. Menstrual maniya. Nevrasteniya. Nimfomaniya (patoloji cinsi meyl). Masturbasiya. Epilepsiya. İpoxondriya. Melanxoliya. İsteriya. Və — hamısının tacı — "bütün dəlilik halları".

1876-cı ildə Robert Betti Amerika Ginekologiya Cəmiyyətinin həmtəsisçilərindən biri oldu.

O, "təbabətin böyük yenilikçisi" idi. Eynilə doktor Con Marion Sims kimi. İkisi də — dünyanı dəyişmiş qabaqcıllarla bir sırada. Tibb tarixi belə deyir. Bu gün. Yüz ildən çox sonra. İndi bir sual verin. Yalnız bir. Qərəzsiz. Əslində onlar kim idi? "Yenilikçi" deyil. "Qabaqcıl" deyil. Cərrahlar. Otuz il dalbadal sağlam qadınları əməliyyat edənlər. Sağlam orqanları çıxaranlar. Süni menopauza yaradanlar. Və buna dəliliyin müalicəsi deyənlər. Otuz il. Sağlam orqanlar. Sağlam qadınlar. Bəlkə də heç olmayan dəlilik. Budur. Bütün "böyük yenilik" budur.

Təsəvvür edək ki, buna 1880-ci illərdə Bostonun, Londonun, Moskvanın və ya Parisin gənc qadınının gözü ilə baxırıq.

Sən iyirmi beş yaşındasan. Evlisən. Bəlkə də uşaqların var. Bu gün depressiya, narahatlıq pozuntusu, bəlkə də premenstrual disforik sindrom adlandırılan şeydən əziyyət çəkirsən. Gecələr ağlayırsan. Narahatlıq hiss edirsən. Diqqətini cəmləyə bilmirsən. Sənə çətindir.

Sən həkimə gedirsən. Həkim kişidir, qara sürtuq geyinib, professor saqqalı var. Həkim səni diqqətlə dinləyir. Başını tərpədir. Deyir: "Sizdə, madam, ovarian insanity — yumurtalıq dəliliyi var. Bu sizin günahınız deyil. Bu xəstəlikdir. Mənim bir üsulum var. Mən kömək edə bilərəm".

Səni klinikaya qoyurlar. Xloroform. Masq ağzına basır. Anesteziya hələ cavandır — aralıq-aralıq nəfəs alırsan, qaranlığa təkanlarla cumursan, kimsə yad barmaqlar biləklərini sıxır. Sən huşsuz ikən qarnını açırlar. Skalpel. Hər iki yumurtalıq — getdi. Heç nə hiss etmirsən. Hələ bilmirsən. Sağ qalsan — "süni menopauza" deyilən şeyi alacaqsan. Dərini yandıran istilik basmaları. Sümükləri içdən qıran osteoporoz. Ölmüş libido. Sonsuzluq. Hər söz — bir hökm. Sağ qalmasan — iyirmi beş faizə qədər şans — səni saymayacaqlar. Adı heç kimin yazmadığı minlərlə qadından biri olacaqsan. Ölüm səbəbi? Bütün varlığın üçün bir sətir. Bütün ömrün üçün. Bütün ağrın üçün: "sinir xəstəliklərinin nəticələri".

Əməliyyatdan bir ay sonra — əgər hər şey "uğurla" keçibsə — müalicə edən həkimin gəlib qürurla deyir: "Siz artıq ailənizin bütün ev işlərini görürsünüz". Ginekologiya jurnalındakı bir məqalədə bu, "parlaq nəticə" kimi qeyd olunacaq.

"Betti əməliyyatı" barədə akademik hesabatlara diqqətlə baxın. Bettinin özünün 1881-ci ildə Britaniya Tibb Jurnalında çap etdirdiyi işi açın. Oxuyun. Axtarın. O quru sətirlərin arxasında nə var? Yoxsa şəfa? Yoxsa xilas? Əməliyyatın uğur meyarı — nədir? Onun əzablarını yüngülləşdirmək? Xeyr. Həyat sevincini qaytarmaq? Xeyr. Emosional həyatı bərpa etmək? Yenə xeyr. Yemək bişirmək bacarığı. Paltar yumaq. Ailəyə qulluq etmək. Budur — qorxunc nəticə. Qırmızı dəmirlə basılmış damğa: qadın yenidən ev işlərinə yararlıdır.

yazılmış versiya: Qadını sağaltmaq üçün onu öz bədənindən ayırırdılar — beləcə ailəsinə daha yaxşı xidmət edə bilərdi.

Betti əməliyyatı — psixiatriya və ginekologiyanın keçmiş iki əsrdə qadınlara necə rəftar etdiyinə dair uzun və rüsvayçı tarixdə sadəcə bir epizoddur. Bu tarixi köklərini dərk etmədən başa düşmək mümkün deyil.

Qadın bədəninin — xüsusilə də uşaqlığın — psixi əzabların mənbəyi olduğu fikri Qərb təbabətindən daha qədimdir. Təxminən e.ə. 1900-cü ildə, yəni az qala dörd min il bundan əvvəl yazılmış Misir Kahun papirusunda artıq "qadın xəstəliklərinin" bədən daxilində gəzib digər orqanlara təzyiq edərək simptomlar yaradan "avara bətn"la bağlı olduğuna dair qeydlərə rast gəlinir.

Platon "Timey" dialoqunda (təxminən e.ə. 360-cı ildə) bu fikri tam hüquqlu təbiət fəlsəfəsinə çevirdi:

Qadınlarda rahim — uşaqlar istəyən canlı bir məxluqdur. Əgər bu orqan müəyyən müddət yetişdikdən sonra sonsuz qalsa, hiddətlənir və bunu ağır şəkildə davam etdirir, bədən boyu gəzərək tənəffüs yollarını bağlayır, nəfəs almanın qarşı-

sını alır və müxtəlif xəstəliklərə səbəb olur. Bu vəziyyət qadın və kişi bir araya gələnədək davam edir.

Bu, qədim histeriya mifidir — yunan sözü ὑστέρα, yəni "uşaqlıq"dan gəlir. Bu ad XX əsrə qədər gəlib çatıb və yalnız 1980-ci ildən sonra rəsmi olaraq diaqnostik təsnifatlardan çıxarılıb.

Hipokrat, epilepsiya ilə bağlı materialist baxışına baxmayaraq, "rahmin əzab çəkdiyi" ideyasını müdafiə edirdi və menstruasiyanı "məyus rahimin qanlı göz yaşları" adlandırırdı. II əsr tibb alimi Soran Efesli "gəzən rahim" nəzəriyyəsinə şəkilə şübhə bildirsə də, özü "rahimin qəzəbləndiyini" və eyni simptomlara səbəb olduğunu irəli sürdü. Qərb tibbində bir min beş yüz il ərzində nüfuzunu qoruyan Qalen isə "qadın cinsəlliyinin xəstəlik mənbəyi olduğu" ideyasını möhkəmləndirdi.

Beləliklə, minilliklər sonra onu XIX əsr klinikalarında, Betti və Simsın əməliyyat otaqlarında, Parisdəki Salpetriyer divarları arasında, Şarkodan Freydə qədər psixiatrların qeydlərində aşkar edirik.

Jan-Marten Şarko (1825–1893). Böyük fransız nevroloqu. Elmi məktəb yaradıcısı. Freydin birbaşa əvvəlçisi. Lakin 1870-ci illərin sonu və 1880-ci illərin əvvəllərində Parisdəki Salpetryer xəstəxanasında nə yaratdı? İsteriyanın əsl teatrı. Həftədə bir dəfə. Çərşənbə axşamları. Şarko böyük zalda tələbələrinə və ictimaiyyətə epileptik tutmaları olan xəstələri nümayiş etdirirdi. Onları "böyük isterik böhranlar" adlandırırdı. Bədənlər yerə yıxılırdı. Onurğa "tağ" şəklində əyilirdi. Qışqırıqlar səssizliyi pozurdu. Əzələlər qəribə pozalarda donurdu. Təbiətin sirri? Yox — anatomik dəqiqlik. Şarko bu vəziyyətlərə diqqətlə baxır və "isteriya tutmasının mərhələləri" adlı mürəkkəb təsnifat yaradırdı: "epileptoid faza", "klounizm", "ehtiraslı pozalar", "delirium".

Tibb tarixçiləri daha sonra sadə və dəhşətli bir fikirdən ürəkləri dəfələrlə titrədi. Bu "tutmalar"ın çoxu qəsdən və ya bilməyərək səhnələşdirilmişdi. Salpetryerdə illərlə əzab çəkən xəstələr digər xəstələrin tutmalarını izləyərək "düzgün" ağrı dilini öyrənmişdilər. Nə etməli idi? Necə çıxış tapılmalı? Ancaq belə. Böyük ustasın bir az diqqətinə nail olmaq üçün əzəblər içində müəyyən ssenariya əsasında bükülərək. Və budur sual — qan donduracaq müəmməya: niyə Salpetryerin divarlarından kənarda belə bir tutma görünməyib? Cavab amansızdır. Xəstəliyin özü klinika tərəfindən yaradılmışdı. Sonra 1893-cü il gəldi. Şarko öldü. Və "böyük isterik böhranlar" dərhal onun palatalarından yox oldu. Silindi. Elə bil olmayıb.

Lakin Şarko — bir çoxlarından fərqli olaraq — kəsmirdi. O hipnoz edirdi. O tədqiq edirdi. O təsnif edirdi. Bu onun rolu idi. Atlantik okeanı arxasında, Kanadada və ABŞ-də isə digər həkimlər bu materialdan tamamilə başqa şeylər düzəldirdilər.

Riçard Moris Bak (Richard Maurice Bucke, 1837–1902) — Kanada psixiatrı, Ontario ştatının London şəhərindəki ruhi xəstələr xəstəxanasının baş həkimi — "dəliliyin ginekoloji nəzəriyyəsi"nin daha radikal davamçısı idi. Bak psixiatrik xəstələri olan qadınlarda histerektomiya, yumurtalıqların və boruların çıxarılması əməliyyatlarını sistemli şəkildə, illər boyu həyata keçirirdi. O, qadınlarda psixi xəstəliklərin əksəriyyətinin "çanaq orqanlarının qeyri-normal fəaliyyəti" ilə bağlı olduğuna əmin idi. Hesabatlarında "uğurlu hallar" dərc edirdi — uşaq doğurma qabiliyyətindən məhrum edildikdən sonra "daha sakit və itaətkar olan" qadınlar.

Bak öz xəstəxanasının müxtəlif hesablamalara görə iki yüzdən beş yüzə qədər qadın xəstəsini əməliyyat etmişdi. Onların bir çoxu hüquqi olaraq imtina edə bilmirdi — məcburi psixiatrik hospitalizasiyada idilər.

Digərləri isə, həmin dövrdə yaşayıb-yaradanlar, nə uşaqlıq, nə də yumurtalıqlarla maraqlanırdılar — klitorla.

Ayzek Beyker Braun (Isaac Baker Brown, 1811–1873), ingilis ginekoloqu, 1860-cı illərdə Londonda klitoridektomiya — klitorun cərrahi yolla çıxarılması — əməliyyatını epilepsiya, isteriya, katalepsiya, həmçinin — bu ayrı bir rüsvayçılıq səhifəsidir — qadınlarda "masturbasiya"nın "müalicəsi" kimi tətbiq edirdi. Beyker Braun qadın masturbasiyasının "qadın cinsinə xas bütün sinir və psixi xəstəliklərin" kökü olduğuna və onun cərrahi yolla aradan qaldırılmasının xəstəni xəstəlikdən xilas etdiyinə əmin idi.

Əməliyyat sadə idi: xloroform altında, skalpellə, əməliyyatdan sonrakı dövrdə adi ağrıkəsicidən istifadə etmədən. Beyker Braun "heyrətamiz nəticələr" haqqında yazırdı: onun pasiyentləri "mülayimləşirdilər", "ərlərinə itaətə qayıdırdılar", "qeyri-təbii oyanıqlıq göstərməyi dayandırırdılar".

1867-ci il. London Mamalıq Cəmiyyəti. Beyker Braun — adı illərlə dillərdən düşməyən cərrah. Qalmaqal qalmaqalın ardınca. Və nəhayət — xaric edilmə. Siyahıdan silindi. Qapıdan qovuldu. Nə üçün? O, qadınları şikəst edirdi. Kəsirdi. Eyibə salırdı. Elə deyilmi? Xeyr. Protokolları diqqətlə oxuyun. İfadələrin mahiyyətinə varın. Əsl pozuntu tamam başqa müstəvidə idi. O, tam həcmli məlumatlı razılıq almırdı — onların ərlərindən. O, həmişə patriarxatdan icazə istəmirdi. Əsl problem burada gizlənirdi. Əməliyyatın özü? Tibb ictimaiyyətinin tənqidçiləri ona şər kimi baxmırdılar. Mübahisəli — bəli. Amma potensial faydalı təcrübə. Qadın bədəni — sadəcə material. Kişi sözü — dəyişməz qanun.

/Qlitoridektomiya tibbi göstərişlər əsasında Qərbi Avropa və ABŞ-da "müalicəvi prosedur" kimi istifadə olunmağa hələ yarım əsr davam etdi — ən azı 1930-cu illərə qədər.

Bunun yalnız okeanin o tayında — Yeni və ya Köhnə Dünyada baş verdiyi illüziyası ilə özünüzü rahatlamayın. Eyni təcrübələr Rusiya torpağında da kök saldı, erkən sovet dövrünə qədər uzandı. XX əsrin əvvəlləri. Vətən psixiatriya jurnallarının səhifələrində qorxunc bir sətir qaralır: "qadınlarda epilep-

toid və isterik halların müalicəsi üsulu kimi ovariotomiya". Diqqətlə oxuyun. Ovariotomiya. Yumurtalıqların çıxarılması. Müalicə? Yoxsa itaətsiz qadın təbiətinə qarşı cərrahi cəza? Skalpel canlı ətlərə soxulur ki, tutmalar yatırılsın. Və bunlar yeraltı təcrübələr deyildi. Bu cür əməliyyatlar Moskva və Sankt-Peterburqun bir neçə ən böyük klinikasının masalarında açıq şəkildə həyata keçirilirdi. Bəli, miqyas başqa idi — ABŞ və ya Kanadadakından az. Amma rəqəmlər sizi aldatmasın. Prinsip eyni idi. Bədən — günahdır. Cərrahiyyə — hökmdür.

Və — bu, mühüm məqamdır — bütün bu təcrübələri özü öyrənənlər, şarlatanlar, cəmiyyətdən qopmuş adamlar həyata keçirmirdi. Bunlar hörmətli professorlar idi. Akademiyaların üzvləri. Kafedra müdirləri. Dövrünün bütün tibb sahəsinin nüfuz sahibi saydığı adamlar.

Yenə və yenə qayıdan bir sual: reallıqla əlaqəni itirmiş kim idi — ona "isteriya" diaqnozu qoyulan xəstə, yoxsa onun göz yaşlarına və təşvişinə cavab olaraq sağlam yumurtalıqlarını çıxarıb bunu tibb hesab edən cərrah?

İsteriya rəsmi diaqnoz kimi uzun və əzabverici bir sona məruz qaldı.

Amerika Psixiatriya Assosiasiyasının Diaqnostik və Statistik Təlimatı DSM-I (1952) artıq isteriyanı ehtiva etmirdi. Lakin 1968-ci ildə o, yenidən DSM-II-də peyda oldu — "isterik nevroz" adı altında. Və yalnız 1980-ci ildə, DSM-III-ün üçüncü nəşrində bu termin rəsmi psixiatrik nomenklaturadan qəti şəkildə çıxarıldı.

1980-ci il. Hələ mən sağ ikən. O vaxt həmkarlarımın çoxu artıq işləyirdi.

Şarko Salpetriyer xəstəxanasının səhnəsindən "isterik tutmaları" nümayiş etdirdiyi vaxtdan dünyanın aparıcı psixiatrik təsnifatının belə bir diaqnozun artıq mövcud olmadığını qəbul etməsinə qədər təxminən yüz il keçdi. Bütöv bir əsr psixiatrik

təcrübə — qadınların əslində olmayan bir xəstəlikdən müalicə edildiyi bir əsr.

"İsteriya" sözünün arxasında nə gizlənirdi? Diaqnoz deyil. Etiket. XIX əsr həkimlərinin qadınlara vurduğu damğa. Və bu damğanın arxasında — bütöv bir əzab kainatı. Bu gün bu kainatın adları var. Panik ataklar. Konversiya pozğunluqları. Somatoform pozğunluqlar. Psixotik epizodlar. Doğuşdan sonrakı depressiyalar. Travma sonrası stres pozğunluğu. Xüsusilə — cinsi və fiziki zorakılıqdan sonra. XIX əsr qadınlarının həyatında isə zorakılıq bol idi. Temporal pay epilepsiyası. Autoimmün nevroloji xəstəliklər. Və — etiraf etmək istədiyimizdən daha tez-tez — sadəcə həyatın dözülməz şərtlərinə təbii emosional reaksiya. Budur onlar, bu şərtlər. Nə hüquqi hüquqlar. Nə iqtisadi müstəqillik. Nə öz bədənini idarə etmək imkanı. Heç nə. Yalnız etiket. Və onun arxasında əzab kainatı.

XIX əsr qadını huşunu itirəndə, hönkürə-hönkürə ağlayanda, qışqıranda, boğulma və sinəsində yanma hiss edəndə — bu heç də həmişə "isteriya" deyildi. Bu, çox vaxt onun həyatına verilən reaksiya idi. Elə bir reaksiya ki, o dövrün tibbi onu qeyri-normal şəraitə verilən normal insan reaksiyası kimi qəbul etməyi bacarmırdı. Elə bir reaksiya ki, onu dinləmək əvəzinə əməliyyat otağına göndərirdilər.

İndi elə bir sual verim ki, o olmasa bu fəsil yarımçıq qalardı.

Dərsimizi öyrəndikmi?

Görünür, belədir. Artıq qadınların yumurtalıqlarını təşviş zamanı əməliyyat etmirik. "İsteriya" zamanı kliptoru çıxarmırıq. Paris auditoriyalarında xəstələri "ehtiras pozalarında" sərgiləmirik.

Amma tibbdə ayrı-seçkiliyin ritmləri istənilən qədər tez yox olmur. Çoxsaylı müasir tədqiqatlar heyrətamiz bir mənzərəni üzə çıxarır: qadın həkimə kişi ilə eyni simptomlarla gəlir. Nə alır? Daha az diqqət. Gec diaqnoz. Və — psixoloji şərh. Real diaqnostika əvəzinə ona hökm oxunur: "Bu sizdə əsəb üstün-

dən baş verir." Miyokard infarktı. Qadınlarda bu, kişilərə nisbətən orta hesabla daha gec diaqnoz edilir. Niyə? Səbəblərdən biri qaranlıq istehzanın içində gizlənib: qadın simptomları çox vaxt "narahatlıq" və ya "panik ataka" kimi qələmə verilir. Ürək bəla harayı çalır, həkim isə yalnız isterika görür. Xronik ağrı? Qadına tibbi səbəb axtarmaq əvəzinə, daha tez psixiatrik damğa vurulur. Amma qəddarlığın mütləq rekordu — endometrioz. Orta hesabla yeddi-on il. Bu qədər il qadın tükəndirici ağrı ilə yaşayır ki, düzgün diaqnoz eşitsin. Yeddi. On. İl. Və bütün bunlar ona görə ki, ağrı şikayətləri illərlə sadəcə görməzliyə vurulur.

Qədim "gəzən uşaqlıq" fikri — qadın əzablarının birtəhər qadın bədəninin dərinliklərindən qaynaqlandığı və əslində əqli kaprislərdən başqa bir şey olmadığı fikri — hələ də yaşayır. Bu fikir sadəcə ginekologiyadan daha incə mədəni qərəz formalarına keçib.

Və bir başqa məqam da var ki, onu qeyd etməzdən keçmək olmaz.

Müasir qadın. Məyus. Ümidsiz. Real tibb cavab vermədi. Ağrı qaldı. Və o zaman o, "dizaynçı" və ya "reqressoloq"un qapısını döyür. Tələyə düşür. Elə həmin tələyə. Ona yenidən deyirlər ki, əzabları onun "qadın təbiətindən" gəlir. "Nəsil travmasından". "Bibisinin abortlarından". "Karmik günahdan". Onun öz ağrısına görə günah yenidən onun boynuna yıxılır. Ona diaqnoz əvəzinə yenidən ayin təklif olunur.

"Avara bətndən" "avara karmaya" — iki min yarım əsr. Biz isə hələ də yoldayıq.

İki minli illərin əvvəllərində Bakı Psixonevroloji Xəstəxanasında xronik psixozlar şöbəsində qadınlara baxanda bir fikir məni bir an da olsun tərk etmirdi: onlardan neçəsi bura həqiqətən şizofreniyadan əziyyət çəkdiyi üçün deyil, ailəsinin və ya ərlərinin onların xasiyyəti, depressiyası və ya roluna uyğunlaşmaq istəməməsi ilə bacara bilmədiyi üçün düşmüşdü?

Budur, nəfəsi kəsən sual. Sovet psixiatriyasında — və post-sovet psixiatriyasında da — bir fenomen yaşayıb, bu gün də yaşayır. Onun hətta adı da var — "məişət psixiatriyası". Bu quru terminin arxasında əsası klinika deyil, münaqişə olan hospitalizasiyalar gizlənir. Qadının öz ailəsi ilə münaqişəsi. Baxın, nə qədər sadədir. Qadın — inadkardır. Bir. Qadın — "sözə baxmır". İki. Qadın — gecələr ağlayır. Üç. Qadın — yemək bişirmək istəmir. Dörd. Dörd maddə. Heç biri psixiatriya dərsliyindən deyil. Dördü də ailə qalmaqalından. Onu gətirirlər. Ona diaqnoz qoyurlar. Onu müalicə edirlər.

Bu təcrübə heç vaxt XIX əsr Amerika ovariektomiyaları qədər geniş yayılmamışdı. Amma burada da eyni məntiq işləyirdi: əgər qadın öz sosial rolunu yerinə yetirmirsə, deməli onunla nəsə düz deyil. Və "səhvi" düzəltmək üçün tibb köməyə çağırılırdı.

Bu hekayə bitmiş bir hekayə deyil. Bu, XXI əsr həkimləri olaraq bizim üçün hələ də uzun müddət səhifə-səhifə bağlamalı olduğumuz bir hekayədir.

İntermezzo. Cinnət düsturu

Burada dayanmaq istəyirəm.

Üç fəsil keçdik. Qırğıcı aləti olan neolit cərrahı. Xaçla şeytan qovan. Sağlam yumurtalıqları kəsib çıxaran skalpelli ginekoloq. Üç dövr, üç qitə, üç lüğət. Görünür, üç ayrı hekayə.

Ancaq yəqin ki, artıq hiss etmisiniz: bu, bir hekayədir. Təkrarlanır. Öz xətti var.

Və irəli getməmişdən əvvəl, bu xətti adlandırmaq istəyirəm. Çünki bundan sonra — bu kitabın iyirmidən artıq fəsilində — siz onunla yenidən, yenidən qarşılaşacaqsınız. Universitet klinikalarında da, Bakı mənzillərində də. Nobel mühazirələrində də, Instagram efirlərində də. Və istəyirəm ki, onu siz özünüz tanıyasınız — mən barmaq uzatmağı bacırmamışdan əvvəl.

Mən bunu dəlilik formulu adlandırıram. Beş addımdan ibarətdir.

Birinci addım. Bir çimdik həqiqət. Əsasda demək olar ki, heç vaxt təmiz yalan olmur. Müşahidə olur — kiçik, həqiqi, bəzən hətta dəqiq. Epilepsiyalı xəstə qıcolmalar içində çırpınır və yad səslə danışır — bu doğrudur, tutmanın görkəmi belədir. Güclü qızdırmadan sonra sifilisli xəstə bəzən sakitləşir — bu da doğrudur, səbəbini hələ görəcəyik. Müşahidə — dürüstdür. Problem növbəti addımda başlayır.

İkinci addım. Həddindən artıq ümumiləşdirmə. Bir qədər həqiqətdən — bütün bir kainat nəticəsi. Çırt! Tələ bağlandı. “Kənardan səs”? Deməli, bədəndə — kənar ruh. “Qızdırma keçəndən sonra sakitləşdi”? Deməli, qızdırma dəliliyi müalicə edir. “Qadın əziyyət çəkir”? Deməli, onun qadın orqanı əziyyət çəkir. Yalnız bir nöqtədə doğru olan müşahidə hər şeyə şamil

edilir: bütün xəstəliklərə, bütün insanlara, bütün hallara. Bürün tükləri ürpəldəyir, miqyası anlayanda: kiçicik bir qığılcım bütün bir dogma kainatını alovlandırıb. Amma əsas dəhşət başqasındadır. Heç kim sual vermir. Bunu yoxladıqmı? Biz müdaxilə etməsək nə olardı? Neçə hadisəni sadəcə gözdən qaçırdıq, çünki onlar fərziyyəni təsdiq etmirdi? Səssizlik. Ölülər ifadə vermir.

Üçüncü addım. Metod. Fərziyyə — yoxlamadan keçmədən — dərhal praktika doğurur. Ruh içəridədirsə — çıxış deşirik. Bətn azıb-dolaşırsa — kəsib çıxarırıq. Qızdırma sağaldırsa — qızdırırıq. "Mənə elə gəlir"lə "Mən bunu insanlarla edirəm" arasında heç bir sədd dayanmır. Bu, həlledici addımdır. Məhz burada fərziyyə məsumluğunu itirir.

Dördüncü addım. Sənaye. Metod öz məktəbini, nüfuzunu, şagirdlərini və mənfəətini yaradır. Öz ustadları, öz sertifikatları, öz ixtisas dərəcələri, öz konfransları ya da öz tərəfdarları, öz kafedraları, öz şöbələri ortaya çıxır. Bu sertifikatlara adları həkk olunmuş insanlar kimlərdir? İnananlar, yoxsa qan iyini duyanlar? İndi metodun, bir zamanlar utancaq fərziyyənin heç vaxt malik olmadığı bir şeyi var: onun hesabına yaşayan, yaşamaq üçün metoda möhtac olan insanlar. Bu andan etibarən metodun işləməyə ehtiyacı qalmır. Artıq şəfa verməyə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə satılması kifayətdir.

5-ci mərhələ: Saxtalıq. Həmişə ən çox əziyyət çəkənlər ödəyir — xəstələr, onların ailələri... İstisna etmək imkanı olmayanlar və etmək imkanı olsa da, həddindən artıq inanmaq istəyənlər. Onların əzabları ya gözdən qaçır, ya "qaçılmaz qiymət" adlandırılır, ya da ən dəhşətlisi — metodun üstünlüyü kimi qeyd edilir: dözürsə, demək müalicə olunur.

Düsturun bir daxili xüsusiyyəti var ki, onu demək olar ki, ölümsüz edir: o, təkzibləri eşitmir. Əgər xəstəyə yaxşılaşdısa — metod işləyir. Yaxşılaşmayıbsa — deməli, xəstə "çətin", "müqavimət göstərir", "az inanıb" ya da "gec gətirilib". Düstur

elə qurulub ki, məğlub olması mümkün deyil. Nəticə nə olursa olsun, düsturu təsdiqləyir.

Bax, indi bu kitabın yazılmasına səbəb olan tərifi verə bilərəm.

Klinik mənada dəlilik xəstəlikdir: iradədən asılı olmayaraq insanı reallıqla əlaqəsini qıran pozğunluq. Məhz belə bir dəlilik bu kitabın başlanğıcına çevrilən otaq xəstəsində də var idi. Bu, seçilmir. Bu, satılmır. Bu, tibbin bacardığı dərəcədə müalicə olunur.

Amma dəlilik başqa cür də ola bilər — daha geniş və qapalı. Məhz bu kitab ondan bəhs edir. Danışdığımız şey reallığın sistemli, davamlı və düzəlməz şəkildə inkar edilməsidir; bu inkar həm onu daşıyanı, həm də ətrafındakıları yaralayır. Bir düşünün. Onun halüsinasiyaları yoxdur. Onun metodu var. O xəstəxana palatasında uzanmır. O xəstənin yatağı başında dayanır. Trepanda. Çarmıxla. Skalpellə. Sonra — şprislə. Buzbalta ilə. Terapiya fiqurkaları ilə. Və profil şərhində "ödənişlə" keçidi ilə.

Formulun beş addımı — bu dəliliyin anatomiyasıdır.

Diqqət yetirin, bu tərifdə nə yoxdur. Burada "səfehlik" sözü yoxdur — düsturla parlaq zehinli insanlar yoluxurdu və biz onlarla hələ rastlaşacağıq. Burada "şər" sözü yoxdur — düsturun daşıyıcılarının əksəriyyəti səmimidir; səmimilik isə səmimilikdən başqa heç nəyi sübut etmir. Və burada "keçmiş" sözü yoxdur.

İnsanlığın panacir (əleyhdərmanı) var? Var. Bu, cansıxıcı, yavaş və kürsüdən satıla bilməyən bir şeydir. Buna yoxlama deyilir. Öz fərziyyəni götürüb onu təkzib etməyə çalışmaq. Müalicə edilənləri müalicə edilməyənlərlə müqayisə etmək. Uğursuzluqları da eyni dəqiqliklə hesablamaq, nə qədər ki, uğurlar hesablanır. Məlumatları yad, xoşagəlməz gözlərə göstərmək. Məğlubiyyət baş verəndə onu qəbul edib metodu tərk etmək.

Elm dəlilik formulundan səhv etməməsi ilə fərqlənmir. Elm daim səhv edir — bu kitabın ikinci hissəsi tamamilə bundan bəhs edəcək və onu oxumaq ağır olacaq. Elm yalnız bir şeylə fərqlənir: onun düzəliş mexanizmi var. Formula isə əbədi səhv edir — çünki öz daxilində heç vaxt səhv etmir.

Bu kitabın quruluşu bir araşdırmaya bənzəyir. Hər fəsildə özünün "işi" olacaq: hər şeyin başlandığı müşahidə; onun şişirdildiyi yer; çevrildiyi metod; onun üzərində yüksələn sənaye; və xəstələrin ödədiyi hesab. Bəzən bu beş addımı birbaşa, ayrıca təhlil şəklində göstərəcəyəm. Çox vaxt isə siz onları məndən əvvəl özünüz görəcəksiniz.

İndi isə — ən əlverişsiz məqam.

İndiyə qədər bu formulu tibbi təhsili olmayan insanlar tətbiq edirdi: kahinlər, ekzorsistlər, loğmanlar. Onları dövrünün cəhaləti bəraət qazandırırdı. Növbəti hissədə formula ağ xalat geyinəcək. Diplom, kafedra, resenziyalı jurnal — və Nobel mükafatı alacaq. Və görəcəyik ki, diplom formulanı sağaltmır. Ondan qurtulmağın yeganə yolu var — yoxlama.

Baxmağa gedirik.

II HİSSƏ. DİPLOMLU DƏLİLİK

Fəsil 4. Kraepelin və Bleyler: söz necə yarandı

Heydelberq Universitetinin professoru Emil Kreplin (1856–1926) 1899-cu ildə Leypsiqdə nəşr olunmuş məşhur "Psixiatriya dərsliyi"nin altıncı nəşrində səssiz bir inqilab etdi. O anda heç kim onun miqyasını dərk etmirdi. Amma məhz bu kitabın səhifələrində ilk dəfə tam və sistemli şəkildə sonrakı yüz il psixiatriyanı müəyyən edən bir konsepsiya təqdim olundu.

Kreplin "dementia praecox" — "erkən əqli zəiflik" — adı altında sələflərinin ayrı-ayrı varlıqlar kimi təsvir etdiyi, guya fərqli olan üç xəstəliyi birləşdirdi. 1871-ci ildə Evald Hekkerin təsvir etdiyi hebefreniya — təfəkkür pozğunluğu olan gənc xəstələrdə müşahidə edilən qəribə, səfeh davranışdır. 1874-cü ildə Karl Lüdviq Kalbaumun ayırd etdiyi katatoniya — donub qalma, mutizm, mum elastikliyi və motor həyəcanlanma epizodları ilə xarakterizə olunan haldır. Paranoid forma isə — sanrı və hallüsinasiyalarla müşayiət olunan, şəxsiyyətin dərin dağılmasına gətirib çıxaran formadır.

Kraepelin bu üç sindroma baxdı və ondan əvvəl heç kimin vermədiyi sualı verdi: görəsən, bunlar müxtəlif cür təzahür edən tək bir xəstəlikdirmi? Əgər belədirsə, onları birləşdirən nədir?

Kreplinə görə onları birləşdirən xəstələrin taleyi idi. Hamısı — həm hebefreniklər, həm katatoniklər, həm də paranoyiklər — gənclikdə, çox vaxt on beşlə iyirmi beş yaş arasında xəstələnməyə başlayırdılar. Hamısı zamanla durmadan pisləşirdi. Hamısı sonda Kreplinin "əqli zəiflik" adlandırdığı vəziyyətə — iradənin dağılmasına, emosional yoxsulluğa, tənqid qabiliyyə-

tinin itirilməsinə gəlib çıxırdı. Bu, erkən əqli zəiflik idi — o dövrdə artıq məlum olan və qocalıqda beyin üzvi zədələnməsinin nəticəsi kimi meydana çıxan senil əqli zəifliyin əksinə.

Kraepelinin bir metodu vardı. O, buna klinik-katamnestik metod deyirdi. Sadədir? Bəli. Amma bir cəhd edin. Müşahidə etmək lazımdır. İllərlə. Onilliklərlə. Hər simptom — dəftərə. Xəstəliyin hər hərəkəti — qeydə. Dinamika. Addım-addım. Gün-gün. Sonra isə — final. On beş il. İyirmi. Xəstə öz son vəziyyətinə çatır. Kraepelin köhnə qeydləri açır. İlk səhifələri. İlk həftələri. İlk simptomları. Və bir sual verir. Xəstəliyin əvvəlində nə bu sonu əvvəlcədən görməyə imkan verirdi?

Bu yolla Kraepelin belə bir fikrə gəldi: bu müxtəlif klinik mənzərələr — bir proses, bir xəstəlik, bir qanuni nəticədir.

Və burada Kraepelin ikinci xətti çəkdi. Hər şeyi dəyişən xətti. Dementia praecox-un qarşısına — dağılma, geridönməzlik, sonluq — o, başqa bir endogen psixoz qrupunu qoydu. Adı: maniakal-depressiv psixoz. İşin açarı elə buradadır. Dementia praecox-da — qırılma. Şəxsiyyətin toxuması cırılır və onu yenidən tikmək artıq mümkün olmur. Son. Burada isə — hər şey əksinədir. Həyəcan və ya depressiya tutmaları. Ağır. Çox ağır. İnsan onların içində fırtınada tələf olan kimi çırpınır — və elə gəlir ki, bu, əbədidir. Amma sonrasında — remissiya. Çox vaxt demək olar ki, tam. Xəstə norma qayıdır. Özünə. Həyata. Növbəti epizoda qədər.

Bu gün psixiatriyanın bipolyar affektiv pozuntu adlandırdığı şey məhz həmin Kraepelin anlayışının varisidir.

Beləliklə, Kreplin XIX əsrin sonunda psixiatriyaya demək olar ki, bugünə qədər davam gətirən bir dikotomiya verdi: tədricən irəliləyən gedişatlı endogen psixoz (dementia praecox) — tutmalarla gedən və remissiyalarla müşayiət olunan endogen psixoz (maniakal-depressiv). Birincisi — pisləşməyə məhkumdur. İkincisi — yox.

Bu dixotomiya bir çox müasir psixiatr tərəfindən şübhə altına alınır — bunu növbəti fəsillərdə görəcəyik. Amma Kraepelin olmasaydı, müasir diaqnostika ümumiyyətlə mövcud olmazdı. Onun "Rəhbərliyi" bugün "elmi psixiatriya" adı altında bildiyimiz hər şeyin başlanğıc nöqtəsidir.

Lakin Kraepelin klinisist idi. Yalnız klinisist. O, diqqətlə təsvir edirdi. O, hərtərəfli təsnif edirdi. O, xəstənin daxilində tam olaraq nə baş verdiyini izah etməyə çalışmırdı.

Bu vəzifəni başqa biri öz üzərinə götürdü.

Sürix. Burghölzli klinikası. Əsrin dönəmində Avropanın ən məşhur psixiatrik müəssisələrindən biri. Burada Eygen Bleyler işləyirdi. 1857–1939. İsveçrəli. Psixiatr. Kreplinin tam əksi. Prussiyada doğulmuş Kreplin skalpel kimi soyuq idi. Sərt. Sistemli. Xəstələr onun üçün yalnız müşahidə obyekti idi. Klinik cədvəldə üzsüz vahidlər. O, onlara şüşə divarın arxasından baxırdı. Bleyler — iliyinə qədər isveçrəli — bu divarı uçurdu. Səmimi. Maraqlanan. Humanist. Onun üçün xəstələr əşya deyildi. Onlar başa düşülməli olan söhbət yoldaşları idi. O, onların qorxudan təhrif olunmuş şüuruna diqqətlə baxır və sanrı deyil, kömək çağırışı eşidirdi. İki temperament. İki yanaşma. Dəliliyə iki baxış. Hansı həqiqəti görürdü?

1911-ci ildə Bleyler psixiatriyanı dəyişən bir kitab nəşr etdi: "Dementia praecox, yaxud Şizofreniyalar qrupu" (Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien).

Adın özündə artıq bütöv bir proqram vardı. Bleyler Kreplinin konsepsiyasını inkar etmirdi. Onu qəbul edirdi, amma adını dəyişdirir və dərinləşdirirdi. Niyə şizofreniya? Söz qədim yunan köklərindən düzəldilmiş mürəkkəb söz idi: σχίζω — "parçalamaq", "yarıb ayırmaq" — və φρήν — "ruh", "ağıl". Hərfi mənada: parçalanmış ağıl.

Bleyler tam olaraq nə demək istəyirdi? Heç də biliyi olmayanların adətən düşündüyü kimi deyil. "Şizofreniya" — "şəxsiyyətin ikiyə bölünməsi" deyil. Bir bədən qəfəsində qapa-

dılmış iki şəxsiyyət deyil. Bleyler daha incə və daha qorxunc bir şeyi nəzərdə tuturdu. Bir insanın daxilində psixi funksiyalar arasında parçalanma. Hisslər — bir şey. Fikirlər — başqa. İradə — üçüncü. Davranış — dördüncü. Sağlam ağılda bu funksiyalar vahid bir sinir düyünündə hörülür, ahəngdar və uzlaşmış şəkildə döyünür. Şizofreniyalı xəstədə isə bu düyün qırılır. Funksiyalar ayrı-ayrılıqda işləyir. Hər biri — öz marşrutu ilə. Hər biri — öz amansız məntiqi ilə.

Buradandır qəribə reaksiyalar. Buradandır davranışdakı təəccüblü paradokslar. Buradandır sonralar affekt dissosiasiyası adlandırılacaq hal: pasiyent yaxın adamının ölümünü təbəssümlə təsvir edir, ya da dəhşətli hallüsinasiyalardan danışarkən gülür. Anlamadığı üçün deyil. Emosional reaksiyası fikrin məzmunundan qopduğu üçün.

Bleylerin əsas töhfəsi onun məşhur "dörd A"-sıdır — şizofreniyanın dörd ilkin, əsas simptomu. Alman dilində onların hamısı "A" hərfi ilə başlayırdı:

Assosiasiyalar — assosiativ təfəkkürün pozulması. Xəstənin fikirləri sürüşür, əlaqəni itirir, atlanır. Məntiq qırılır. Psixopatologiyada buna "təfəkkürün formal pozulması" deyilir.

Affekt — emosionallığın pozulması. Emosiyalar ya düzləşmiş, ya məzmununa uyğunsuz, ya da daxilən ziddiyyətli olur.

AMBİVALENTLİK — eyni obyektə qarşı zidd hisslərin, düşüncələrin və istəklərin bir arada yaşamasıdır. Xəstə eyni anda anasını həm sevir, həm də nifrət edir. Həm istəyir, həm də qorxur. Həm təsdiq edir, həm də inkar. Bu tərəddüd deyil; bu eyni zamanda mövcud olmaqdır.

Autizm — öz daxili aləminə çəkilmə. Lakin ehtiyatlı olmaq lazımdır: "autizm" terminini Bleyler məhz burada dövriyyəyə buraxmışdı və yalnız sonralar, 1943-cü ildə Leo Kanner bu sözü uşaqlarda tamam başqa bir pozuntuya — bu gün "autizm" adlandırdığımız hala tətbiq etdi. Bleyler başqa bir şeyi nəzərdə

tuturdu — reallıqdan qapanma, öz fantaziya və düşüncələrinə bağlanıb qalma.

Bu dörd ilkin simptomla yanaşı, Bleyler ikincili, yaxud köməkçi simptomları da təsvir etmişdi — hallüsinasiyalar, sayıqlama, katatonik simptomlar və başqaları. Vacib bir detal: Bleyler hallüsinasiya və sayıqlamanı şizofreniyanın ən əsas əlamətləri saymırdı. Onun üçün ən əsas olan psixi funksiyaların özlərinin parçalanması idi. Sayıqlama və hallüsinasiyalar başqa xəstəliklərdə də rast gəlinə bilər. Parçalanma isə — yalnız bu xəstəlikdə.

Bu gün Bleylerin spesifik nəzəri quruluşlarının böyük hissəsi müasir psixiatriyada təmiz şəkildə istifadə olunmur. "Dörd A" konsepsiyası pedaqoji və tarixi bir abidə kimi qalmışdır — psixiatriya tələbələri onu öyrənirlər, lakin şizofreniyanın müasir diaqnostikası DSM-5 və ICD-11-də təsvir edilmiş başqa, daha ciddi meyarlara əsaslanır.

Lakin Bleylerin filosofi töhfəsi böyük əhəmiyyət daşıyır. O, psixiatriyaya Kraepelində olmayan bir şey gətirdi: xəstənin daxili dünyasını və yaşadıqlarının məntiqini anlamağa çalışmaq. Kraepelin müşahidə edir və təsnif edirdi. Bleyler isə dinləyir və bu daxili kodları deşifrə etməyə çalışırdı.

Və burada tez-tez gözdən qaçırılan mühüm bir məqam var. Bleyler Ziqmund Freydin ideyalarını ciddi qəbul edən və onları psikozlara tətbiq edən ilk böyük psixiatr idi. Onun Burghölzli klinikasında hələ Freydlə küsməmiş Karl Qustav Yunq çalışırdı. Onlar birlikdə assosiativ testləri müzakirə edir və şizofreniyalı xəstənin daxili aləmində tam olaraq nə baş verdiyini anlamağa çalışırdılar.

Freyd özü 1914-cü ildə psixoanalizin tarixinə baxanda yazırdı:

"Bleyler göstərdi ki, bir sıra sırf psixiatrik halları psixoanalizin yuxuları və nevrozu anlamaq üçün təsvir etdiyi proseslərin müdaxiləsi ilə izah etmək olar. Yunq analitik şərh meto-

dunu ən qəribə və anlaşılmaz hadisələrə uğurla tətbiq edərək nümayiş etdirdi ki, bu cür hadisələr xəstələrin həyatından və qorxularından qaynaqlanır. Bu andan etibarən psixiatrlar üçün psixoanalizi görməməzliyə vurmaq mümkünsüz oldu. Bleylerin şizofreniya haqqında böyük əsəri (1911), burada psixoanalitik və klinik-sistematik aspektlər bərabər səviyyədə nəzərdən keçirilir, nəhayət ona uğur gətirdi."

Bleyler — İsveçrəli kliniki psixiatr — Kraepelinlə Freyd arasında körpü rolunu oynadı. Klassik təsviri psixiatriya ilə dərin psixologiya arasında, görmə cəhdi ilə başa düşmə cəhdi arasında əlaqə yaradıb.

Amma elə bu yerdə kitabım üçün vacib olan bir qeyd etmək istəyirəm. Bu qeyd Bleylerin özünə deyil, onun barəsində bu gün bəzən necə danışıldığına aiddir.

Psixiatriya tarixinin populyar təqdimatlarında, o cümlədən bəzi internet mənbələrində Bleylerin guya hansısa "şizofreniyanın biokimyəvi nəzəriyyəsi" olduğu, xəstələrin beynindən və ya qanından "toksik maddələr", "tiroksin" və ya buna bənzər nə isə ayırdığı, guya şöhrət naminə bu nəzəriyyənin uğursuzluğunu gizlətdiyi barədə iddialara rast gəlmək olar. Bu iddialar gəzir, lakin heç biri tarixi mənbələrlə təsdiqlənmir. Nə Bleylerin öz əsərlərində, nə də psixiatrların yazdığı elmi bioqrafiyalarda belə faktlar yoxdur.

Bleyler ciddi bir klinik fenomenoloq idi. Gördüklərini təsvir edirdi və biokimyəvi izahlara iddialı çıxışlar etmirdi, çünki XX əsrin əvvəllərində biokimyanın imkanları belə bir şeyə icazə vermirdi. Nəzəri fərziyyələri bioloji istiqamətli müasirlərinə həvalə etdi. Özü isə xəstələrin yaşadıqlarını anlamaqla məşğul idi.

Bunu açıq demək niyə vacibdir? Çünki psixiatriyada miflərin təhlilinə həsr olunmuş kitabımızda biz də eyni günaha batmaq istəmirik. XX əsr psixiatrik təcrübəsini tənqid etmək olar və lazımdır. Lakin tənqid sənədlərə əsaslanmalıdır. "Bley-

lerin biokimyəvi cinayətləri"ni uydurmaq — "Hellingerin düzülüşlərinə" inanmaq qədər yalandır. Hər ikisi — fakt yerinə fantaziyadır.

Beləliklə, XX əsrin əvvəllərində psixiatriya Kraepelin və Bleylerdən bir söz və konsepsiya hədiyyəsi aldı. Şizofreniya təsadüfi əlamətlər toplusu olmaqdan çıxdı və kliniki vahidə çevrildi. Bu vahidlə isə növbəti nəsillər işləməli idi.

Və əsl faciə məhz burada başladı.

Çünki konsepsiya var idi, müalicə isə yox idi.

Psixiatriya belə yaşadı — diaqnoz var, cavab yox. Söz var idi. O, hökm mənasını verirdi. Vasitə isə — yox idi. Və bu geniş boşluğa — deşilmiş gövdəyə su kimi — nəzəriyyələr axışdı. Birbirinin ardınca. Hipotezlər. "Metodlar". Hər yeni onillik özünü irəliləyiş elan etdi. Hər biri — arxasında bir qəbiristanlıq qoyub getdi. Malyariya. Xəstəyə malyariya plazmodisi yeridilirdi. Məqsəd — dəhşət dərəcədə sadə: qızdırma psixozu yandırıb külə döndərsin. Bəzən yandırırdı. Onunla birlikdə. İnsanla birlikdə. İnsulin komaları. Xəstə dərin hipoqlikemiyaya salınırdı — artıq geri dönüşü olmayan həmin həddə. Həddə. Sonra isə — geri çıxarılırdı. Bəzən — çıxarmırdılar. Bəzən — vaxtında çatdırmırdılar. Sülfozin. Lobotomiya. Elektroşok. Siyahı uzanırdı. Qurbanlar siyahısı da. Və yalnız XX əsrin ortalarında ilk neyroleptiklər meydana çıxdı. Milyonlarla insana həqiqətən kömək edənlər. Hərçənd özləri də problemlərin özünəməxsus mürəkkəb fəslini açdılar.

Lakin bu ana qədər — 1899-cu ildə Kraepelindən 1952-ci ildə xlorpromazinə qədər — psixiatriya yolu kor-koranə axtaracaq. Və onu dərhal tapmayacaq. Və axtarışın əvəzini insan taleləri ilə nəhəng bir qiymətlə ödəyəcək.

Bəzi bu axtarışlar barədə — və onların bədəli barədə — növbəti fəsillərdə söhbət açılır.

Fəsil 5. Odla müalicə: malyariyadan sülfozinə qədər

Bakıda, iki minlik ilin əvvəlində, şəhərin ən böyük psixiatriya stasionarı olan İkinci Klinik Xəstəxanada internaturaya başladım. İyirmi dörd yaşım vardı. Həvəslə dolu idim və özümü bu peşədə görülən hər şeyi öyrənməli olan gələcək həkim kimi görürdüm. Məni kişilər üçün xroniki psixozlar şöbəsinə təyin etdilər. Orada yüz iyirmi çarpayı vardı. Xəstələr burada illərlə, bəziləri isə onilliklərlə uzanmışdılar.

İlk həftələrdə sülfozinoterapiyanın necə tətbiq olunduğunu gördüm.

Sülfozin. Şaftalı yağında təmizlənmiş kükürdün yağlı süspansiyası. Onu qızdırırlar — dəqiq bədən temperaturuna qədər. Yuxarı yox. Və yavaş-yavaş, millimetr-millimetr, dərin əzələdaxilinə yeridirlər. Dərinin altına. Əzələyə. Dərinliyə. Nə üçün? Cavab elə metodun özündə gizlənib. O, sovet psixiatriyasına 1920-ci illərdə gəlib. Adı — piroterapiya. Odla müalicə. Süni qızdırma vasitəsilə müalicə. Məntiq — qüsursuz. Demək olar ki, əlkimyəvi. Xəstənin bədən temperaturunu qaldır. 39-a qədər. 40 dərəcəyə qədər. Və onda — hərarət. Hərarət mərkəzi sinir sistemini silkələyəcək. Elə silkələyəcək ki, psixoz geri çəkilsin. Qanda qaynayan isti su. Xilas. Remissiya. Belədirmi? Yoxsa süni od şüurdan insana aid nəyisə yandırıb-yaxırdı?

Bunu öz gözlərimlə görürdüm. İki sağrı nahiyəsi. Bəzən — üstəlik hər iki kürək. İnsan bədənində dörd nöqtə. Onları öz adı olan bir fiqurda birləşdirirdilər — “sülfozin xaçı”. Ad demək olar ki, ritual səslənirdi. Əslində, elə də idi. Bir neçə saat sonra ağrı gəlirdi. Dərhal yox — gecikməylə, artıq bildiyin,

amma hələ də keçəcəyinə ümid etdiyin hökm kimi. Keçmirdi. Ağrı günlərlə davam edirdi. Temperatur qalxırdı, bədən içdən yanırdı. İnsan qalxa bilmirdi. Hər hansı hərəkət — dönmək, nəfəs almaq, qalxmağa cəhd etmək — iynə yerlərində kəskin bir parıltı ilə səslənirdi. Dərinin altında isə öz işi gedirdi. İri əzələlərdə infiltratlar çökürdü. Təkrar yeridilmələrlə nekroz zonaları yaranırdı. Ölü toxuma. Canlı insanın içində. Və buna müalicə deyilirdi.

Xəstələr bu prosedura birmənalı yanaşırdılar. Ona nifrət edirdilər. Ondan qorxurdular. Onu müalicə yox, cəza kimi qəbul edirdilər. Və tibbi baxımdan onlar bəzi həmkarlarımdan daha çox həqiqətə yaxın idilər.

Çünki iki minlik ildə — mən durub buna baxanda — bütün dünya elmi ədəbiyyatında artıq onilliklər boyu şizofreniyada sülfozinin effektivliyini təsdiqləyən heç bir randomizə edilmiş nəzarətli tədqiqat mövcud deyildi. Heç biri. Metod klinik ətalətə, sovet dövrünün dərsliklərinə və "belə qəbul olunub", "belə işləyir", "nəticəni görürük" kimi sözlərə dayanırdı.

Mən gənc həkim idim. Bütün bunlara baxır və anlayırdım: bu, tibb deyil. Bu, başqa bir şeydir. Bu, keçən əsrin məntiqini təkrar-təkrar canlandıran bir ritualdır. Bu, psixiatriyanın heç bir alternativi olmadığı dövrdən bizə gəlib çıxmış və rəsmi olaraq heç kim tərəfindən ləğv edilmədiyi üçün divarlarımızın arasında ilişib qalmış bir təcrübədir.

Lakin onu tətbiq etməyə davam edirdilər.

Bunun necə baş verdiyini anlamaq üçün XIX əsrin sonu — XX əsrin əvvəllərinə qayıtmaq lazımdır. Elə bir dövrə ki, "şizofreniya" sözü tibb lüğətlərində təzəcə görünməyə başlamışdı, bu xəstəlik haqqında artıq kifayət qədər çox şey bilirdilər, amma onu nə ilə müalicə etmək lazım olduğunu heç bilmirdilər.

O dövrün psixiatrik klinikalarındakı mənzərə qaranlıq idi. Xəstələr onilliklərlə uzanırdılar. Onilliklərlə! Onlar deqradasi-

yaya uğrayırdılar. Onlar ölürdülər. İnterkurrent infeksiyalardan. İntiharlardan. Fiziki tükənmədən. Həkim yanında dururdu. Hərfi mənada yanında. Və praktiki olaraq yalnız bir şey edə bilirdi: təcrid etmək, saxlamaq, müşahidə etmək. Heç bir effektiv dərman yox idi. Psixozlar üçün heç bir psixoterapiya yox idi. Yalnız sedasiya üçün barbituratlar. Və uzun dəhlizlər. Əzab çəkənlərlə dolu dəhlizlər.

1917-ci ildə Vyana Universitetinin psixiatriya professoru Julius Wagner-Jauregg proqressiv paralicin (gec neyrosifilisin) malyariya yoluxdurmaqla müalicəsi haqqında əsərini çap etdirdikdə, bu, tibb aləmində partlamış bomba təəssüratı yaratdı.

Wagner-Jauregg həqiqətən də gözəl iş görmüşdü. XX əsrin əvvəllərində progresiv iflic — qeyri-müalicəli və ölümcül sayılan nevrosifilisin bir növü — insanın beynini təsir edirdi. Bu, psixi xəstəliklərin ən dəhşətli formalarından biri idi: xəstə bir neçə il ərzində ağrılı şəkildə məhv olub ölürdü. Wagner-Jauregg bu cür xəstələri qəsdən qızdırmayla xəstələndirirdi. Qızdırma tutması zamanı yüksələn temperatur sinir toxumasında sifilisin törədicisi olan solğun treponemi məhv edirdi. Bir çox xəstə əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşma əldə edirdi. Bəziləri isə tamamilə sağalırdı.

1927-ci ildə Wagner-Jauregg tibb üzrə Nobel mükafatına layiq görüldü — bu, psixiatrik müalicə metoduna görə verilən ilk Nobel mükafatı idi. İkincisi — və eyni zamanda sonuncusu — isə lobotomiya üçün veriləcək, bu barədə daha sonra danışacağıq.

Və elə o vaxtdan psixiatriyada belə bir fikir kök saldı: əgər qızdırma neyrosifilisə kömək etdisə, bəlkə digər psixozlarda da kömək edər?

Məntiq yanlış idi. Tamamilə. Ümidsizcəsinə. Proqressiv iflic — infeksiyadır. Onun törədicisi var. Canlı, konkret, toxunula bilən. Bu törədicı temperatur qalxdıqda məhv olur. Hər

şey uyğun gəlir. Hər şey işləyir. Şizofreniya — infeksiya deyil. Bu endogen pozuntudur. XX əsrin əvvəlində onun təbiəti haqqında heç nə bilmirdilər. Bu gün yalnız qismən bilirlər. Törədicisi yoxdur. Mövcud deyil. Heç vaxt olmayıb. Amma fikir artıq doğulmuşdu. Psixiatriyanın universal metodu kimi "piroterapiya" fikri. O, ağıllara ölüm tutuşu ilə yapışmışdı. Niyə? Çünki elmi görünürdü. Çünki arxasında Nobel mükafatının kölgəsi ucalırdı. Çünki Nobel laureatı ilə mübahisə etməyə kim cəsarət edər? Onu hər yerə sürüklədilər. Hər klinikaya. Hər palataya. İşləyə bilmədiyi yerə. Müalicə edəcək bir şeyi olmayan yerə. Yanlış müddəa. Qüsursuz reputasiya. Və bədənlərini artıq heç bir səbəb olmadan qızdırma sındıran xəstələr.

1920-ci illərdə danimarkalı psixiatr Knud Şröder süni qızdırma yaratmaq üçün malyariyadan daha sadə və nəzarət edilə bilən bir vasitədən — yağ süspensiyasında steril kükürd inyeksiyalarından istifadə etməyi təklif etdi. Dərman sülfozin adını aldı. Malyariyadan fərqli olaraq, onu xəstənin orqanizmində "becərmək" lazım deyildi; temperaturun 40 dərəcəyə qalxmasına səbəb olmaq üçün bir inyeksiya kifayət edirdi və bu vəziyyət iki-üç gün davam edirdi.

Metod tezliklə Sovet İttifaqına keçdi. 1930-cu illərdə sülfozin sovet psixiatrik xəstəxanalarında geniş və müntəzəm şəkildə tətbiq olunmağa başladı — əvvəlcə şizofreniya və maniakal vəziyyətlərdə piroterapiya vasitəsi kimi, sonralar isə getdikcə daha çox "terapevtik rezistentliyi aşmaq" vasitəsi kimi, yəni digər metodların kömək etmədiyi hallarda istifadə edilirdi.

XX əsrin ortalarında sülfozin daha bir vəzifə qazandı ki, bu barədə susmaq olmaz. O, cəza psixiatriyasının alətinə çevrildi.

Bu tarixi məqamı çoxlarının qələmə aldığına şahidik. Sovet dissidentləri Leonid Plyuş, Vladimir Bukovski, Pyotr Qriqorenko və Viktor Nekipelov — hamısı siyasi baxışları ucbatından psixiatriya xəstəxanalarında saxlanıldıqları dövrlərdən

bəhs edir. Öz xatirələrində onlar xüsusilə "sülfozin" adlanan üsula toxunurlar.

Vladimir Bukovski bunu belə təsvir edirdi: şöbədəki sanitarkalar sülfozini intizam aləti hesab edirdilər. Hər hansı "itaətsizlik" — yeməkdən imtina, etiraz cəhdi və ya sadəcə kəskin bir söz — inyeksiya ilə nəticələnə bilərdi. İnyeksiyanın ağrısı o qədər güclü idi ki, xəstə bir neçə gün fiziki olaraq hərəkət edə bilmirdi. Bu, itaətə ehtiyacı olan bir müəssisə üçün mükəmməl idi.

Leonid Plyuşç, riyaziyyatçı və dissident, xatirələrində yazırdı: "Mənə üç kub sülfozin vurdular. Ağrıdan huşumu itirdim. Sülfozin insanın iradəsini qırmaq, onu qorxuya düşmüş heyvana çevirmək lazım gələndə təsirli olurdu".

1984-cü ildə bu ifadələr Vaşinqtonda Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Komissiyasının (CSCE) dinləmələrində təqdim edildi. Amerika psixiatrları sovet sülfozin təcrübəsini araşdıraraq belə nəticəyə gəldilər: metod terapevtik məqsədlərdən çox cəzalandırıcı məqsədlərlə istifadə olunurdu. Onlar inyeksiyaların səciyyəvi nəticələrini qeyd edirdilər: "güclü ağrı, hərəkətsizlik, yüksək temperatur, əzələ nekrozu".

1983-cü ildə Ümumittifaq Psixiatrlar Cəmiyyəti Ümumdünya Psixiatriya Assosiasiyasından çıxmaq məcburiyyətində qaldı — dünya ictimaiyyətinin sərt tənqidindən sonra qaçılmaz olan xaric edilməni gözləmədən. Formal səbəb psixiatriyadan siyasi məqsədlərlə sui-istifadə idi. Əslində isə — sülfozinin əsas rol oynadığı nəsillər boyu davam edən repressiyalara görə.

1989-cu ildə, yenidənqurma dövründə SSRİ-də sülfozinin tətbiqi rəsmi şəkildə məhdudlaşdırıldı. Sovet Rusiyasında bu üsul tövsiyə olunan metodlar siyahısından rəsmi olaraq çıxarıldı.

Amma 2000-ci ildə Bakıda özüm gördüyüm kimi, əslində o, hələ də tətbiq olunurdu.

Burada səmimi olmaq lazımdır — bu, mövzunun ən həssas tərəflərindən biridir.

2017-ci ildə Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture akademik jurnalında israilli psixiatr Roman Bekker və rusiyalı psixiatr Yuri Bıkovun "Sülfozin — SSRİ psixiatriya məktəbinin məhsulu: terapevtik agent, yoxsa cəzalandırıcı psixiatriya vasitəsi?" adlı məqaləsi dərc olundu. Müəlliflər ətraflı tarixi və ədəbi icmal aparmışdılar. Onların mövqeyi belədir: sülfozin qaranlıq reputasiyasına baxmayaraq, təkcə cəzalandırıcı alət deyil, həm də müəyyən, dar klinik vəziyyətlərdə terapevtik rezistentliyi aşmağın mümkün metodudur. Onlar postsovet ölkələrində sülfozinoterapiyanın bu günə qədər tətbiq olunmağa davam etdiyini, üstəlik, onların iddiasına görə, bəzən müsbət nəticə verdiyini göstərən məlumatlar təqdim edirlər.

Onların işi resenziyalı jurnalda dərc olunmuş elmi məqalədir. Onu "təbliğat" kimi kənara atmaq olmaz. Amma tənqidsiz qəbul etmək də düzgün deyil. Və elə burada ilk çat yaranır. Müəlliflər özləri etiraf edirlər: sülfozinlə plasebo nəzarətli tədqiqat aparılmayıb. Heç biri. Müasir metodlarla müqayisəli sınaqlar da mövcud deyil. Bütün sübut bazası klinik müşahidələrdən ibarətdir. Sovet psixiatriyasının onillikləri. İllər, palatalar, minlərlə xəstə. Amma nəzarətli eksperiment yoxdur. Randomizə edilmiş seçmə yoxdur. Kor protokol yoxdur. Müşahidələr. Yalnız müşahidələr.

Ciddi sübuta əsaslanan tibb baxımından bu, effektivliyin sübutu sayılmır. Bu, ən yaxşı halda, nəzarət edilən üsullarla yoxlanılması zəruri olan bir fərziyyə üçün əsasdır. Belə bir yoxlama aparılmayıb.

Onda sual yaranır: əgər metod ciddi sübut bazasına malik deyilsə, güclü ağrı, əzələ nekrozu, yüksək hərarət yaradırsa, xəstələr ondan qorxur və cəza kimi qəbul edirsə, onilliklər boyu repressiya aləti kimi fəal tətbiq olunubsa — 2000-ci və 2010-cu illərdə xəstələrə venadaxili yeridilməsinin əsası nədir?

Düzünü desəm, ətalətlə. "Belə öyrədiblər" prinsipi ilə. "Görürük ki, kömək edir" düşüncəsi ilə. Xəstələrin səs hüququ olmaması ilə.

Bu elmi psixiatriya deyil. Bu, keçmişində ilişib qalmış psixiatriyadır.

Bu fəsilə başladığım xatirəyə qayıdıram.

2000-ci ildə Bakıda sülfozin inyeksiyası hazırlanan o xəstə — üzünü xatırlayıram. Arıq idi, təxminən otuz yaşında. On il idi şizofreniyadan əziyyət çəkirdi və dəfələrlə bu elə xəstəxanada yatmışdı. İndi nə baş verəcəyini bilirdi. Tibb bacısı ampula ilə gələndə o, səssizcə üzü üstə uzandı və başını divara tərəf çevirdi.

O, qışqırmırdı. Etiraz etmirdi. Şikayət etmirdi. Heç bir şeyin dəyişməyəcəyini bilirdi. Bu öyrənilmiş acizlik — bəlkə də sovet və postsovet psixiatriya mədəniyyətində xroniki şizofreniya xəstələrinin ən xarakterik simptomudur. Onlar özlərinə nə ediləcəyini bilirdilər. Bunu dəyişə bilmirdilər. Səssiz qalırdılar.

Pəncərənin önündə dayanıb baxırdım. Gənc həkim, intern. Baş verənlərin elmi əsası olmadığını anlamaq üçün kifayət qədər bilirdim. "Xeyr" deməyə haqqım olmaq üçün isə kifayət qədər bilmirdim — interni heç kim eşitməzdi. Dayanıb susurdum.

Bu mənim sükutumdur. Elə ön sözdə danışdığım sükut. Səssiz razılaşma. Görünməz mexanizm. Keçmişin bütün iyrəncliyinin indiki zamanda işləyə bilməsi üçün o dişli çarxsız mümkün olmazdı. O gün mən onun şərikinə çevrildim. Yüzlərlə gənc həkimin sırasında dayanmışdım. Yanımda — sülfozinin hərarəti ilə qızmış şprislər. Yanımda — insulin kommasının buzlu uçurumuna düşən xəstələr. Yanımda — anesteziyasız elektroşok, əti yandıran. Dayanıb susurduq. Niyə? Çünki belə qəbul olunmuşdu. Çünki mübahisə edəcək kimsə yox idi. Çünki heç kim bizə alternativ göstərməmişdi.

Bu kitab — o cümlədən — bu gecikmiş səssizliyi pozmaq cəhdidir. O zaman deməli olduğum şeyi indi də olsa deyim. Ən azından geridən baxaraq.

1950-ci illərin ortaları. Geri dönüş nöqtəsi. Laboratoriyalarda xlorpromazin sintez edildi — 1952. Xaosu həqiqətən qıran ilk neyroleptik. Və elə bu anda sülfozin inyeksiyaları da daxil olmaqla piroterapiya mənasını itirir. Hər hansı elmi əsas kart evi kimi uçur. Əgər qıfılın açarı varsa, ağlı qızdırma ilə yandırmaq nəyə lazım? Psixiatriyanın nəhayət silahı olur. O, çoxuna kömək edir. Hamıya yox. Və həmişə yox. Amma — kömək edir. Simptomlar geri çəkilir, göz önündə zəifləyir. Hezeyan öz əzabverici kəskinliyini itirir, əti incitməkdən əl çəkir. Halüsinasiyalar seyrəlir. Və xəstələr qaranlıqdan çıxırlar. Onlar həyata qayıda bilərlər.

Qərbi Avropa və ABŞ-də neyroleptiklərin və müasir forması ilə elektrokonvulsiv terapiyanın ortaya çıxması ilə birlikdə sülfozin və digər piroterapiya formaları klinik praktikadan səssizcə uzaqlaşdı. 1960-cı illərin sonuna qədər onlar demək olar ki, tamamilə yox oldu.

Sovet İttifaqında və bəzi postsovet ölkələrində — yoxa çıxmayıb.

Bu mənim əsas fikirlərimdən biridir və istəyirəm ki, aydın səslənsin. Postsovet psixiatriyası bir çox cəhətdən hələ psixiatriya olmayıb. O, hibriddir. İçində dünya psixiatriyasında olan hər şey var: müasir antipsixotiklər, BQX üzrə diaqnostika, protokollar, etika komitələri. Hamısı yerindədir. Amma bu qatın altında başqa bir qat var. Heç kimin təmizləmədiyi keçmiş qatları. Sülfozin. Ayrı-ayrı stasionarlarda hələ də istifadə olunur. İnsulin komaları. Lazımi anesteziya olmadan elektroşok. Dünyanın çoxdan imtina etdiyi, ambulator idarə ilə əvəz etdiyi uzunmüddətli hospitalizasiyalar. Postsovet məkanından kənarda ağlasığmaz təcrübələr. Bayırda — müasir klinika. İçəridə — getməmiş keçmiş. Və bu haradasa deyil. Bu buradadır.

Və burada açıq şəkildə etiraf etməliyik: bu, psixiatriyanın səhvidir. Ümumiyyətlə psixiatriyanın yox. Keçmişindən tam şəkildə imtina edə bilməyən konkret regional formasının səhvidir.

İslahata gedən yol yalnız metodların dəyişdirilməsini tələb etmir. O, mədəniyyətin dəyişməsini tələb edir. Elə bir mədəniyyətin ki, orada gənc həkim qeyri-etik praktika gördükdə susa bilməz. Elə bir mədəniyyətin ki, orada xəstənin səsi və imtina etmək hüququ var. Elə bir mədəniyyətin ki, orada "cəzalandırıcı müalicə" ideyasının özü — hətta onun intonasiyası belə — dərhal rədd edilmə doğurur.

Bu mədəniyyət təsdiqlənməyincə, bizdə yenə də pəncərənin önündə durub susan gənc həkimlər görünəcək. Mənim kimi. Və yenə də üzüstü uzanıb imtina edə bilmədikləri iynəni gözləyən qocalan xəstələr olacaq.

Düsturun izi. Bir çimdik həqiqət — və partlayış. Hərarət həqiqətən də sifilis törədicisini məhv etdi. Amma yalnız bir tək xəstə qrupunda. Yalnız "proqressiv iflic" diaqnozu qoyulanlarda. Və elə burada ölümcül bir həddən artıq ümumiləşdirmə baş verdi: "hərarət ümumiyyətlə psixozları müalicə edir". Heç bir sübut yoxdur. Yalnız kor-koranə inam. Metod? Malyariya peyvəndləri. Sonra sülfozin. Hərarət naminə hərarət. Tək bir nəzarətli sınaq belə aparılmadı. Sənaye hərəkətə keçdi: yetmiş il "piroterapiya". Şöbələr. Mərclər. Dərsliklər. Hər şey konveyerdəki kimi. Bəs hesabı kim ödəyirdi? Xəstələr. Bu qızmar işgəncəyə məhkum edilmiş nəsillər boyu xəstələr. Bu kitabın onunla başladığı adam da daxil olmaqla.

Növbəti fəsildə şizofreniyaya dərman axtarışının həmin dövründə doğulmuş daha bir metodu nəzərdən keçirəcəyik. Geniş tətbiq tapmış, sübutsuz bir nəzəriyyəyə əsaslanmış və neyroleptiklər meydana çıxdıqdan sonra köhnəlmiş sayılmış bir metod. Lakin vaxtilə o qədər ümidverici görünürdü ki, onun ixtiraçısı dünya şöhrəti qazandı.

Söhbət Manfred Zakelin insulin koma terapiyasından gedir.

Fəsil 6. Şəkərli diabet dəliliyin müalicəsi kimi: Manfred Zakelin komaları

1927-ci ildə Berlində, Lixtenfeld xüsusi klinikasında çalışan gənc nevroloq Manfred Sakel (1900-1957) çətin bir vəziyyətlə üzləşdi. Ona heroin bağımlılarından ibarət bir qrup tapşırılmışdı və bir çoxunda narkotikdən imtina edildikdə ağır abstinentlik halları — həyəcan, aqressiya, təşviş növbələri müşahidə olunurdu. Ənənəvi sakitləşdirici dərmanlar isə bu hallarla effektiv şəkildə mübarizə apara bilmirdi.

Zakel yeni bir silaha ümid bağlamışdı. Tibb arsenalında cəmi bir neçə il əvvəl peyda olan bir vasitəyə. İnsulinə. 1921-ci ildə Torontoda kəşf edilmiş bu maddə artıq 1920-ci illərin ortalarında şəkərli diabeti zəncirdə saxlayırdı. Onun zərbə gücü sadə idi: qandakı qlükoza səviyyəsini yerə çırpırdı. Diabet xəstələri üçün bu, xilas demək idi. Bəs əgər iynə sağlam bir adama vurulsa? Xilas edən normanın o tayında nə gizlənir? Əgər insulini kifayət qədər dozada yeritsən, şəkər elə güclə çökür ki, beyin fəaliyyətini dayandırır. Əvvəlcə bədəni xırda titrəyişlər bürüyürdü. Tremor. Sonra buz kimi tər qabarması başlayırdı. Şüur qarışıq sayıqlamalar içində dağılırdı. Və sonra — uçurum. Dərin hipoqlikemik koma.

Sakel gördü ki, insulinin kiçik dozaları heroin asılılığı olan xəstələrində həyəcanı azaldır və sakitləşdirici təsir bağışlayır. O, dozanı artırmağa başladı. Və elə bir mərhələyə çatdı ki, xəstədə əsl hipoqlikemik koma inkişaf edirdi — əzələ sərtliyi, avtomatizmlər, bəzən qıcolmalarla müşayiət olunan dərin

şüursuz vəziyyət. Sonra damcı vasitəsilə qlükoza yeridilirdi və xəstə yavaş-yavaş ayılırdı.

Zakel yazırdı ki, bu dozalardan sonra narkomanları "sakit, mülayim, müalicəyə daha asan tabe olan" adamlara çevrilirdilər. Bu müşahidə onda illər boyu yetişmişdi. Və 1933-cü ildə Vyanaya köçüb psixiatrik klinikada işləyərkən o, qətiyyətli bir addım atdı: bu metodu narkomanlara deyil, şizofreniya xəstələrinə tətbiq etdi.

Hər şey belə başladı. Xəstəyə insulin yeridilirdi — doza-doza, pillə-pillə, qandakı şəkər o qədər aşağı düşənə qədər ki, adam dərin komaya qərq olurdu. Dəqiqələr. Bəzən bir saat. Bəzən iki saat. Bütün bu müddət ərzində o, həyatla ölüm arasında asılı qalırdı, həkimlər isə yanında dayanıb gözləyirdilər. Sonra — qlükoza. Zond vasitəsilə ya damcı ilə. Və xəstə geri qayıdırdı. Gözlərini açırdı. Şüuru özünə gəlirdi. Amma bir koma müalicə deyil. Bu, yalnız başlanğıcdır. Kurs — otuz, qırx, əlli koma. Gün keçdikcə. Hər biri ayrı bir ölüm kimi — geri qayıtmaq lazım olan bir ölüm. Bütün kurs iki aya qədər uzanırdı. İki ay — həyatla ölüm arasında. İki ay — sərhəddə.

Koma zamanı xəstə ilə nə baş verirdi? Qlükozasız qalan beyin normal fəaliyyətini dayandırırdı. Avtomatik hərəkətlər meydana çıxırdı, bəzən qıcolmalar, bəzən — epileptiform tutmalar. Xəstə tamamilə aciz vəziyyətdə idi. Müalicədəki hər hansı səhv — həddindən artıq dərin koma, qlükozanın vaxtında yeridilməməsi — beynin dönməz zədələnməsinə və ya ölümə gətirib çıxara bilərdi.

İnsulin komatoz terapiyasından ölüm halları, müxtəlif hesabatlara görə, bir faizdən beş faizə qədər dəyişirdi. Bu — bir kursa aid idi. Yəni kursu keçmiş hər iyirminci-yüzüncü xəstədən birinin müalicəsi ölümlə nəticələnirdi.

Lakin Sakel öz hesabatlarında heyrətamiz statistik məlumatlar gətirirdi. O bildirirdi ki, şizofreniya xəstəsi olan pasiyentlərinin 88 faizinə qədəri yaxşılaşma, bir çoxu isə tam

remissiya əldə edib. O, öz metodunu "qlükohipoqlikemik müalicə" adlandırırdı. Tibb ictimaiyyəti heyrətə gəlmişdi.

1937-ci ildə İsveçrədə insulin komatoz terapiyası üzrə beynəlxalq konqres keçirildi. Bu vaxta qədər metod artıq onlarla ölkədə tətbiq edilmişdi: Harvard, Mayo Klinika, Salpetrier, Leninqraddakı Bextrev İnstitutu. Bütün inkişaf etmiş ölkələrdə "insulin şöbələri" yaranmışdı; orada onlarla və yüzlərlə xəstə həftələrlə uzanan koma kurslarından keçirdi.

Sakel ABŞ-a mühacirət etdi, Nyu-York klinikalarında çalışdı və Amerika psixiatriyasının ulduzlarından birinə çevrildi. Ona Nobel mükafatı vəd edirdilər — necə ki, Wagner-Jauregg malyariyaterapiyaya görə bu mükafatı almışdı.

Amma.

Amma XX əsrin ortalarında tədqiqatçılar insulin koma terapiyasının ciddi müqayisəli sınaqlarını keçirməyə başlayanda — yəni onu komasız adi qayğı alan nəzarət qrupları ilə müqayisə edəndə — mənzərə tamam başqa cür oldu.

London, 1953-cü il. Son nöqtəni qoymalı olan bir tədqiqat. Harold Born və həmkarları xəstələri götürüb təsadüfi qaydada bölürlər. Birinci qrup — insulinokomatoz terapiya. İkinci — sedativ barbituratlar. Heç bir koma yox, yalnız yuxu. Nəticələri müqayisə edirlər. Və burada heç kimin gözləmədiyi şey baş verir. Effektlər demək olar ki, eynidir. Zakel və onun davamçılarının məhz koma ilə izah etdikləri yaxşılaşmalar, ümumiyyətlə komaya düşməyən şizofreniya xəstələrində də eyni tezliklə baş verirdi. Deməli, komanın bunda heç bir rolu yoxdur? Bəs onda nə müalicə edir? Yaxud — kim?

Bu, sadə və dəhşətli bir şey demək idi. Zakelin 88%-i metodologiyanın artefaktı idi. Zakel nəzarət qrupları olmadan işləyirdi. O, öz xəstələrini paralel şəkildə adi üsullarla müalicə olunanlarla deyil, öz təəssüratı ilə — "əgər onları müalicə etməsəydim, nə olardı" fikri ilə müqayisə edirdi. Belə müqayisəni obyektiv aparmaq mümkün deyil. Kəskin şizofreniyalı bir

çox xəstə heç bir müalicə olmadan da bir neçə həftə ərzində xəstəliyin spontan dinamikası hesabına yaxşılaşır — xüsusilə xəstəliyin ilk epizodunda. Vəziyyəti pisləşənlər Zakelin hesabatlarında "müalicəyə cavab verməyənlər" kateqoriyasına düşürdü. Yaxşılaşanlar isə uğurlar kateqoriyasına.

Bu, klassik metodoloji səhvdir və bir çox müasir psevdoterapiyalar hələ də bu səhvdən azad deyil: müştərilərinin təəssüratlarını toplayıb "yaxşılaşmaları" saymaq, nəzarət qrupu olmadan isə metodun işlədiyini bəyan etmək.

1950-ci illərin ortalarına doğru dünya psixiatriyasında şübhə yığılmağa başladı. 1952-ci ildə isə dönüş nöqtəsi oldu: fransız həkimləri Jan Deleye və Per Deniker xlorpromazinin — ilk həqiqi antipsixotikin — tətbiqinin ilk nəticələrini dərc etdilər. Bir neçə il sonra bu, hər şeyi dəyişdi. İnsulin koma terapiyası tezliklə mövqelərini itirdi. 1960-cı illərin sonunda Qərbin əksər klinikalarından yoxa çıxdı.

SSRİ-də, sülfozinlə olduğu kimi, hər şey başqa cür idi. İnsulin koması hələ uzun müddət tətbiq olunmaqda davam edirdi. 2001–2003-cü illərdə ixtisaslaşma keçdiyim Bextrev İnstitutunda hələ də xəstələrə insulin terapiyası tətbiq edilən şöbələr var idi — hərçənd o vaxta qədər bu artıq komatoz deyil, subkomatoz dozalarda idi, yəni şüurun tam söndürülməsi olmadan hipoqlikemiya yaradırdı. Bu, "yumşaq üsul" sayılırdı.

İnsulin şöbələrini xatırladıqca, ağlımdan çıxmayan bir fikr var.

Otuz-qırx komadan sonra xəstələri "yaxşılaşdıran" nə idi? Əlbəttə, komanın özü deyildi. Bu, bu gün aydındır. Bəs onda nə?

Birinci: reqressiya. Beş həftə yarımkomatoz vəziyyətdə qalmış, susuzlaşmış və tükənmiş xəstə kursdan ruhi və fiziki cəhətdən gücsüz çıxırdı. Passivləşir, etiraz etməyi, tələb irəli sürməyi və personala mane olmağı dayandırırdı. Bu passivliyi "yaxşılaşma" kimi qəbul etmək olardı, xüsusilə psixiatrik per-

sonalın xəstəni "həyəcanlı" və ya "narahat" təyin etdiyi şəraitdə.

İkincisi: diqqət. İnsulin şöbəsində xəstə adi şöbədəkindən qat-qat çox diqqət alırdı. Tibb bacıları gün ərzində bir neçə dəfə onun nəbzini, təzyiqini və qlükoza səviyyəsini ölçürdülər. Onlar həmişə yanındadırlar, onunla söhbət edirlər. Hər hansı tibb sahəsində ən güclü terapevtik amillərdən biri sadəcə kiminsə sənə diqqət yetirməsidir.

Üçüncüsü: spontan remissiya. Şizofreniya tutmalarla keçən bir xəstəlikdir. Bir çox xəstə kəskin fazanın ilk bir neçə ayında təbii yolla yaxşılaşır. Əgər təsadüfən bu an komatoz terapiya aparılırdısa, yaxşılaşma terapiyaya aid edilirdi.

Bütün bunlar birgə "88% yaxşılaşma" statistikasını verirdi ki, bu da bilavasitə müşahidə edənlərdə tam bir "möcüzə" təəssüratı yaradırdı. Mif möhkəmləndi. Metodun elə bir mərhələyə çatmağına imkan verildi ki, o, bəzi klinikalarda sözün əsl mənasında bütün qalan psixiatriyanı əvəz etdi.

Amma dürüstlüklə bunu da qəbul etməliyik ki, o dövrün psixiatriyasının çərçivəsində Zikelin insulin koması terapiyası nə cəfəngiyyat, nə də cinayət idi. Bu, digər üsulların kömək etmədiyi və daha yaxşı bir seçim olmadığı bir vəziyyətdə kömək etmək cəhdi idi.

Zakel savadlı həkim idi. O, müasir "dizaynçılar" və ya "ThetaHealing ustaları"nın şarlatan olduğu mənada şarlatan deyildi. O, öz metoduna səmimi inanırdı. Nəticələrini resenziyalı jurnallarda dərc edirdi. Elmi müzakirələrdə iştirak edirdi. Onu tənqid edirdilər, o, tənqidçiləri dinləyir və onlara cavab verirdi.

Burada — uçurum var. Onu müasir ezoteriklərdən əbədi olaraq ayıran dərin uçurum. Bəli, onun nəticələri artefakt oldu. Metodologiyanın illüziyası. Lakin o, elmin içində qaldı. Onun qaydaları ilə oynadı — metodda ölümcül, fəlakətli səhv olsa da. Və məhz buna görə elm onun sistemini aşkara çıxara

bildi. Sınaqdan keçirdi. Təkzib etdi. Kənara qoydu. Habbardçı və ya kommersiya "unikal metodu"nun yaradıcısı heç vaxt öz məhsulunun plasebo-nəzarətli sınaqların odlu közündən keçməsinə icazə verməz. Bu, onların biznesini məhv edərdi. Bu, kommersiya strukturunu kökündən dağıdardı. Zakel — icazə verdi. Zakel — uduzdu. Və tarix bu nəticəni qəbul etdi.

Bu fərq əsas məqamdır. Elmi psixiatriya səhv edir və düzəldir. Psevdoelmi sistemlər isə düzəlmir, çünki öz sistemləri daxilində heç vaxt səhv etmirlər.

Lakin bütün bunlar mənim nəslimin və ölkəmizin həkimlərini bir böyük problemdən azad etmir: nə üçün insulin komaları bütün dünya onlardan imtina etdikdən sonra postsovet psixiatriyasında bu qədər uzun müddət qaldı?

Cavab sülfozinlə eynidir. Mədəni ətalət. Sovet dövründə yazılmış dərsliklər yenidən yazılmadı. Yaşlı mütəxəssislər gənclərə yalnız özlərinin bacardıqlarını öyrədirdilər. Peşə daxili müzakirə? Belə bir şey yox idi. Gənc həkim narahat edən sual verə bilməzdi — palata divarları yalnız sükutla razılaşmanı udurdu. Bir də sadə inzibati fakt. Bütün bunlar nə yeni dərman, nə şöbələrin yenidən təchizatı, nə də kadrların yenidən hazırlanması tələb etmirdi. İnsulin var idi. Qlükoza var idi. Şprislər masaların üstündə idi. Çarpayılar sıra ilə düzülmüşdü. Metod ucuz idi. Bu, büdcəsi məhdud səhiyyə sistemi üçün az əhəmiyyətli amil deyildi.

Lakin sistem səviyyəsində qənaət bu üsulların tətbiq olunduğu hər bir ayrı-ayrı pasiyent üçün nəhəng itkilərə çevrilirdi.

Bu gün Zakyelin insulin komatoz terapiyası demək olar ki, heç yerdə tətbiq olunmur. Onun tarixi rolu bir şeydən ibarət idi: göstərmək ki, şizofreniya hökm deyil. Ondan əvvəl psixiatrların çoxu şizofreniyaya dönməz surətdə irəliləyən fəlakət kimi baxırdılar. Ondan sonra — heç olmasa illüziya çərçivəsində — elə göründü ki, bu xəstəlikdə təsiredici yaxşılaşma əldə etmək mümkündür.

İllüziya əsl antipsixotiklər səhnəyə çıxdığı anda dağıldı. Onların meydana gəlməsi ilə insulin komaları bir anda bütün mənasını itirdi. Lakin bu ilğım öz gizli işini görə bilmişdi. O, psixiatriyaya ümid verdi. Sübut etdi: cəhd etmək olar, axtarmaq olar, ümid etmək olar. Bu güclü emosional dönüş olmasaydı, 1950-ci illərdə psixiatriyanı həqiqətən dəyişən o tədqiqatçılar nəsli meydana gələrdimi? Çətin ki. Axı insanlar ümidsiz işə heç vaxt çox güc qoymurlar.

Bu kiçik, lakin mühüm bir qeyddir. Tibb tarixindəki hər bir yanlış təcrübə ancaq zərər deyildir. Onların bəziləri keçid rolunu oynayır, sonra gələcək yeniliklər üçün zəmin hazırlayır. Insulin koması terapiyası da məhz belə bir hal idi.

Formuldan sonra. Həqiqətdən bir çimdik: hipoqlikemik komadan sonra xəstələr daha sakit görünürdülər. Həddindən artıq ümumiləşdirmə: "koma şizofreniyanı müalicə edir". Metod: kursa onlarla koma — nəzarət qrupu olmadan. Sənaye: dünyanın hər yerində insulin şöbələri, Zakelin dünya şöhrəti, "88% yaxşılaşma". Qurbanlar: hər əllinci — həlak olan; qalanlar — "yaxşılaşması" tükənmə olanlar.

Həmin nəslin digər təcrübələri qat-qat dramatik idi. Növbəti fəsildə bu axtarış dövrünün ən məşhur — və ən qaranlıq — qolunu görəcəyik. Lobotomiya ilə — Nobel mükafatı alacaq və bu dövrün ən dəhşətli hesabını arxasında qoyacaq üsulla.

Fəsil 7. Buz baltasına görə Nobel mükafatı: lobotomiya və onun qiyməti

17 yanvar 1946-cı ildə Vaşinqtonda, həkim Frimenin kabinetində Salli Ellen İonesku adlı bir amerikalı qadın psixiatrik müayinəyə gəldi. Qadın ağır depressiyadan əziyyət çəkirdi. Həkimi Volter Frimen onu ayrıca otağa dəvət etdi. Oturtdurdu. Elektroşok aparatını birləşdirdi. Tok vurdu. Qadın huşunu itirdi.

O, huşsuz halda uzanmışdı. Frimenin barmaqlarında bir alət parıldadı. Buzxançal. Adi buz parçalamaq üçün dəstdən götürülmüş buzxançal. Belə bir alət necə ola bilərdi ki, həkimin əlində olsun? Bir tapmaca. Amma cavab artıq cərrahın ölümcül niyyətində gizlənirdi. Frimen alətin ucunu xəstənin üzünə yaxınlaşdırdı. Hədəf — göz yuvası idi. O, buzxançalı yuxarıdan, yuxarı göz qapağının altından, göz alması ilə göz yuvasının damı arasındakı o xırda boşluğa soxdu. Bir saniyəlik sükut. Və — zərbə. Çəkic sap üzərinə kəskin şəkildə endi. Xırtıltı. Gözün üstündəki nazik sümük lövhəsi deşildi. Alətin ucu beynin ön payına girdi. Frimen sapı möhkəm sıxdı. Soldan sağa apardı. Yuxarıdan aşağıya. Ön pay ilə beynin qalan hissəsi arasındakı əlaqələri kəsərək, sanki şəxsiyyəti ağıldan ayırırdı. Aləti çıxardı. Qan üzdən çəkildi. Amma əməliyyat hələ bitməmişdi. Eyni şeyi digər göz yuvasından da etdi.

Bütün prosedur təxminən on dəqiqə çəkdi.

Misis İonesko özünə gələndə Frimen onu taksijə mindirib evə yola saldı.

İyirmi beş il. İki min beş yüz insan beyni. Bir buz baltası. Bu necə mümkün ola bilər? Transorbital lobotomiya. Sadəcə desək — "buz baltası ilə lobotomiya". Alət? Bar stolunda buz qıran eyni alət. Giriş nöqtəsi? Göz yuvası. Düz beynə. Onun adı Volter Frimen idi. Və ilk şok budur: o cərrah deyildi. O, bir həvəskar idi. Bir furgon. Frimen ölkəni bu adi furgonla gəzirdi. Həftədə yüz xəstə. Əsas qorxunc hadisə isə Qərbi Virciniyada baş verdi: on iki günlük bir səfərdə iki yüz iyirmi beş nəfər. İki yüz iyirmi beş. On iki gündə. Dayanın. Düşünün. Artıq əməliyyat otağına ehtiyac yox idi. Artıq neyrocərraha ehtiyac yox idi. Nə qalırdı? Yalnız buz baltası. Çəkic. Və elektrik şoku cihazı. Hamısı budur. Bütün dəst. Çəkic. Buz baltası. Elektrik.

ABŞ-da cəmi nə qədər xəstəyə lobotomiya edilib? Təxminən əlli min. Onların da təxminən on mini Frimen üsulu ilə, buz baltası ilə. Qalanları isə daha əvvəlki prefrontal lobotomiya metodikası ilə, onu başqa bir adam icad edib. 1949-cu ildə buna görə Nobel mükafatı alan həmin adam.

Portuqaliyalı nevroloq António Egas Moniz (1874–1955) — sözün tam mənasında akademik. Parlament deputatı, 1918-ci ildə Paris sülh konfransında Portuqaliyanın xarici işlər naziri, diplomat. Amma təkcə bunlar deyil. O, parlaq bir nevroloq, serebral angioqrafiya metodunun — beyin damarlarının rentgen şüaları ilə görüntülənməsi üsulunun müəllifidir. Kəllə içərisinə baxış, gizlini görünən edən bir baxış. Məhz bunun üçün onu Nobel mükafatına namizəd göstərmək lazım idi. Əgər o, bu mükafatı məhz bunun üçün almış olsaydı. Bəs niyə belə deyil? Bu "əgər"in arxasında hansı dəhşətli sirr gizlənir?

1935-ci ildə Londonda keçirilən beynəlxalq konqresdə Moniz iki amerikalı tədqiqatçının — Con Fulton və Karlayl Yakobsenin məruzəsini eşitdi. Onlar şimpanzelər üzərində təcrübə aparırdılar. Xüsusilə, Bekki və Lusi adlı iki meymunun ön paylarını çıxarmışdılar. Əməliyyatdan əvvəl, tapşırığı yerinə yetirə bilmədikdə, Bekki qəzəbli tutmalara düşürdü — yırğalanır, qışqırır, qəfəsin barmaqlıqlarına çırpınırdı. Əməliyyatdan

sonra isə hər hansı uğursuzluq zamanı sakit qalırdı və bir daha qəzəblənmirdi.

Fulton və Yakobsen quru bir elmi müşahidə dərc etdilər. Sadəcə məlumat. Sadəcə faktlar. Və bu kifayət etdi. Lissabonda onların hesabatı üzərinə əyilən Eqaş Moniş oldu — və müəlliflərin görmədiyini gördü. Müşahidə yox. Silah. Evə qayıtdı. Neyrocərrah tapdı — Pedro Almeida Limu. Və 1935-ci ilin noyabrında əməliyyat otağına girdilər. Xəstə — orta yaşlı bir qadın. Ağır depressiya. Nə həblərin, nə də zamanın aradan qaldıra bilmədiyi ümidsizlik. Limu qazmağı götürdü. Kəllədə iki dəlik. İçəriyə leyqotom sürüşdü — ucunda çıxarıla bilən tel ilgək olan dar bir alət. Fırlanma. İlgək frontal payın ağ maddəsini gəmirirdi. Mişarlayırdı. Beynin kiçik bir parçası — ümid müqabilində. Yaxud boşluq müqabilində. O vaxt bunu hələ heç kim bilmirdi.

Növbəti iki il ərzində Moniş və Lima təxminən iyirmi belə əməliyyat keçirdi ki, bunu leyukotomiya adlandırdılar. Moniş nəticələri nəşr etdi. Onun qiymətləndirməsinə görə, yeddi xəstədə "yaxşılaşma", yeddi xəstədə "qismən yaxşılaşma", altı xəstədə isə "dəyişiklik olmadı" müşahidə edildi.

İyirmi xəstə. Altı ay müşahidə. Bir dənə də nəzarət qrupu yox. "Yaxşılaşma"nın təyini o qədər sərbəst idi ki, hətta bir cəsəd də buna uyğun gələrdi. Təvazökar, metodoloji cəhətdən uğursuz bir sıra. Əsas belə görünürdü. Elə bir əsas ki, onun üzərində tezliklə bütöv bir sənaye quruldu. 1936-cı ildə bu kövrək körpüləri Atlantikanın o tayında da gördülər. ABŞ-da işə gənc psixiatr Volter Frimen (Walter Freeman, 1895–1972) başlayır. Onun əlində ambisiyalar skalpeli və bir Müttəfiqi var — neyrocərrah Ceyms Uotts. İkisi birlikdə Monizin metodunu götürür və onu bir az da sadələşdirirlər. Artıq olan — kənara. Mahiyyət qalır. Öz yaratdıqlarına prefrontal lobotomiya deyirlər. Səsi demək olar ki, zərərsiz səslənir, bahalı restoranda yeməyin adı kimi. Amma bunun arxasında artıq bir uçqun qalxır.

1945-ci ilədə Qərbdə artıq minlərlə lobotomiya əməliyyatı həyata keçirilmişdi. 1946-cı ildə Frimen özünün transorbital "qazma" modifikasiyasını ixtira etdi — beləliklə, əməliyyat daha sadə, sürətli və nevrocərrahi avadanlıq tələb etməyən bir prosesə çevrildi.

1949-cu ildə Nobel Komitəsi Monişə "müəyyən psixozlar zamanı leykotomiya terapevtik təsirinin kəşfinə görə" mükafat verdi. Dəqiq belə bir ifadə istifadə edilmişdi.

Prefrontal lobotomiya zamanı xəstə ilə nə baş verirdi? Əvvəlcə — ümumi narkoz və ya Frimen vəziyyətində elektroşok. Sonra cərrah kəllədə iki dəlik açırdı. Dəliklərdən metal ilgəkli bir alət — ley kotom daxil edirdi. Alət ön payın ağ maddəsinə — ön qabığı beynin qalan hissəsi ilə birləşdirən sinir liflərinə çatırdı. İlgək irəli çıxarılır, fırlanır, lifləri kəsirdi. Alət çıxarılırdı. Bir tərəfdəki əməliyyat tamamlanırdı. Prosedur digər tərəfdə təkrarlanırdı.

Bəs xəstə bundan sonra nə yaşadı? XX əsr psixiatriya tarixinin ən dəhşətli sualı elə budur.

"Cərrahi yolla yaradılmış uşaqlıq". Frimen məqalələrində nəticəni belə — hərfiyən — adlandırırdı. Onun məntiqi amansız dərəcədə aydın idi: əməliyyatdan sonra xəstə uşaqlıq emosional asılılığı vəziyyətinə qayıdırdı. Və bu, onun iddiasına görə, sağalmanın zəruri mərhələsi idi. Amma yaxınları üçün bu necə idi? Gəlir və dəhşətdən donub qalırdılar. Onların anası. Onların bacısı. Lobotomiya sonrası o "hərəkətsiz", "yavaş", "passiv" olmuş, "yaşamaq iradəsini itirmiş"di. Onlar bu yaşayan, amma boşaldılmış bədənlərə baxır və yaxınlarını tanımırdılar. Frimen onların nə gördüyünü bilirdi. Və ona həmişə hazır cavabı var idi: bu keçəcək. Bu — ancaq keçici vəziyyətdir. Sonra o az qala əvvəlki kimi olacaq.

Bir çox xəstədə bu vəziyyət heç vaxt keçmədi.

Keçəsi yoxdu. Çünki bu əməliyyat müalicə etmirdi — şikəst edirdi. Tamamilə. Həmişəlik. Alın payları. İnsanı insan edən

məhz budur. Planlaşdırma. İnisiqa. Zaman anlayışı. Emosiyalar. "Nə olacaq?" sualını başa düşmək qabiliyyəti. Hamısı — oradadır. Milyonlarla sinir lifi ilə beynin qalan hissəsinə bağlanan bu paylarda. Cərrah alət daxil edir. Kəsir. Liflər qopur. Alın payları ilə beynin digər hissələri arasındakı əlaqə məhv olur. İnsan sağalmır. Sadəcə düzləşir. Emosional düzlük. İntellektual düzülmə. İradə düzənliyi.

Frimen lovğalanırdı ki, lobotomiyadan sonra o, xəstələri "əsl ev heyvanına" çevirə bilir. Yazılarında bunu heç bir istehza olmadan, düz beləcə yazırdı. Onun fikrincə, bu, klinik ideal idi.

ABŞ-da əməliyyat olunmuş o əlli min nəfərin arasında adlarını bildiyimiz konkret insanlar da var idi.

Rozmari Kennedi, Cozef və Roz Kennedilərin böyük qızı, gələcək prezident Con F. Kennedinin bacısı idi. Uşaqlıqda onun inkişafı qardaşları və bacılarından geri qalırdı. Yeniyetməlik dövründə onun təhsilində çətinliklər, əhvali-ruhiyyə dəyişiklikləri, mümkün epileptik tutmalar müşahidə edilirdi. Gəncliyində ona yüngül zehni geriliklə və müşayiət edən affektiv pozğunluq diaqnozu qoya bilərdilər, bəlkə də heç bir diaqnoz qoymazdılar. Sadəcə, o fərqli idi. Sadəcə, Kennedi sülaləsinin əzəmət layihəsinə uyğun gəlmirdi.

Coseph Kennedi narahat idi. Oğulları üçün siyasi ambisiyaları getdikcə daha israrla bəsləyirdi. Rozmari isə iyirmi üç yaşında — 1941-ci ildə — gecələr monastır məktəbindən qaçmağa başladı. Atası onun kişilərlə görüşdüyünü güman edirdi. Narahat olurdu: bəlkə hamilə qaldı? Bəlkə qalmaqal düşdü?

O, Volter Frimenə müraciət etdi. Frimen lobotomiya ilə "həll yolu" təklif etdi. Cozef Kennedi arvadına bu qərarından xəbər vermədi. Digər uşaqlarından da heç kimə demədi. 1941-ci il noyabr ayında Corc Vaşinqton Universitetinin xəstəxanasına gətirilən Rozmerini əməliyyat masasına yatırdılar. Frimen və Votts onun başında deşiklər açdı.

Proses zamanı — kəsin nə qədər dərin olacağını müəyyən etmək üçün — Frimen ona suallar verirdi. “Atamız” duasını oxumasını, “God Bless America” mahnısını oxumasını və əks ardıcıllıqla saymasını istəyirdi. “Biz kəsimin dərinliyini onun cavablarına görə qiymətləndirdik” — sonradan tibbi sənədlərdə yazılacaq. Onlar kəsirdilər və soruşurdular, kəsirdilər və soruşurdular. Cavabları qarışıq və tutarsız olduqda isə dayandılar.

Artıq çox gec idi.

Roza Kennedi, əməliyyatdan sonra gəzə bilmirdi. Aydın danışa bilmirdi — yalnız bir neçə söz deyə bilirdi. Özünə qulluq edə bilmirdi. Sfinkterlərini idarə edə bilmirdi. Onun zehni və emosional səviyyəsi kiçik bir uşağın səviyyəsinə qədər geriləmişdi.

Onu Viskonsindəki Müqəddəs Kolettanın katolik internatına göndərdilər. Anası iyirmi il boyunca onu ziyarət etmədi. Atası isə heç vaxt yanına gəlmədi. Qardaşları və bacıları 1960-cı illərin əvvəllərinə qədər onun harada olduğunu və ona nə olduğunu bilmirdilər. Rozmeri 2005-ci ildə vəfat edənə qədər internatda yaşadı — əməliyyatdan sonra keçən 64 il. O, 86 yaşında dünyasını dəyişdi. Kennedy ailəsinin tarixindən bu illər ərzində sanki tamamilə silinib atılmışdı.

O, bəlkə də lobotomiyanın ən məşhur qurbanı idi. Amma o, on minlərlə insandan yalnız biri idi.

Volter Frimen hər kəsə lobotomiya tətbiq edirdi. Depressiya? Lobotomiya. Narahatlıq? Lobotomiya. Şizofreniya? Lobotomiya. Yuxusuzluq? Lobotomiya. Migren? Lobotomiya. Homoseksuallıq? Lobotomiya (bəli, bir neçə sənədləşdirilmiş halda əməliyyat xüsusi olaraq “homoseksual meyli müalicə etmək” üçün istifadə edilmişdi). “Yeniyetmələrin sözə qulaq asmaması”? Bəzi hallarda Frimen 12 yaşlı uşaqlara belə lobotomiya tətbiq edirdi.

Onlardan biri — Hovard Dalli — 1960-cı ildə, on iki yaşında ikən, Frimen tərəfindən lobotomiya əməliyyatına məruz qaldı. Ögey ana uşağın "tənbəl", "xəyalpərəst" və "itaətsiz" olduğundan psixiatr şikayətlənirdi. Psixiatr onu Frimenə göndərdi. Frimen uşağa "uşaq şizofreniyası" diaqnozu qoydu — bu, müasir təsnifatda mövcud olmayan bir diaqnoz idi — və transorbital lobotomiya həyata keçirdi. Dalli sonradan sağ qaldı. Böyük çətinliklərlə həyat qurmağı bacardı — avtobus sürücüsü oldu. 2007-ci ildə o, National Public Radio-nun "Mənim Lobotomiyam" sənədli layihəsində öz hekayəsini danışdı. Bu, lobotomiya qurbanının sonradan ictimai şəkildə danışa bildiyi nadir hallardan biridir.

Əksəriyyəti — bacara bilmədi.

Əldə etdiyimiz statistik məlumatlar tam olmasa da, şoka salır.

1935-1960-cı illər arasında bütün dünyada müxtəlif təxminlərə görə yüz mindən iki yüz minə qədər lobotomiya aparılmışdır. Əksəriyyəti ABŞ-də həyata keçirilmişdir ki, burada metod ən fəal tətbiq olunurdu. Lakin həmçinin Böyük Britaniyada, Skandinaviyada, Kanadada, Yaponiyada, Fransada, İtaliyada, Almaniyada, Sovet İttifaqında da.

Müalicənin ölüm dərəcəsi 2 ilə 6 faiz arasında dəyişirdi. Yəni hər 50 xəstədən biri, bəzi hallarda isə hər 16 xəstədən biri sağ qalmırdı.

Sağ qalanların müxtəlif hesabatlar əsasında təqribən 40 faizində "yaxşılaşma" müşahidə olunub. Burada "yaxşılaşma" anlayışı demək olar ki, yalnız davranış baxımından müəyyən edilib: xəstə sakitləşib, idarəolunan hala gəlib, daha az aqressiv və etiraz etməyə daha az meylli olub.

Təxminən 40 faiz xəstədə heç bir gözəçarpan dəyişiklik olmadı.

Təxminən 20 faizində isə aşkar pisləşmə müşahidə olunub: ağır koqnitiv və emosional pozuntular, "tərəvəz" vəziyyəti, epileptik tutmalar, sidik-qada tutmama, tam müstəqillik itkisi.

Lakin hətta "yaxşılaşdırılmış" 40% da şəfa deyildi. Bu, şəxsiyyətin məhv edilməsi bahasına edilən davranış dəyişikliyi idi. Bu xəstələr narahat olmağı, hirs etməyi, etiraz etməyi dayandırdılar. Və yaradıcılığa son qoydular. Şadlıq hissini itirdilər. Xəyal qurmaqdan vaz keçdilər. Sevgi hissini unutdular. Frimenin yazdığı o "ev heyvanlarına" çevrildilər.

1950-ci il. Qərbdə neyrocərrahların skalpeli diri beyinləri metodik şəkildə itaətkar bulama çevirərkən, Sovet İttifaqı ağlasığmaz görünən bir addım atır. Lobotomiyanın rəsmi qadağanı. Planetdə "dayan!" deməyə cəsarət edən azsaylı ölkələrdən biri. Səhiyyə Nazirliyinin quru əmrində nazir Yefim Smirnovun imzası dayanır. Amma hər şey bu qədər sadədirmi? Doğrudanmı bu addımın arxasında yalnız humanizm durur? Səthin altına baxaq. Qadağanın səbəbi soyuq müharibənin dadını daşıyır — "burjua təbabəti"nə qarşı ideoloji qarşıdurma. Yad skalpelin amansızlığı çürüyən Qərbin növbəti sübutuna çevrildi. Yenə də fakt faktlığında qalır: Qərb klinikalarında lobotomiya öz dəhşətli şöhrətinin zirvəsini yaşayarkən, SSRİ-də onu kökündən yandırıb yox edirlər. XX əsrin sovet psixiatriyasının qaranlıq tarixində işıqlı bir üz də boylanır.

Lakin bu o demək deyil ki, Sovet İttifaqında psixocərrahiyyədən heç istifadə olunmurdu. Ayrı-ayrı hallar — xüsusilə stereotaksik əməliyyatlar şəklində — sonrakı onilliklərdə də davam edirdi. Ancaq ABŞ-dakı kimi lobotomiya kütləvi xarakter almadı.

ABŞ-də lobotomiya ancaq 1954-cü ildən sonra, amerikan bazarına ilk antipsixotik dərman olan xlorpromazinin gəlməsindən sonra tədricən tərk edildi. Bu dərman artıq iki ildən çoxdur ki, Fransada istifadə olunurdu. Şizofreniya xəstələrinə kömək edən həqiqi dərmanların ortaya çıxması aydın etdi ki,

beyini buzqıranla kəsməyə ehtiyac yoxdur. Bizim həblərimiz var.

Frimen 1967-ci ilə qədər son lobotomiya əməliyyatını həyata keçirdi. Bu əməliyyatın xəstəsi — Helen Mortensen — əməliyyat zamanı daxili qanaxma nəticəsində həlak oldu. Bu, Frimenin rəhbərliyi altında Mortensenin üçüncü ölümü idi — o, əvvəlki illərdə artıq iki dəfə lobotomiya olunmuşdu. Bu dəfə Frimen onun üçüncü əməliyyatını həyata keçirmək niyyətində idi. Bəlkə də o, artiq metodun vəd etdiyi kimi işləmədiyini başa düşürdü.

Bu hadisədən sonra Frimenə cərrahiyyə əməliyyatları aparmaq qadağan edildi. O, 1972-ci ildə vəfat etdi və ölümünə qədər öz təcrübəsini müdafiə edərək həyata keçirdiyi 3500 lobotomiya ilə fəxr etməyə davam etdi.

Lakin ən dəhşətli şey Frimenin özü deyil. Dəhşətli olan, Nobel Komitəsinin 1949-cu ildə, metodun ən aktiv şəkildə tətbiq olunduğu bir dövrdə Monişə mükafat verməsidir. Bu, keçmişdəki pioner işin tanınması deyildi. Bu, mövcud təcrübəyə aktiv dəstək idi. Bu, dünyanın ali elmi instutisiyasından verilmiş yaşıl işıq idi.

2011-ci ildə Torsten Vizel, özü də tibb üzrə Nobel mükafatı laureatı, 1949-cu il Nobel mükafatı haqqında açıq şəkildə belə demişdi: “Bu, dəhşətli bir səhv idi.”

Komitə isə həmin mükafatı heç vaxt rəsmi şəkildə geri götürmədi. Stokholmda Medal Zallarında hələ də Monişin portreti asılıb. Adı laureatlar siyahısındadır. Nobel laureatlarını sayanda onun adı da hamı ilə birlikdə sayılır.

Və burada bu fəslin ən acı nəticəsinə gəlirik. Nobel mükafatı kimi təqdim edilmiş psixiatriya səhvi — onu törədən elə həmin institut tərəfindən düzəldilmədi. Nobel komitəsi öz səhvini ayrı-ayrı alimlərin səsləri ilə etiraf etdi. Amma rəsmi olaraq — yox. İnstitusional olaraq — yox.

Bu, vacib bir dərsdir. Elm səhv edir. Lakin onun özünü düzəltmə mexanizmləri də var: təsadüfiləşdirilmiş nəzarətli təcrübələr, placebo, sistemli təhlillər, meta-analizlər. Bu mexanizmlər yavaş, lakin qaçılmaz şəkildə nəyin işlədiyini, nəyin işləmədiyini göstərir. Nəticədə lobotomiya elm tərəfindən ifşa edildi. Buzqıran tibbdən uzaqlaşdırıldı. Frimen peşədən qovuldu.

Lakin elmin institusional orqanları — akademiyalar, komitələr, redaksiyalar — çox vaxt bu prosesdən geri qalır. Onlar öz səhvlərini tanımaqda tərəddüd edirlər. Mükafatları geri çağırmaqdan çəkinirlər. Səssiz qalmağa üstünlük verirlər.

Və bu, müqəddimədə bəhs etdiyim o "səssiz auditoriya"nın başqa bir tərəfidir. Yalnız cəmiyyət deyil, ezoterika satıcıları minlərlə insanı gözü önündə aldadanda da susur. Elmi qurumlar isə bir zamanlar fəlakəti mükafatlandırdıqlarını etiraf etməkdən çəkindikləri zaman da sakit qalırlar.

Bu gün müasir psixiatriyada lobotomiya yerinə bir neçə başqa yanaşma — neyrocərrahi və nevromodulyasiya üsulları istifadə olunur. Dərin beyin stimulyasiyası (DBS) ağır obsesif-kompulsiv pozuntu və müqavimətli depressiya hallarında tətbiq edilir. Zinqlotomiya son dərəcə nadir hallarda, yalnız bütün digər üsullar kömək etmədikdə istifadə olunur. Həmçinin sterotaktik əməliyyatlar və transkranial maqnit stimulyasiyası da həyata keçirilir.

Bütün bu üsullar Freemenin etdiklərindən prinsipcə fərqlənir. Onlar nöqtəvi, geri çevrilə bilən və ya yarımgeri çevrilə biləndir. Bunları yalnız istisna hallarda tətbiq edirlər. Onlar xəstənin məlumat əsasında razılığını nəzərdə tutur, etik komitələrdən keçir və konkret nevrofizioloji modellərə əsaslanır.

Amma Frimenin qoyub getdiyi qorxu irsi — transorbital lobotomiya irsi, "baltacı" irsi — indiki psixi pozuntuların neyrocərrahiyyasında öz ağırlığını hələ də hiss etdirir. DBS-nin

kömək edə biləcəyi bir çox xəstə, "beyin əməliyyatı" sözlərini eşidən kimi bundan imtina edir. Və bu imtinada bir nə qədər haqlılıq var. Onun ölümündən yarım əsr sonra belə biz hələ də Frimenin əks-sədasını müşahidə edirik.

Bu da onun arxasında qoyub getdiyi bir səhvdir. O, sadəcə əməliyyat etdiyi xəstələrin həyatını dağıtmaqla qalmadı. O, bütöv bir tibb sahəsinə olan inamı nəsillər boyu zəhərlədi.

Nobel mükafatı — bir bədheybətin doğulmasına kömək edən ağır bir yükdür.

Bir neçə onillik keçdikdən sonra Frimenin ölümündən sonra onun adı psixiatriya dərsliklərində demək olar ki, söyüş sözünə çevrildi. Nobel mükafatçısı Moniş isə dərsliklərdə hələ də görkəmli alim kimi qalır. Məhz bu boşluqda — dərsliklərdəki qəbul ilə real qiymətləndirmə arasında — elm tarixindəki ən böyük həll olunmamış etik problemlərindən biri öz varlığını davam etdirir.

Bugün faciəli səhvlərə çevrilmiş metodlara görə Nobel mükafatlarını geri çağırmaq üçün əlimizdə dürüst bir mexanizm varmı?

Hələlik — yox. Amma elm dünyasının qarşısında duran bu sual, durmağa da davam edəcək. Biz cəsarət edib də belə məsələləri rəsmi səviyyədə qoyduğumuz gün isə — elm adını layiqincə daşıyan bir psixiatriyaya bir addım daha yaxınlaşacağıq.

Sonrakı düstur. Bir çimdik həqiqət: frontal lobların zədələnməsi davranışı dəyişir — şimpanze Bekki narahatlığını itirdi. Həddindən artıq ümumiləşdirmə: "deməli, frontal bağların kəsilməsi ruh xəstəliklərini müalicə edir". Metod: lobotomiya — iki meymun haqqında məruzədən bir neçə ay sonra. Sənaye: yüz minə qədər əməliyyat, Frimenin konveyeri, Nobel mükafatı. Qurbanlar: ölənlər və əlil qalanlar, Rozmari Kennedi, Haouard Dalli — və nəsl boyu bir tibb qoluna olan inam.

Fəsil 8. Sovet psixiatriyasının qaranlıq səhifəsi

1971-ci ildə SSRİ-nin məhkəmə psixatriyasının aparıcı qurumu olan Moskvadakı Serbski İnstitutunda müayinə keçirildi. Xəstə Ukraynalı riyaziyyatçı Leonid Plyuş idi. Ona SSRİ Cinayət Məcəlləsinin 70-ci maddəsi əsasında — "antisovet təşviqat və təbliğat" ittihamı qoyulmuşdu. Plyuş dissidentlərin müdafiəsi üzrə bir neçə məktub yazmış, samizdat fəaliyyətində iştirak etmiş və etiraz müraciətlərini imzalamışdı.

Akademik Andrey Vladimiroviç Snejevski başda olmaqla komissiya Plyuşa "zəif proqressiyalı şizofreniya" diaqnozu qoydu. Bu diaqnozla o, SSRİ Daxili İşlər Nazirliyinin Dnepropetrovsk xüsusi psixiatriya xəstəxanasına — SSRİ-nin ən sərt psixiatriya həbsxanalarından birinə göndərildi. Orada ona sülfozin, həlqələk haloperidol, triftazin və insulin inyeksiyaları edildi.

Plyuş psixiatriya xəstəxanasında demək olar ki, üç il keçirdi. Onu yalnız genişmiqyaslı beynəlxalq kampaniyadan, qərb psixiatrlarının, siyasətçilərin və riyaziyyatçıların təzyiqi nəticəsində azad etdilər. Nəhayət, 1976-cı ildə sərbəst buraxıldıqda və Fransaya miqrasiya etdikdə, onu müstəqil psixiatrlar müayinə etdi. Heç kim onda şizofreniya əlaməti tapmadı. Nə zəif proqressiyalı, nə də hər hansı digər növ.

Plyuşun işi çoxsaylı hallardan biri idi. 1970-ci illərdə SSRİ-də Snejevski məktəbinin ixtirası olan "zəif proqressiyalı şizofreniya" diaqnozu siyasi repressiyalar alətinə çevrildi. Müxtəlif qiymətləndirmələrə görə, bu onillikdə Sovet İttifaqının "xüsusi" və "ümumi" tipli psixiatriya xəstəxanalarından yüz-

lərlə müxalifət keçdi. Mühəndislər, yazıçılar, keşişlər, fəhlələr, Krım tatarları, baptistlər, yəhudi fəalları, Ukrayna millətçiləri — partiyanın mövqeyindən fərqli fikirlər söylədikləri üçün psixiatrik diaqnoz aldılar.

Bu, sovet tibb tarixində ən dəhşətli təhrif idi. Və o, kənardan, hansısa siyasi idarələrdən gəlməmişdi. O, psixiatriyanın öz içindən gəlmişdi.

Bunun necə mümkün olduğunu anlamaq üçün Andrey Vladimiroviç Snejnevski (1904-1987) şəxsiyyətindən başlamaq lazımdır.

Snejevski siyasi funksioner deyildi. O, alim idi. 1962-ci ildən SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının Psixiatriya İnstitutunun direktoru, akademik, Lenin mükafatı laureatı idi. Görkəmli klinisist. Ciddi təşkilatçı. Sovet dövrünün ən nüfuzlu psixiatrlarından biri. Onun əsərləri bir çox dillərə tərcümə olunub. Sosialist dünyasının hər yerindən onun yanına öyrənməyə gəlirdilər.

Snejevski öz şizofreniya konsepsiyasını yaratdı. O, qərbdəkindən köklü şəkildə fərqlənirdi. Şizofreniya — təcrid olunmuş bir epizod deyil. Bu bir davamlılıqdır. Müxtəlif ciddilik dərəcəsi və dinamikası olan sonsuz bir spektr. O, üç formasını fərqləndirdi: davamlı gedişli, epizodik-rekurent və üçüncü, ən vacib, zəif proqressiyalı, yavaş inkişaf edən. Bu quru terminin arxasında nə gizləndi? Minlərin taleyini dəyişən bir sirr. Xəstədə parlaq hallüsinasiya yox idi. Delir yox idi. Kəskin tutmalar yox idi. Bədən spazmlarda gərilmirdi. Ağıl qışqıran qırıqlara bölünmürdü. Hər şey olduqca normal görünürdü. Amma Snejevski başqa cür gördü. Bu normal olanda bir diaqnoz gizləndi. Onun konsepsiyasına görə, zəif proqressiyalı şizofreniya silinmiş, çətin seçilən simptomlarla xarakterizə olunurdu: “xüsusi düşünüş tərzi”, “qəribə maraqlar”, “artıb gedən emosional kasıblıq”, “həqiqətin səhv qiymətləndirilməsi”. Və buna görə də — şizofreniya.

Bütün maraqlı məqam da buradan başlayır. Qərb psixiatriyası — DSM, ICD, siyahılar deməkdir. Şizofreniya diaqnozunun dayandığı dörd sütun: halüsinasiyalar, sayıqlamalar, nizamsız təfəkkür, neqativ simptomlar. Bunlardan heç olmasa birini çıxar — diaqnoz dağılır. Bütün Qərb dünyası belə işləyir. İndi diqqətlə baxın. Sovet konsepsiyasında bu simptomlardan heç biri məcburi deyildi. Heç biri. Adam səs eşitməyə bilərdi, sayıqlaya bilməzdi, fikirlərini ardıcıl və məntiqli ifadə edə bilərdi, iradəsini və emosiyalarını itirməyə bilərdi. Bütün Qərb dərsliklərinə görə — o, sağlamdır. Sovet konsepsiyasına görə isə — o, artıq xəstədir. Bəs nə qalırdı? Nə kifayət edirdi? Cəmi iki şey: "qəribə xarakter" və "islahatçı ideyalar". İki söz — və "ləng şizofreniya" diaqnozu birdəfəlik yapışdırılır.

Sovet sistemi məhz bu nöqtədən yapışdı.

Əgər "islahatçı ideyalar" diaqnoz meyarıdırsa, onda istənilən dissident ruhi xəstə sayıla bilərdi. Üstəlik, sadəcə xəstə deyil, şizofreniya xəstəsi — yəni ömürlük xəstəlik, məcburi müalicə tələb edən və yalnız ixtisaslaşdırılmış xəstəxananın divarları arxasında təhlükəsiz olan bir xəstəlik.

1969-cu ildə KQB Yuri Andropovun imzaladığı rəsmi məruzədə Sov. İKP Mərkəzi Komitəsinə psixiatriyadan məhkəmə sistemini yan keçmək aləti kimi istifadə etməyi təklif etdi. İş burasındadır ki, açıq siyasi məhkəmələr, xüsusən də 1966-cı ildə Sinyavski və Daniel işindən sonra Qərb mətbuatının diqqətini cəlb etməyə və sovet ədalət mühakiməsinin nüfuzunu ləkələməyə başlamışdı. Psixiatrik müayinə isə qat-qat asan idi. Açıq məhkəmə lazım deyil. Beynəlxalq müşahidəçilər lazım deyil. Diaqnozu psixiatrlardan ibarət komissiya qoyur. Qərar — formal olaraq — hüquqi deyil, tibbi qərardır. Özünü ifadə qabiliyyətini itirmiş sayılan pasiyent qeyri-müəyyən müddətə xüsusi psixiatrik xəstəxanaya göndərilir — komissiya onun "sağaldığına" qərar verənə qədər.

Təcrübə geniş yayıldı. Dnepropetrovsk, Sıçevka, Kazan, Blaqoveşşensk, Oryol, Leninqrad, Çernyaxovskdakı Daxili İşlər

Nazirliyinin xüsusi psixiatrik xəstəxanalarında onlarla, bəzi hesablamalara görə isə yüzlərlə dissident vardı. Ən məşhurları arasında — yazıçı Vladimir Bukovski, riyaziyyatçı Leonid Plyuşç, general Pyotr Qriqorenko, şair Viktor Nekipelov, insan haqları müdafiəçisi Natalya Qorbanevskaya ki, onu "ləng şizofreniya" diaqnozu ilə Dnepropetrovsk xüsusi xəstəxanasında saxlayırdılar.

Bu xəstəxanalarda silah sovet psixiatriyasının 1960-1970-ci illərdəki bütün arsenalı oldu. Sülfozin. Ağır ekstrapiramidal yan təsirlər — əzələlərin iztirablı gərginliyi, titrəmə, şiddətli distoniya doğuran böyük dozalarda haloperidol. Triftazin. Majeptil. Kütləvi dozalarda aminazin. Elektroşok — nə anesteziya, nə əzələ gevşetici olmadan. 1930-cu illərin ilk forması — cəhənnəm qıcolmaları pasiyentlərin sümüklərini sındırır, əzələlərini cırırdı. İnsulin komaları.

Plyuşçun azadlığa çıxdıqdan sonrakı ifadələri, Bukovskinin "Və külək qayıdır" (1978) kitabındakı şahidlikləri, Qriqorenkonun "Yeraltında yalnız siçovullara rast gəlmək olar" (1981) xatirələrindəki məlumatları, Natalya Qorbanevskayanın hesabatları — hamısı eyni dəhşəti təsvir edir. Tibbi preparatlar müalicə kimi deyil, nəzarət aləti kimi tətbiq olunurdu. Sülfozin işgəncə vasitəsi idi — üç kub inyeksiya elə bir ağrı doğururdu ki, pasiyent bir neçə gün yerindən tərpənə bilmirdi. Korrektor olmadan böyük dozalarda haloperidol akatiziya — durmaq, oturmaq, uzanmaq mümkün olmayan iztirablı hərəkət narahatlığı doğururdu. Bəzi pasiyentlər fiziki ağrıya üstünlük verərdilər.

Bu kimyəvi işgəncə idi. Görünən iz qoymurdular. "Müalicə" kimi görünürdülər. Tibbi dilə sığınırdılar.

Əslində isə bu işgəncə idi. Tibbi kontekstin gətirdiyi o etik neytrallıq olmadan.

1971-ci ildə sovet psixiatriya müəssisələrindən dəfələrlə keçmiş Vladimir Bukovski Qərbə altı dissidentin xəstəlik tarix-

çəsini əks etdirən sənədləri ötürməyi bacardı. Həmin şəxslər sovet cəza psixiatriyasının qurbanına çevrilmişdilər. Bu materiallar tərcümə edilib nəşr olundu və böyük beynəlxalq əksəsəda doğurdu.

1977-ci ildə Honoluluda keçirilən Dünya Psixiatriya Assosiasiyasının (World Psychiatric Association, WPA) konqresində Sovet nümayəndə heyəti sərt tənqidlə üzləşdi. Burada Hawaii Deklarasiyası qəbul edildi — bu, WPA-nın tarixindəki ilk rəsmi etik kodeks idi və psixiatriya vasitələrinin siyasi məqsədlər üçün istifadəsinin qəbuledilməzliyi açıq şəkildə qeyd olunurdu.

Sovet psixiatriyası tənqidi də, bəyannaməni də görmazlığa vurdu. Fikri başqa cür olanları "müalicə etməyə" davam edirdi.

1983-cü ildə Vyanada keçirilən WPA konqresində Ümumittifaq Psixiatrlar Cəmiyyəti (sovet psixiatrlarının peşəkar təşkilatı) xaric edilmə təhlükəsi altında WPA-dan çıxmağa məcbur oldu. Bu, dünya psixiatriya tarixində misli görünməmiş bir hadisə idi. Bütöv bir milli məktəb beynəlxalq peşəkar birliyin xaricində qaldı.

Sovet tərəfi WPA-ya yalnız 1989-cu ildə qayıtdı — yenidənqurma dövründə, qismən etiraflardan və islahat vədlərindən sonra.

1984-cü ildə ABŞ-da Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Komissiyasının (CSCE) dinləmələrində çıxış edən keçmiş sovet psixiatrı-mühacirlər sistemi içəridən təsvir etdilər. 1989-cu ildə APA (American Psychiatric Association) nümayəndə heyəti sovet psixiatriya xəstəxanalarına səfər etdi. Nümayəndə heyətinin hesabatı dövrün ən mühüm sənədlərindən birinə çevrildi. Amerika psixiatrları təsdiqlədilər: onlar psixiatriyadan siyasi məqsədlərlə sui-istifadənin çoxsaylı hallarını aşkar etmişdilər.

SSRİ-nin 1991-ci ildə dağılması postsovet məkanına formal olaraq yeni bir dövr gətirdi. "Ləng gedən şizofreniya" konsepsiyası sovet formasında rəsmən rədd edildi. 1990-cı illərdə tətbiq olunan ICD-10 belə bir diaqnozu ehtiva etmir. Psixiatriya vasitəsilə siyasi repressiyalar açıq kütləvi şəkildə dayandı.

Lakin ətalət yaşamaqda davam edirdi.

2001-ci il. Sankt-Peterburq. V. M. Bekterev adına Psixonevroloji İnstitut. Postsovet məkanının aparıcı psixiatriya müəssisələrindən biri. İxtisasa başlamaq üçün məhz bura gəlmişdim. Bekterev institutu. Nəhəng tarixi olan bir məkan. Divarların hər şeyi xatırladığı yer. XIX əsrin sonu — XX əsrin əvvəli. Bu dəhlizlərdə bizzat Vladimir Mixayloviç Bekterev dərs deyirdi. Onun kölgəsi hələ də burada görünməz şəkildə mövcud idi. Amma onu təkcə bu yer hərəkətə gətirmirdi. Sovet dövrünün görkəmli psixiatrları öz izlərini qoymuşdular: İvan Sluçevski, Mixail Kabanov, Raisa Qolant, Boris Voskresenski. Onların adları bu müəssisənin yaddaşına həkk olunub. Və indi də bura oxumağa gəlirlər — MDB ölkələrindən, Şərqi Avropadan, Asiyadan. Onları nə cəlb edir? Bilik? Təcrübə? Yoxsa bu divarlarda gizlənən sirlər?

Bexterev İnstitutunda Sovet psixiatriya məktəbinin ən yaxşı tərəflərini görmək mümkün idi. Düşüncəli, bəzən fövqəladə klinisistlər. Dərin klinik təhlillər. Xəstəyə diqqət və qayğı. Bexterevin özündən qaynaqlanan humanist ənənə. Mən müəllimlərimdən çox şey öyrəndim və onlara dərin minnətdaram.

Lakin Bexterevdə də — postsovet məkanının hər yerində olduğu kimi — kölgəli tərəflər vardı ki, bu kitabda onlar barədə susmağa haqqım yoxdur.

Klinika. Yaşıl boya ilə ləkələnmiş sakit dəhliz. Divarda ildırımın ziqzaqına bənzəyən çat. Kabinet qapısının arxasında otuz beş yaşlarında bir kişi yumruqlarını sıxaraq pəncərədən bayıra baxır. Onu bura bir saat əvvəl gətirmişdilər: küçədə qışqırır, əllərini yelləyirdi. Bəlkə boşanmaya reaksiyadır. Bəlkə

doza həddinin aşılmasıdır. Bəlkə maniakal tutmadır. Amma artıq qırx dəqiqə sonra onun kartına səliqəli bir qeyd düşəcək: "F20.0 — paranoid şizofreniya". Mürəkkəb möhürü. Düzəliş hüququ olmadan. Qərb psixiatrı diaqnozu beş ildən sonra yenidən yoxlayacaq. Burada isə o, damğaya çevriləcək. Bu diaqnoz xəstəlik tarixçəsində sadəcə bir sətir deyil. O, işi əlindən alacaq. Sürücülük vəsiqəsindən məhrum edəcək. Nikah müqaviləsini skalpel kimi kəsəcək. Karton üzlük. Mavi möhür. Hökm.

Xeyr, burada birbaşa mənada cəza psixiatriyası yox idi. Amma bu, elə bir mədəniyyətin mirasıdır ki, orada diaqnoz elmi əsaslı klinik rəydən çox, sosial damğa kimi işləyir.

İkincisi — fiksasiya təcrübələri. Şöbələrdə uzun müddət çarpayılara bərkidilmiş xəstələr görmüşdüm — bəzən bütün sutka boyu. Formal olaraq bu, "həyəcan zamanı məcburi üsul" idi. Lakin əslində bu, çox vaxt personal çatışmazlığının və yumşaq sedativ üsulları və ya gücləndirilmiş qulluq tətbiq etmək əvəzinə mexaniki saxlamaya əl atma vərdişinin nəticəsi olurdu.

Üçüncüsü — dildir. Heyət xəstələr barədə tez-tez şəxsiyyətsizləşdirən tərzdə danışırdı. "12-ci palatadan olan xəstə". "On dördüncüdəki şizofrenik". Adı ilə yox. Şəxsiyyət kimi yox. Öz nəzarət qrupundakı statistik vahid kimi.

Dördüncü — EST praktikaları. Burada bir az dayanmağa dəyər. Bextyerev klinikasında elektroşok tətbiq olunurdu və bu, peşə baxımından özünü doğruldurdu — EST, növbəti fəsildə göstərəcəyim kimi, müəyyən vəziyyətlərdə sübut edilmiş effektivliyə malikdir. Lakin onu necə tətbiq edirdilər? Cavab adamı ürpədir. Postsovet klinikalarındakı metodika dünya standartlarından amansızcasına geri qalırdı. Anesteziya? Həmişə deyil. Bədəni dağıdıcı qıcolma zərbəsindən qoruyan əzələ relaksantları? Həmişə deyil. Beynə çırpılan gərginlik və cərəyan parametrləri? Həmişə müasir standartlara cavab vermirdi. Hətta kursdakı sessiya sayının da həmişə heç olmasa

bir əsası olurdu. Niyə? Sistem buna necə yol verə bilərdi? Cavabı o dövrün psixiatriyasının öz mexanizmində gizlənən bir tapmaca.

Beşinci. Bəlkə də — ən vacibi. Sual verməmək mədəniyyəti. Gənc həkim şöbənin kandarını aşır — və tələyə düşürdü. Ona narahat suallar vermək qadağan idi. Cavab tələb etmək qadağan idi: niyə bu xəstəyə bu qədər böyük dozada haloperidol vurulur? Şöbə müdirilə mübahisə etmək qadağan idi. Xarici jurnallarda oxuduğu alternativ yanaşmaları təklif etmək qadağan idi. Əgər yenə də soruşurdusa — dərhal dərisində hiss edirdi: növbəti dəfə sussan yaxşıdır.

Bu sualsızlıq mədəniyyəti — sovet sisteminin birbaşa mirasıdır. Həmin sistemdə iyerarxiya həqiqətdən daha vacibdir. Böyüklərin təcrübəsi tədqiqat nəticələrindən üstün tutulur. "Ələ belə olub" ifadəsi isə kifayət qədər əsasdır.

Məhz bu mədəniyyətdə bu kitabda yazdığım bütün səhvlər kök salıb. İnsanlar pis olduqları üçün deyil, susmağa öyrəşdikləri üçün belədir.

2026-cı ilə qayıdıb geriyə nəzər salarkən sovet psixiatriyası və onun mirası barədə vacib bir şey demək istəyirəm.

Bütün sovet psixiatriyası cəzalandırıcı deyildi. Onu yalnız işgəncə aləti adlandırmaq — həqiqəti kobud şəkildə təhrif etmək deməkdir. Milyonlarla xəstə ölkənin psixiatrik müəssisələrindən keçmişdi və onların çoxu həqiqətən kömək alırdı. Pulsuz, əlçatan, öz sərt məhdudiyyətləri çərçivəsində isə — vicdanla. SSRİ-də geniş psixiatrik xidmət şəbəkəsi fəaliyyət göstərirdi, gözəl klinisistlər yetişdirilirdi. Lakin başqaları da var idi — susmaqdan imtina edənlər, sistemin sui-istifadələrinə müqavimət göstərənlər və bunun əvəzini öz karyeraları ilə ödəyənlər. Dissident psixiatrlar Semyon Qluzman, Aleksandr Voloşanoviç — onların adları ağ xalatlılar imperiyasına atılan etiraz çağırışına çevrildi.

Lakin sovet psixiatriyası özünü daxili sui-istifadələrdən qoruya bilmədi. Effektiv etik mexanizmlər yaratmadı. Gənc həkimin böyük həmkarının qərarını mübahisə edə biləcəyi bir mədəniyyət qura bilmədi. "Asta gedən şizofreniya" konsepsiyasını lazımi metodoloji tənqid olmadan qəbul etdi və bu konsepsiya repressiv dövlətin əlində alətə çevrildi.

Buna görə məsuliyyət yalnız KQB-nin, yalnız Snejnevskinin, yalnız Serbski İnstitutunda "ekspert rəyi" imzalayan psixiatrların üzərinə düşmür. Bu məsuliyyət bütün peşənin üzərinə düşür. Baş verənləri bilən, ya da bilə biləcək milyonlarla həkimin üzərinə düşür — susan həkimlərin.

Mən də bu sükut zəncirində idim. 2000-ci illərin əvvəllərində olmamalı olan şeyləri gördüm və susdum, çünki gənc idim, səsim yox idi, qorxurdum. İndi də susmağa davam edən çoxlu həmkarlar tanıyıram — köhnəlmiş metodların tətbiq olunduğu şöbələrdə, xəstələrin səs hüququndan məhrum olduğu, iyerarxiyanın həqiqətdən üstün tutulduğu yerlərdə.

Bu kitab — mənim gecikmiş sözlərimdir. Susduğum zamanlarda danışmalı olduğumu etiraf edirəm. İndi isə danışmağa başlamaq cəhdim — təkcə keçmiş haqqında deyil, müasirlik haqqında da. Təkcə sovet dövründən deyil, həm də ondan bizə miras qalan və hələ də divarlarımızda yaşayan şeylərdən də danışmaq istəyirəm.

Snejnevski 1987-ci ildə, yenidənqurmanın lap başlanğıcında vəfat etdi. O, 1990-cı illərdə ICD-nin rəsmi nəşrlərinin "yavaş gedən şizofreniya" konsepsiyasından imtina edəcəyini görməyə macal tapmadı. Onun irsinin yenidən nəzərdən keçiriləcəyini görməyə macal tapmadı.

Lakin onun təsiri yoxa çıxmadı. Onun şagirdlərindən və ya şagirdlərinin şagirdlərindən təhsil almış bir çox psixiatr bu gün də onun kateqoriyaları ilə düşünür. Postsovet psixiatriyası tamhüquqlu islahat prosesindən yalnız qismən keçdi. Bəzi

müəssisələrdə və keçmiş SSRİ-nin bəzi ölkələrində köhnə mədəniyyətin elementləri hələ də qalmaqdadır.

Bu abstrakt problem deyil. Bu, hər gün sovet paradigması ilə təhsil almış psixiatrın yanına konsultasiyaya gələn və həmin paradigmada formalaşmış diaqnoz, müalicə və damğa alan pasiyentlərin problemidir.

Sovet irsinin psixiatriya sahəsində aşılması — bir nəslin işi deyil. Bu, bir neçə nəslin əməyini, uzun, çətin və peşəkar mədəni fəaliyyəti tələb edir. Bu iş görülməlidir — əks halda repressiv psixiatriyanın kölgələri klinikalarımızdan getməyəcək. Özlüyündə yox olmayacaqlar. Onları qovanmaq lazımdır — elmə, etikaya və cəsarətə söykənərək, şüurlu şəkildə.

Bu, öz şeytanlarımızı qovmaq prosesidir. Orta əsrlərdən deyil, bu günümüzdən bəhs edirik. Ayinlərlə deyil, islahatlarla həyata keçirilir.

Növbəti bölmələrdə — müasir cəhalət pandemiyasının izinə düşəndə — bizi böyük bir ifşa gözləyir. Görməliyik ki, sovet psixiatriyası bizə sadəcə metodlar deyil, bir virus da miras qoyub. Sükut mədəniyyətini, yalançı iyerarxiya mədəniyyətini, kor-koranə "belə adətdir" mədəniyyətini. Bu virus isə təkcə xəstələrə qarşı fəaliyyət göstərmir. Bu gün mistik xidmətlər satanların da əlinə oynayır. Çünki sükut universal bir resursdur. Şəkilsiz, mütləq bir resurs. Onu istifadə edə bilmək üçün hər kəsə yol açır.

Və biz, psixiatrlar, öz günahlarımız barədə susduqca, cəmiyyətdən tələb etməyə mənəvi haqqımız yoxdur ki, o, düzənləyicilərin, reqressoloqların və saxta xoşbəxtlik satanların günahları barədə danışsın.

Özümdən. Özümdən başlayaq.

Fəsil 9. Ququ quşu yuvasının üzərindən uçarkən: bir hekayənin iki tərəfi

Romada, 1938-ci ilin aprelində, La Sapienza Universitetinin psixiatrik klinikasında iki həkim tibb tarixinə düşəcək bir eksperimentə hazırlaşırdı.

Onların adları Ugo Çerletti (Ugo Cerletti, 1877–1963) və Lucio Bini (Lucio Bini, 1908–1964) idi. Amma onları psixiatriya palatalarının qaranlığından keçirən ideya onlara məxsus deyildi. Bundan bir neçə il əvvəl macar psixiatr Ladislaus Meduna (Ladislas von Meduna, 1896–1964) maraqlı bir klinik fakt aşkar etmişdi. Eyni zamanda şizofreniyadan əziyyət çəkən epilepsiya xəstələrində sayıqlama geri çəkilirdi. Hər epileptik tutmadan sonra psixotik simptomatika zəifləyirdi. Yoxsa dəliliyi tutma ilə aradan qaldırmaq mümkündür? Meduna təcrübə keçirməyə qərar verdi. Qıcolma tutmaları şizofreniyada müalicəvi ola bilər. O, bunları süni yolla yaratmağa başladı — əvvəlcə kobud kamfora inyeksiyaları ilə, sonra daha idarəolunan bir preparatla — kardiazol ilə. Metod işləyirdi. Bəs hansı qiymətə? İnsanın daxilində ilkin qorxu artırdı. Bədəni silkələyən qıcolma bükməzdən əvvəl xəstə boğulma hissi keçirirdi. Kəskin qorxu boğazı sıxırdı. Yenə də klinik effekt var idi.

Çerletti və Bini fikirləşdilər: bəlkə qıcolma tutmasını başqa üsulla — daha idarəolunan və daha az travmatik bir yolla çağırmaq olar? Elektriklə?

Onlar Romdakı qəssabxanalarda donuzlara kəsimdən əvvəl elektrik cərəyanı verildiyini müşahidə edirdilər. Cərəyan

donuzlarda qısa qıcolmalar yaradırdı. Çerletti optimal parametrləri öyrənmək üçün icazə istədi, təcrübələr apardı və müəyyən etdi: gərginlik təqribən 80–120 volt, təsir müddəti — saniyənin bir neçə payı, elektrodlar gicgahlarda.

Birinci pasiyent. Qırx yaşlarında kişi. Diaqnoz — ağır paranoyid psixoz. Onu klinikaya gətirdilər və o, metodu sınadıqları ilk adam oldu. Birinci cərəyan — gərginlik azdır. Bədən reaksiya vermədi. Nə qıcolma, nə tutma. Çerletti gərginliyi artırdı. İkinci cərəyan. Qısamüddətli əzələ spazmı. Yenə də — tam tutma yoxdur. Köməkçi dayanmağı təklif etdi. Pasiyent iki cərəyan zərbəsindən sonra özünə gəldi və aydın şəkildə latınca dedi: “Non iterum!” “Yenidən yox!”

Çerletti bu ifadəni yadda saxladı. Sonrakı xatirələrində etiraf etdi: bu, fəlsəfi etiraz kimi səsləndi. Amma o zaman dayanmadı. Gərginliyi artırdı. Üçüncü cərəyan. Bu dəfə — tam epileptiform tutma. Bir neçə dəqiqə sonra pasiyent özünə gəldi. Çerletti və Bininin hesabatlarına görə, psixotik simptomatikada yaxşılaşma müşahidə olundu.

Metod elektrokonvulsiv terapiya (EKT) və ya elektrotutma terapiyası adını aldı. Bu üsul tez bir zamanda bütün dünyaya yayıldı.

İlkin formasında EKT anesteziyasız, miorelaksantsız, monitorinqsiz tətbiq olunurdu. Pasiyenti küncə uzadır, əlləri ilə saxlayırdılar. Canlı bədən — yad bir vəhşi güclə. Elektrodları gicgahlara qoyur, cərəyan verirdilər və bədən partlayırdı. Ümumiləşmiş qıcolma tutması insanı bütövlükdə bürüyür, əzələləri elə dağıdıcı güclə bükürdü ki, toxuma cırılır, skelet çatıldayırdı. Onurğa fəqərələrinin, bud sümüklərinin sınıqları. Çiyin oynaqlarının çıxıqları. Əzələ yırtıqları. Çənələr elə sıxılırdı ki, dişlər dili qan içində kəsirdi — amansız zədələr hər nəfəsi ağrı ilə deşirdi. Tutma keçirdi. Amma arxada nə qalırdı? Yandırılmış boşluq. Qarışıqlıq. Dezorientasiya. Müvəqqəti amneziya və nitq pozuntuları — bir anda lövbərindən qoparılmış şüur.

Bütün bunlara baxmayaraq, metod tətbiq olunmağa davam edirdi. Və sadəcə tətbiq olunmur, 1940–1950-ci illərdə psixiatrik xəstəxanaların əsas metodlarından birinə çevrilirdi. Niyə? Çünki sülfozin və ya lobotomiyadan fərqli olaraq, o, həqiqətən kömək edirdi. Çerletti və Bininin düşündüyü kimi şizofreniyada yox, ağır depressiyada, katatoniyada, affektiv komponenti aydın ifadə olunmuş bəzi psixoz formalarında. Həftələrlə dərin depressiyada qalan və ya katatonik stuporda hərəkətsiz uzanan pasiyentlər bir neçə EKT seansından sonra həyata qayıdırdılar. Bu nəzərə çarpırdı. Bu klinik cəhətdən inandırıcı idi.

Amma bunun necə göründüyü — fiziki, vizual, insani baxımdan — dəhşətli idi.

1959-cu il. Menlo-Park, Kaliforniya. Gecə. Gənc yazıçı Ken Kizi veteran xəstəxanasının astanasından keçir. İyirmi dörd yaşı var. O, Stenfordu təzəcə bitirib, yazıçılıq ustalığı şöbəsində bədii qələmini bizzat Uolles Stegnerin rəhbərliyi altında itiləyib. Amma indi onun iş aləti artıq mürəkkəb deyil. Onun yeri — psixiatrik şöbədir. Zülmət qaranlıqda növbətçilik. O nə görür? Amansız elektroşok cərəyanı altında qıcolmalarla silkələnən bədənlər. Xlorpromazinin böyük dozaları ilə əzilmiş şüurlar — sakit, itaətkar, sıfıra silinmiş. Burada kim hökmranlıq edir? Sanitar qadınlar. Baş tibb bacıları. Onların hakimiyyəti mütləqdir, sərhədsizdir. Onlar nəzarətçilərdir, pasiyentlər isə eyni otaqların əbədi məhbuslarıdır. İl illərlə. Ümidsiz. Çıxışsız. Kizi baxır. Kizi yadda saxlayır. Elə bu qaranlıq yanacağa çevriləcək. Elə bu sistem içdən partlayacaq.

Bu dövrdə olduğu kimi Kizi də müxtəlif psixi araşdırmalarda iştirak edirdi — hələ qadağan olunmayan və ciddi alimlər tərəfindən mümkün müalicə vasitəsi kimi tədqiq edilən LSD-nin təsiri ilə bağlı təcrübələrdə iştirak edirdi. Dərman reseptinə uyğun alır və hisslərindən yazırdı. Bu izləri onun psixiatriya şöbəsindəki müşahidələri ilə birləşdi.

1962-ci ildə o, ilk romanını — "Ququ yuvası üzərindən uçuş" əsərini nəşr etdirdi. Kitab böyük uğur qazandı. Əsərin qəhrəmanı, irlandiyalı pozğun və iradəsiz insan Randl Patrik Makmerfi həbsdən yayınmaq üçün psixi xəstəliyi özünə varmış kimi göstərir və qəddar baş tibb bacısı Reçedin idarə etdiyi psixiatriya şöbəsinə düşür. Kitabın kulminasiyasında Makmerfi nizam-intizamı pozduğuna görə cəza kimi elektroşok müalicəsinə məruz qalır. Əsərin sonunda isə onu tamamilə iradəsiz edən lobotomiya əməliyyatından keçir.

Roman 1975-ci ildə çex rejissoru Miloş Forman tərəfindən Cek Nikolsonun baş rolda oynadığı filmə çevrildi. Film "Ən yaxşı film", "Ən yaxşı rejissor", "Ən yaxşı kişi rolu" (Cek Nikolson), "Ən yaxşı qadın rolu" (Reçed rolunda Luiç Fleçer) və "Ən yaxşı uyğunlaşdırılmış ssenari" nominasiyalarında beş "Oskar" mükafatı qazandı. Bu, anti-psixiatriya tarixinin ən parlaq əsərlərindən birinə çevrildi.

Və bu, bütöv bir nəslin psixiatriyanın nə olduğu barədə təsəvvürünü formalaşdırdı.

"Ququ yuvası üzərindən uçuş" — öz dövrünə qarşı ağır zərbə idi. Həqiqəti üzə çıxaran və üstündəki bütün pərdələri yırtan bir kitab idi. XX əsrin ortalarında psixiatriya şöbələrinin qapıları arxasında nələr gizlənirdi? Az sayda xəstənin səsi. İşçilər tərəfindən özbaşınalıq. "Müalicə" adı altında gizlədilən, amma əslində kobud şəkildə nəzarət üçün istifadə edilən üsullar. Elektroşok. Anesteziya olmadan. Cərəyan bədəni yandırır, əzələləri qıcolğa salır, şüur isə səssiz qışqırıq içində əzilir. Son çarə kimi lobotomiya. Polad bıçaq beyinə girir və şəxsiyyətin görünməz iplərini sonsuz üçün kəsir. İnsan hələ nəfəs alır, amma artıq yoxdur — yalnız bir "tərəvəz vəziyyəti", işıqsız bədən qalır. Bütün bu mənzərə heç də karikatura deyil. Bu, tarixən doğru reallıq əksidir. Kizi bunları öz gözləri ilə görmüşdü. 1959-cu il. O, orada dayanmış, xəstəxana efirini inhalə edir, boş gözlərə baxırdı — və hamı üçün ümumi heç kim tərəfindən mübahisə olunmayan reallığı qeyd edirdi.

Formanın 1975-ci ildə çəkdiyi film ən dəqiq anda meydana çıxdı. Tomas Sas, Ronald Leynq və Franko Bazalya tərəfindən başladılmış anti-psixiatriya hərəkatının zirvəyinə təsadüf etdi. Həmin il İtaliyada 180 saylı Bazalya Qanunu ilə böyük psixiatriya xəstəxanalarının bağlanmasına başlanıldı. Bütün qərb dünyasında psixiatriya xidmətlərinin islahatı müzakirə edilirdi. İctimai rəy köhnə üsullara qarşı kəskin şəkildə döndü.

"Ququ quşu yuvasının üzərindən uçarkən" filminin bu dönüşdə böyük rolu oldu. O, milyonlarla tamaşaçıda psixiatriyanı bütöv bir repressiya sistemi kimi dərindən və emosional şəkildə təsvir etdi. Elektroşok adi insanın şüurunda işgəncə ilə sinonimləşdi. Lobotomiya isə insanı tərəvüzə çevirmə sözü ilə. Psixiatrlar isə soyuq, mexaniki və qəddar Reçed sözü ilə.

Problem təkcə budur. Bu obraz həqiqətən XX əsrin ortalarına uyğun gəlir. Amma müasir psixiatriya praktikasına uyğun gəlmir. Faciə də elə bundadır.

Gəlin dürüst olaq. Gəlin iki ayrı məsələni bir-birindən ayıraq.

Birinci sual: XX əsr psixiatriyasında sistemli sui-istifadələr, köhnəlmiş üsullardan istifadə, xəstələrin insan ləyaqətindən məhrum edilməsi, cəza tədbirləri mövcud idimi?

Cavab: bəli. Bəli, mövcud idi. Snejnevskinin rəhbərliyi altında sovet xüsusi psixiatrik xəstəxanalarında. Frimin dövründə amerikan müəssisələrində. Avstraliyadakı Çelmsford "dərin yuxu terapiyası"nda (Chelmsford Deep Sleep Therapy) — 1963-1979-cu illər arasında bir psixiatrın fikirləşdiyi, on beş il boyunca heç kimin dayandırmadığı, nəhayət Kral Komissiyasının araşdırması başlayana qədər davam edən təcrübə nəticəsində 24 xəstə həyatını itirmişdi. Çətin yeniyetmələr üçün amerikan "islahxanalar"ında. 1940-1950-ci illərin klinikalarında, elektroşokun anesteziya olmadan tətbiq edildiyi yerlərdə. Bu siyahını uzatmaq olar. Kizi və Formanın təsvir etdiyi dünya — realdır.

İkinci sual: bu metodlar bu gün də eyni şəkildə tətbiq olunurmu? Müasir psixiatriya "Rətçed" sistemi kimi fəaliyyət göstərirmi?

Cavab: xeyr. Böyük əksəriyyətlə — xeyr. Və bu barədə köhnə sui-istifadələr qədər uca səslə danışmaq lazımdır.

Konkret bir nümunəyə baxaq — elektrokonvulsiv terapiya.

Müasir EKT 1940-1950-ci illərin prosedurları deyil. O vaxt bədən qıcolmalar içində əzilirdi. Sümüklər sınırdı. Əzələlər cırılırdı. Qışqırıqlar hələ də qulaqlarda səslənir. Bu gün hər şey başqadır. Xəstəyə ümumi anesteziya verilir. Şüur sönür. O, proseduru dərk etmir. Heç bir narahatlıq hiss etmir. Qana əzələ gevşediciləri yeridilir. Onlar əzələ qıcolmalarını iflic edir. Sınıqlar? Cırılmalar? Artıq baş vermir. Cərəyan səviyyəsi ciddi dozalanır. Nəzarət EES vasitəsilə həyata keçirilir — beynin hər impulsu nəzarət altındadır. Prosedur xüsusi avadanlıqla təchiz edilmiş palatada keçirilir. Reanimasiya dəstəyi hazır vəziyyətdədir. Xəstə yalnız narkoz verilənə qədər şüurlu qalır. Nəfəs alır. Qaranlıq. Növbəti xatirə — oyanma palatasında gözlərini açır. Bütün prosedur təxminən otuz dəqiqə çəkir. Yan təsirlər? Yalnız ilk saatlarda yüngül çaşqınlıq. Bəzən — qısamüddətli yaddaşın müvəqqəti pozulması. Amma yalnız prosedurla bağlı hadisələrə dair. Keçmişin kölgələri məğlub edilib.

Bu, Formanın filmində göstərilənlə tamamilə fərqlidir.

Amma əsas olan göz önündə gizlədilib. Müasir EKT sübuta əsaslanan effektiv metoddur. Tibb tarixində ən yaxşı öyrənilmiş üsullardan biri. Bu necə mümkündür? Həlli tələb edən sirr. Lakin faktlar amansızdır. Cochrane Library-dəki sistematik icmallar, Amerika Psixiatriya Assosiasiyasının (APA) təlimatları, Böyük Britaniyanın Səhiyyə və Klinik Mükəmməllik Milli İnstitutunun (NICE) protokolları, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (WHO) sənədləri — hamısı EKT-ni tanıyır. Müəyyən hallarda effektiv müalicə metodu kimi tanıyır. Dərman müalicəsinə cavab verməyən ağır depressiyada — ilk növbədə.

Kimya aciz qaldıqda, cərəyan qaranlığı deşib keçir. Psixotik xüsusiyyətlərlə müşayiət olunan ağır depressiyada da vəziyyət eynidir. Katatoniyada — xüsusilə həyat üçün təhlükəli, ölümcül olduqda, bədən daşa döndükdə və nəfəs tükəndikdə. Ayrı-ayrı hallarda — ağır maniya ilə müşayiət olunan bipolyar pozuntuda. Yaşlılarda bəzi psixoz formalarında.

ABŞ-da hər il təxminən 100 000 EKT seansı keçirilir. Böyük Britaniyada — təxminən 11 000. Aİ-də — yüz minlərlə. Əksər hallarda — məlumatlı razılıq alınmaqla, anesteziloji müşayiətlə, sənədləşdirilmiş klinik göstərişlə.

Burada psixiatr kimi mövqeyim tamamilə aydın olmalıdır.

Mən psixiatriyanın XX əsrdə etdiyi hər şeyin müdafiəçisi deyiləm. Bu kitabın səkkiz əvvəlki fəslində psixiatriyanın necə səhv etdiyini, insanları ziyan vurduğunu və öldürdüyünü yazmışam. 2000-ci illərin əvvəllərində Bakı və Sankt-Peterburq klinikalarında köhnəlmiş metodlara özüm şahid olmuşam. Mən hər hansı bir peşə dayağının nümayəndəsi deyiləm.

Məhz buna görə də əminliklə deyə bilərəm: müasir EKT (elektrokonvulsiv terapiya) əziyyət deyil. Bu, ağır depressiyadan əziyyət çəkən xəstələrin həyatını xilas edən, elmi əsaslandırılmış müalicə üsuludur.

Ağır depressiyalı bir qadın özünə qəsd etmək fikirləri ilə mübarizə aparır, yemək-içməkdən, yatmaqdan imtina edir, şəxsi gigiyenaya qayğı göstərə bilmir, həftələrlə antidepresantlar fayda vermir, ümidsizlik və intihar riski getdikcə artırsa — EKT onu həyata qaytaran yeganə üsul ola bilər. Və edir də. Hər gün. Dünyanın yüz müxtəlif klinikasında.

Ən qəribəsi isə budur: Kizinin romanı və Formanın filmi yaratdığı bu qəhvəyi əfsanə yaşamaqda davam edir və hər bir xəstəyə psixoloji təzyiq göstərir. EKT təklif edilən hər kəsə. Psixiatr prosedura yönləndirməzdən əvvəl bilir ki, bu söhbət əvvəlcədən qətiləşib. Yarımsaat. Ən azı. Əvvəlcə — anesteziya. Bəli, istifadə olunur. Sümükləri sındıracaq qədər güclü konvul-

siyalar olmayacaq. Xəstə bitki həyatına qayıtmayacaq. Yaddaş bərpa olunacaq. Bu, adi tibbi prosedurdur. Əməliyyat otağında. Hər hansı digəri kimi.

Bu inandırma mübarizəsi — həm resursları aparır, həm stiqmanı gücləndirir, həm də qərar vermə prosesini uzadır. Bəzi hallarda — EKT-dən fayda görə biləcək xəstənin imtina etməsinə və əziyyətini davam etdirməsinə səbəb olur, bəzən isə faciəli nəticələnir.

Beləliklə, 1950-ci illərin real sui-istifadələrinə cavab olaraq doğulan mif XXI əsrdə xəstələrin əleyhinə işləyir.

Və burada qarşımıza dəyə bilməyəcəyimiz mürəkkəb bir həqiqət çıxır.

1960-1970-ci illərdə güclənən antipsixiatriya hərəkatı düzgün və lazımlı bir iş gördü. Onlar real sui-istifadələri ifşa etdilər. Onlarla "ilan yuvası"nın — xəstələrin onilliklərlə unudulduğu nəhəng psixi xəstəxanaların bağlanmasına nail oldular. Xəstələrə səs qazandırdılar və müasir psixiatriya islahatı üçün etik baza yaratdılar.

Onlar başqa bir şey də etdilər. Psixiatriyanı təbiəti etibarilə repressiv bir elm kimi möhkəm bir şəkildə təsvir etdilər. Bu təsvir bir dəfə formalaşdıqdan sonra dəyişikliyə qarşı davamlı oldu. Psixiatriya həqiqətən də dəyişsə belə, bu təsvir olduğu kimi qaldı.

Bu obrazın, bu köhnəlmiş kölgənin üzərində bu gün bütöv bir sənaye çiçəklənir. Elə bir sənaye ki, keçmişin real faciələrindən istifadə edərək müasir sübuta əsaslanan psixiatriyanı nüfuzdan salır — və öz alternativlərini təbliğ edir; çox vaxt bu alternativlər 1950-ci illərdə olanlardan qat-qat daha azğın olur.

Təsəvvür edin: 1969-cu il. Keçmiş dənizçi, fantast yazıçı və Sayentoloji Kilsəsinin qurucusu Ron Habbar təxminən zərərsiz ad daşıyan bir təşkilatın yaradılması sənədini imzalayır — İnsan Hüquqları üzrə Vətəndaş Komissiyası (Citizens Commission on Human Rights, CCHR). Dinləyəndə insan hüquqları

təşəbbüsü kimi səslənir. Lakin bu etiketin arxasında dünyanın ən aqressiv antipsixiatriya kampaniyalarından biri gizlənir. Onlar müzakirə etmirlər. Mübahisə etmirlər. Birbaşa ürəyə zərbə endirirlər. Onların üsulu budur. Sənədli filmlər. Ekranda — lobotomiya kadrları. Zorakılığın real sübutları. "Quş yuvasının üstündən uçuş" filmindən fraqmentlər. Üç obraz, bircə hekayədə birləşdirilib. Seçim əldə etməyə imkan verməyən montaj. Bax. Bu həkim. Bu xəstə. Bu alət. Və izləyicinin şüuruna vurduqları nəticə: müasir psixiatriya — qətlin sənayesidir. Psixotrop dərmanlar — zəhərdir. Psixiatrlar — qatildir. Üç tezis. Üç zərbə. Xatırla bunları. Çünki sonra bu maşının necə işlədiyini araşdıracağıq.

Eyni zamanda Sayentoloji Kilsəsi öz "alternativ müalicə"lərini satır. Onun əsasında Habbarın "enqram" adlanan cəfəngiyyat konsepsiyası durur. Enqramlar — hüceyrələrdə qeyd olunmuş ağrı izləridir. Elmi səslənir? 1950-ci ildə Erik Fromm soyuqqanlılıqla bu nəzəriyyəni təhlil edib onu "səhv başa düşülmüş və tərsinə çevrilmiş freydizm, yeni lüğət paltarına bürünmüş" adlandırıb. Bu — elm deyil. Bu — kommersiya sektasıdır. Bəs o necə bu qədər möhkəm şəkildə gücünü qoruyur? Onun təbliğatı XX əsrin psixiatrik faciələrinə söykənir. O, Frimen və Rozmari Kennedinin xəstələrinin diri, əzabverici, geri dönməz ağrılarından parazitlik edir. Onların qırılmış taleləri üzərində biznes qurur, öz "təmizlənmə kursları"nı satır.

Buna görə də bu kitabda hər şeyi aydın şəkildə ayırmaq istəyirəm. Bir şey köhnəlmiş üsulları tənqid etməkdir. Digəri isə müasir sübuta əsaslanan psixiatriyanı inkar etməkdir. Birincisi zəruridir. İkincisi isə xəstələr üçün təhlükəlidir və təəssüf ki, müasir alternativ təkliflər satanların çoxunun etdiyi şeydir.

"Ququ quşu yuvasının üzərindən uçarkən" filmi möhtəşəm bir əsərdir. Onun bədii dəyərini azaltmaq istəmirəm. O, haqlı olaraq kino tarixində ən güclü antiutopik filmlərdən biri kimi qalır.

Lakin o, 1959-cu ilin psixiatrik reallığına əsaslanan bədii əsərdir. 2026-cı ilin yox.

Biz psixiatrlar xəstədən belə bir söz eşidəndə: "Mən EKT-dən qorxuram, filmlərdə görmüşəm ki, ondan sonra insan tərəvəzə çevrilir" — səbirla izah etməliyik ki, kino 1959-cu ilin həqiqətini göstərib, 1959-cu il çoxdan keçib, müasir prosedur tamam başqadır, biz başqa bir zamanda yaşayırıq və sübuta əsaslanan tibb xeyli irəli gedib.

"Psixiatriya yalandır. Dərmanlar zəhərdir. Terapevta gedin: kimyasız, elektroşok olmadan hər şey düzələcək." Bu sözlər daş kimi ürəyə dəyir. Onu dost fısıldayır. Qohum təkrar edir. Tanış iddia edir. Biz cavab verməliyik. Sakitcə. Möhkəm. Psixiatriya elmdir. Yetmiş il. Özünü tənqid edən yeddi onillik amansız yol. Mükəmməl deyil. Bitmiş deyil. Amma tamamilə realdir. Bəs "terapevt" kimdir? Sizə ideologiya satan bir insan. Bu ideologiyanın yalnız otuz ili var. Otuz əksinə yetmiş. Əsas zərbə isə budur: bu ideologiya heç bir placebo-tutqunluq testindən keçməyib. Heç birindən. Sübut yoxdur. Yalnız havadır.

Mən psixiatrlara kor-koranə inanmağı tələb etmirəm. Mən bunun əvəzinə elmi fənni kommersiya mistikasından ayırmağı tələb edirəm. Bunlar tamamilə fərqli şeylərdir və bu fərq əsaslıdır, hər iki tərəf nə qədər qeyri-adi və ya qorxuducu görünsə də.

Müasir psixiatriya səhv edir. Hələ də səhv edəcək. Lakin onun içində elə mexanizmlər var ki, tədqiqatlar, meta-analizlər və təsnifatların yenidən nəzərdən keçirilməsi yolu ilə xətaları düzəldir. "Düzənləyici"nin bu cür mexanizmləri yoxdur, çünki onun sistemi elmi yoxlamaya tab gətirmir — o, elmi olmayan fərziyyələr irəli sürür ki, onları təkzib etmək mümkün deyil.

Bundakı fərq də məhz budur. Bu kitabın oxucusu artıq onun adını bilir: korreksiya mexanizmi. Elmdə bu var. Cinnət düsturunda isə yoxdur və ola da bilməz.

Formanın filmini ilk dəfə görəndə tibb institutunun tələbəsi idim. O vaxt gənc idim və heyran qalmışdım. Elə bilirdim: budur, psixiatriyanın həqiqəti. Budur, mənim seçdiyim peşə.

Sonra internaturaya daxil oldum və tamam başqa bir şeylə üzləşdim. Ratçedlə yox — postsovet sistemində onun kimilərinə də rast gəlinirdi. Həqiqətən pis vəziyyətdə olan və müasir tibbin kömək edə biləcəyi xəstələrlə. Çox vaxt səmimi şəkildə çalışan həmkarlarla. İşləyən üsullarla və işləməyən üsullarla. Kino filmindən daha mürəkkəb çıxan həqiqətlə.

Formanın filminə baxanda peşəyə gəldiyim ideallara xəyanət etmədim. Onları daha da dərinləşdirdim. Anladım ki, pis psixiatriya ilə mübarizə aparmaq vacibdir. Yaxşı psixiatriya uğrunda mübarizə aparmaq isə daha da vacibdir.

Və budur — tələ. Görünməz. Ölümcül. Birini digərindən ayırmamaq — yaxşı, mərhəmətli insanın heyrətamiz müntəzəmliklə düşdüyü tələdir. Ratçed olmaq qorxusu ilə dəhşət içində geri çəkilir. Öz anası suisidal depressiyanın dibinə batanda EKT-dən imtina edir. Fridmenə nifrət edir — amma məhz bu qəzəb onun gözünü tutur. Şizofreniya xəstəsi qardaşını düzənləyiciyə aparır, "orada heç olmasa kimya yoxdur" illüziyasına yapışaraq. Özünü psixiatriyanın tənqidçisi hesab edir. Sistemə meydan oxuyur. Amma əslində kimə çevrilir? Qurbana. Ya da psevdomedisina sənayesinin iştirakçısına — daha betərinə.

Düzgün seçim, pis psixiatriya ilə elmi əsası olmayan alternativ arasında deyil. Əsl seçim, yaxşı və sübuta əsaslanan psixiatriya ilə digər hər şey arasındadır. Buraya həm pis psixiatriya, həm də kommersial mistika daxildir.

Bu tənliyin ikinci tərəfinə — psixiatriyanın çatışmazlıqlarından qidalanaraq özünün daha da şübhəli üsullarını satan müasir "şüura alternativ yardım" sənayesinə də toxunacağıq. Hellingerə. Stibala. Habbarda. Bu kitabda onların da vaxtı gələcək.

Amma əvvəlcə — araşdırmamızın üçüncü hissəsi. Qaydaları qəbul etməyənləri mühakimə etməzdən əvvəl qaydaların özünün necə doğulduğunu dürüst göstərmək lazımdır: iyirminci əsr elminin şizofreniyanı anlamağı və — daha vacibi — özünü öz kölgəsindən ayırmağı necə öyrəndiyini. Psixiatriyanı ilk dəfə dərinliyə aparan adamdan — Ziqmund Freyddan başlayaq.

Birinci ara səhnə. Palatadan gələn səs

İnterlüdiyaların monoloqları müəllif tərəfindən xəstələrin real hekayələri əsasında bərpa edilib; adlar və detallar dəyişdirilib, birbaşa nitq yaddaş və qeydlər əsasında bərpa olunub.

Adım Rafiqdir. İlk dəfə məni yatıranda iyirmi altı yaşım vardı. İndi altmış birimdir, elə özünüz hesablayın görək o illər necə illər idi.

Səslər barədə danışmayacam. Eşidən bilir, eşitməyənə isə nə deyəsən? Yalnız onu deyim ki, sonda öz səslərimi pilləkən qəfəsindəki qonşulardan yaxşı tanıyırdım. Düzünü desəm, səslərdən ən az qorxurdum.

Mən çərşənbə axşamından qorxurdum. Çərşənbə axşamları şöbədə kükürd vururdular.

Bunu hamı bilirdi. Səhər palatalarda elə bir sakitlik hökm sürürdü ki, sanki hərbi hissədə sıraya duruşdan əvvəl olur. Sanitar qab-qacaq şıngıltısı ilə bildirirdi ki, bu gün kimə növbədir. Kim olduğunu söyləmirdilər. Bunu yalnız səhər yeməyindən sonra deyirdilər: sən, sən və sən.

Bunun nə olduğunu sizə sadəcə izah edim. Təsəvvür edin ki, həyatınızda bədəninizin keçirdiyi ən yüksək hərarəti. Üstünə bir o qədər də artırın. İndi təsəvvür edin ki, o hərarətdə yanbazı çevrilə bilmirsiniz, çünki bədəninizdə dörd nöqtə var və hər biri elə bil oraya qaynar su tökmüşlər və o, soyumur. Bir saat deyil. Üç gün.

Su içmək elə istənir ki, yuxuda belə su görünür. Ördək yanında dayanıb, amma çatmaq olmur, səsləyirsən. Haradasa

gəzən birisi gəlir, su verir. Xəstələr bir-birinə kömək edirdi. Əgər bilmək istəyirsinizsə, bu şöbədəki tək əsl müalicə də elə budur — ki, biz bir-birimizə su verirdik.

Kükürd vurmağın nə üçün olduğunu heç kim izah etmirdi. Həkimlər deyirdilər: göstərişdir. Amma biz cədvəli həkimlərdən yaxşı bilirdik. Sanitara kobudluq etdin — çərşənbə axşamı sənindir. Evə çox tez-tez can atırdın — sənindir. Susursan, uzanırsan, salam verirsən — baxırsan ki, yanından ötüşdü. Bu nə cür müalicədir ki, davranışa görə verilir? Bu müalicə deyil. Sadəcə bunu ucadan demək olmazdı. Desən — deməli, "öz vəziyyətinə tənqidi yanaşmırsan". Tənqid yoxdursa — deməli, nə? Deməli, çərşənbə axşamı.

Bu da sona çatdı. Birdən-birə deyil, bir ildə deyil, amma sona çatdı — yeni dərmanlar, yeni həkimlər ortaya çıxdı. Onlar sulfura indi mənim baxdığım kimi baxırdılar. İndi ayda bir dəfə müasir iynə vurulurlar mənə, səslər isə divarın arxasından gələn radio kimi: nə danışdığını bilirəm, amma sözləri ayırd edə bilmirəm. Nəvələri məktəbə aparıram.

Amma çərşənbə axşamı içimdə qaldı. Qırx il keçdi — poliklinikadayam, tibb bacısı "prosedur otağına keçin" deyəndə kürəyimin tərlədiyini hiss edirəm. Kürəyim xatırlayır. Axı heç kim ona başa salmayıb ki, zamanlar dəyişib.

Orada kitablar yazırsanız, bilirəm. Bunu yazın: Bəxtəvərlikdə xəstəliyimi mənə Allah verdi, mən onunla razılaşdım. Çərşənbə axşamlarını isə mənə diplomlu insanlar gətirdi. Və bununla razılaşmaq daha çətindir.

III HİSSƏ. QAYDALARA UYĞUN SƏHV ETMƏK

Fəsil 10. Freyd və psixikanın qüvvələri: psixoanaliz psixozla qarşılaşır

1903-cü ildə Almaniyanın Drezden şəhərində yüksək dərəcəli hakim, hüquq elmləri doktoru, Saksoniya Ali Apellyasiya Məhkəməsinin keçmiş sədri Daniel Paul Şreber (Daniel Paul Schreber) psixiatriya və psixologiya tarixinin ən gizəmgir sənədlərindən biri hesab ediləcək bir kitab nəşr etdirdi. Kitab "Nerv xəstəsinin xatirələri" (Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken) adlanırdı.

Şrebər xəstə idi. Bunu bilirdi. Psixiatriya klinikasının divarları uzun illər boyu onun ətrafını sarıb. Lakin onun xatirələrində, həddindən artıq dəqiqlik və aydınlıq hiss edilir — psixoz girdabına düşmüş bir insan üçün qeyri-adi bir vəziyyət. Bu, parçalanaraq dağılan bir ağlın, öz agoniyasını bu qədər aydın izah edə bilməsi necə mümkündür? Bu bir sirrdir. Şrebər səslər eşidirdi. Ona inanırdı ki, Allah onu seçib. Amma nə üçün? Xüsusi bir missiya üçün. Onun bədəni qadına çevrilməli idi. Və ondan — ondan! — yeni bir insanlıq doğulmalı idi. Öz bədəninin gözü qarşısında dəyişdiyini görürdü. Fiziki olaraq "ilahi şüaların" onu deşib keçdiyini və içindən yandırdığını hiss edirdi. Və onlar onun dalınca gedirdi. "Bir anlıq yaradılmış insanlar". Canlı, nəfəs alan, həqiqətən var olan varlıqlara bənzəyən məxluqlar. Amma yalnız bir anlıq. İllüziya. Allahın onu sınaqdan keçirmək üçün yaratdığı bir kölgə oyunu.

Şrebərin kitabı Ziqmund Freydin (Ziqmund Freyd, 1856–1939) əlinə düşdü. Freyd heç vaxt Şrebərlə şəxsən görüşməsə

də, 1911-ci ildə xatirələri diqqətlə oxuduqdan sonra psixoanaliz tarixində dönüş nöqtəsi olan bir əsər yazdı: "Paranoyanın (dementia paranoides) avtobioqrafik halına dair psixoanalitik qeydlər".

Freyd, daha əvvəl əsasən nevrozlar ilə məşğul olan bu elmin banisi, ilk dəfə psixozların ərazisinə addımını qoydu. Bu addım ilə şizofreniya haqqında düşüncə tarixində tamamilə yeni bir dövr açdı.

Freydin şizofreniya haqqında nə dediyini öyrənməzdən əvvəl hər şeyi dəyişən bir faktı qəbul etməliyik. Freyd. Heç vaxt. Şizofrenikleri. Müalicə etməyib. Şəxsi. Heç birini. Bergqasse, 19. Vyana. Psixoanalizin doğulduğu kabinet. Yüzlərlə nevrotikin uzandığı kreslo. Sərbəst assosiasiyalar. Yuxuların şərh edilməsi. Transferin izahı. Bütün bunları onların — narahat, obsesiyalı, isteriklərin üzərində cilalayıb. Amma heç bir şizofrenik bu kresloya uzanmayıb. Heç dəfə. Və Freyd bunu gizlətmədi. Açıq danışırdı — və uzun müddət danışırdı: psixoanaliz psixozlar üçün uyğun deyil. İlk sual budur. Heç vaxt psixozlu bir xəstəyə müraciət etməmiş bir adam necə psixiatriya tarixində ən çox müzakirə olunan şizofreniya konsepsiyalarından birinin müəllifi oldu?

Niyə? Psixoanalitik müalicənin mərkəzi anlayışı — transferdir. Bu, xəstənin uşaq yaşlarında qurduğu əlaqələrdən formalaşan hisslər və gözləntiləri analitikin fiquruna köçürməsi zamanı baş verir. Ata. Ana. Qardaş. Bacı. İlk sevgi. Bu köhnə emosional şəbəkələr analitikə proyeksiya olunur. Analitik xəstəyə onları görüb başa düşməyə və bu təcrübə vasitəsilə zehni həyatını dəyişdirməyə kömək edir.

Freyd üçün köçürmə sadəcə texniki üsul deyildi. Bu, psixoanalitik müalicənin mümkünlüyünün əsas şərti idi. Köçürmə olmadan müalicə də yoxdur. Xəstə ilə analitik arasında terapevtik işin getdiyi körpü də yoxdur.

Və Freyd öz nevrotik xəstələrini müşahidə edərək belə bir nəticəyə gəldi: şizofrenik xəstələrdə transfer formalaşmır. Və ya o qədər qəribə və təhrif olunmuş formada formalaşır ki, onunla adi analitik iş aparmaq mümkün deyil. Xəstə xarici dünyadan çox uzaqlaşıb, daxili proseslərinə çox batıb, başqa bir insanla sabit əlaqə qurmaq qabiliyyətini o qədər itirib ki.

"Narsizmə dair: giriş" (1914) adlı əsərində — mən bunu XX əsr psixiatriya tarixinin ən təsirli mətnlərindən biri hesab edirəm — Freyd bu müşahidəyə nəzəri forma verdi.

Freydın mərkəzi ideyası belədir: İnsanın psixi inkişafında "ilkin narsisizm" adlandırdığı bir mərhələ mövcuddur. Körpə, hələ özünü və dünyanı fərqləndirmədiyi bir vaxtda, bütün psixiki enerjisini — libidonu — öz "mən"-inə yönəldir. O, kainatın mərkəzidir. Onun ehtiyacları bütün dünyadır.

Uşaq inkişaf etdikcə libidosunu xarici obyektlərə yönəldir — ilk növbədə anasına. Bu proses "obyektli kataksis" adlanır. Bundan sonra libidonun bir hissəsi "Mən"ə, bir hissəsi isə xarici dünyanın obyektlərinə aid olur. Bu, normal yetkin fərdin mövcudluq üsuludur.

Bəs bu modeldə psixoz nədir? Reqressiya. Geriyə dönüş. Xəstə həyatının hansısa məqamında daxili konfliktin dözülməz təzyiqi altında radikal bir manevr edir: libidonu geriyə atır. Enerji xarici obyektlərdən qopur və sürətlə "Mən"ə qayıdır. Xəstə yenidən narsisistik olur. Öz daxili yaşantılarına qapanır. Xarici aləm onun üçün bir anda reallığını itirir. O, fantaziyalar, qorxular, böyüklük, təqib hissi ilə dolu bir daxili aləmdə yaşayır.

Buradan da klinisistlərin şizofreniyada müşahidə etdiyi simptomlar yaranır. Özünə çəkilmə (Bleylerin "autizm" adlandırdığı şey). Emosional təcrid. Xəstənin xarici reallıq yerinə daxili aləmini əks etdirən hallüsinasiyalar və sayıqlamalar. Meqalomaniya (böyüklük maniyası) — həmin narsisistik qayı-

dışın təzahürü kimi: əgər "Mən" yenidən hər şeyin mərkəzidirsə, deməli, o, böyük olur.

Əsas məsələ isə ondadır ki, bu proses köçürülə bilməz. Əgər xəstənin libidosu öz "Mən"i daxilində qapalıdırsa, analitik onun üçün əhəmiyyətli bir fiqur deyil, daha çox Şrebərin yazdığı kimi "anlıq yaranmış insanlardan" birinə çevrilir. Boş bir qabıq. Büdcələşdirilmiş bir dekor.

Freyd bundan aşkar nəticə çıxardı: şizofreniya xəstələri psixoanalizə tab gətirmirlər.

Bu — hekayənin bir tərəfi. Freyd — təmkinli, ciddi Freyd, öz metodunun hüdudlarını qəbul etməyə hazır.

Amma Freydin şagirdləri də vardı. Və onların hamısı belə sərhədləri qəbul etməyə hazır deyildi.

1907–1908. Vyana. Freydin ətrafına toplaşmış dar bidətçi dairəsi bir küfr sualından lərzəyə gəldi: bəlkə də psixoanalizi yenə də şizofreniyaya tətbiq etmək olar? Üç nəfər həddi aşmağa cəsarət etdi. Paul Federn. Karl Abraham. Və — xüsusilə — Karl Qustav Yunq. Elə o Yunq ki, Burqxolslidə Bleylerin rəhbərliyi altında işləyirdi. Yunq palıd masanın arxasında nəzəriyyə qurmurdu. O, şizofrenləri hər gün görürdü. Onların parçalanmış gözlərinə baxırdı. Dağılan danışıqlarını dinləyirdi. Xəstəxana onun laboratoriyasına çevrilmişdi. O, firavan Vyanadakı Freyddən daha yaxşı görürdü.

Yunq hesab edirdi ki, şizofreniyalı xəstələrdə də köçürmə qabiliyyəti var — hərçənd çox təhrif olunmuş şəkildə. Və onlarla psixoanalitik iş aparmaq mümkündür, sadəcə buna uyğunlaşdırmaq lazımdır. Bu mövqe 1913-cü ildə Yunqun Freydlə münasibətlərinin kəsilməsinə səbəb olan çoxsaylı mübahisə mövzularından biri idi.

1920-ci illərə qədər, hətta ayrılığa baxmayaraq, psixozlarla işləmə ideyaları psixoanalitik hərəkatda kök saldı. Buna çox şeydə Bleyler və Yunqun artıq uzun illər şizofreniyalı xəstələrin müalicəsinə psixoanalitik yanaşma tətbiq etdiyi Burqxol-

sliklinikasına dünyanın hər yerindən psixoanalitiklərin oxumağa gəlməsi kömək etdi. 1930-cu illərə qədər şizofreniyanın psixoanalitik nəzəriyyəsi artıq öz tarixinə, öz məktəblərinə və öz texnikalarına malik idi.

ABŞ-da bu ənənəni Frida Fromm-Rayxman (1889–1957) davam etdirdi. Alman yəhudisi, psixoanalitik. 1935-ci ildə o, nasist Avropasından qaçaraq Merilend ştatındakı "Çestnat Loc" klinikasına düşür. Orada nə edir? Qeyri-mümkün sayılan şeyi. Fromm-Rayxman şizofrenləri — öz sayıqlamalarının qəfəsinə əbədi qapanmış olanları — müalicə etməyə girişir. Onları psixoterapiya ilə müalicə edir. Özünü dağıdan bir zehnə necə yol tapmalı? Fromm-Rayxman səbir, empatiya və psixodinamikanın dərin dərki ilə giriş yolu axtarır. O, sözün əsl mənasında başqasının dağılmasının nəbzini yoxlayır. Onun xəstələrindən biri Coan Qrinberq idi. Qız uçurumdan qurtuldu. Sonralar Hanna Qrin təxəllüsü ilə məşhur avtobioqrafik "Mən sənə heç vaxt qızılgül bağı vəd etməmişəm" (1964) povestini yazacaqdı. Hər səhifə — şizofreniya təcrübəsinin və onu həyata qaytaran terapiyanın yandırıcı şahidliyidir.

Digər mühüm simalar — Harri Stək Sallivan (Harry Stack Sullivan, 1892–1949), psixozların psixoterapiyasına interpersonal yanaşmanı işləyib hazırlamış amerikalı psixiatr; Melani Klayn (Melanie Klein, 1882–1960), obyekt münasibətləri nəzəriyyəsini və paranoid-şizoid mövqeyin inkişafın universal erkən mərhələsi olduğu fikrini irəli sürmüş; Herbert Rozenfeld (Herbert Rosenfeld, 1909–1986), Klaynın şagirdi, Britaniyada psixotik xəstələri sistemli şəkildə müalicə etmişdir.

Bütün bunlar ciddi bir hərəkat idi. Ağıllı, vicdanlı, çox vaxt parlaq klinisistlər. Onilliklərlə davam edən iş. Minlərlə pasiyent.

Bəs nəticədə nə alındı?

Burada biz eyni zamanda həm hörmətli, həm də sərt olmalıyıq.

Psixoanalitik təfəkkür psixiatriyaya çox böyük bir şey verdi. Məhz psixoanalitiklər sayəsində psixiatriya şizofren xəstənin daxili yaşantılarından danışmağa imkan verən bir dil qazandı. Freyd və onun davamçılarından əvvəl şizofren təsvir obyekti idi — qəribə, anlaşılmaz, qorxuducu. Freyddən sonra isə o, öz daxili məntiqi, öz tarixi, öz şüursuz konfliktləri olan bir insana çevrildi. Hallüsinasiyalar artıq sadəcə "mənasız hadisələr" deyildi — onlar xəstənin psixikası haqqında məlumat daşıyan mətnlər kimi oxunmağa başlandı. Delirium artıq absurd deyildi — o, müdafiəyə, psixi dağılma fəlakətinə məna yükləmək cəhdinə çevrildi.

Anlama sahəsindəki bu inqilab bu günə qədər müasir psixiatrik təcrübənin əsasını təşkil edir. Müasir psixiatr paranoid deliriumlu xəstəni dinləyərkən və bu xəstədə məhz belə məzmunlu deliriumun niyə meydana çıxdığını anlamağa çalışarkən, istər şüurlu, istər şüursuz şəkildə Freydin qoyduğu paradiqma çərçivəsində hərəkət edir.

Lakin digər tərəfdən — şizofreniyada psixoanalizin klinik effektivliyi sübutsuz qaldı.

Bu, prinsipial məsələdir. XX əsrin ortaları. Alimlər ilk dəfə psixoanalitiklərin əsrlər boyu qaçdığı bir şeyə cəsarət göstərirlər: nəzarət edilən müqayisəli tədqiqatlar aparmağa. Psixoanalitik yönümlü psixoterapiyanı götürüb digər yanaşmalarla və adi qayğı ilə amansız bir səlib yürüşünə atırlar. Nəticələr dağıdıcı oldu. Məyusluq. İllərlə küncdə uzanıb psixoanalizdən keçən xəstələr ən yaxşı halda sadəcə adi qayğı alanlarla eyni nəticələr göstərirdilər. Eyni sağalma səviyyəsi. Heç bir sehr yox idi. Amma daha pisi başqa idi. Ən pis ssenari. Psixoanalitik yanaşma sadəcə sağaltmırdı — o, dağıdırdı. Daxili konfliktlərin intensiv şərhi qeyri-sabit xəstəyə detonator kimi dəyirdi. Sözlə müalicə edən şəxs bilmədən köhnə yaraları açır, simptomların kəskinləşməsini təhrik edirdi. Xilas etməli olan şey xəstəliyi yeni güclə alovlandırırdı.

Bu tipli ən tanınmış tədqiqatlardan biri — Şizofreniyanın psixoterapiyası üzrə Boston layihəsi (Gunderson et al., 1984) — intensiv psixoanalitik psixoterapiyanı strukturlaşdırılmış dəstək terapiyası ilə müqayisə etdi. Nəticə: strukturlaşdırılmış dəstək klassik psixoanalizdən daha yaxşı klinik nəticələr verirdi. XX əsrin sonlarına doğru əksər beynəlxalq təlimatnamələrdə şizofreniyaya klassik psixoanalitik yanaşma səmərəsiz və ya az səmərəli kimi qəbul edildi.

Bəs nə işləyir? Müalicənin əsasını antipsixotiklər psixososial müdaxilələrlə birlikdə təşkil edir — psixozlarda koqnitiv-davranış terapiyası (CBTp), ailə terapiyası, sosial bacarıqlar təlimi, icmada aktiv dəstək (assertive community treatment). Psixoanalitik yönümlü fərdi terapiya vəziyyət stabilləşdikdən sonra ayrı-ayrı xəstələr üçün faydalı əlavə ola bilər, lakin terapiyanın birinci xətti kimi və ya dərmanların əvəzi kimi yox.

Psixoanalitik düşüncənin həddindən artıq irəli getdiyinin ən dramatik nümunəsi "şizoqrenogen ana" (schizophrenogenic mother) anlayışıdır.

Bu termini 1948-ci ildə Frida Fromm-Rayxman özünün "Notes on the Development of Treatment of Schizophrenics by Psychoanalytic Psychotherapy" adlı məqaləsində irəli sürmüşdü. O, bu tip ananı soyuq, uzaq, hökmran, eyni zamanda həddindən artıq qayğıkeş və emosional cəhətdən boş bir qadın kimi təsvir edirdi. Onun fərziyyəsinə görə, məhz bu cür analıq uşaqda şizofreniyanın inkişafına şərait yaradırdı.

İdeya yayıldı. Başqa müəlliflər də onu mənimsədilər. 1950-ci illərə qədər Amerika psixiatriyasında — həmçinin Avropa psixiatriyasının bir hissəsində — şizofreniya xəstələrinin analarını günahlandırmaq, onların xəstəliyinin tərbiyənin nəticəsi olduğunu söyləmək adət halına gəldi. Bu analar oğullarının və ya qızlarının psixiatrına gəlir və həkimdən eşidirdilər ki, uşağın xəstəliyinə görə günahkar özləridir.

Bu, amansız idi. Bu, yalan idi. Və bu, həm özünü günahkar hiss edərək əzab çəkən analar üçün, həm də kömək axtarmaq əvəzinə ailəni günahlandırma ideologiyasına batmış xəstələrin müalicəsi üçün zərərli idi.

1960–1970-ci illər. Genetika və neyrobiologiya qılıncı qınından çıxarır. "Şizofreniya doğuran ana" konsepsiyası yeni məlumatların təzyiqi altında dağılır. Dəhşətli tapmaca açılır: şizofreniyanın təbiəti genlərdədir, ananın soyuq sözlərində deyil. Rəqəmlər amansızdır: irsiyyət səviyyəsi 80%-ə çatır. Bunu əkizlər üzərində aparılan tədqiqatlar göstərib. Səksən faiz! Deməli, milyonlarla qadın illər boyu törətmədikləri bir cinayətin ağır günah yükünü daşıyıblar. Ananın ünsiyyət tərzi? Bəli, o mövcuddur. Lakin xəstəliyin gedişatına o, yalnız kəskinləşməyə səbəb olan qığılcım kimi təsir edir, nə kök, nə də ilkin səbəb kimi. Etiologiyada rolu yoxdur. Və budur, 1990-cı il. Amerika psixiatrı Con Neyl yekun vurur. Onun məqaləsi hökm kimi səslənir: "Whatever became of the schizophrenogenic mother?". Nəticə amansız və aydındır. İdeya səhvdir. O, taleləri şikəst edib, dözülməz əzablar gətirib. Ondan birdəfəlik, amansızcasına və həmişəlik imtina edildi.

Bu epizod sadəcə tarixin bir səhifəsi deyil. Bu, psixiatriyanın təməlindəki bir çatdır. Baxın: "şizofrenogen ana" anlayışı. Nə siyasət, nə də şöhrət hərisliyi. Sadəcə bir nəzəriyyə. Yaxşı, ağıllı bir nəzəriyyə. Amma yetərli empirik nəzarət olmadan tətbiq edildi. Və onun nəticələri zərər oldu. Xəstələr üçün, onların ailələri üçün. Psixiatriya öz elmi paradiqmasının daxilində belə səhv edir. Sovet məhkəmə psixiatriyasında olduğu kimi siyasi təzyiq altında deyil. Lobotomistlərdə olduğu kimi şöhrət hərisliyi ilə də deyil. Sadəcə nəzəriyyə faktlardan daha inandırıcı göründü. Və ən təhlükəlisi budur.

Lakin — bu da vacibdir — psixiatriya bunu özü aşkar edib kənara qoydu. Tədqiqatlar vasitəsilə. Məlumatların toplanması yolu ilə. Açıq ictimai yenidən baxış sayəsində.

Hellinger metodu ilə çalışan terapept müştəriyə gözlərini dikib hökm çıxarır: sənin depresiyan özündə bağışlanmamış nənənnənin günahının qisasıdır. Zərbə. Ağrı bədəni bürüyür. Amma bunun arxasında nə dayanır? Mahiyyət etibarilə, bu terapept 1950-ci illərdə amerikalı psixoanalitik psixiatriyanın "şizofrenogen ana" konsepsiyası ilə etdiyini edir. Təsadüf? Xeyr. Sistem. Xəstəliyin günahını ailənin konkret üzvlərinin üzərinə atır. Empirik olaraq təsdiqlənməyən uydurma səbəb-nəticə əlaqəsi yaradır. Xəstəyə əlavə travma vurur.

Fərq düzəliş mexanizmindədir. XX əsrdə psixiatriya bu səhvi qəbul etdi və ondan əl çəkdi. Hellingerin metodologiyası 2020-ci illərdə bunu etmir və edə də bilməz, çünki onun özünütənqid üçün institusional mexanizmləri yoxdur. Müstəqil rəyçilikdən keçən jurnallar, etik komitələr, sistemli icmallar yoxdur. Uğursuzluqlar barədə hesabat vermək öhdəliyi yoxdur.

Psixoanalizin şizofreniyanın anlaşılmasına qatdığı son töhfə nədir? Məncə, bunu belə ifadə etmək olar.

Psixoanaliz şizofreniyanın müalicəsi məsələsini həll edə bilmədi. Bu problemi qismən 1952-ci ildən başlayaraq antipsixotiklər həll edəcəkdir. Lakin bu gün də tam olaraq həll olunmayıb.

Lakin psixoanaliz psixiatriyaya bir dil bəxş etdi. Elə bir dil ki, onunla xəstənin daxili aləmi, qorxuları, fantaziyaları, məna dünyası haqqında danışmaq mümkündür. Bu dil olmasaydı, psixiatriya simptomlar haqqında təsviri bir elm olaraq qalardı. Onun sayəsində psixiatriya insanı bütün mürəkkəbliyi ilə anlamağı bacaran bir fənnə çevrildi — ya da çevrilməyə can atır.

Və bir də. Psixoanaliz göstərdi ki, xəstənin dinlənməsi sadəcə tibbi bir formal deyil, terapiya alətidir. Bu şizofreniya üçün tək alət kimi uyğun gəlmir. Lakin bu olmadan ümumilikdə yaxşı psixiatriya mövcud ola bilməz.

Buna görə də bu fəsillə vidalaşarkən qeyri-adi bir şey demək istəyirəm.

Şizofreniyanın müalicəsi kimi psixoanalizə gəldikdə mən skeptikəm.

Amma insan psixikasının antropologiyası kimi psixoanalizin tərəfdarıyam.

Freyd. Onun bir çox konkret nəzəriyyələri nə qədər mübahisəli olsa da, o, tibbə ən vacib şeyi öyrətdi.

İnsanın dərinliyi var.

Bilinclatı mövcuddur.

Uşaqlıq tarixi izlər buraxır.

Simvollar məna daşıyır.

Bunsuz psixiatriya mexaniki olardı. Bununla isə o, bütöv insanın tibbinə çevrilir.

İndi isə Freydi və onun şagirdlərini buraxaraq, şizofreniyanın anlaşılmasına Freyd qədər əhəmiyyətli töhfə vermiş, lakin tamamilə fərqli bir istiqamətdə irəliləmiş başqa böyük bir nəzəriyyəçiyə müraciət edirik: Karl Qustav Yunqa.

Fəsil 11. Yunq və kollektiv şüursuzluq: psixiatriya miflə qarşılaşdıqda

1913-cü ildə, 38 yaşlı şveytsarlı psixiatr Karl Qustav Yunq (Carl Gustav Yunq, 1875–1961), bir zamanlar Ziqmund Freydin sevimli şagirdi və təyin edilmiş "varisi" olan, lakin indi müəllimi ilə əlaqələrini tamamilə kəsən bu adam, qəflətən səslər eşitməyə başladı.

O, fantastik mənzərələr görürdü. Daxili gözü önündə canlanan fiqurlarla — Filémon adlandırdığı müdrik qocayla, Saloma adlı varlıqla və başqalarıyla söhbət edirdi. Ona elə gəlirdi ki, Avropanı tezliklə "qan dənizi" bürüyəcək. Bu, 1913-cü ilin sonlarında — Birinci Dünya müharibəsinin başlanmasından səkkiz ay əvvəl idi.

Yunq özünün sonradan "şüursuzluqla üz-üzə gəlmə" adlandıracağı vəziyyətə düşdü. Halüsinasiyalar. Paranoyak fikirlər. Reallığın təhrifi. Müasir psixiatriya dilində desək — saf psixotik epizod. Ağ xalat, məcburi köynək, xəstəxana palatası. Amma Yunq xəstəxanaya yatırılmadı. Niyə? O, iş qabiliyyətini itirməmişdi. Gündüzlər — xəstə qəbulları, mühazirələr, kitablar. Gecələr isə cəhənnəm açılırdı. Özü də bunun normal olmadığının fərqində idi. Dəliliyə təslim olmadı — onun qara boğazına doğru addımladı. Hər bir daxili zərbəni qeyd etdi, eskizlər çəkdi, sənədləşdirdi. Belə doğuldu "Qırmızı Kitab" — illustrasiyalı, kalliqrafik əlyazma, yarım əsrə yaxın sirr qoruyan. O, yalnız 2009-cu ildə, onun ölümündən 48 il sonra nəşr olunacaq.

1913-1919-cu illəri əhatə edən bu epizod, onun öz etirafına görə, sonrakı bütün nəzəri işlərinin əsasını təşkil etdi. O illərdə ona görünən obrazlar kollektiv şüursuzluq və arxetiplər konsepsiyasının təməlini qoydu. Yunq təhlilinin məşhur etdiyi hər şey, əslində, onun bu altı illik "nəzarət altına alınmış psixotik dövr"ündən yaranıb.

Burada dərhal vacib bir qeyd etmək lazımdır. Müasir psixiatriya Yunqun şizofreniya xəstəsi olduğunu düşünmür. Klinik mənzərə uyğun gəlmir. Kriteriyalar ödənilmir. Bəs onda bu xaosu necə izah etmək olar? Yunq peşəkar və sosial funksionallığını qoruyub saxlamışdı. Öz təcrübələrinə "daxil ola" və "çıxa bilərdi" — uçuruma addım atıb, arxasında qapını bağlayaraq qayıda bilərdi. Şizofreniyada bu mümkün deyil. Çox güman ki, bu, psixotik xüsusiyyətləri olan ağır nevrotik böhran idi. Bədən və ağıl nəhəng təzyiq altında əzilirdi: Freydlə qırğın, klinik yanğı, erkən orta yaş, dünya müharibəsinin yaxınlaşması.

Lakin bizim mövzumuza daha vacib olan başqa bir məsələ var. Yunq dərin psixologiyanın böyük banilərindən yeganə şəxsdir ki, psixotik təcrübələrdən şəxsi olaraq keçmiş və bu təcrübələri tədqiqat materialı kimi istifadə etmişdir. O, sonralar şizofreniya haqqında yazarkən, Freyd kimi kənardan deyil, daxildən yazırdı.

Yunqun psixiatriyaya olan yolu Freydlə qırğın çoxdan əvvəl başlamışdı. 1900-cü il. Yunq iyirmi beş yaşındadır. Bürgxolzli psixiatrik xəstəxanasının (Zürix) astanasını keçir. Eyni xəstəxana ki, idarəçisi Evgen Bloylerdir. Yunq bu divarlar arxasında doqquz il keçirəcək. Dəlilik içində doqquz il. Nə axtarır? Bu müddət ərzində dissertasiya yazır, məşhur söz assosiasiyası tədqiqatını aparır və nəhayət, zərbə endirir — ilk böyük əsəri "Erkən Dementiya Psixologiyası"nı (Über die Psychologie der Dementia praecox, 1907) nəşr etdirir.

Bu kitab tez-tez kənara qoyulur. Onu Yunqun sonrakı "mifoloji" əsərləri kölgədə qoyur. Amma məhz burada, gələcək

miflər kölgəsində, bomba basdırılıb. Kitab dövrünün ruhuna tam uyğun gəlirdi. Yunq assosiativ təcrübədə işlənib hazırlanmış metodu götürüb birbaşa şizofreniya xəstələrinə tətbiq etdi. Bu necə işləyir? Xəstəyə stimul sözlərin siyahısı verirdi. Bir-bir. Və xahiş edirdi: ağlına gələn ilk şeyi adlandır. Sonra cavabların mahiyyətini təhlil edirdi. Reaksiya vaxtını ölçürdü. Cavabların xarakterini öyrənirdi. Və — ən əsası — düşüncənin sürüşdüyü, əlaqənin qırıldığı və qəribə, qorxulu assosiasiyaların yarandığı anları qeyd edirdi. Bu uğursuzluqların arxasında nə dayanır? Yunq artıq cavabı bilirdi.

Yunqun qənaəti belə idi: hər qəribə cavabın arxasında "kompleks" dayanırdı — emosional yüklü, çox vaxt travmatik məzmun ki, şüura inteqrasiya olunmamışdı. Erkən demans xəstələrində bu komplekslər xüsusilə güclü idi və Yunqun fərziyyəsinə görə, birbaşa şüura nüfuz edərək hallüsinasiya və sayıqlama yarada bilirdi.

Bu gözəl klinik iş idi. Bu, Bleylerə birbaşa təsir etmişdi, həmçinin onun "şizofreniya" termini seçimində rol oynamışdı — "parçalanmış zehn", yəni müxtəlif komplekslərin bir-birindən təcrid olunaraq yaşadığı, inteqrasiya olmayan bir zehn.

"Erkən demans psixologiyası"nda Yunq oyunun gedişatını tamamilə dəyişən bir addım atdı. Bir fərziyyə. Sonradan udmaq məcburiyyətində qalacağı bir ehtimal. O bildirdi: şizofreniya xəstəsinin kompleksi toksin istehsal edir. Müəyyən bir maddə. Sağlam beyinə zərbə vuran, onun normal fəaliyyətini iflic edən və şüurun qapılarını taybatay açan görünməz qatil. Şüursuzluq çatlamış bənddən sızan qaranlıq su kimi xaricə qalxır. Bu, dəliliyə yaxın bir cəsarət idi. Amma cavab başqa cür oldu. Toksin? O yox idi. Heç bir maddə tapılmadı. Boşluğa atılan güllə. Sonralar Yunq özü də geri çəkildi və bu ideyanı sükutla basdırdı.

Budur — hər şeyin asılı olduğu an. Bunu yadda saxlayın. Yunq. Bleyler. Freyd. O dövrün alimləri. Onlar bioloji fərziyyə-

lər irəli sürməkdən qorxmurdular — hətta onları yoxlaya bilmədikləri halda belə. Cəsarət? Bəli. Amma tək bu deyil. Çünki sonra ən vacibi baş verirdi. Fərziyyə empirik olaraq təsdiqlənmirdi — və Yunq onu kənara atırdı. Təəssüflənmədən. Heç bir şərt irəli sürmədən. Atırdı — və davam edirdi. Buna elmi yanaşma deyilir. İndi ətrafınıza baxın. Müasir ezoterik məktəblər öz ideyalarına sımsıkı sarılırlar. Sübut olmadığına baxmayaraq. Heç nəyə baxmayaraq. Eyni söz — "fərziyyə". İki əks dünya.

1913-cü ildə Freydlə əlaqəni kəsdikdən və 1913–1919-cu illərdə keçirdiyi şəxsi psixotik böhrandan sonra Yunq yetkin nəzəriyyəsinə gəlib çatdı.

Onun əsas anlayışlarını belə ifadə etmək olar.

Şəxsi şüuraltı — şüurdan fərdi olaraq itələnmiş şeylərdir: unudulmuş travmalar, basdırılmış arzular, qəbuledilməz düşüncələr. Bu sahə Freydin öz işini həyata keçirdiyi ərazidir.

Kollektiv şüursuzluq — daha dərin bir şeydir. Yunq psixologiyanın təməllərini partladan bir bəyanat verdi: psixikanın fərdə aid olmayan bir qatı mövcuddur. O, bütün bəşəriyyət üçün ümumidir. Bəs bu dibdə nə gizlənir? Universal psixi strukturlar. Yunq onları arxetiplər adlandırdı. Bunlar konkret obrazlar deyil, forma-matrislərdir — görünməz cizgilər ki, dünyanın bütün mədəniyyətlərində oxşar mifoloji motivlər qorxunc dəqiqliklə onların üzərində əriyib tökülür. Fərqli qitələrə — eyni ssenarilər. Bu qədim varlıqların adları zehnin toxumasına həkk olunur: Qəhrəman, KöLGƏ, Ana, Müdrik qoca, Böyük ana. Anima və Animus — kişidə gizlənən əzəli qadınlıq və qadında gizlənən kişilik. Və nəhayət, hamısını taclandıran — Özünlük.

Yunq bu anlayışa iki heyrətamiz faktı müşahidə edərək gəldi. Birincisi, şizofreniya xəstələri tez-tez elə sayıqlama və hallüsinasiya obrazları yaradırdılar ki, məzmunca qədim mədəniyyətlərin mifoloji süjetləri ilə heyrətamiz dərəcədə üst-

üstə düşürdü — halbuki xəstənin bu barədə heç nə bilməsi mümkün deyildi. İkincisi, oxşar motivlər müxtəlif mədəniyyətlərə mənsub insanların yuxularında görünürdü.

Bunu necə izah etmək olardı? Yunq belə bir fərziyyə irəli sürdü: bu motivlər anadangəlmədir. Onlar təlim yolu ilə deyil, insan psixikasının quruluşunun özünün bioloji irsiyyəti vasitəsilə ötürülür. Milyonlarla il boyu təkamül keçirmiş beyin öz içində əsrlər boyu bəşərin ortaq yaşantılarının — qorxunun, sevginin, itkinin, sitayişin, keçid ritualarının — "izlərini" daşıyır. Bu izlər də arxetiplərdir.

Şizofreniya. Bu modeldə bu, diaqnoz deyil. Bu, fəlakətdir. "Mən" ilə kollektiv şüursuzluq arasındakı sərhədlər nazikləşir, qırılır və tamamilə dağılır. Xəstə arxetipik materialın altında qalır. Yad obrazlar şüura sel kimi axır — gəmi gövdəsindəki deşikdən suyun axdığı kimi. Onun hallüsinasiyaları və sayıqlamaları əlaqəsiz parçaların təsadüfi toplusu deyil. Xeyr. Bu, kollektiv məzmunun fərdi psixikaya soxulmasıdır. Xəstə bayağı mənada dəli deyil. O, bəndin dağıldığı insandır. Normalda yalnız miflər, sənət və dini ayinlər vasitəsilə yumşaldılmış şəkildə qavranılanı təmiz, yandırıcı formada yaşayan insandır.

Bu konsepsiya Qərb ziyalı elitasına son dərəcə güclü təsir bağışladı. Yunq böyük şöhrət qazandı — xüsusilə İkinci Dünya müharibəsindən sonra, avropalılar yaşadıqları fəlakətdən sonra məna axtardıqları dövrdə. XX əsrin ortalarında o, mədəniyyətdə ən nüfuzlu simalardan birinə çevrildi — Freydin yanında ən çox yalnız Eynşteynin adı çəkilir.

Amma — və bu, kitabımız üçün böyük əhəmiyyət daşıyır — elmi dairələr, xüsusən də Anglo-Sakson dünyasında, Yunqa şübhə ilə yanaşdı. Niyə?

Çünki Yunqun mərkəzi anlayışı — kollektiv şüursuzluq və arxetiplər — Popperin təkzibediləbilirlik meyarına cavab vermir. Dayan. Bu nə deməkdir? Budur: Bir təcrübə təsəvvür etmək mümkün deyil. Bir müşahidə göz önünə gətirmək

mümkün deyil. Arxetiplərin mövcudluğu haqqında hipotezi təkzib edəcək heç bir təcrübə yoxdur. Yoxlayaq. Xəstənin yuxularında mifoloji motiv peyda olur? Arxetip işləyir. Peyda olmur? O, gizli şəkildə işləyir. Tamam başqa bir motiv peyda olur? Bu da arxetipdir, sadəcə başqası. Nəzəriyyə təkzib edilə bilməz. Heç vaxt. Deməli, o, ciddi elmi deyil.

Bu o demək deyil ki, yunqçu psixologiya faydasızdır. O, insan psixikası üzərində çoxsaylı incə müşahidələr verdi, din psixologiyasına, mifin dərk edilməsinə, ədəbiyyatşünaslığa və kulturologiyaya mühüm töhfə verdi. Lakin psikozların müalicəsi üçün klinik fənn kimi o, klassik psixoanaliz kimi, ciddi elmi yoxlamadan keçmədi.

Şizofreniyada yunqçu analizin müasir randomizə edilmiş nəzarətli tədqiqatları praktiki olaraq yoxdur. Mövcud olanlar yunqçu metodun digər psixoterapiya formalarından üstünlüyünü təsdiqləmir. Antipsikotiklər isə — Yunqun heç vaxt üzərində işləmədiyi dərmanlar — qat-qat proqnozlaşdırıla bilən klinik effekt verir.

Lakin Yunq haqqında sualın başqa, daha qaranlıq bir tərəfi də var. Psixiatriya ədəbiyyatının uzun müddət toxunmadığı, lakin bu gün açıq şəkildə müzakirəyə layiq olan bir tərəf.

Yunq bir sıra müasir ezoterik və psevdoterapevtik məktəblər üçün intellektual mənbə oldu. Öz iradəsi ilə deyil. O, şarlatan mənasında ezoterik deyildi. Lakin onun dili — arxetiplər, kollektiv şüursuzluq, “psixikanın bütövlüyü”, “individuasiya”, “sinxronistlik” — sərbəst yenidən şərh üçün mükəmməl uyğunlaşdı.

Bu gün Tarot kartlarının qablaşdırmasına “yunqçu Tarot” yazanda. Astroloqlar müştərinin xəritəsində “Mars arxetipi”ndən danışanda. “Düzülmə” mütəxəssisləri düzülmədə baş verənləri “Böyük Ananın arxetipinin aktivləşməsi” ilə izah edəndə. “Reqressoloqlar” xəstənin keçmiş həyatlarda “öz Köl-

gəsi ilə rastlaşdığını" iddia edəndə. "Şaman təcrübələri" və "qadın dairələri" Yunqa öz nəzəri bazaları kimi istinad edəndə.

Elə bir etiraf var ki, az adam eşidib. Bütün bunlar Yunqdan sui-istifadədir. Nə yozum, nə də ideyaların inkişafı. Sadəcə sui-istifadə. Yunqun özü sərt akademik mədəniyyətli adam idi. O, Karl Yaspers və Martin Buber dövrünün dilində yazırdı. O, heç vaxt öz anlayışlarından bu cür istifadəni bəyənməzdi. Heç vaxt. O, həkim idi. Səhnədə bir guru, mistik deyildi. Öz dövrünün psixiatriyası ilə metodoloji bağlı olan bir həkim. Və şagirdlərindən klinik ehtiyatlılıq tələb edirdi. Xahiş etmirdi — tələb edirdi. O, "mənəvi inflyasiya" adlandırdığı şeyə qarşı yazırdı. Bu, insanın öz fərdi təcrübələrini böyük mənəvi həqiqətlərlə qarışdırdığı haldır. O, bu səhvi görürdü. Onu adı ilə çağırırdı. Və xəbərdarlıq edirdi.

Tarix amansızdır. Əsas anlayışları sınaqdan keçməyən nəzəriyyələr dərhal mənəvi dəyərlərin şişirdilməsi üçün ideal vasitəyə çevrilir. Boş sözlər. Yoxlanılmaz konsepsiyalar. Beləcə, saxta nominal dəyəri olan qızıl sikkə qorxunc asanlıqla zərb olunur. Müasir ezoterik öz lüğətini haradan götürüb? Dəqiq uyğunluq: Yunqdan. Məhz ondan çıxarılan terminlər bu gün "meyarlar qoyucular"ın ofislərinə yayılıb. Metodun nəzəri əsası haqqında onlara sual verin. Cavab olaraq nə eşidəcəksiniz? Keçid təqdimatı: "Bu, yunqçu yanaşmadır." Akademiklik illüziyası, ardında isə boşluq. Bunun Yunqla nə əlaqəsi var? Uranın "enerjisini" astroloji şərh etməyin nüvə fizikası ilə əlaqəsi qədər.

Yanaşmaq mümkün olmayan daha bir mövzu da Yunqun nasizmə münasibətidir. Bu, onun bioqrafiyasındakı ağrılı yerdir. 1933–1934-cü illərdə Yunq Beynəlxalq Ümumi Tibbi Psixoterapevtik Assosiasiyanın sədri vəzifəsini tutdu — bu təşkilat həmin dövrdə nasist rejiminə tabe olmuş və alman bölmələrindən yəhudi üzvlərini xaric etmişdi.

Yunq son nəfəsinə qədər özünü müdafiə etdi. Onun versiyası qüsursuz səslənirdi: guya o, vəzifədə yalnız xilas etmək

üçün qalmışdı. Yəhudi psixoanalitiklərə kömək etmək üçün. Onların çap imkanını qorumaq üçün. Mənafelərini müdafiə etmək üçün. O təkid edirdi: mən heç vaxt antisemit olmamışam. Və bəzi yəhudi şagirdləri — məsələn, Erix Noymann — bunun doğru olduğuna and içirdilər. Amma sözlər yalnız sözlərdir. Həqiqət həmişə sənədlərdə gizlənir. 1933-cü il. 1934-cü il. Bu gün oxuyanda qanı donduran sətirlər. Orada, sətirlər arasında bir diaqnoz döyünür: "ari" və "yəhudi" psixologiyalarının fərqləri haqqında mülahizələr. Bu gün fiziki narahatlıq duymadan oxumaq mümkün olmayan ifadələr. Bəs necə? Xilaskar dahi, yoxsa soyuqqanlı konformist?

Müharibədən sonra Yunq bu məsələdə öz səhvlərini açıq şəkildə etiraf etdi. O, öz ifadələrini "axmaq və ədalətsiz" adlandırdı. Yəhudi həmkarları ilə işləməyə davam etdi. 1946-cı ildə "Faciədən sonra" əsərini nəşr etdi — bu, almanların kollektiv günahının geniş düşünülmüş təhlili idi.

Bütün bunları indi niyə eşələyirik? Yunqu "ləğv etmək" üçün deyil. Biz başqa bir şey axtarırıq. Xəbərdarlıq. Nəzəriyyənin lap qəlbində gizlənən təhlükə. Orada ki, səhnəyə "kollektiv" varlıqlar çıxır: "xalqın arxetipləri", "irqin ruhu", "millətin əqidəsi". Qulaq asın, necə səslənir. Hiss edirsinizmi, bu məna əti nə qədər yumşaq, nə qədər yoğrulandır? Tarixən bu cür konstruksiyalar ideoloji manipulyasiyalar üçün ideal gildir. Hitlerçilər ondan öz qara miflərini yoğurdular. Yeni dövrün evangelistləri ondan şirin bir kult sıxdılar. Hər cür millətçilər öz qəzəblərini haqq qazandırmaq üçün bu sözlərə hərisliklə diş batırdılar. Müxtəlif anlarda hamısı Yunqda axtardıqlarını tapdılar. Yunqun özünün günahı? Xeyr. Amma risk. Onun nəzəri sisteminə mexanizmə quraşdırılmış yay kimi tikilmiş risk.

Bəs bu gün psixiatriyada yunqçu ənənə nə olaraq qalır?

Əsas olan — psixotik təcrübələrin mənalılığı ideyasıdır. Yunq, özündən əvvəl Bleyler kimi, qeyri-mümkünü etdi: şizofrenik sayıqlama xaosuna nəzər saldı. Səslərin gurultusuna.

Hallüsinasiya qırıntılarına. Orada məna varmı? Yunq tapdı. Sayıqlama mənasız səs-küy deyil. Hallüsinasiyalar təsadüfi nasazlıq deyil. Onlarda struktur var. Onlarda xəstənin bioqrafiyası ilə, qorxuları ilə, ümidləri ilə, böyüdüyü mədəniyyətlə əlaqə döyünür. Müasir psixiatriya bunu inkar edə bilmədi. Bu ideyanı öz yanaşmasına daxil edərək qəbul etdi. Bəs necə? Yunq ontologiyası şəklində deyil, klinik müdriklik şəklində.

Müasir həkim paranoid sanjıları olan xəstəsi ilə ünsiyyət qurarkən bu sanjıların mənasını anlamağa çalışır — niyə məhz FSB, niyə məhz yuxarıdakı qonşular, niyə məhz su vasitəsilə zəhərlənmə? Bunu edərkən Freyd və Yungun bizə öyrətdiklərini tətbiq edir. O, sanjıları sadəcə "sinir zöngüsü" kimi qiymətləndirmir. Onların xəstənin həyatı və daxili dünyası ilə əlaqəsini axtarır.

Bu — Yunq təhlili deyil. Bu — insaflı psixiatriyadır. Yunq məktəbi isə, Freyd məktəbi ilə yanaşı, onun formalaşmasına böyük töhfələr vermişdir.

Amma Yunqun anlayışları fərdi xəstənin kliniki müalicəsi çərçivəsindən çıxıb "kosmologiya" sahəsinə keçdikdə başqa bir şey baş verir. Kommersiya əsaslı ezoterika özünü göstərir.

1990-cı illərin əvvəlləri. Bert Hellinger — haqqında daha sonra ayrıca danışacağımız bir şəxs — dünyaya öz metodunu yağdırır. Bunu "ailə yerləşdirmələri" adlandırır. Təsadüf? Zəif ehtimal. Hellinger sonrakı əsərlərində Yunga istinad edir. Onun ardıcılları isə bunu daha tez-tez və daha təkidli edirlər. Sirr metodun özündə gizlənir: yerləşdirmələrdəki "nəsillər sahəsi" konsepsiyası kollektiv şüursuzluğun qan qohumu kimi təqdim olunur. Hellingerin "sevgi qaydaları" isə arxetipik quruluşların canlı əti kimi. Və beləcə tələ işə düşür. Postsovet məkanında minlərlə insan Yung vasitəsilə gəzib — birbaşa Hellingerin qucağına düşür. Hellinger vasitəsilə isə Yungla heç bir əlaqəsi olmayan bir sistemə daxil olurlar.

Eyni şey reqressologiyaya da aiddir. "Sistem düzümlərinə" də. Qadın retreatlərinə və kişi inisiasiyalarına da. "Arxetip" sözünün öz ciddi analitik mənasından kənar səsləndiyi hər yerdə — çox güman ki, Yunqun kommersiya məqsədilə istismarı ilə üzləşmişik.

Yunq 1961-ci ildə vəfat etdi. O nə Vudstoku, nə Nyu Eycı, nə də Instagram psixoloqlarını görmədi. Əgər görsaydı, məncə, dəhşətə gələrdi. Məntiq və klassik təhsili sevən ciddi İsveçrə psixiatrı öz irsinə etdikləri şeyləri təsdiqləyə bilməzdi.

Beləliklə, XIX əsrin sonu — XX əsrin əvvəllərində Kraepelin, Bleyler, Freyd və Yunqun səyləri sayəsində psixiatriya dörd ən mühüm alət əldə etdi.

Kraepelindən — klinik metod və endogen psixozların dixotomiyası.

Bleylerdən — şizofreniya anlayışının özü və onun daxili psixi quruluşu haqqında təsəvvür.

Freyddən gələn şey, şüursuz proseslər haqqında danışmaq üçün dil və psixotik əlamətləri daxili münaqişənin nəticəsi kimi başa düşməkdir.

Yunqdan — psixotik məzmunun mənasına diqqət yetirmək və başa düşmək ki, hallüsinasiyalarda və sayıqlamalarda təkcə şəxsi deyil, ümumbəşəri mövzular da əks olunur.

Bu konseptlər toplusu bu gün də şizofreniya haqqında düşüncə tərzimizin təməlini təşkil edir. Hətta müasir psixiatr Freydi və ya Yunqu sitat gətirmədikdə belə, onların yaratdığı paradigma çərçivəsində çalışır.

Lakin bunların heç biri müalicə etmirdi. 1930-cu illərə qədər psixiatriya qüsursuz nəzəriyyəyə malik olsa da, xəstə yatağı qarşısında demək olar ki, çılpaq əllərlə dururdu. Və çarəsizlik içində, heç olmasa "işləyən" bir praktika axtarışında olan həmin dövr həkimləri 5-7-ci fəsillərdə oxuduğumuz üsullara — insulin komasına, piroterapiyaya, lobotomiyağa üz tutdular. Bu radikal bioloji təsir üsulları ilə paralel olaraq

nəzəri axtarışlar da davam edirdi. Növbəti fəsildə biz 20-ci əsrin əvvəllərində fəlsəfə və psixiatriyanın kəsişməsində yaranan başqa bir böyük məktəbə — fenomenoloji məktəbə — və tibbin hələ də ən sirli xəstəliklərindən birini anlamağa olan töhfəsinə nəzər salacağıq.

Fəsil 12. Fenomenoloji məktəb: pasiyent olmağı necə öyrənmək olar

1911-ci ildə, doğuşdan ağır ürək çatışmazlığı və bronxoektaziya xəstəliyindən əziyyət çəkən və hər gününün özünə bir hədiyyə olduğunu bilən otuz yaşlı Heydelberq Universitetinin psixiatriya klinikasının assistenti Karl Yaspers (Karl Jaspers, 1883–1969) kiçik bir məqalə dərc etdi. Məqalə təvazökar ad daşıyırdı: "Psixopatologiyada fenomenoloji yanaşma". İyirmi səhifədən bir qədər çox. Nə müəllifin özü, nə də başqa heç kim bu məqalənin dünya psixiatriyasında inqilab edəcəyini gözləmir idi.

Amma elə də oldu.

İki il sonra — 1913-cü ildə — Yaspers bu məqaləni əsas götürərək onu iri bir monoqrafiyaya çevirdi: "Ümumi psixopatologiya" (Allgemeine Psychopathologie). 1959-cu ilə qədər — müəllifin sağlığında çıxan son nəşrdə — kitab təxminən min səhifəyə çatdı. Bu rəqəm insanın tənəffüsünü kəsir: min səhifə tək bir adamın, tək bir zəkanın, tək bir tutqunun məhsuludur. Bu cild heç bir şişirdilmə olmadan XX əsrin alman dilli dünyasında ən təsirli psixiatriya dərsliyinə çevrilmişdir. Onu onlarla dilə tərcümə etmiş, psixiatrların nəsilləri oxumuşdur. Akademik jurnallarda hələ də ona istinad edirlər.

Bunların hamısı isə maraqlı bir detalın fonunda baş verib. Yaspers ciddi mənada klinik psixiatr olmayıb. Onun tibb təhsili var idi, lakin o, psixiatriya sahəsində çox az işləmişdi — yalnız bir neçə il Heydelberqdə assistent vəzifəsində çalışıb. Sonra fəlsəfəyə keçmişdi. O, Hanna Arentin müəllimi, Haydeg-

gerin müzakirə yoldaşı, XX əsrin əsas ekzistensialist filosoflarından biri idi. Onun fəlsəfəsi ölüm, həddindən artıq vəziyyətlər və şəxsiyyətlər arasındakı əlaqə problemləri ilə formalaşıb.

Lakin məhz bu qəribə yol — əvvəl tibb, sonra fəlsəfə, daha sonra yenidən psixopatologiyaya qayıdış — Yaspersə xalis klinisistlərin edə bilmədiyini etməyə imkan verdi.

O, dəqiq nə etmişdi?

O, sadə, lakin inqilabi bir sual verdi: biz psixiatrlar ümumilikdə psixi xəstəliklər haqqında bildiyimizi necə bilirik?

Yaspersdən əvvəl psixiatrlar simptomları təsvir edirdilər: halüsinasiyalar, deluziyalar, narahatlıq, depressiya. Onlar xəstəlikləri təsnif edirdilər: şizofreniya, mani-depressiv psixoz, isteriya. Lakin onlar nadir hallarda bu bilikləri əldə etmək üçün istifadə olunan metod haqqında düşünürdülər. "Təsvir etmək" halüsinasiyanın mənası nədir? "Başa düşmək" deluziyanın mənası nədir? Biz bunları necə bir-birindən fərqləndiririk?

Yaspers alman filosofu Edmund Husserlin (Edmund Husserl, 1859–1938) tərəfindən işlənilmiş metodologiyanı götürərək onu psixiatriyaya tətbiq etdi. Husserl öyrədir ki, şüuru öyrənmək üçün bütün nəzəriyyələri, bütün əvvəlcədən qəbul edilmiş izahları, bütün önyarğıları şübhə altına almaq və yaşantının özünə necə verildiyinə qayıtmaq lazımdır. "Zu den Sachen selbst" — "Əşyaların özünə".

Yaspers psixiatriyaya qaranlıq bir labirintə daxil olan kimi girdi. Və özü ilə bir qayda gətirdi. Psixotik yaşantıları — libido, şüuraltı, nevrologiya və ya hər hansı başqa şeylə izah etməzdən əvvəl, onları düzgün təsvir etməyi öyrənmək lazımdır. Niyə? Cavab özü xəstədə gizlənir. Ona yaxınlaş. Nəzəriyyəsiz. Zehni bütün düsturlardan təmizlə. Onu dinlə. Onun öz dünyasını necə yaşadığını anlamağa çalış. Onun əyri-dəyri gerçəkliyini hiss et, onun kainatını içəridən gör. Və yalnız bundan sonra — dəqiq təsvirdən sonra — səbəblər haqqında suallar ver.

Bu, inqilabi bir dönüş idi. Psixiatriyanı xəstəyə tərəf çevirdi.

Yaspersin ikinci əsas töhfəsi psixopatologiyada iki bilik növünü ayırd etməsidir.

O, birinci tipə "anlama" — Verstehen adını verdi. Bu, bir şüurun başqa birinin yaşantılarının zirehini yarıb keçə bilmə qabiliyyətidir. Təsəvvür edin: qarşınızdakı adam anasının öldüyünü deyir. Siz bu kədəri hiss edirsiniz. Ağlınızda kədər haqqında bir nəzəriyyə qurulduğu üçün yox, özünüz ət və qandan olduğunuz üçün. Bədəniniz daxili təcrübədən itkinin nə demək olduğunu xatırlayır. Bu anlama sübut tələb etmir. O, intuitiv, empatik, birbaşadır.

İkinci tipə Yaspers "izah" (Erklären) adını verdi. Bu, hadisələr arasında səbəbiyyət əlaqələrinin qurulmasıdır. "Bu xəstədə depressiya var, çünki sinapslarda serotonin səviyyəsi aşağı düşüb" — dedikdə, onun depressiyasını içəridən anlamırıq, tədqiqatla əsaslandırılmış səbəb-nəticə zənciri vasitəsilə xaricdən izah edirik.

Yaspers üçün bu iki metod bir-birinə zidd deyildi, sadəcə fərqli bilik sahələrinə aid idi. Anlama psixikadakı məna əlaqələrindən söhbət gedəndə işləyir: bir yaşantının digərinə necə gətirib çıxardığı, fikrin emosiyanı necə doğurduğu. İzah isə bədəni, bioloji, neyrokimyəvi proseslərdən söhbət gedəndə işləyir.

Və elə burada Yaspers şizofreniya barədə heyrətamiz bir müşahidə etdi. O iddia edirdi ki, şizofrenik xəstələrin psixotik yaşantıları — özünün deliryum mahiyyətində — anlamağa tabe deyil. Yəni psixiatr sadəcə empatiya səyi ilə FSB-nin divarlardakı naqillər vasitəsilə ona mesajlar ötürdüyünə inanmağın necə bir şey olduğuna nüfuz edə bilməz. Bu, kədərə bənzəmir. Bu, təşvişə bənzəmir. Bu, tamam başqa bir şeydir, adi insan həyatında heç bir bənzəri yoxdur. Şizofrenik deliryum — ununderstandable, "anlaşılmaz"dır.

Yaspersin bu fikri sonralar psixiatriya fəlsəfəsində ən çox müzakirə olunan ideyalardan birinə çevriləcəkdi. Bəzi tələbələri onunla razılaşacaqdılar. Digərləri — xüsusən də hələ haqqında yazacağım Binsvanqer — onunla mübahisə edəcəkdilər. Bu mübahisə bu günə qədər davam edir.

Amma belə bir mübahisənin mümkün olmasının özü də Yaspersin xidmətidir. O, psixiatriyanı XIX əsrin pozitivist özgüvənliyindən çıxarıb qarşısına hələ də həllini axtardığı fəlsəfi suallar qoydu.

Yaspers ilk olsa da, tək deyildi. Fenomenoloji yanaşma XX əsrin ilk yarısında psixiatriyada bütöv bir hərəkatın meydana gəlməsinə səbəb oldu.

Onun ən parlaq nümayəndələrindən biri Ejen Minkovski (Eugène Minkowski, 1885–1972) idi. Bu qeyri-adi adam Varşavada yəhudi ailəsində doğulmuşdu. Almaniya, İsveçrə və Fransada tibb təhsili almışdı. Burghölzli-də Bleylerin assistenti işləmişdi. 1914-cü ildə, Birinci Dünya müharibəsi başlayanda, Minkovski — Rusiya imperiyasının vətəndaşı olmasına baxmayaraq — könüllü surətdə Fransa ordusuna hərbi həkim kimi yazılmışdı. Sonralar Fransada məskunlaşdı, Parisin Sent-Ann xəstəxanasının baş psixiatrı oldu və ömrünün qalan hissəsini orada yaşadı. İkinci Dünya müharibəsi zamanı arvadı ilə birlikdə yəhudi Müqavimət hərəkatında iştirak edərək uşaqları deportasiyadan xilas edirdi.

1927-ci ildə Minkovski "Şizofreniya" (La schizophrénie) kitabını dərc etdirdi. 1933-cü ildə isə ondan daha məşhur olan "Yaşanmış zaman" (Le temps vécu) əsərini nəşr etdirdi. Bu əsərlərində psixopatologiya tarixinin ən dərin anlayışlarından birini — "trouble générateur" (əsas, yaradıcı pozuntu) anlayışını irəli sürdü.

Minkovskinin ideyası — bu, bir detektiv sxemidir. Halüsinasiyalar. Deliryum. Emosional yastılaşma. Davranış qəribəlikləri. Şizofreniyanın bütün bu simptomları təsadüfi

qırıntılar yığımı deyil. Onlar bir dərin sıxılmadan boy atır. Bəs kök haradadır? Məhz nə dağılıb? Minkovski boşluğu tapdı. Şizofrenik xəstədə onun varlığının strukturunun özündə nə isə fundamental pozulub. Xüsusilə də Minkovskinin "reallıqla həyati təmas" (contact vital avec la réalité) adlandırdığı şey. Abstract səslənir. Amma bu formulun arxasında bədənsəl fəlakət gizlənir. Bu, kortəbii, refleksiyadan əvvəl, bütün varlığı ilə dünyada olmaq qabiliyyətidir. Onu nəfəs almaq, ona toxunmaq. Başqa insanlarla qarşılıqlı təsirdə olmaq. Zaman axınının necə döyündüyünü hiss etmək. Intuitiv, heyvani bir "hüzur"a malik olmaq. Onlar bu əlaqəni itiriblər. Onlar varlıq toxumasından qoparılıblar.

Minkovskinin fikrincə, şizofreniyada bu həyati əlaqə pozulur və ya itir. Xəstə sanki reallıq axınından kəsilir. Onun üçün zaman dayanır və ya qəribə şəkildə axır. Digər insanları dərk etmə qabiliyyəti itir. Dünya formal, mexaniki və yad bir məkanə çevrilir. Bütün digər simptomlar bu əsas pozuntunun nəticəsidir.

Bu, çox gözəl və dərin bir fikirdir. Həm də bunun praktik əhəmiyyəti var idi: şizofreniya xəstəsi ilə ünsiyyət quran psixiatra anlamağa kömək edirdi ki, qarşısındakı sadəcə qəribə simptomlar toplusuna malik bir adam deyil, dünyada olma tərzinin özünün əsaslı dəyişməsini yaşayan bir insandır.

Minkovski daha bir anlayış irəli sürdü. Təhlükəli. Yaxalanması çətindir. "Praecox hissi" — sentiment de précocité, bəzən praecox-Gefühl. Bu nədir? Təcrübəli psixiatrın şizofreniyadan əziyyət çəkən xəstə ilə qarşılaşdıqda hiss etdiyi subyektiv duyğu. Tutulması çətin, təsviri demək olar ki, mümkünsüz, lakin səhvsiz. Həkim insana baxır — və dərisində ürpertici soyuqluq hiss edir. Boğazda spazm. İçgüdü təhlükə barədə xəbərdar edir. Psixiatr bu insanın qəribəliyini, yadlığını hiss edir. Bunu klinik terminlərlə, sözlərlə, diaqnozla ifadə edə bilməzdən əvvəl. Həkimin bədəni ağlının hələ dərk edə bilmədiyini oxuyur. Minkovski bunu "nüfuz vasitəsilə diaqnostika" —

diagnostic par pénétration adlandırdı. Şizofrenik quruluşun intuitiv dərk edilməsi.

Müasir psixiatriyada bu ideya tez-tez göz ardı edilir, çünki "elmi deyil" və "subyektiv" hesab olunur. Lakin bir çox təcrübəli klinisyenlər — mən də daxil olmaqla — sizə deyəcək ki, praecox-Gefühl mövcuddur. Biz həqiqətən də şizofreniyası olan pasientlə qarşılaşdıqda xüsusi bir hiss keçiririk. Elm hələ ki, bunu necə formalaşdırmağı bilmir. Bəlkə bir gün öyrənəcək.

Fenomenoloji məktəbinin üçüncü mühüm şəxsiyyəti — İsveçrəli psixiatr Lüdviq Binsvanqerdir (1881–1966). O, İsveçrənin Kroytslingen şəhərindəki nüfuzlu "Belvyu" sanatoriyasının direktoru idi — məhz həmin sanatoriyada Anna O., Jozef Breyerin məşhur xəstəsi və psixoanaliz tarixinin ilk nümunələrindən biri müalicə almışdı.

Binsvanqer Freydden Haydeggerə qədər uzanan bir yol keçdi. Psixoanalitik kimi fəaliyyətə başlayan, Freydin yaxın dostu olan və onunla demək olar ki, qırx il ərzində yazışan Binsvanqer tədricən psixoanalitik dilin psixotik xəstələri təsvir etmək üçün yetərsiz olduğunu hiss etdi. Daha dərin, daha fəlsəfi bir şey lazım idi.

Bunu Martin Haydeggerin (Martin Heidegger, 1889-1976) fəlsəfəsində, xüsusilə də onun məşhur "Varlıq və Zaman" (1927) kitabında tapdı. Binsvanqer öz üsulunu yaratdı və ona Haydeggerin "Dasein" (burada-var olmaq) terminə istinadən "Daseinsanalyse" — "mövcudluq təhlili" adını verdi.

Təsəvvür edin: dəlinin ağlını başa düşmək üçün onun beynini öyrənmək yetərli deyil. Onun dünyada varlıq şəklinin necə qurulduğunu anlamaq lazımdır. Hər birimiz özümüzə məxsus üsulla mövcud oluruq — hər kəsin məkan, zaman, öz bədəni və digər insanlarla münasibəti özünəməxsusdur. Varlıq forması məhz budur. Və əgər bu forma pozulubsa — psixopatologiya yaranır. Binsvanqer sadəcə müalicə etmirdi. O, insan

varlığının özünün strukturunu açırdı. Şizofreniya, maniya, melanxoliya — adi mənada xəstəlik deyil. Bunlar dünyada-varolmanın pozulmuş müxtəlif rejimləridir. Düz budur.

1957-ci ildə Binsvanqer "Uğursuz varlığın üç forması" (Drei Formen missglückten Daseins) əsərini nəşr etdi və burada üç hadisəni təhlil edirdi: ağır depressiya və intihar, şizofreniya və ekstremal qəribəlik. Hər bir hadisəni "simptomlar" vasitəsilə deyil, xəstənin varlıq üsulu — məkanda, zamanda və münasibətlərdə yaşayış şəkli vasitəsilə təsvir edirdi.

Bu, bəlkə də psixiatriya tarixində ən fəlsəfi yanaşmadır. Onu "texniki" tətbiq etmək çətindir. Psixiatrdan dərin fəlsəfi bilik, ədəbi həssaslıq və səbir tələb edir. Amma tətbiq olunduqda, xəstəni hər hansı digər məktəbdən daha dərindən anlamağa imkan verir.

Yasperslə Binsvanqer arasında olan mübahisə fenomenoloji psixiatriya tarixində mühüm məqam idi. Yaspers israrlı idi: şizofreniyanı empatiya yolu ilə dərk etmək mümkün deyil. Binsvanqer etiraz edirdi: şizofreniya dünyada-varolmanın spesifik rejimidir və əgər biz bu rejimin quruluşlarını yetərincə dərin təhlil etsək, onu başa düşə bilərik. Lakin ayrı-ayrı simptomlar kimi deyil, tam həyat forması kimi.

Hər iki mövqe həqiqətin bir hissəsini özündə daşıyır. Hər ikisi bugünkü psixiatriyada yaşamaqda davam edir.

Fenomenoloji məktəb bu gün, tomoqrafiya, psixofarmakologiya və böyük məlumatlar dövründə bizim üçün nəyə görə dəyərlidir?

Əsas odur ki, o psixiatriyaya qulaq asmaq sənətini bəxş etdi.

Müasir tibbdə, daha çox qısa məsləhətləşmə, standart sorğu vərəqələri və MKB ya da DSM-yə əsaslanaraq tez diaqnoz qoyuluşu üzərində qurulan sistemdə böyük bir təhlükə var. Psixiatrın qarşısındakı insanın konkret, tək və qəribə təcrübəsini dərindən anlamadan, klinik vərəqələrdə yalnız işarələr qoyan bir operatora çevrilməsi təhlükəsi...

Fenomenoloji ənənə bizə xatırladır: pasiyent simptomlar məcmusu deyil. Pasiyent dünyanı özünəməxsus şəkildə yaşayan insandır. Onun bu unikal yaşantı tərzi özlüyündə klinik əhəmiyyət daşıyır. Həkim qulaq asmırsa, xəstəliyi görmür. O, yalnız sorğu vərəqlərində qeyd etdiyini görür.

Hər dəfə müasir psixiatr xəstəsi ilə söhbət edərkən standart klinik şkaladan deyil, canlı maraqdan suallar verəndə: "Bu sizin üçün necədir?", "Zəhmət olmasa, bu anda nə hiss etdiyinizi təsvir edin", "Zaman sizin üçün adi axır, yoxsa başqa cür?" — o, Yaspers, Minkovski və Binsvangerin qoyduğu ənənəyə əsaslanaraq iş görür.

Bu mənada fenomenoloji irs yaşayır. Ayrı bir məktəb kimi deyil, psixiatriyanın vicdanı kimi. Bu, klinik kateqoriyaların arxasında yaşayan və acı çəkən insanların dayandığını xatırladan bir səs kimi.

Amma burada da — Freydlə olduğu kimi, Yunqla olduğu kimi — aydın demək lazımdır. Fenomenoloji məktəb şizofreniyanın müalicəsi vəzifəsini həll etmədi. Nə Yaspers, nə Minkovski, nə də Binsvanqer antipsixotik dərmanlarla müqayisə oluna biləcək terapevtik nəticələr verən metod işləyib hazırlamadılar. Onların töhfəsi müalicədə deyil, anlamadadır.

Burada isə bu kitabın əsas mövzusuna qayıdan çox mühüm bir qeyd etmək istəyirəm.

Fenomenoloji yanaşması — çoxillik fəlsəfi və klinik təhsil tələb edən ciddi akademik fəndir. Binsvangər "Ellen Vest" və ya "Lola Foss" hallarını təhlil edərkən Haydeggerin, Husserlin, Şelerin və Bergsonun əsərlərinə dərindən bələd idi. O fəlsəfəni orijinal dilində oxuyur, əsərlərini illərlə yazıb redaktə edirdi.

Bu — müasir kommersiya məhsulu olan "ekzistensial psixoterapevtlər" deyil, bir neçə tərcümə kitab oxuyub "biznes üçün Haydegger" kurslarını pulla keçirənlər deyil. Bu — ezoterik "uyğunlaşdırıcılar" deyil, ara-sıra Binsvangeri özlərinin öncülü kimi xatırlayanlar deyil. Bu — "ekzistensial" sözünün

reklam nişanı kimi istifadə olunduğu məktəblər deyil. Xeyr. Bütün bunlar — saxtadır. Və təhlükəli bir saxtakarlıqdır. Çünki onun arxasında əsl tarix durur. Başqa bir tarix. Qorxunc bir tarix. Fəlsəfənin satılmadığı, xilas etdiyi tarix. Və ya xilas etmədiyi — onda insan özü ilə ödəyir.

Həqiqi fenomenoloji psixiatriya — nadir rast gəlinən, xüsusi hazırlıq tələb edən və çox "satıla bilən" olmayan bir sahədir. Məhz buna görə də müasir kommersiya məkanında onu demək olar ki, görmək mümkün deyil. Əvəzində isə onun təqlidləri var — "fenomenologiya", "iştirak", "dünyada var olmaq", "əslilik" kimi sözlərdən istifadə edən, amma bunların nə fəlsəfi, nə də klinik əsasını verməyən yanaşmalar.

Bu sözləri "terapevtik retrit" reklamında eşitdikdə özünüzdən soruşun: aparıcı Husserl'in "epoché" dediyini bilir? Jasper'ı orijinalında və ya akademik tərcümədə oxuyubmu? Klinik təlim keçibmi? On halın doqquzunda cavab "xeyr" olacaq. Qarşınızda fenomenoloji ənənə deyil. Qarşınızda bu terminologiyanın kommersiya məqsədli istifadəsi var.

Bu, müasir çılğınlıq pandemiyasının ən geniş yayılmış mexanizmlərindən biridir: metodoloji cəhətdən məzmunsuz təcrübələri ört-basdır etmək üçün ciddi akademik fənlərin dilindən istifadə.

Beləliklə, XX əsrin ortalarına qədər psixiatriyanın üç güclü nəzəri ənənəsi mövcud idi — Kraepelinin klinik yanaşması, Freyd-Yunqun dərin psixoloji metodları və fenomenoloji fəlsəfi mövqeyi. Bu yanaşmalar bir-birini tamamlayır, mübahisə edir və zənginləşdirirdi. Birlikdə onlar, 1950-ci illərdə ilk antipsixotik dərmanların meydana çıxması zamanı psixiatriyanın üzərində durduğu ideyalar kompleksini təşkil edirdilər.

Lakin elə bir dördüncü ənənə də vardı ki, o, əsrin birinci yarısında hələ zəif inkişaf edirdi, amma əsrin sonlarına doğru psixiatriyada faktiki olaraq hökmran mövqeyə yüksəldi. Bu, bioloji yanaşma idi — şizofreniyanı neyrokimya, genetika, ney-

rovizualizasiya və immunologiya vasitəsilə anlamaq cəhdi. Bu yol uzun, ağrılı, yalançı ümidlərlə və dalanlarla dolu idi. Elə söhbətimiz də məhz bu barədə — psixiatriyanın "bioloji dönüşü" və onun bu günə qədərki nəticələri haqqında olacaq.

Fəsil 13. Bioloji nəzəriyyələr: beyinə açar axtarışı

1952-ci ildə Fransada bir hadisə baş verdi ki, bu daha sonra tibb tarixinin ən mühüm mərhələlərindən biri adlandırıldı. Bu hadisə milyonlarla xəstənin həyatını dəyişdirdi. Lakin psixiatriyada tez-tez olduğu kimi, bu təsadüfən baş verdi.

Fransız anesteziologu Anri Labori (1914–1995) çarəsiz halda dərman axtarırdı. Ona tək bir şey lazım idi — cərrahi xəstələrdə əməliyyatdan sonrakı şoku aradan qaldırmaq. Maddəni bir-birinin ardınca sınaqdan keçirirdi, nəhayət qəribə bir şeyə rast gəldi. Fenotiazinlər qrupuna aid sintetik birləşmə. Laboratoriya protokollarında o, üzsüz bir kodla — RP-4560 kimi qeyd olunmuşdu. Və işləyirdi. Amma Laborinin gözlədiyi kimi yox. Dərman xəstələri sadəcə sakitləşdirmirdi. Onda Laborinin "evforik biganəlik" (désintéressement euphorique) adlandırdığı hala səbəb olurdu. Xəstələr narahat olmağı dayandırırdılar. Əməliyyatdan qorxmağı dayandırırdılar. Döş qəfəsləri rahatlanır, nəfəs almaları bərabərləşir, çiyinləri düşürdü. Qəribə dərəcədə sakitləşirdilər — amma şüurları yerində qalırdı.

Labori düşündü: bəlkə bunun psixiatriyaya faydası dəyər?

O, bu barədə həmkarlarına danışdı. Müqəddəs Anna xəstəxanasında çalışan iki parisli psixiatr — Jan Deley (Jean Delay, 1907–1987) və Pyer Deniker (Pierre Deniker, 1917–1998) — buna maraq göstərdilər. Artıq xlorpromazin (chlorpromazine) ticarət adını almış dərmanın bir neçə ampulasını götürüb psixotik pozğunluğu olan xəstələrinə verməyə başladılar.

Nəticə heyrətamiz oldu.

Kəskin şizofreniyası olan, o vaxta qədər divarlara çırpınan, saatlarla qışqıran və əzabverici hallüsinasiyalar keçirən xəstələr sakitləşməyə başlayırdılar. Sadəcə sedasiyadan yuxuya getmirdilər, realıqla — heç olmasa qismən — əlaqəyə qayıdırdılar. Deliryum geri çəkilir, hallüsinasiyalar kəskinliyini itirir, emosional gərginlik isə azalırdı.

Dele və Deniker öz tədqiqat nəticələrini 1952-ci ildə "Annales Medico-Psychologiques" jurnalında dərc etdirdilər. 1954-cü ildə xlorpromazin ABŞ bazarında "Torazin" brendi altında satışa çıxdı. 1955-ci ildə isə Böyük Britaniyaya daxil oldu. Onilliyin sonuna qədər artıq dünyanın bütün inkişaf etmiş ölkələrində istifadə olunurdu.

Bu, ilk antipsixotik idi. Tibb tarixində şizofreniya simptomlarını həqiqətən — və ya xəyali, placebo və ya ritualla deyil — yüngülləşdən ilk dərman idi.

Xlorpromazinin psixiatriyaya gəlişi ilə yeni bir dövr başladı. Xəstəxananın yalnız təcrid yeri olmaqdan çıxdığı dövr. Bəs necə oldu ki, cılız bir molekul metrlərlə qalın divarları sındıra bildi? 1950-ci illərdə Amerika və Avropa psixiatrik xəstəxanaları bir neçə yüz min xronik xəstəni qıfıl altında saxlayırdılar. Donmuş bədənlər. Boş baxışlar. Çoxu onillərlə orada uzanmışdı, soyuq çarpayılara möhkəm zəncirlənmişdilər. Sonra antipsixotiklər gəldi. Və hər şey dəyişdi. Xəstəxanalardakı xəstələrin sayı azalmağa başladı. Bu prosesə deinstitusionallaşdırma dedilər. Otuz il — və "ilan quyularının" çoxu artıq yox idi. Yardım ambulator sahəyə keçdi.

Amma xlorpromazin yalnız klinik effekt vermədi. O, həm də elmi bir sual doğurdu: niyə işləyir?

Farmakoloqlar təsir mexanizmini öyrənməyə başladılar. Və tədricən, 1960–1970-ci illər boyu mühüm bir nəticəyə gəldilər: xlorpromazin beyindəki dopamin reseptorlarını bloklayır. Dopamin — motorika, emosional tənzimləmə və mükafat sis-

temi də daxil olmaqla bir çox funksiyada iştirak edən neyrotransmitterdir. Xlorpromazin beynin subkortikal strukturlarındakı D2 tipli reseptorları xüsusilə güclü bloklayırdı.

Buradan şizofreniyanın ilk ciddi bioloji nəzəriyyəsi — dopamin hipotezi doğuldu. 1960–1970-ci illərdə irəli sürülmüş klassik formulirovkasında o belə səslənirdi: şizofreniya — beynin müəyyən şöbələrində həddindən artıq dopaminerjik aktivliyin yaratdığı haldır. Əgər dopaminin reseptorlarını bloklamaqla aktivliyini aşağı salsan, simptomlar zəifləyər.

Bu hipotezi iki müşahidə möhkəmləndirirdi. Birincisi, dopaminerjik ötürməni gücləndirən dərmanlar — amfetaminlər, kokain, L-DOPA (Parkinson xəstəliyində tətbiq olunur) — böyük dozalarda şizofreniyaya bənzər psixotik hallar yarada bilir. İkincisi, o illərdə təsirli olan bütün antipsixotiklər — xlorpromazindən haloperidola qədər — D2 reseptorlarını bloklayırdı. Dərmanın effektivliyi ilə D2 blokadasının gücü arasındakı korrelyasiya çox yüksək idi.

Bir neçə onillik boyu dopamin hipotezi bioloji psixiatriyada hökmranlıq edirdi. Zərif görünürdü. Perspektivli görünürdü. Vəd edirdi ki, nə vaxtsa, beynin dopaminergik sistemləri haqqında daha dəqiq biliklə şizofreniyanı empirik yox, rasional şəkildə müalicə etməyi öyrənəcəyik.

Amma yarım əsr keçdi. Və mənzərə xeyli mürəkkəb oldu.

Birinci problem: antipsixotiklər dopamini demək olar ki, dərhal bloklayır, amma klinik effekt həftələr sonra inkişaf edir. Əgər şizofreniya tamamilə dopamin artıqlığından ibarət olsaydı, simptomlar reseptorlar bloklandıqdan dərhal sonra zəifləməli idi. Lakin zəifləmir. Deməli, dopamin — bütün mənzərə deyil.

İkinci problem: antipsixotik dərmanlar “pozitiv” simptomları — hallüsinasiyaları, deliryumu, pozulmuş davranışı yaxşı aradan qaldırır. Lakin onlar “neqativ” simptomların öhdəsindən zəif gəlir — apatiya, emosional yastılaşma, sosial təcrid,

maraqların itirilməsi. Bundan başqa, koqnitiv pozuntularda — diqqət, iş yaddaşı, icraedici funksiyaların pozulmasında kifayət qədər effektiv deyillər; bu gün bunlar şizofreniyanın əsas xüsusiyyətlərindən biri hesab olunur.

Bu o deməkdir ki, dopamin blokadı klinik mənzərənin "üst qatını" aradan qaldırır, lakin onun əsasını toxunmur.

Üçüncü problem. Alimlər PET — pozitron-emissiya tomoqrafiyasından istifadə edib canlı beynin içinə baxdılar. 2000-ci illər. 2010-cu illər. Diqqətli skan illəri. Və budur — zərbə. Şizofreniya xəstələrində striatumda həqiqətən də dopamin coşur: onun sintezi və ifrazı hədsiz dərəcədə artmışdır. Hipotez təsdiqləndi? Qələbə? Elə də deyilmiş. Eyni beyin, eyni xəstələr — amma baxış prefrontal korteksə yönəlir. Orada isə hər şey əksinədir. Dopaminerjik aktivlik amansızcasına azalır. Bu necə mümkündür? Bir neyromediatr — və bir başda iki tamamilə ziddiyyətli reallıq. Bu, adi məntiqi dağıdır. "Hər yerdə çoxlu dopamin" kimi sadə bir izah yoxdur. Qarşımızda beynin müxtəlif zonaları arasında parçalanma, xaos, disbalans dayanır. Və sirr getdikcə daha qatı qaranlığa bürünür.

Dopamin hipotezinin müasir ifadəsi (2009-cu ildə Howes və Kapurun təklif etdiyi sözdə "üçüncü versiya") bu mürəkkəbliyi nəzərə alır. O, dopaminerjik sistemin regiona xas disregulyasiyasından şizofreniyanın əsasında duran bir çox mexanizmdən biri kimi bəhs edir — amma yeganə və bəlkə də ən vacib mexanizm kimi yox.

Bioloji nəzəriyyələrdə ikinci əsas namizəd — glutamatdır.

Qlutamat — beynin əsas oyadıcı neyrotransmitteridir. Alimləri sarsıdan müşahidə sadə və dramatik idi. Ketamin və fensiklidin (PCP) — qlutamatın NMDA reseptorlarını tamamilə bloklayan dissosiativ anesteziklər — sağlam insanlarda şizofreniyadan qorxulu dərəcədə seçilməyən vəziyyətlər yarada bilir. Bəs necə? Niyə məhz reseptorun bloklanması dəliliyi doğurur? Amfetamin psixozu yalnız pozitiv simptomları — deliryum,

hallüsinasiyaları canlandırırdı. Ketamin psixozları isə hər şeyi dağıdırdı: həm neqativ, həm də koqnitiv komponentləri. Ketamin qəbul edən xəstələr buz kimi depersonalizasiyada donub qalırdılar. Onlar emosional uzaqlaşma hiss edirdilər, sanki ruhları bədənlərini tərk etmişdi. Onları təfəkkür pozuntusu bürüyürdü. Demək olar ki, əsl şizofreniya xəstələri kimi. Qlutamat sistemində bir boşluq — və şüur içdən parçalanır.

Buradan da şizofreniyanın qlutamat hipotezi yaranır: əsas problem dopaminin artıqlığında deyil, NMDA reseptorlarının hipofunksiyasındadır. Bu hipotezə görə, dopaminerji pozuntular ikincildir və qlutamaterjik disfunksiyanın nəticəsi kimi meydana çıxır.

Bu hipotezin dəmir-beton əsasları var. O, dopamin nəzəriyyəsinin izah edə bilmədiyini açır. Neyrovizualizasiya. Genetika. Biokimya. Məlumatlar bir nöqtəyə zərbə vurur: qlutamat öz rolunu oynayır. Amma budur sirr. Dərman hardadır? Yoxdur. Balanssız qlutamaterjik ötürməni etibarlı şəkildə sakitləşdirə və şizofreniya zəncirini qıra bilən preparatlar hələ də mövcud deyil. Elmi dalana dirənmə? Sanki qurtuluş yaxın idi. Klinik sınaqlara bir-birinin ardınca ümidverici birləşmələr qatılırdı: qlisin, D-serin, metabotrop qlutamat reseptorlarının aqonistləri. Alimlər irəliləyiş gözləyirdilər. Xəstələr möcüzə gözləyirdilər. Lakin final aldatıcı çıxdı. Nəticələr məyusluqla heyrətə saldı. Ən yaxşı halda — orta səviyyəli. Heç bir sağalma yox. Qlutamatın sirri hələ də qıfıl altındadır.

Maraqlı müasir preparat olan lümateperon (lumateperone, Caplyta ticarət markası altında) 2019-cu ildə FDA tərəfindən təsdiq edilib. Bu dərman eyni zamanda dopaminerjik, serotoninerjik və qlutamaterjik sistemlərə təsir göstərir. Lakin bu da inqilab hesab edilmir, yalnız yeni nəsil preparatlardan biridir.

Bioloji tədqiqatların üçüncü cəbhəsi — genetika.

Şizofreniya — yüksək dərəcədə irsi xəstəlikdir. Əgər əkizlərdən biri xəstələnibsə, digərinin xəstələnmə ehtimalı təxminən

40-50 faizdir. Əgər əkizlər bir yumurtalı deyilsə, bu göstərici təxminən 15 faizə qədər düşür. Bu, ümumi populyasiyadakı (təxminən 1 faiz) göstərici ilə müqayisədə xeyli yüksəkdir. Belə yüksək irsi meyillilik (tədqiqatlara görə təxminən 80%) açıq şəkildə göstərir ki, genetika burada mühüm rol oynayır.

Uzun müddət "şizofreniya geni" axtarıldı — bir və ya bir neçə mutasiya, hansı ki, xəstəliyi izah edə bilərdi. Gözləntilər yüksək idi. Nəticələr isə məyus edici old. Heç bir "şizofreniya geni" tapılmadı. Bunun əvəzinə, 2000-ci illərdən başlayaraq genom assosiasiya tədqiqatlarının (GWAS) inkişafı ilə tamamilə fərqli bir mənzərə üzə çıxdı.

Şizofreniya — poligen xəstəliyidir. Onun riskində yüzlərlə, bəlkə də minlərlə müxtəlif gen iştirak edir. Hər biri yalnız kiçik, demək olar ki, hiss edilməz töhfə verir. Kimlərdir bu molekulyar sui-qəsdçilər? 2022-ci il üzrə şizofreniya riski ilə statistik əlaqəsi olan 250-dən çox genom lokusu müəyyən edilmişdir. 250-dən çox gizli sığınacaq. Bəs onlar nə edir? Ən müxtəlif proseslərdə iştirak edirlər: neyrotransmissiya, immun funksiyası, gen ekspressiyasının tənzimlənməsi, sinaptik plastiklik, sinir liflərinin miyelinizasiyası. Onlar hər şeyə zərbə endirir. Siqnal dağılır. Müdafiə zəifləyir. Kod pozulur. Əlaqələr kəsilir. İzolyasiya azalır. Xəstəlik bu puzzle-i hissə-hissə yığır.

Bu o deməkdir ki, şizofreniya — "bir genin işləməməsi" deyil, bir çox genetik faktorların və onların ətraf mühitlə qarşılıqlı əlaqəsinin iştirak etdiyi kompleks pozğunluqdur. Təxminən eyni şeyi biz 2-ci tip şəkərli diabetdə və ya ürək-damar xəstəliklərində də müşahidə edirik. Bu, "bir səbəbin deyil", "çoxlu kiçik töhfələrin biologiyası"dır.

Bu, müasir vəziyyəti anlamaq üçün prinsipial əhəmiyyət daşıyır. "Şizofreniyanın bioloji markeri" axtarışı — yəni qan analizi ilə müəyyən edilə biləcək marker — hələ də mümkünsüzdür. Genetik risk profilini qiymətləndirmək

mümkündür, lakin bu diaqnoz qoymur. Yalnız artan meyilliyi göstərir.

Dördüncü cəbhə — neyroinkişafdır.

Müasir psixiatriyada ən nüfuzlu nəzəriyyələrdən biri — şizofreniyanın neyroinkşaf hipotezidir (neurodevelopmental hypothesis). Bu konsepsiya 1987-ci ildə amerikalı psixiatr Daniel Vaynberqer (Daniel Weinberger) tərəfindən ən dolğun şəkildə irəli sürülmüşdür.

Mətləb budur. Şizofreniya — yeniyetməlik və ya gənclik dövründə, ilk klinik simptomların ortaya çıxdığı vaxt meydana gələn bir "beyin nasazlığı" deyildir. Bu, daha erkən, ana bətnindəki dövrdə və ya erkən uşaqlıqda baş verən beyinin inkişaf pozuntularının nəticəsidir. Bu pozuntular uzun illər boyu "səssiz" qalır. Onlar beynin tənəzzülə uğradığı kritik dövrlərdə, xüsusilə də yeniyetməlik və gənclik çağlarında, beyinin artıq neyron əlaqələrindən aktiv şəkildə xilas olduğu sinaptik "incəlmə" dövründə özünü göstərir. Əgər əlaqələrin quruluşu əvvəldən pozulubsa, bu incəlmə prosesi pozuntuları daha da dərinləşdirə bilər və şizofreniyanın klinik şəkildə aşkar olunmasına səbəb ola bilər.

Bu hipotez bir çox məlumat xətləri ilə dəstəklənir. Epidemiologiya tədqiqatları göstərir ki, şizofreniya xəstələrində ümumi populyasiyaya nisbətən daha çox döl və erkən inkişaf risk faktorlarına rast gəlinir: hamiləlik dövründə anaların yoluxma xəstəlikləri, doğum komplikasiyaları, hipoksiya, doğumda çəki çatışmazlığı. Neyrovizualizasiya tədqiqatları xəstələrin beyinlərində müəyyən struktur anomaliyaları müəyyən edir — genişlənmiş mədəciklər, boz maddənin həcminin azalması — bunlar, görünür, xəstəliyin başlanğıcında mövcud olur və onun nəticəsi deyil. Kognitiv tədqiqatlar göstərir ki, bir çox xəstə hələ uşaq yaşlarında, ilk psixotik epizoddan illər əvvəl, məktəbdəki uğurunda, motor koordinasiyasında və sosial davranışda yüngül sapmalar nümayiş etdirir.

Bu, adətən məntiqi dağıdan bir baxışdır. Şizofreniya kəskin fəlakət deyilmi? Şüuru parçalayan qəfil göy gurultusu deyilmi? Belə çıxır ki, xeyr. Bu, uzun, gizli bir prosesin nəticəsidir. İçdən qaynayıb-yanan bir alovun. Və bu kəşfin aşkar klinik tətbiqi var. "Erkən müdaxilə" yanaşması — early intervention. Bu gün Avropa səhiyyə sistemlərində qızıl standartdır. Mahiyyəti sadə və amansızdır: prodromal simptomlar göstərənləri tapmaq. İnsanları ilk tam psixotik epizod baş verməzdən əvvəl aşkar etmək. Şüuru uçurumdan bir addım öncə tutmaq. Və onlara ixtisaslaşdırılmış yardım göstərmək.

Beşinci cəbhə — immunoloji və infeksion hipotez.

Bu, daha yeni və hələ də tam formalaşmamış bir araşdırma istiqamətidir. Onun əsas müşahidələri belədir:

Hamiləlik dövründə — xüsusilə birinci və ikinci trimestrdə — keçirilən ana infeksiyaları övladlarda şizofreniya riskini artırır. Bu həm qripə, həm toksoplazmoza, həm də bəzi digər infeksiyalara aiddir. Mexanizm, ehtimal ki, ananın immun aktivasiyası ilə bağlıdır ki, bu da sitokinlər vasitəsilə dölün inkişaf edən beyninə təsir göstərir.

Şizofreniya xəstələrinin beynində xroniki neyroyanma əlamətləri aşkar edilib. Bunlara beynin immun hüceyrələri olan mikroqliyanın həddindən artıq aktivləşməsi, qanda və onurğa beyni mayesində proyanqam sitokinlərinin səviyyəsinin yüksəlməsi daxildir.

Şizofreniya riski ilə bağlı bəzi genlər — məsələn, 6-cı xromosomdakı əsas histouyğunluq kompleksi (MHC) bölgəsində yerləşənlər — immun funksiyası ilə əlaqəlidir.

Bu məlumatlar şizofreniyanın immun (immuniltihabi) hipotezini yaratdı. Hətta iltihab əleyhinə dərmanları — aspirin, seleksoksib, minosiklin — köməkçi müalicə kimi sınayan kiçik tədqiqatlar da var və nəticələr ziddiyyətli olsa da, ümidvericidir.

Doğrusunu desək, immunoloji fərziyyə hələlik müalicəvi əhəmiyyət daşıyan bir fakt kimi sübuta yetirilməyib. Bu maraqlı bir istiqamətdir, amma həqiqətə çevrilmiş deyil.

Bəs yetmiş il intensiv bioloji tədqiqatlardan sonra nə əldə etmişik?

Bizdə çoxlu qismən modellər var: dopamin modeli, qlutamat modeli, neyroinkiafla bağlı model, genetik model, immun model, oksidativ stress modeli, mielinləşmə pozuntuları modeli. Bunların hər biri mənzərənin bir hissəsini izah edir. Heç biri tamını izah etmir. Bütün bu məlumatları şizofreniyanın vahid, bütöv bioloji modelinə çevirəcək bir sintez bu günə qədər mövcud deyil.

Bizdə antipsikotiklər var ki, onlar əksər xəstələrdə pozitiv simptomları effektiv şəkildə aradan qaldırır, lakin neqativ və koqnitiv simptomların öhdəsindən zəif gəlir. Bizdə ikinci və üçüncü nəsil antipsikotiklər var (klozapin, risperidon, olanzapin, ketiapin, aripiprazol, lumateperon) ki, onların effektivlik və yan təsir profilləri fərqlidir, amma birincidən — xlorpromazindən — köklü şəkildə üstün deyil. Bizdə psixososial müdaxilələr var ki, onlar dərman müalicəsini tamamlayır və uzunmüddətli nəticələri yaxşılaşdırır.

Bu, dürüst bir elmi nəticədir. Şizofreniya müasir tibbin ən çətin problemlərindən biri olmaqda davam edir. Onu anlamaq çətindir, proqnozlaşdırmaq çətindir, tam şəkildə müalicə etmək çətindir. Amma onunla işləmək mümkündür. Ən müvafiq müalicə və dəstək şəraitində xəstələrin əksəriyyəti kifayət qədər funksional həyat tərzi sürə bilər.

Və burada mən vacib bir şey demək istəyirəm — bu kitab boyu qırmızı xətt kimi keçən bir şey.

Şizofreniyanın heç bir ciddi bioloji hipotezi möcüzə vəd etmir. Bunu yadda saxlayın. Nə dopamin hipotezi, nə qlutamat, nə genetik, nə də neyroinkiaf hipotezi. Hamısı eyni şeyi deyir — amma bunu pıçıltı ilə deyir, çünki həqiqət sensasiya

kimi səslənmir. Xəstəlik mürəkkəbdir. Çoxfaktorialdır. Onun bioloji əsaslarını yalnız qismən başa düşürük. Həqiqi alimlər budur ki, nə edir. Onlar məlumatları resenziyalı jurnallarda dərc edirlər. Onlar öz modellərinin məhdudiyyətlərini özləri göstərirlər — tənqidçilərdən əvvəl, birinci olaraq. Onlar elmi ədəbiyyatı izləyirlər. Onlar mövqelərini daim yenidən nəzərdən keçirirlər. Özünüzdən soruşun: nə üçün? "Həqiqəti" tapmış insan nə üçün onun natamamlığını könüllü şəkildə etiraf edir? Cavab sadədir: çünki o, həqiqəti axtarır, onun üzərində hakimiyyət deyil.

İndi isə bunu genetik, döl daxili, neyrokimyəvi və psixososial kökləri olan problemi bir seansda həll edəcəyini vəd edən hər hansı "unikal metod" satıcısı ilə müqayisə edin.

Fərq astronomikdir. Bir tərəfdə ən mürəkkəb bioloji sistemi öyrənməyə onilliklər həsr etmiş və bilikləri çətinliklə, zərrə-zərrə toplayan insanlar. Digər tərəfdə isə bir həftəsonu ərzində "metod ustası" kimi "sertifikatlaşdırılmış" və xidmət satmağa hazır insanlar.

Kimdənsə "müasir psixiatriya şizofreniyanın səbəbləri haqqında heç nə bilmir, amma mənim metodum bu problemi anladı" sözünü eşidəndə — bilin ki, ikinci ifadə yalandır. Danışan pis olduğu üçün deyil. Sadəcə olaraq o bilmir ki, beyin biologiyası əslində nə qədər mürəkkəbdir və həqiqi elm onu nə qədər uzun və vicdanla araşdırır.

Psixiatriya elm kimi şizofreniya haqqında çox şey bilir. Çox vaxt düşündüyümüzdən qat-qat artıq. Və öz biliyinin sərhədlərini də bilir — bu, yetkin elmi fənnin əlamətidir, zəifliyi deyil.

Bioloji psixiatriya bu gün həlledici dövrə gəlib çatıb. Önümüzdə böyük bir sıçrayış durur. Dörd texnologiya cəhalət divarını dağıdacaq: təkhüceyrəli genomika, konnektomika tədqiqatları, optogenetika və CRISPR. Daha dünən fantastika kimi görünən şeylər indi reallaşır: beyin ən incə və əlçatmaz səviyyələrdə öz sirlərini açır. Gələcək onilliklər bizi nə gözlə-

yir? Hazırkı köhnəlmiş, kobud və "kor" antipsixotiklərdən köklü şəkildə üstün olan dərmanlar. Amma bu, yalnız başlanğıcdır. Şizofreniya riskini əvvəlcədən proqnozlaşdıra biləcəyikmi? Bəli. Prodromal mərhələyə qədər dəqiq proqnozlaşdıra biləcəyik — xəstəliyin şüura kök salmasının qarşısını alacağıq. Və son zərbə: biomarkerləri tapacağıq. Onlar sayəsində şizofreniyanı alt tiplərə ayıra biləcəyik. Fərqləndirəcəyik. Hər bir xəstəyə fərdi yanaşacağıq. Və fərdiləşdirilmiş terapiya təyin edəcəyik — kor-koranə deyil, dəqiq hədəfə.

Bu — hərəkətdə olan elmdir. Tamamlanmayıb. Amma irəli gedir — dürüstcə, metodik, səhvlər və düzəlişlərlə.

Növbəti fəsil şizofreniyanın başqa bir ölçüsünə qapını taybatay açacaq. Sistemli yanaşmalar. Onlar təcrid olunmuş xəstənin beynini skan etmir — onlar əlaqələrin öz toxumasında virusu tapırlar. Ailə. Sosial kontekst. Psixikanın büdrədiyi və dağıldığı qarşılıqlı təsirlər labirinti. Qreqori Beytsonun qoşa rabitə nəzəriyyəsi. Ailə terapiyası. Kommunikativ modellər. Bu məktəblər sizə həb təklif etməyəcək. Onların kimyəvi skalpeli yoxdur. Amma onlar başqa bir şey təklif edir — kor nöqtəyə dəqiq dəyən bir baxış. Kritik vəziyyətdə terapevtik xilasa çevrilə bilən bir baxış.

Fəsil 14. Beytson və ikiqat bağ: ailə döyüş meydanına çevriləndə

1954-cü ilin payız günü Kaliforniya ştatının Palo-Alto şəhərindəki veteran xəstəxanalarından birinin palatasında İkinci Dünya müharibəsi veteranı oturmuşdu. Ona "şizofreniya" diaqnozu qoyulmuşdu. O, tarixini bilməyən heç kimin cavab verə bilməyəcəyi qəribə bir cümlə dedi: "Hakim bəyənməyib".

Yanında ingilis antropoloqu əyləşmişdi — peşəcə psixiatriyaya heç bir aidiyyəti olmayan, amma zehni quruluşuna görə o dövrün əksər həkimlərindən daha çox şey görən bir adam. Adı Qreqori Beytson idi (Gregory Bateson, 1904–1980). Xəstənin cümləsini eşidəndə, bu klinikadakı hər hansı adi həkim kimi onu cəfəngiyat saymadı. Tam ciddiyyətlə cavab verdi:

Sizə vəkil lazımdır.

Bu zarafat deyildi. Bu, xəstəni diaqnoz obyekti deyil, həmsöhbətə çevirən bir addım idi. XX əsr psixiatriya mədəniyyətinə yeni bir fikrin daxil olduğu an idi: bəlkə də şizofrenik sayıqlıq adlandırdığımız şey mənasızlıq deyil, sadəcə oxumağı bacarmadığımız mənadır.

Beytson qeyri-adi bir şəxsiyyət idi. İngilis antropoloqu, "genetika" sözünü elmi dövriyyəyə gətirmiş məşhur genetikin — Uilyam Beytsonun oğlu. Qreqori Yeni Qvineya və Bali tayfalarını öyrənmiş, Marqaret Midlə — bir müddət onun arvadı olmuş qadınla — ekspedisiyalara çıxmışdı. 1940-cı illərin ortalarında yeni bir elmin — kibernetikanın doğulduğu məşhur Meysi konfranslarında iştirak etmişdi. Norbert Viner və Klod Şennonla birlikdə bu elmin banilərindən biri idi.

1949-cu il. Beytson Palo-Altodakı veteran xəstəxanasının qapısını açıb keçir. Tapşırıq — şizofrenləri araşdırmaq. Quru bir söz. Dövlət damğası. Bəs əslində onun arxasında nə gizlənir? Qanı donduran, səbəbsiz aqressiya partlayışları. Şüuru tor kimi bürümüş hallüsinasiyalar. Boğazı sıxan təqib qorxusu. Emosional "donmalar" — buz kəsilmiş canlı insanlar. Bunlar İkinci Dünya müharibəsinin veteranlarıdır. Cəbhədən qayıdıblar. Amma cəbhə onları buraxmayıb — əzələlərində, hüceyrələrində, əsən əllərində ilişib qalıb. Onların davranışı qəribə adlanırdı. Özləri isə — şizofren. Diaqnoz kütləvi şəkildə qoyulurdu, düşünmədən möhür vurulurdu. Niyə? Çünki sadəcə başqa söz yox idi. "Posttravmatik stress pozuntusu" anlayışı hələ mövcud deyildi. O, yalnız 1980-ci ildə — DSM-III-ün işıq üzü görməsiylə peyda olacaqdı. Otuz bir il sonra. Otuz bir il... Otuz bir il həkimlər insanda əbədi ilişib qalmış müharibəni şizofreniya adlandırırdılar.

Beytson psixiatr deyildi. Müalicə etmirdi. O, baxır və dinləyirdi. Həkimlərin gözündən qaçan bir həqiqətə diqqət çəkdi: xəstələrin qəribə ifadələri çox vaxt məna daşıyırdı — əgər onların həyat konteksti bilinsə. Bu mənasız sözlər deyil. Bu — mümkünsüz vəziyyətə uyğunlaşmadır.

Beləliklə, XX əsrin ən nüfuzlu və eyni zamanda ən mübahisəli şizofreniya nəzəriyyələrindən biri meydana gəldi.

1952-ci ildə Beytson Rokfeller Fondunun qrantını alaraq kommunikasiya paradokslarını öyrənməyə başladı. Ətrafına bir komanda topladı: gənc psixiatr Donald Cekson (Don D. Jackson), mühəndis-antropoloq Con Uikland (John Weakland) və psixoloq Cey Heyli (Jay Haley). İş Palo-Altoda aparılırdı və sonralar bu qrup "Palo-Alto məktəbi" adlandırılacaqdı. O, ailə terapiyasının beşiklərindən birinə çevriləcəkdi.

1956-cı il. Kitabxanalarda hələ də olmayan jurnal — təzəcə təsis edilib. Behavioral Science. İlk sayının özündə isə — tufan. Zərbə endirdilər. Birgə məqalə. Bu, təməlləri partlatdı — məcaz deyil, elmi gündəlik həyatın sakit otağında bombanın

dəqiq effekti. Adı aldadıcı dərəcədə təvazökar idi: "Şizofreniya nəzəriyyəsinə doğru" — Toward a Theory of Schizophrenia. Quru bir ifadə. Həllinə dair bir işarə belə yox. Halbuki həll var idi. Bəs əgər dəlilik beynin pozulması deyilsə? Bəs əgər bu, sağ qalmaq üçün ümidsiz bir cəhddirsə? Bu sualın üzərində dayan. O, hər şeyi alt-üst edir. Beytson və həmkarları faktlar zənciri qurdular. Fakt-fakt üstə — və heyrətamiz bir hipotez irəli sürdülər: şizofrenik simptomlar — bu reaksiyadır. Nasazlıq deyil. Qüsur deyil. Reaksiya. Nəyə? Düzgün cavab verməyin sistematik qeyri-mümkünlüyünə. Sistematik. Qeyri-mümkünlük. Cavab vermək. Tələni təsəvvür et. Sənə eyni anda iki məntiqi səviyyədə mesajlar göndərilir. Onlar bir-birinə ziddir. Hər addımın — səhv. Hər sözün — buraxılmış hədəf. Çapalayırsan, çıxış yolu axtarırsan — yoxdur. Ağıl kar divara dirənir. Və o zaman yeganə mümkün olanı edir: əvvəlki mənada ağıl olmaqdan çıxır. Bu vəziyyətə qoşa bağlılıq — double bind adını verdilər. Ad qoyuldu. Başlanğıc nöqtəsi — keçildi.

İkili bağ nədir?

Təsəvvür edin: ana oğluna deyir: "Səni sevirəm", amma bədəni gərginləşir, üzü daş kimi donur, qucaqlaşması taxta kimi olur. Verbal səviyyədə — sevgi mesajı. Qeyri-verbal səviyyədə — rədd mesajı. Məntiqin müxtəlif səviyyələrində iki mesaj, hər ikisi eyni adamdan gəlir, eyni anda doğrudur — və onlar bir-birini ləğv edir.

Əgər uşaq şifahi mesaja cavab verib yaxınlaşmağa çalışsa — qeyri-şifahi rədd cavabı alacaq. Əgər qeyri-şifahi mesaja cavab versə — şifahi hiddətə tuş gələcək: "Necə belə deyə bilərsən, axı mən səni sevirəm!"

Hər iki davranış xətti cəzaya aparır. Çıxış yoxdur. Baş verənləri sözlə ifadə etmək — "Ana, görürəm ki, bir şey deyirsən, başqa şey edirsən" — da mümkün deyil: uşaq ya çox kiçikdir, ya da sistem ona belə bir metadildən istifadə etməyi

qadağan edir. Necə danışdığımız haqda danışmaq olmaz. Ananın sevgisindən şübhələnmək olmaz.

Beytsona görə, məhz bu vəziyyətdə — dəfələrlə təkrarlanan, sistematik, illərlə davam edən — uşaqda bir vərdiş formalaşır. Mesajların daim ziddiyyətli olduğu bir dünyada yaşamaq. Gerçəkliyi yoxlamağın mümkün olmadığı yerdə. Ən yaxın adamların eyni zamanda həm xilaskar, həm təhlükə olduğu bir aləmdə. Sonra bu vərdiş ümumiləşir: bütün dünya sonsuz ikimənalı mesajlar mənbəyinə çevrilir. Bu çıxılmaz vəziyyətdən necə qurtulmalı? Budur, nəzəriyyə iddia edir ki, şizofrenik simptomlar elə burada inkişaf edir. Tələdən çıxmağın yeganə yolu — öz məna dünyasına sığınmaq. Qoy o dünya sanrılı olsun.

Bu nəzəriyyə inqilabi idi. Kraepelindən sonra yarım əsr ərzində ilk dəfə kimsə ciddi şəkildə irəli sürdü ki, şizofreniya beyin xəstəliyi deyil, ünsiyyət modelidir. Anatomiya deyil, dil. Genlər deyil, münasibətlər.

Nəzəriyyə sahəni partlatdı. Yeni doğulan ailə psixoterapiyası onu dərhal qurtuluş kəməndi kimi qapdı. Onun əsasında əfsanəyə çevrilməli olanlar işlərini qurdular: San-Fransiskoda Virciniya Satir və Filadelfiyada Salvador Minuxin. "İkiqat bağ" termini dövriyyəyə soxuldu. Bununla şizofreniyanı izah edirdilər? Bəli. Amma bununla kifayətlənmədilər. Sərhəd pozuntuları? Psixosomatika? Narahatlıq? "İkiqat bağ" universal açar oldu. Onunla hər şeyi açırdılar.

Teorinin qaranlıq üzü var idi. 1950-ci illər. 1960-cı illərin əvvəlləri. Amerika psixiatriyası dəhşətə gəldi: onun lüğətinə dəhşətli bir termin yapışdı — "şizofrenogen ana". Bunu ilk kim söylədi? Psixoanalitik Frida Fromm-Rayxman. Hələ 1948-ci ildə. Lakin Beytsonun nəzəriyyəsi bu obrazı yeni, vəhşi bir həyatla doldurdu. Dəli necə yaradılır? Konsepsiya ürpertici bir cavab verirdi. Ana. Soyuq. Hakim. Ziddiyyətli. Canlı əlaqə qurmaq qabiliyyəti olmayan. Öz əllərilə, öz ikili mesajları ilə

uşağın psixikasını günbəgün sındıran. Analar öz uşaqlarından şizofreniklər formalaşdırırdı.

Bu, minlərlə ailə üçün faciə idi. Uşaqları şizofreniyaya yaxalanan analar, müəyyən diaqnozla yanaşı, öz günahlarına dair bir damğa da daşıyırdı. Onlar psixiatrın köməyinə müraciət edirdi, amma geri dönəndə içlərində bir fikir daşıyırdı: "Bu mənim günahımdır. Mənim qucaqlarım çox soyuq idi. Uşağımı mən qırdım."

1970-ci illərin ortalarına doğru toplanmış məlumatlar sarsıdıcı bir həqiqəti üzə çıxardı. Anaların davranışı ilə uşaqlarda şizofreniyanın yaranması arasındakı əlaqə əvvəllər düşünüldüyündən qat-qat mürəkkəb çıxdı. Amma əsas zərbə nəzəriyyənin özünə dəydi. Tapmaca qorxunc bir sadəliklə həll olundu. Xəstələrin ailələrində müşahidə edilən qəribəliklərin çoxu xəstəliyin səbəbi deyildi. Onlar xəstəliyin nəticəsi idi. Evə ağır xəstə bir adam gələndə kommunikasiya anında dəyişir. Təbii olmaqdan çıxır. Hamı barmaqlarının ucunda yeriyir. Nəfəsini içinə çəkib. Qalmaqaldan qorxur. Bir-birinə zidd siqnallar ötürür — çünki necə düzgün davranmağı bilmir. Bu, şizofreniya törətmir. Bu — ona qarşı çarəsiz, yaralı bir reaksiyadır.

1970-ci illərin sonuna doğru gözəl hipotez dağıldı. İkiqat əlaqə — şizofreniyanın birbaşa səbəbi. Bir düstur kimi səslənirdi. Ailə üçün hökm kimi işləyirdi. Alimlər məlumatların üzərində əlləşirdilər. Sıra-sıra — empirik tədqiqatlar. Yenə və yenə. Faydasız. Ailədəki ikiqat əlaqələrlə xəstəliyin inkişafı arasında dəqiq korrelyasiyanı təkrar yaratmaq mümkün olmurdu. Rəqəmlər uyuşmurdu. Qrafiklər dağılırdı. Faktlar inadla susurdu. Tapmaca olaraq qalırdı. 1980-ci illərin əvvəllərinə qədər hətta Beytsonun ən sadiq davamçıları da gözlərini yerə dikdilər. Amansız bir həqiqəti etiraf etmək lazım gəldi: şizofreniyanın etioloji nəzəriyyəsi kimi ikiqat əlaqə işləmir. Çıxılmaz vəziyyət? Xeyr. İfşa. Diqqəti başqa yerə yönəldən tədqiqatçılar başqa bir şey gördülər. Disfunksional ailə ünsiyyəti-

nin modellərindən birinin təsviri kimi ikiqat əlaqə bu gün də işləyir.

Bəs Beitsondan nə qaldı?

Çox şey qalır. Birincisi, ailə psixoterapiyasının bütün xəritəsi. Palo-Alto məktəbinin işlərindən sonra psixi pozuntunu yalnız fərdi patologiya kimi düşünmək artıq mümkün deyil. Ailə elə bir sistemdir ki, burada bir elementdəki nasazlıq bütün digərlərinin işini dəyişir — bu baxış müasir klinik praktikanın ayrılmaz hissəsinə çevrilib.

İkincisi, dairəvi səbəbətmə prinsipi. "Səbəb → nəticə" xətti zəncirinin əvəzinə Beytson ailə münasibətlərini qarşılıqlı geri əlaqə döngələri kimi nəzərdən keçirməyi təklif etdi. Əgər ana oğlunu danlayır, oğlu da buna görə özünü qapatır, ana isə bu səbəbdən onu daha da çox danlayırsa — bu "kim başladı" hekayəsi deyil. Bu bir döngüdür. Onu istənilən nöqtədən qırmaq olar.

Üçüncüsü, metaəlaqə anlayışı. Biz yalnız sözlərlə deyil, həm də ton, mimika, fasilələrin ritmi ilə danışırıq. Sağlam ailədə insanlar öz söhbətlərinə şərh verə bilər: "Ata, niyə mənə belə baxdın?" Disfunksional ailədə isə belə şərh qadağandır. Bu, dünyanın hər yerində ailə terapevtlərinin bu gün də istifadə etdiyi diaqnostik alətdir.

Dördüncü zərbə isə xəstəyə olan münasibətdə köklü dəyişiklik oldu. O veteran kömək üçün gəlmişdi. Danışırdı. Gözləyirdi. Beytson isə cavab verdi: "Sizə vəkil lazımdır." Bu sadə ifadə ilə o, görünməz bir ipi kəsdi. Bu sözlərin arxasında nə dayanırdı? Biganəlik deyildi. İmtina da deyildi. Bu bir partlayış idi. Psixiatriya mədəniyyətinin ilk dəfə xəstədə diaqnostik manipulyasiyalar üçün nasaz mexanizm deyil, söhbət yoldaşı gördüyü an. Sözlərinin məna daşıdığı bir insan. Bu kövrək andan sonra artıq göy gurultusu yaxınlaşırdı. Bu, antipsixiatriyanın sonrakı hərəkətini — formasına, gücünə və nəti-

cələrinə görə fərqli, lakin qarşısıalınmaz olan, XX əsrin ikinci yarısında yayılan hərəkətini təşəkkül etdirdi.

1963-cü ildə Beytson yoxa çıxdı. Sadəcə, psixiatriyadan getdi. Həmişəlik. Niyə? Xəstələrlə məşğul olmaq dözülməz oldu — emosional təzyiq əzib keçir, bütün şirələri sıxıb çıxardı. Beytson Havay adalarına qaçdı. İnsanın travmaya uğramış ağlını balinalar və delfinlərin ağlı ilə əvəz etdi. Lakin qoşa bağlanma sirri onu təqib etməkdə davam etdi. Hovuzlara baxır və eyni naxışı tapırdı. Delfinlər də tələyə düşürdü! Məşqçi eyni zamanda hərəkət tələb edib bunun üçün şiddətli cəza verdikdə, heyvanın parıldayan bədəni də o eyni anlaşılmaz tələdə titrəyirdi. Tələ hər yerdədir. Buna qalib gəlmək mümkünsüzdür? Xeyr. Beytson heyrətamiz kəşf etdi. Qoşa bağlanma təkcə patologiya deyil, həm də yaradıcılıq doğurur. Sirr meta-səviyyədədir. Əgər insan və ya delfin tələnin üstünə atıla, onu yuxarıdan görə bilsə — üçüncü çıxış yaranır. Məhz bu, yeniliyin mənbəyidir.

Beytsonun irsindən ən gözəl məqam da budur. Şizofrenik ikiüzlü pəmbəyə düşüb sayıqlayır. Şair ikiüzlü pəmbəyə düşüb yeni məna doğurur. Alim ikiüzlü pəmbəyə düşüb kəşf edir. Onların arasındakı xətt bizim fikirləşdiyimizdən də incədir.

Burada kitabımız üçün vacib olan bir sual yaranır.

Əgər ikiqat əlaqə nəzəriyyəsi şizofreniyanın etioloji hipotezi kimi mübahisəli hesab olunursa — bu o deməkdir ki, Beytson səhv etdi? Bəs biz, müasir psixiatrlar, bu cür nəzəriyyələrə necə yanaşmalıyıq?

Budur xəttin keçdiyi yer. Ayrılıq xətti — onsuz oxuduğunuz hər şey dağılıb tökələcək. Beytson mümkünsüzü bacardı. O, elmi hipotez irəli sürdü. Nə təxmin, nə mistik pıçıltı, nə intuisiyanın bulanıq ləkəsi. Əsl hipotez. Müşahidə olunan hadisələrin sərt terminlərinə tökülmüş. Operasionallaşdırıla bilən — hissələrə ayırıb hər birini yoxlamaq mümkün olan. Təkzib edilə bilən — təkzib olunmaq haqqına malik olan. Deməli, elm

adlanmaq haqqına da malik olan. O və həmkarları fikri boşluğa atmadılar. Onu canlı klinik reallığa mıxladılar. İllüstrasiyalar gətirdilər — xəstəliyin ətini, nəfəsini, çatlarını çılpaqlaşdırdılar. Dəqiq meyarlar təklif etdilər. Konkret şərtləri göstərdilər. Fikir bədən qazandı. Elmi icma isə skalpelə əl atdı. Yoxlama. Soyuq empirik bıçaq nəzəriyyəni yarır — qat-qat, sümüyə qədər. Nə tab gətirəcək? Nə çökəcək? Tab gətirməyən amansızcasına kəsilib atıldı. Rədd edildi. Zərbə altında ayaqda qalan isə müasir praktikaya daxil oldu. Canlandı. Xəstələrin ağlını və bədənini ələ keçirdi.

Elm elə də budur. Elmin mahiyyəti həmişə haqlı olmasında deyil. Elm, yoxlanıla bilən fikirlər irəli sürmək və faktlar əksini göstərərsə, onlardan əl çəkmək cəsarətindədir.

Müasir bir teta-hiler "Bütün Varlığın Yaradıcısı ilə əlaqə" vasitəsilə yeddi saniyəyə "məhdudlaşdırıcı inanclar"ı dəyişdirib şizofreniyanı sağalda biləcəyini iddia edəndə — bir saniyə dayanın. Yenidən oxuyun. Yeddi saniyə. Şizofreniya. Bu bir fərziyyə deyil. Fərziyyəni yoxlamaq olar. Bu bir təsdiq də deyil. Təsdiqi təkzib etmək olar. Bu bir bəyannamədir — və o, kilidsiz zirhli qapı kimi hər hansı yoxlamadan qorunur: yanına yaxınlaşmaq mümkün deyil. Xəstə sağalmayıb? Deməli, "inanclar daha dərin". Deməli, "müştəri açılmayıb". Deməli, "enerji hələ keçməyib". Hər uğursuzluq təsdiqə çevrilir. Hər sual isə inamın sübutuna. Heç bir eksperiment metodun işləmədiyini göstərə bilməz. Çünki metodun heç bir işləmə meyarı yoxdur. Bir dənə də yox.

Bu, elmlə yalançı elm arasındakı sərhəddir. Beytson öz fərziyyələrində səhv etsə belə, bu xəttin elm tərəfində dururdu. Ailə yerləşdirmə terapistləri, regressoloqlar, teta-hilerlər isə digər tərəfdə. Fərq onların hansının düzgün olmasında deyil. Fərq ondadır ki, kim səhv etdiyini öyrənməyə hazırdır və əgər öyrənsə, öz nəzəriyyəsindən imtina edəcəkdir.

Psixiatriya elm kimi irəliləməyə dəqiq ona görə davam edir ki, öz səhvlərindən imtina edir. Yalançı elm isə yerində qalır —

və məhz buna görə də belə “sabit” və “əbədi” görünür. Heç bir ailə yerləşdirmə üsulu müəllifi tərəfindən heç vaxt ləğv edilməyib. Heç bir kommersial “müəllif üsulu” sahibi tərəfindən təkrar nəzərdən keçirilməyib. Onlardan heç kəs heç nə öyrənmir — çünki axtarmır.

Bu, bizə irəlidə gözləyən bölümlər üçün mühüm bir nəticədir.

Fəsil 15. Antipsixiatriya: Lainq, Bazalya və hərəkatın sərhədləri

1967-ci ilin yay axşamlarından birində Londonun İstend rayonunda, Kinqsli-holl adlanan böyük bir köhnə evdə qəribə bir mənzərə yaşanırdı. Meri Barns adlı gənc qadın yorğana bürünmüş halda yerdə uzanmışdı, başında müxtəlif yaşlarda bir neçə kişi və qadın vardı. Meri keçmiş tibb bacısı idi və "paranoyid şizofreniya" diaqnozu ilə kömək axtarmışdı. İndi o, "yenidən doğuş" keçirirdi — kuratoru buna belə deyirdi. Xəstəliyini körpəlik vəziyyətinə qayıdış kimi yaşayırdı: divarlara defekasiya edir və nəcisi yaxırdı. Onu məcbur etmirdilər, aminazin vurmurdular, duşa salmırdılar və danlamırdılar. Özü geri qayıtmaq istəyənə qədər bu yoldan keçməsinə icazə verirdilər.

Bu adı yadda saxlayın: Ronald Devid Ləng. 1927–1989. Bəlkə də XX əsrin ikinci yarısının ən məşhur və ən ziddiyyətli psixiatrı. Şotlandiyalı. Qlazqo Universiteti. Britaniya ordusunda xidmət. Və — Londondakı Tavistok klinikası. Britaniya psixiatriya maşınının onun keçdiyi ağzı. Oradan nə götürdü? Böyük cazibə. Kəskin intellekt. Və bir kitab. "Bölünmüş Mən", The Divided Self, 1960-cı il. Bir əsər. Bir mətn. Və — partlayış. Bu, XX əsrin ən çox satılan psixiatriya mətnlərindən biridir. Bəs necə oldu ki, bir mətn eyni zamanda ən mübahisəli mətnlərdən birinə çevrildi?

Leynq şizofreniyaya təzə bir baxışla yanaşdı. Ondan əvvəl Kraepelindən miras qalmış təsəvvür hökm sürürdü: şizofreniya — beynin xəstəliyidir, deqradasiyaya aparır, dərk edilə bilməz, dərman nəzarəti tələb edir. Xəstə — obyekt, simptom-

lar — mənasız, həkimin vəzifəsi — xəstəliyin təzahürlərini boğmaq.

Leynq fərqli bir təklif irəli sürdü. O dedi ki, gəlin fərz edək şizofrenikişi bizə mənalı bir şey deyir, əgər dinləməyi öyrənsək. Onun delilikləri qarışıqlıq deyil, ontoloji qorunmasızlıq qarşısında qorunma strategiyasıdır — mövcudluğunun özünün təhlükədə olduğu dərəcədə dərin və dözülməz bir hiss. Onun simptomları, "mən"in parçalanaraq dağıldığı bir dünyada heç olmasa bir növ "məni" qoruma cəhdidir.

"Bölünmüş Mən"də Ləng mexanizmi açıb göstərir. Ontoloji təhlükəsizlik təhdidi ilə küncə sıxılmış insan parçalanma edir. Xarici bir "yalançı mən" yaradır — cəmiyyətin tələblərinə cavab verən itaətkar maska. İçəridə isə, qaranlıq bir dərinliyə, "əsl mən"i gizlədir — çılpaq, həssas, müdafiəsiz. Yarıq böyüyür. Çat uçuruma çevrilir. Və budur, "yalançı mən" hakimiyyəti ələ keçirir. Sonra nə baş verir? Psixotik çöküş. Xəstə başını bütünlüklə sayıqlığa qərq edir. Nə üçün? Sayıqlıq dağılma deyil, əsl mənin qalıqlarını çılgıncasına qoruyan son qalxandır.

Bu ifadə 1960-cı illərdə inanılmaz dərəcədə məşhur idi. O dövrün minlərlə gənci özünü bu sözlərdə tapırdı. "Bölünmüş Mən" Herbert Markuzun "Birtəhərli insan"ı, Mişel Fukonun "Dəlilik və sivilizasiya"sı və Ken Kizinin romanları ilə yanaşı, mədəni hərəkatın kitabına çevrildi. O vaxt elə görünürdü ki, "normallıq" anlayışının özü də azadlığı boğmaq üçün burjua cəmiyyətinin zorla qəbul etdirdiyi repressiv bir quruluşdur.

Amma Ləng daha irəli getdi. 1960-cı illərin əvvəllərində və ortalarında — Aaron Estersonla birlikdə "Ağıllılıq, dəlilik və ailə" kitabında (Sanity, Madness and the Family, 1964), Devid Kuperlə birlikdə — əslində "antipsixiatriya" termininin özü də məhz ona məxsusdur — Ləng şizofreniyanın xəstəlik kimi mövcud olmadığını iddia etməyə başladı. Bu, cəmiyyətin (ilk növbədə ailənin) uyğunlaşa bilməyənlərə yapışdırdığı

etiketdir. Bu, ağılsız dünyaya verilən ağıllı cavabdır. Dəli bir dünyada dəliliyi seçmək — bəlkə də sağlamlıq əlamətidir.

1965-ci il. London. Yoldan keçənlərin doxsan doqquz faizi üçün heç bir məna daşımayan bir söz. Filadelfiya. Amerikan şəhəri deyil. Yunan sözüdür. "Qardaş sevgi". Ləng və həmkarları bu sözü götürüb bir assosiasiyanın — okeanın o tayındakı Filadelfiya ilə heç bir əlaqəsi olmayan Filadelfiya Assosiasiyasının təməlinə qoyurlar. Qəribə seçim? Yalnız ilk baxışda. Hər şeyi tərcümə həll edir. Sonra — ünvan. Kinqsli-holl. Assosiasiyanın Londondakı ilk müəssisəsi. Klinika deyil. Xəstəxana deyil. Ev. Bu evdə hamı bir yerdə yaşayır. Xəstələr. Terapevtlər. Bərabər şərtlərlə. Burada diaqnoz yoxdur. Dərman yoxdur. Məcburi müalicə yoxdur. Qeyd kartında bir dənə də ştamp yoxdur. Əldə bir dənə də həb yoxdur. Bir dənə də bağlı qapı yoxdur. Xəstə öz psixozunu sərbəst şəkildə "içəriyə səyahət" kimi yaşaya bilər. Və yanında həmişə əməkdaşlardan biri olur. Dayandırmaq üçün deyil. Düzəltmək üçün deyil. Müşayiət etmək üçün.

Kingsli Hol beş il fəaliyyət göstərdi. Oradan onlarla insan keçdi. Bəziləri, məsələn, Meri Barns, sonralar hətta yaşadıqları təcrübə haqqında kitablar yazdılar. Rəylərə görə, kimisi oradan həqiqətən də daha yaxşı vəziyyətdə çıxdı, kimisi isə daha pis vəziyyətdə. Statistika aparılmırdı. Eksperiment 1970-ci ildə qonşuların və rəsmilərin təzyiqi altında bağlandı. Binanın özündən yalnız fotoşəkillər və bir əfsanə qaldı.

Ancaq Leynq bu hərəkatda tək deyildi və hətta ən əhəmiyyətli fiqur da deyildi.

İtaliyanın şimal-şərqi. Yuqoslaviya ilə sərhəddə yerləşən balaca Qoritsiya şəhəri. 1961-ci il. Psixiatriya xəstəxanasına yeni direktor təyin olunub — Franco Bazalya. Müharibə veteranı. İtaliya Kommunist Partiyasının üzvü. Milan Universitetinin professoru. 1924-1980. Xəstəxananın divarları arxasında onu nə gözləyirdi? Müharibədən sonrakı Avropada hər yeni psixiatrın özündən əvvəl gördüyü eyni mənzərə. Ancaq

danışılanları eşitmək başqa şeydi, öz gözlərinlə görmək isə tamam başqa. Bazalya xəstəxanaya daxil oldu. Və donub qaldı. Qəfəslər. Məhbus dəmir barmaqlıqlar. Xəstələrin bədənlərini sıxacaq məcburi köynəklər. Beyinləri yandırmağa hazır daşınabilən elektroşok cihazları. Və anbarlar... Tozlu qaranlıqda unudulmuş xəstələrin şəxsi əşyalarının saxlandığı anbarlar. Üstəri torpaq çəkilmiş bu əşyaların sahiblərini xatırlayan yox idi artıq. Bu insanlar xəstə idi, yoxsa məhbus? Müalicə ilə zorakılıq arasında həddi-hüdud haradan keçirdi? Bazalya barmaqlıqlara baxdı — və artıq cavabını bilirdi. Sistem çılpaq şəkildə üzə çıxmışdı. Və o, dəhşətli idi.

Bazalya sadə bir addım atdı. Xəstələri yataqlara bağlamağı ləğv etdi. Təcridi dayandırdı. Qəfəsləri ortadan qaldırdı. İşçilərə dedi: Xəstə də bir insandır. Biz onunla birgə işləyirik. Ona qarşı deyil.

1964-cü ildə Londonda keçirilən konqresdə Bazalya "Psixiatriya xəstəxanasının institusionalizasiya yeri kimi dağıdılması" adlı məruzə ilə çıxış etdi. İdeya sadə və radikal idi: psixiatriya xəstəxanaları özləri patogen varlıqlardır. Onlar insanları xəstə edirlər. Əzabı xroniki vəziyyətə çevirirlər. Onları bağlamaq lazımdır.

Bazalya hərəkatın lideri oldu. İtaliyada buna "demokratik psixiatriya" adı verdilər. Həkimlər, xəstələr, onların ailələri, həmkarlar ittifaqları, siyasi partiyalar — hamısı bir gün bir sıraya səf çəkdilər. 1970-ci illərin sonuna doğru bu artıq sadəcə bir qardaşlıq deyildi — bu, uçqun kimi qarşısıalınmaz bir kütləvi siyasi qüvvə idi. 13 may 1978-ci il. Roma. İtaliya Parlamenti 180 nömrəli Qanunu qəbul edir. Bu qanun tarixə əbədi olaraq "Bazalya Qanunu" kimi daxil olacaq. Bəs bu sənəd nə etdi? İfşa. Dövlət tarixində ilk dəfə qanun qərar verdi: İtaliyada psixiatriya xəstəxanaları bağlanmalıdır. Bu müəssisələrə yeni xəstə qəbulu qadağandır. Yenilərinin tikintisi də. Artıq daş kisələr yoxdur. Yardım bundan sonra başqa yollarla axmalıdır — bila-

vasitə icma daxilində canlı psixi sağlamlıq mərkəzləri şəbəkəsi vasitəsilə. Centri di Salute Mentale.

İtaliya öz psixiatrik xəstəxanalarını bağlayan dünyada ilk ölkə oldu.

Bu, antipsixiatriya hərəkatının triumfu idi. Lakin tarix, tez-tez olduğu kimi, onun müəlliflərinin gözlədiyindən daha mürəkkəb çıxdı.

Bazalya 1980-ci ildə vəfat etdi, qanun qəbul edildikdən cəmi iki il sonra. O zaman ona əlli altı yaşı vardı. Onun islahatının taleyini görmək ona nəsib olmadı.

Sonra qanun reallıqla üz-üzə gəldi. Xəstəxanaların bağlanması haqqında qanun qəbul etmək bir şeydir. İcmada işləyən yardım mərkəzləri şəbəkəsi qurmaq isə tamam başqa şeydir. İtaliyanın bir çox regionlarında mərkəzlər üçün pul çatmadı. Personal kifayət qədər hazırlıqlı deyildi. Koordinasiya xaotik idi. Keçmiş psixiatriya xəstəxanalarından buraxılan minlərlə xəstə küçədə qaldı. Həbsxanalarda. Keyfiyyəti şübhəli özəl sığınacaqlarda. Ağır xəstə yaxınlarını geri alan qohumlar çox vaxt onlarla nə edəcəklərini bilmirdilər. Və o zaman italyanların il rito della porta girevole — "fırlanan qapı ritualı" adlandırdıqları bir hadisə meydana çıxdı. Xəstə kəskin vəziyyət şöbəsinə düşür. Onu çıxarırlar. Ailəsinə qaytarırlar. Böhran baş verir. Yenidən kəskin vəziyyət şöbəsi. Yenidən çıxarırlar. Yenidən ailə. Yenidən böhran. Qapı fırlanır.

2020-ci ildə European Journal of Public Health jurnalında 180 nömrəli Qanunun qəbulunun sonrakı illərdə İtaliyada intihar səviyyəsində statistik əhəmiyyətli artımla əlaqəli olduğunu göstərən kvazieksperimental araşdırma dərc edilib. Bu, qanunun səhv olduğunu sübut etmir, lakin islahatın faktiki nəticələrinin onun müəlliflərinin idealist gözləntilərindən uzaq olduğunu nümayiş etdirir.

Nəticə sadədir. Pisi bağlamaq yaxşını qurmaq demək deyil. İnstitusiyanı ləğv etmək avtomatik olaraq onun daha insani

alternativini təmin etmək demək deyil. Əgər dövlətin icmada real yardım şəbəkəsi yaratmaq üçün iradəsi və pulu varsa — Bazalya islahatı işləyir. Yoxdursa — o, xəstələrin bir müəssisədən heçliyə buraxılmasına çevrilir. İtaliyada bu bəzi regionlarda alındı (ilk növbədə Triestdə, Bazalyanın son illərini çalışdığı yer), bəzilərində isə alınmadı. Bu gün dünyanın hər yerindən psixiatrlar İtaliya təcrübəsini həm uğur, həm də xəbərdarlıq kimi öyrənirlər.

Leynqlə nə baş verdi?

Leynq — bəlkə də, bu kitabın ən faciəvi personajlarından biridir.

1960-cı illərin sonunda o, artıq superulduz idi. Dünyanın hər yerində mühazirələr oxuyurdu. Kitabları milyonlarla nüsxədə satılırdı. Rok ulduzları, aktyorlar, filosoflarla dostluq edir, psixodelik maddələrlə təcrübələr aparır və çox içirdi. Klinik fəaliyyətlə getdikcə az, şəxsi imici və mədəniyyətdəki nüfuzu ilə isə daha çox maraqlanırdı.

1970-ci illərin ortalarında hər şey dağılmağa başladı. Dostlar və həmkaralar bir-bir arxa çevirdi. Evlilik həyatı toz-duman içində qaldı. Oğlu Adrian sonralar bu yaraya toxundu: Leynq ailəsindəki dəhşətli uşaqlıq haqqında bir kitab yazdı. Alkoqol çay kimi axırdı. 1987-ci ildə yeni bir qorxunc hadisə baş verdi — tibbi lisenziya ləğv edildi. Tibb Kollecinin qərarı belə idi: onun psixi vəziyyəti artıq praktikada fəaliyyət göstərməyə imkan vermir. Depressiya boğazını sıxırdı. Sonra 1989-cu il gəldi. Cənubi Fransa. Tennis kortu. Leynq qəflətən yerə yıxıldı. Ürək tutması. 61 yaşı var idi.

Onun irsi — mina sahəsidir. Bir küncündə — "Parçalanmış Mən". XX əsri yaradan kitab. O ilk dəfə cəsarətlə dedi: şizofrenikin daxili dünyası — xaos deyil. Absurd da deyil. Onun mənası var. Bu inqilab idi. Yeni klinik mədəniyyətin təməli. Amma sonra — çat. O iddia etdi ki, şizofreniya yoxdur. Yalnız yapışdırılan etiket — ailə və sosial siyasətin alətidir. Hallüsina-

siyalar, sanrılar — simptomlar deyil, "ruhun səyahətləridir". Onlara mane olmaq lazım deyil. Onların baş verməsinə icazə vermək lazımdır. Dayan. Nə? Neyrobiologiya. Genetika. Neyrovizualizasiya. Üç elm. Üç müstəqil mənbə. Terabaytlarla məlumat. Hamısı bir nöqtədə birləşir: şizofreniyanın bioloji əsası var. Onu inkar etmək — aşkar olunanı inkar etməkdir. Onun sonrakı iddiaları o zaman yanlış idi. İndi də yanlış olaraq qalır.

Ən ağrılı olan isə müəyyən insanların hekayələridir, onların müalicəsində Leynqin ideyaları böyük rol oynamışdır. 1970-ci illərdə valideynlər onun kitablarını oxuyur, psixiatriya xidmətindən imtina edir, aminazin istifadə etməkdən çəkinir və övladlarına Leynqın məsləhət verdiyi kimi "bunu özləri ilə dəf etməyə" şərait yaradırdılar. Bu uşaqların bir hissəsi psixozdan keçib sağalmışdılar. Bəziləri isə sağalmaq mümkün olmadı. Kiməsə ömrünün qalan hissəsini xroniki vəziyyətdə yaşamaq mümkün oldu, halbuki bu vəziyyət vaxtında müalicə ilə qarşısı alına bilərdi.

Bəs antipisixiatriyadan nə qəbul etməli, nə isə rədd etməliyik?

Götürək belə edək.

Birinci — xəstəyə insan kimi hörmət göstərmək məcburidir. Onun simptomları mənasızdan ibarət deyil, onlar bir məna daşıyır. Onunla danışmaq, onu dinləmək və onun əzablarını tanımaq lazımdır. Beytstonla Palo Altoda keçirilən görüşdən sonra ortaya çıxan Leynqin bu prinsipi klinik mədəniyyəti əbədi olaraq daha yaxşıya doğru dəyişdi.

İkinci. Sosial və ailə kontekstinə diqqət. Xəstə vakuumda yaşamır. Ailənin ona necə yanaşması, cəmiyyətin onu necə qəbul etməsi, institusiyanın onu necə saxlaması — bütün bunlar xəstəliyin gedişinə təsir edir. Bazalya göstərdi ki, institusiyanın özü patogen ola bilər — və bu, təkzibedilməz bir dərsdir.

Üçüncü. Xəstənin ləyaqət hüququ. Bazalya qanunu italyan xəstələrinə onillərlə məhrum edildikləri vətəndaşlıq hüquqlarını qaytardı. Bu, geri döndərilə bilməz mənəvi qazanımdır. Hazırda belə hüquqlar BMT-nin əlillərin hüquqları haqqında Konvensiyasında (2006-cı il) və inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətinin qanunvericiliyində təsbit edilmişdir.

Rədd etmək də vacibdir.

Birinci. Şizofreniyanın mövcud olmaması iddiası. Bu, empirik verilənlərlə təsdiqlənə bilməyən ideoloji tezisdir. Şizofreniya mövcuddur. Onun bioloji əsası var. O, xüsusi müalicə tələb edir. Onun varlığını inkar etmək xəstələrə kömək deyil, zərər gətirir.

İkincisi — psixozun romantikləşdirilməsi. Psixoz — "ruhun səyahəti" deyil. O əzabdır. Dözülməz, dağıdıcı və bəzən də... ölümcül dərəcədə təhlükəlidir. Kəskin fazada insana "bu onun ruh yolu olduğu üçün" antipsixotik verməmək — onun əzabına qarşı zorakılıq etməkdir.

Üçüncüsü. Dərman terapiyasının prinsipcə pislənməsi. Müasir nevroleptiklər ideal müalicə vasitəsi deyil: çoxsaylı yan təsirləri var, həmişə effektiv işləmirlər, bir çox simptomlara qarşı gücsüzdürlər. Lakin psixozun kəskin fazasında olan əksər xəstələr üçün onlar həyat qurtarır — bir sözün hərfi mənasında. İdeoloji mülahizələrə görə onlardan imtina etmək xəstəyə qarşı cinayətdir.

Və burada — bütün bu kitab üçün daha bir vacib düşüncə.

Anti-psixiatriya, bütün səhvlərinə baxmayaraq, elmi hərəkət idi. Onun nümayəndələri oxuyur, yazır, nəşr edir, mübahisə edir, səhv edir və bu səhvlərini düzəldirdilər. Leyinq ömrünün sonunda gənclik dövründə dediklərinin çoxunun həddindən artıq olduğunu etiraf etmişdi. Bazalya isə davamlı olaraq vurğulayırdı ki, onun islahatı uzun yolun sonu yox, başlanğıcıdır. Bu, elmi müzakirə çərçivəsində baş verirdi.

Müasir sayentoloq və ya teta-hiler bu ideyaları kontekstdən çıxararaq bir neçə sitatı — "şizofreniya yoxdur", "psixiatriya xəstə yaradır", "dərmanlar zəhərdir" — seçib sosial şəbəkələrə atarkən eyni zamanda iki şey edir. O, Leyinqlə və Bazalyanın arqumentlərini təhrif edərək, çoxrəngli elmi mübahisələri kobud şüarlara çevirir. Həmçinin öz xidmətlərini pul qarşılığı satmaq üçün bu adların nüfuzundan istifadə edir.

Leyinq "Leyinq terapiyasının sertifikatı" satmırdı. Bazalya "deinstitusionalizasiya təlimləri" üçün pul almırdı. Onlar həkim idi. Səhv edirdilər, amma axtarırdılar. İşlərinə can atır və tez-tez bu uğurda özlərini məhv edirdilər. Bu onları müasir "rəhbər ruhlar"dan fərqləndirir ki, onlar da öz mənafeləri uğrunda Leyinq və Bazalyanın adlarına istinad edirlər.

Antipsixiatriya elmi psixiatriya tarixinin bir hissəsidir. Onun dilindən istifadə edən müasir "şəfavericilər" onun davamı deyil, parodiyasıdır.

Fəsil 16. Biopsixososial model: mozaikanı bir araya gətirmək cəhdi

1970-ci illərin ortalarına yaxın psixiatriya qəribə bir vəziyyətə düşmüşdü. Bir tərəfdən, onun əlində heyrətamiz bir arsenal var idi: xlorpromazin və onun ardıcılları milyonlarla xəstənin taleyini dəyişmişdi; litium bipolyar pozğunluğun tsiklik kəsilmələrinin qarşısını alırdı; trisiklik antidepresantlar ağır depressiyanı aradan qaldırırdı. Digər tərəfdən, bu elmin sərhədləri heç vaxt bu qədər qeyri-müəyyən olmamışdı.

Psixiatriyanın içində bir neçə bir-birinə sığmayan paradigma amansız bir döyüşdə üz-üzə gəlirdi. Hansı haqlı idi? Bioloji məktəb ilk zərbəni endirirdi. Psixi xəstəlik — beyin xəstəliyidir. Pozulmuş neyrotransmitteri tap. Dərman ver. Qalan hər şey — lirikadır. Psixoanalitiklər digər cinahdan hücuma keçirdilər. Xəstəlik — şüursuzluğun konfliktidir. Küncdə otur, hekayəni danış. Keçmiş həll olunacaq. Antipsixiatriya isə bütün gücü ilə zərbə endirdi. Heç bir xəstəlik yoxdur! Yalnız sosial damğa var. Və onu repressiv cəmiyyət ona mane olanların üstünə yapışdırır. Bixevioristlər ən son daxil oldular. Beyni unudun. Şüuraltını atın. Sadəcə davranışı yenidən öyrədək. Dəliliyin dörd mənzərəsi. İnsanı sındırmağın — ya da sağaltmağın dörd yolu. Hansı haqlıdır?

Hər bir məktəbin öz kafedrası, öz jurnalı, öz qurultayı var idi. Psixiatriya üzrə təhsil alan hər bir tələbə onlardan birinə mənsub olmalı idi — digərlərini isə rəqib kimi görməli idi.

Xəstə üçün bu vəziyyət çox pis idi. Əgər o, bioloqa düşürdüsə — ona dərman verirdilər və deyirdilər: "Ananla münasibətlərin mənim ixtisasım deyil". Əgər analitikə düşürdüsə — onu həftədə üç dəfə əlli dəqiqə dinləyirdilər, amma hallüsinasiyalarını aradan qaldırmırdılar. Əgər bihevioristə düşürdüsə — ona simptomları göstərməməyi öyrədirdilər, amma nə hiss etdiyini soruşmurdular. Bütöv bir insanı heç kim görmürdü.

Gözlənilməydən bir yerdən səs eşidildi. Danışan psixiatr deyil, Roçester Universitetindən olan patoloq və terapevt idi.

Corc Libman Engel (George Libman Engel, 1913–1999) qeyriadi tərcümeyi-halı olan bir həkim idi. O, tibb təhsilini Cons Hopkinsdə almış, patologiya, terapiya, sonra isə psixoanaliz üzrə ixtisaslaşmışdı. Qırxdan çox yaşında o, xəstənin psixi vəziyyətinin somatik xəstəliklərin gedişinə necə təsir etdiyi ilə maraqlanmağa başladı. O, yaralı koliti, psixogen ağrını, ürək-damar pozuntularını öyrənirdi. O görürdü ki, eyni bioloji patologiya müxtəlif insanlarda fərqli keçə bilər — və bu fərqin səbəbləri psixikada və sosial vəziyyətdə yatır.

1977-ci ildə Engel Science jurnalında səkkiz səhifəlik "Yeni tibbi modelə ehtiyac: biotibbə çağırış" (The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine) adlı məqalə dərc etdirdi. Bu məqalə bu gün on minlərlə dəfə sitat gətirilir. O, XX əsrin ən nüfuzlu tibbi nəşrlərindən biridir.

Engel belə yazırdı. Müasir tibb, deyirdi o, biotibbi modelə əsaslanır. Bu model xəstəliyi bioloji səviyyədəki qüsurlara — genlərə, biokimyaya, anatomiyaya, fiziologiyaya — endirir. O, infeksiyalar, travmalar, cərrahiyyə, bir çox somatik xəstəliklər sahəsində inanılmaz dərəcədə uğurludur. Amma onun kor zonaları var.

O, xəstə olan insanı nəzərə almır. Onun xəstəliyi şəxsi olaraq necə yaşadığını nəzərə almır. Sosial mühitin — ailənin, işin, mədəniyyətin, resurslara çıxışın — xəstəliyin yaranmasına və gedişinə necə təsir etdiyini nəzərə almır. Səhiyyə siste-

minin özünün təkcə bioloji bir quruluş deyil, həm də sosial bir quruluş olduğunu nəzərə almır.

Bir sıra xəstəliklər üçün, — davam edirdi Engel, — bu boşluq xüsusilə kritikdir. Məsələn, diabet: şəkərin kompensasiyası təkcə insulindən deyil, həm də insanın necə qidalandığından, rejimə nə dərəcədə əməl etdiyindən, ailəsinin ona hansı dəstəyi göstərdiyindən və dərmanların nə qədər əlçatan olduğundan asılıdır. Təbii ki, bu şizofreniyaya da aiddir. Şizofreniyanın biologiyası mövcuddur, amma onun gedişi, residivləri, proqnozu və həyat keyfiyyəti artıq təkcə biologiya deyil.

Engel biopsixososial adlandırdığı modeli irəli sürdü. Bu modelə görə, xəstəlik üç səviyyəli faktorların qarşılıqlı əlaqəsinin nəticəsidir:

— Bioloji amillər (genlər, beyin neyrokimyası, endokrin sistemi, immunitet vəziyyəti, fizioloji xüsusiyyətlər).

— Psixoloji amillər (şəxsiyyət xüsusiyyətləri, idrak üslubları, öhdəsindən gəlmə strategiyaları, keçmiş travmalar, psixikanın ehtiyatları).

— Sosial amillər (ailə mühiti, peşə mühiti, mədəniyyət, tibbi xidmətə çıxış, iqtisadi durum, stiqma səviyyəsi).

Üç səviyyə: bioloji, psixoloji, sosial. Onlar bir-birinin üstündə qat-qat yığılıb oturmur. Qarışıb-dolaşıblar, qan damarları kimi. Birindən çək — hamısı silkələnəcək. Baxın. Sosial səviyyə. Adam işini itirir. Sonra nə baş verir? Psixoloji səviyyə depressiya ilə cavab verir. Bioloji səviyyə? Kortizol səviyyəsi dəyişir. İmmunitet funksiyası pozulur. İşdən çıxarılıbsan — və bədən artıq yenidən qurulur. Səssizcə. Səndən soruşmadan. Və bu birtərəfli yol da deyil. Əksinə çevirək. Antipsixotik terapiyaya başlayıbsan — bioloji səviyyə. Ünsiyyət qurma qabiliyyəti bərpa olunur — psixoloji səviyyə. İnsan işinə qayıdır — sosial səviyyə. Üç səviyyə. Bir zərbə. Üç dalğa.

Engelın 1977-ci ildəki məqaləsi bir azadlıq effekti yaratdı.

Məktəblər arasındakı daxili vətəndaş müharibəsindən yorulmuş psixiatrlar elə bir konseptual dil əldə etdilər ki, bu dil onlardan heç birini inkar etmirdi, əksinə, hamısını birləşdirirdi. Bioloq neyromediatrlarla məşğul olmağa davam edə bilərdi, psixoterapevt xəstəni dinləyə bilərdi, sosial işçi isə mənzil və iş tapmaqda kömək edə bilərdi. Hamısı bir ümumi iş görürdü — xəstəyə kömək edirdi, onu bir bütöv kimi görürdü.

Model sürətlə ortodoksal xarakter aldı. 1980-ci illərə qədər o, psixiatrların bütün təhsil proqramlarına, bütün dərsliklərə, peşəkar assosiasiyaların bütün tövsiyələrinə daxil oldu. Amerika Psixiatriya Assosiasiyası öz təsnifatını köklü şəkildə islah etdi — 1980-ci ildə DSM-III ilə psixiatriya ilk dəfə diaqnozlar üçün heç bir məktəbə bağlı olmayan, az-çox ciddi operasional meyarlar əldə etdi. Bu, biopsixososial idealın birbaşa reallaşması idi: diaqnoz elə olmalıdır ki, bioloq da, psixoanalitik də eyni xəstəyə baxaraq onu eyni cür qoysun.

BİOPSİKOSOSİAL MODELİNİN PASİENT ÜÇÜN ÖNƏMİ:

Biopsikososial model pasientə qarşı kompleks yanaşma deməkdir. Bunun praktikada əksini belə görürük: müasir təşkilatlı psixiatr ilk dəfə şizofreniya epizodu ilə müraciət edən pasientlə qarşılaşdıqda, hər üç səviyyədən suallar verməlidir.

Bioloji: hansı dərmanlar təyin edilməlidir, hansı dozada, necə izlənilməlidir? Somatik yanaşı xəstəliklər varmı? Narkotik maddələrlə, alkoqolla vəziyyət necədir? Ailə yüklülüyü varmı?

PSİXOLOJİ: Xəstənin xəstəlikdən əvvəlki şəxsiyyəti necə idi, təhsili, maraqları nə qədər inkişaf edib? Xəstəliyi necə yaşayır? Travmatik təcrübələri varmı? Hansı qoruyucu mexanizmlərdən istifadə edir? Psixoterapiyaya ehtiyacı varsa, hansı növü daha uyğundur?

Sosial vəziyyət: kiminlə yaşayır? Ailədə məişət mühiti necədir? İşi, təhsili, dostları varmı? Xəstəliyə ailənin münasibəti nə qədər dəstəkləyicidir? Keyfiyyətli tibbi kömək almaq imkanı

var? Sığorta şərtləri nə qədər əlverişlidir? Sosial izolyasiya, evsiz qalma riski varmı?

Yalnız bütün bu suallara cavab verdikdən sonra həkim müalicə planını qurur. Və bu plan həmişə çoxqatlı olur: dərmanlar üstəgəl psixoterapiya üstəgəl ailə ilə iş üstəgəl sosial reabilitasiya.

Düzünü demək lazımdır: biopsixososial modelin ciddi tənqidçiləri də var.

Ona qarşı irəli sürülən əsas ittiham budur: bu model həddindən artıq genişdir. O deyir ki, üç səviyyə var və onlar qarşılıqlı təsirdədir. Bəs bu qarşılıqlı təsir konkret olaraq necə baş verir? Hansı mexanizmlərlə? Hansı gücdə? Xəstəliyin hansı mərhələsində hansı səviyyə daha önəmlidir? Model bu suallara birbaşa cavab vermir.

Psixiatr Nəssir Qaemi "The Rise and Fall of the Biopsychosocial Model" (2010) kitabında aydın yazır: biopsixososial model klinik boşboğazlığa çevrilib. Hər psixiatr hər dəfə müalicə planı qurarkən bu üç səviyyəni sıralayır, amma əsl qərar qəti metodologiya olmadan, daxilən qəbul edilir. Qaemi "universal bio-psixo-sosial yanaşma" əvəzinə plüralist yanaşma təklif edir: hər konkret diaqnoz üçün onu ən yaxşı təsvir edən model tətbiq edilməlidir.

Bu tənqid baxımından haqlıdır. Amma onu müxtəlif şəkildə başa düşmək olar. Gündəlik klinik praktikada biopsixososial model hələ də əlində olan ən yaxşı vasitədir. O, həkimi xatırladır: xəstə biokimyəvi reaksiyalar cəmi deyil. Xəstə cəmiyyətdə yaşayan, öz tarixçəsi olan, xəstəliyini özünəməxsus yaşayan insandır. Bu sadə həqiqəti on dəqiqəlik qəbul tələsdikcə unutmaq asandır.

Elə burada da XXI əsrdə modelin üzərində asılı qalmış incə bir təhlükədən danışmaq lazımdır.

Son illərdə psixologiya və psixiatriyada "biopsixososial yanaşma" bayrağı altında Engel'in heç yuxusunda belə görmə-

yəcəyi şeylər yayılmağa başladı. Dəqiq desək, dəlilə əsaslanan metodlardan tutmuş açıq-aşkar elmi əsası olmayan əqidələrə qədər hər şeyin eyni çatı altında toplandığı qeyri-müəyyən eklektika.

Tipik bir Rusiya "inteqrativ psixoloq"unun saytını açaq. Baxaq, oxuyaq: "Mən kompleks biopsixososial yanaşmadan istifadə edirəm. İşimdə kognitiv-davranış terapiyası, psixoanaliz, Xellinger üsulu ilə ailə yerləşdirmələri, reqressiv hipnoz, nəsil proqramları ilə iş və transpersonal təcrübəni birləşdirirəm". İnandırıcı səslənir, elədir? Terminlərin ağırlığı ilə titrəyən sətir. Biopsixososial. Kognitiv-davranış. Transpersonal. Hər ikinci söz nüfuzlu tibb lüğətindən qoparılıb. Mətnin elmi xətti monolit kimi görünür. Amma yaxından baxaq. Şübhənin soyuq nəfəsini içinə çək. Hər üçüncü söz — düzənlənmə psevdoelm. Ağ gecəlik altına diqqətlə gizlədilmiş elm minaları.

Tələ burdadır. Biopsixososial model — eklektikaya icazə deyil. Bunu xatırlayın. Günah çıxarma kağızı deyil. Nəyi istəsən qarışdırmaq azadlığı deyil. Bu, xəstəyə müxtəlif bucaqlardan baxmaq dəvətidir. Müxtəlif bucaqlardan. Amma hər bir baxış bucağının elmi əsası olmalıdır. Hər biri. İstisnasız. Və bütün dəyişmə elə burada başlayır. İncə. Az qala görünməz. "Sosial səviyyə" adı altında müştərinə onun "keçmiş həyatından gələn mənfi proqramlar"dan danışmaq olmaz. Olmaz! Eşidirsən? Bu sosial səviyyə deyil. Bu heç bir səviyyə deyil. Bu uydurmadır. Hörmətli adla örtülən uydurma.

Həqiqi biopsixososial müalicə belə görünür. Onun anatomiyası amansız və dəqiqdir. Beyin kimyası. Beynəlxalq təlimatların protokollarına yazılmış dərmanlar. Üstəlik şüurun dəqiq yenidən nizamlanması: sübut edilmiş effektivliyi olan psixoterapiya növləri — kognitiv-davranış, ekspozisiya, psixodinamik. Hər biri sərt indikasiyalar əsasında tətbiq edilir. Üstəlik qan yaxınlığı sisteminə təsir: klinik sınaqlarla təsdiq edilmiş modellər əsasında ailə işi. Multifokal ailə terapiyasının çoxamlı bisturi təsiri. Bilgisizlik xaosunu kəsib atan ailə

psixotəhsili. Üstəlik sınaqdan keçmiş sosial reabilitasiya proqramları vasitəsilə dünyaya qayıtma. Məşğulluqda dəstək modelləri. Əsaslı ictimai müalicə. Bunlar dağınıq praktikalar toplusudur? Xeyr. Bu dörd element birləşib vahid blok-sistemə çevrilmişdir. Kombinasiyada işləyən sınaqdan keçmiş alətlər. Müasir psixiatriya budur.

"Biopsixososial yanaşma" parlaq yazısı altında gizlənən saxta elm tibb bədənində xərçəng şişi kimidir. Məhz bu, həqiqi yanaşmaya olan xəstələrin etimadını yavaş-yavaş məhv edir, zəhərləyir, dağıdır. Təsəvvür edin: bir insan. İki il ömrü. İki ildir ki, "psixoloq"un "inteqrativ terapiya" tələsinə düşüb. İki ildir onu mantra uydurmaları ilə əzirlər. Kabinetdə nə baş verir? Bacarıqlı əllər fiqurcələr düzəldir. Laringal səs "nəsildə qalmış karmanı təmizləyir". Keçmiş həyatlarını "işləmək" üçün transa salırlar. Və əsas məsələ! Yüngülləşmə yoxdur. Boşluq. İki il buxara çevrildi, ağrı qaldı. Bu insan nə edir? Küçəyə çıxır və bütün psixoterapiyaya soyuq baxır. Gözlərində xəyanətin yandırdığı boşluq var. İndi ona elə gəlir ki, bütün "psixologiya" bir balaca şarlatanlıqdır.

Peşənin vəzifəsi biopsixososial yanaşma anlayışını onu sui-istifadə edənlərdən qorumaqdır. Qorumaqla ki, psixoloq və psixoterapevt adı sərt ixtisas meyarları əsasında verilsin. Qorumaqla ki, praktikada istifadə olunan üsullar sübut bazasına malik olsun. Qorumaqla ki, sui-istifadələr hüquqi nəticələr doğursun.

Bu şərtlərdən heç biri bu gün postsovet məkanının böyük hissəsində yerinə yetirilmir. Cinnət pandemiyası yayılır — o cümlədən ona görə ki, "biopsixososial yanaşma" kimi gözəl ifadənin qanadı altında elmlə heç bir əlaqəsi olmayan çox şey gizlənir.

Amma bu, növbəti fəsillərin mövzusudur. İndi isə mən bu fəsli ümid notu ilə bitirmək istəyirəm.

Biopsixososial model — bütün zəif cəhətlərinə baxmayaraq — XX əsrin böyük nailiyyətidir. O, psixiatriyaya bütöv insanı qaytardı. "Ya beyin, ya ruh" kimi yalançı dikotomiyanı aradan qaldırdı. Bioloqla psixoanalitikin bir-birinə nifrət divarından baxdığı o vəziyyəti bir dəfəlik mümkünsüz etdi.

Bu gün hər hansı Avropa ölkəsində savadlı bir psixiatrın kabinetinə girən xəstə bilir ki, ondan təkcə simptomlar barədə deyil, həyatı barədə də soruşacaqlar. Onu dinləyəcəklər. Ailəsi, işi, münasibətləri — hamısı nəzərə alınacaq. Ona təkcə həb təklif etməyəcəklər.

Bu, 2000-ci ildə Baki klinikamızda gördüklərimizdən lap yaxşıdır. O vaxt pasiyentə sadəcə sülfozin çarpazı vurub, elə bil hər şeyi həll etmişdilər.

Amma bu modelin həqiqətən hər yerdə işlədiyi vəziyyətə hələ çox uzağıq. Bu da təkcə ona görə deyil ki, elmi psixiatriya ilə xəstə arasına pul müqabilində tez xoşbəxtlik vəd edən bir nəsil özünü "şəfa verən" adlandıranlar girib.

Onlara yaxınlıqda müraciət edəcəyik. Amma ondan əvvəl — bir vacib dayanacaq. Özünü şəfa verənləri mühakimə etmək üçün əvvəlcə öz məcəlləni ortaya qoymalısan. Gəlin görək peşənin özü özü üçün hansı qaydaları işləyib hazırlayıb — və bu qaydalar praktikada nəyə dəyər.

Fəsil 17. Hippokratdan Madridə: peşə etikasının doğuşu

İyirmi yaşımda Hippokrat andının kağız üzərində çap olunmuş halını ilk dəfə gördüm. Bu, Bakı Tibb Universitetində, dekanatın dəhlizində, şüşəli çərçivədə idi. Adi bir kağız vərəqi — saralmış, tipik dövlət şrifti ilə. Və üç abzas mətn ki, o vaxt mənə izah etdilər, son iki min beş yüz il ərzində tibb peşəsinin etikasını müəyyənləşdirib.

“Müalicə üsullarını xəstələr üçün faydalı hesab edərək, gücüm və düşüncəm çərçivəsində tətbiq edəcəyəm; hər hansı zərər və haqsızlıqdan çəkinəcəyəm. Məndən istənilən zəhərli vasitəni heç kimə verməyəcəyəm və belə bir niyyətin yolunu da göstərməyəcəyəm... Daş kəsmə əməliyyatını icra etməyəcəyəm, bunu bu işlə məşğul olan adamlara buraxacağam. Hansı evə daxil olsam, xəstənin xeyrinə daxil olacağam; hər hansı qəsdən, haqsız və dağıdıcı niyyətdən uzaq olacağam... Müalicə zamanı — yaxud müalicəsiz — insan həyatına dair heç vaxt açılmamalı olan nə görsəm və ya eşitsəm, bu kimi şeyləri sirr sayaraq susacağam”.

Bu, yunan ənənəsində eramızdan əvvəl V–IV əsrlərdə yaşamış Koslu Hippokrata aid edilən mətnin bir parçasıdır. Müasir tibb tarixçiləri hesab edirlər ki, bu andı tam şəkildə Hippokratın özünün yazdığı ehtimalı azdır; onun az-çox son redaksiyası daha sonra, ellinizm dövründə formalaşıb. Amma məsələ dəqiq müəllifliyin müəyyən edilməsində deyil. Məsələ ondadır ki, hələ iki min beş yüz il əvvəl həkimlər xəstədən xahiş olunsa belə, nəyi etməyəcəklərini formalaşdırmağa çalışırdılar.

Zəhər yazmayacağam. Qadağan olunmuş üsulla abort etməyəcəyəm. Xəstəmlə cinsi əlaqədə olmayacağam. Eşitdiklərimi sirr saxlayacağam. Biliksiz olduğum metodlardan istifadə etməyəcəyəm.

Sadə prinsiplər. Və — bu fəsildə görəcəyimiz kimi — bəşəriyyətin psixiatriya sahəsində özünün qısa elmi tarixi boyunca demək olar ki, daim pozduğu prinsiplər.

Yeni dövrdə Hippokrat andının ilk genişləndirilməsi. Qədim məcəlləyə toxunmağa kim cəsarət etdi? Mançesterli ingilis həkim Tomas Persival. 1803-cü il. Onun qələmindən uzun və ağır adlı bir kitab çıxır: "Tibbi etika, yaxud Həkimlərin və cərrahların peşəkar davranışı üçün uyğunlaşdırılmış institutlar və göstərişlər məcəlləsi". Bu, tibbi etikanın ilk müasir sistemli məcəlləsidir. Mançester xəstəxanalarının dəhlizləri. Münaqişələrə qapanmış həkimlər. Persival məhz onlar üçün yazır. Məqsədi xaosu nizama salmaqdır: həkimlərin bir-biri ilə, xəstələrlə, ictimaiyyətlə münasibətləri. Və burada — zərbə. Adi qaydanın ifşası. Məhz Persivalda ilk dəfə xəstənin məlumatlı razılığı tələbi meydana çıxır — müasir terminologiya ilə desək. Həkim artıq tanrı deyil. Xəstə öz bədəni haqqında həqiqəti öyrənir və öz taleyini özü həll edir.

1847-ci ildə yaradılan Amerika Tibb Assosiasiyası Tomas Percivalin əsərinə istinad edərək ilk Etik Kodeksini qəbul etdi. Bu əhəmiyyətli bir addım idi: tarixdə ilk dəfə böyük bir peşəkar cəmiyyət vahid qaydalara riayət etməyə öhdə götürdü.

Lakin XX əsrin əvvəllərində dəhşətli bir çat ortaya çıxdı: ən hörmətli məcəllələr belə, həkimlər total təzyiqin pəncəsinə düşəndə toz-torpağa çevrilir. 1930–40-cı illər. Alman tibb elitasının əhəmiyyətli hissəsi — Hippokrat andını dilinə gətirən o adamların özü — qaranlığa addım atdı. Onlar T4 proqramının bir hissəsinə çevrildilər. Ruhi xəstələrin, inkişafdan geri qalmış uşaqların, qocalar evlərindəki yaşlıların kütləvi öldürülməsi. 1939-cu ildən 1941-ci ilə qədər. Xüsusi mərkəzlər — Hadamar, Grafeneck, Hartheim və başqaları. Orada insan-

ları qaz kameralarına doldururdular. Yetmiş min həyat boğucu havada əriyib yox oldu. 1941-ci ildə proqram rəsmi olaraq bağlandı. Amma öldürmə mexanizmini əmrlə dayandırmaq olarmı? Öldürülmələr davam etdi. Mərkəzləşməmiş şəkildə. Səssizcə. Xəstəxana palatalarında. Ölüm inyeksiya və aclıq şəklində gəldi. Daha yüz min həyat.

Bunu marjinallar etmirdi. Bunu psixiatriya professorları, klinikaların baş həkimləri, universitet müəllimləri edirdi. Onların bir qismi səmimiyyətlə inanırdı ki, "irq gigiyenası" kimi mühüm bir vəzifəni yerinə yetirir. Bir qismi isə sadəcə tabe olurdu. Hippokrat andı heç bir şeyə mane olmadı.

İkinci dünya müharibəsindən sonra gördüklərindən sarsılan dünya tibb ictimaiyyəti yeni bir etika qurmağa cəhd etdi — bu dəfə beynəlxalq mexanizmlərlə.

AZ MƏTNİ /1947-ci ildə Nürnberq Kodeksi qəbul edildi — klinik tədqiqatlar etikasının əsasını təşkil edən on maddə. Kodeksin birinci maddəsi belə deyirdi: "İnsan iştirakçısının könüllü razılığı tamamilə zəruridir". Nürnberqdən sonra bu artıq ümumi həqiqətə çevrildi. Nürnberqdən əvvəl isə belə deyildi.

1948-ci ildə Dünya Həkimlər Assosiasiyası Cenevrə Bəyannaməsini qəbul etdi — bu, Hipokrat andının müasir versiyası idi. 1964-cü ildə isə Assosiasiya Helsinki Bəyannaməsini təsdiqlədi ki, bu da indiyədək biomediki tədqiqatların etik normaları üzrə beynəlxalq standart olaraq qalır.

Lakin psixiatriya üçün bu kifayət deyildi. Psixiatriya — tibbin xüsusi sahəsidir. Burada həkim yalnız xəstənin bədəni barədə deyil, həm də onun azadlığı (məcburi hospitalizasiya), iradəsi (dərman sedasiyası), hüquqları (fəaliyyət qabiliyyəti) barədə qərar qəbul edir. Və məhz burada — ilk beynəlxalq etik standartların yaradıldığı dövrdə — XX əsrin ən qaranlıq səhifələrindən biri açılırdı.

Biz artıq sovet cəza psixiatriyasından danışmışıq. Leonid Plyuşşun Serbski İnstitutundakı işi. General Qriqorenkonun işi. "Ləng gedən şizofreniya xəstələri" elan edilən yüzlərlə, minlərlə insan xüsusi psixiatrik xəstəxanalara düşdü və orada terapevtik dozaları aşan haloperidol, sülfozin xaçları, məcburi insulin aldılar. Bunların hamısını həkimlər edirdi. Tibb diplomu, professor dərəcəsi, elmi adı olan həkimlər. Onların hamısı Hippokrat andı içmişdi.

1970-ci illərin əvvəllərinə qədər Qərb tibb ictimaiyyəti "dəmir pərdə"nin arxasında nələr baş verdiyi barədə kifayət qədər məlumat əldə etmişdi. Qismən dissidentlərin özlərinin nəşrləri sayəsində — Vladimir Bukovskinin toplusu, Pyotr Qriqorenkonun əsərləri, Semyon Gluzmanın ifadələri. Qismən jurnalist araşdırmaları sayəsində. Qismən Qərbə mühacirət etmiş sovet psixiatrlarının ifadələri sayəsində.

Ümumdünya Psixiatriya Assosiasiyasının — WPA (World Psychiatric Association) — reaksiyası əvvəlcə zəif idi. 1961-ci ildə yaradılmış WPA-nın hələ aydın etik sənədləri yox idi. Nizamnamələri, ümumi bəyanatları vardı, lakin istinad edilə biləcək kodeksi yox idi.

1977-ci ildə Havay adalarında keçirilən WPA-nın VI Konqresində bu çatışmazlıq aradan qaldırıldı. Baş Assambleyada Havay Bəyannaməsi qəbul edildi — tarixdə ilk dəfə məhz psixiatrlara ünvanlanmış etik kodeks.

Havay Bəyannaməsi on bənddən ibarət idi. Onun müəllifi Karolinska İnstitutundan isveçli tibb etikası professoru Klarens Blumkvist idi. Birinci bənd SSRİ-də baş verənlərə birbaşa reaksiya idi: o, psixiatriyadan siyasi məqsədlərlə sui-istifadəni — psixiatrik diaqnozlardan və metodlardan fikir ayrılığında olanları təqib etmək üçün istifadəni pisləyirdi.

Havay Bəyannaməsi bu gün öz-özünə aydın görünən, lakin 1977-ci ildə inqilabi sayılan bir neçə fundamental prinsip formalaşdırdı:

— Psixiatriyanın məqsədi psixi pozuntuları müalicə etmək və psixi sağlamlığa xidmət etməkdir. Siyasi nəzarət deyil. Sosial gigiyena deyil. "Yenidən tərbiyə" deyil.

— Psixiatr pasiyentə həmkarına göstərdiyi hörmətlə yanaşmalıdır. Terapevtik münasibətlər qarşılıqlı etimada əsaslanır.

— Pasiyentin məlumatlı razılıq əsasında müalicəsi barədə qərar qəbul etmək hüququ var.

— Məcburi müalicə yalnız o halda caizdir ki, xəstə öz xəstəliyi üzündən qərar qəbul etmək iqtidarında olmasın və müalicə həyati zərurət daşısın. Belə hallar müstəqil araşdırmaya açıq olmalıdır.

— Xəstədən alınan məlumatın məxfiliyi mütləqdir; yalnız nadir, dəqiq müəyyən edilmiş istisnalar (başqalarının həyatı üçün təhlükə) bundan kənardır.

— Psixiatr öz peşə imkanlarından insan ləyaqətini hər hansı şəkildə alçaltmaq üçün istifadə etməməlidir.

Havay Bəyannaməsi hüquqi baxımdan məcburi sənəd deyildi. Lakin o, milli psixiatriya cəmiyyətlərinin dövlətlərlə mübahisələrində istinad edə biləcəyi mənəvi standarta çevrildi.

Honolulu konfransından dərhal sonra SSRİ Psixiatrlar və Narkoloqlar Ümumittifaq Cəmiyyətinə təzyiq kəskin şəkildə gücləndi. 1983-cü ildə, Vyanada keçiriləcək WPA növbəti konqresinin ərəfəsində — gündəlikdə sovet psixiatriyasının WPA-dan çıxarılması məsələsi duranda — sovet cəmiyyəti könüllü olaraq özü ayrıldı. Bu, əslində, etiraf idi — istəməsə də.

1989-cu ildə, yenidənqurma başladıqdan sonra, sovet tərəfi ilk dəfə siyasi sui-istifadə faktını açıq şəkildə etiraf etdi və readmissiya prosedurlarına razılıq verdi. 1991-ci ildə SSRİ-yə səfər edən beynəlxalq ekspert qrupu açıq sui-istifadə formalarının dayandırıldığını təsdiqlədi. Sovet cəmiyyəti WPA-ya qaytarıldı.

Bu, beynəlxalq elmi-etik birliyin dövlət zorakılığı üzərində qazandığı nadir qələbələrdən biri idi. Tam deyildi — cəza psixiatriyasının nəticələri hələ uzun müddət hiss olundu və postsovet məkanında hələ də hiss olunmaqdadır. Amma presedent kimi — bu, dünya psixiatriyasının dövlətə "yox" dediyi an idi.

1990-cı illərin ortalarına doğru mənzərə aydınlaşdı. Havay Bəyannaməsi — zahirən nə qədər monolit görünsə də — çat verdi. Bəli, o, sovet cəza psixiatriyasına qarşı mübarizənin dar kontekstində qalxan oldu. Amma köhnə düşmənin kölgəsi çəkildi, qaranlıqdan isə yeni təhlükələr üzə çıxdı: evtanaziya, ölüm hökmü və tətiyin səsi — ki, orada həkim də iştirak edir, genetik tədqiqatlar — həyat kodunun özünə müdaxilə, əczaçılıq sənayesi ilə qovuşma, həkimlə xəstəni ayıran sərhədin aşınması. Bu məsələlərin heç birini Havay Bəyannaməsi açıq şəkildə əhatə etmirdi. Mətn qəbir sükutu saxlayırdı.

1993-cü ildə Rio-de-Janeyroda keçirilən Ümumdünya Psixiatrlar Konqresində WPA öz Etika Komitəsinə yenilənmiş və genişləndirilmiş sənəd hazırlamağı tapşırdı. İşə Argentinalı Auqusto Kastanyolli-Bubis rəhbərlik etdi, sonra onu Misirli Əhməd Okaşa davam etdirdi. Sənəd bir neçə redaktə mərhələsindən və milli cəmiyyətlərlə, WPA Şurası və İcra Komitəsi ilə razılaşdırmadan keçdi.

1996-cı ilin avqustunda, Madriddə keçirilən X Ümumdünya Psixiatrlar Konqresində Psixiatriyada Etik Təcrübə Standartları haqqında Madrid Bəyannaməsi qəbul edildi.

Madrid Bəyannaməsi Havay Bəyannaməsindən xeyli genişdir. O, yeddi ümumi rəhbər prinsipi və konkret situasiyalara dair bir sıra xüsusi bölmələri əhatə edir. Əsas müddəaların bəzilərini sadalayaq.

Xəstənin muxtariyyəti. Xəstə terapevtik prosesdə tərəfdaşdır. O, öz xəstəliyi, təklif olunan müalicə, onun alternativləri, riskləri və perspektivləri barədə məlumat almaq hüququna malikdir. Müalicə qərarı birgə qəbul edilir.

Klinik münasibətlərin sərhədləri. İncə qırmızı xətt. Madrid Bəyannaməsi bu tabuya birbaşa və birmənalı şəkildə hücum edir: psixiatrla xəstə arasında cinsi əlaqə qəti qadağandır. Bəs niyə? Tapmacanın özü sənədin formulunda gizlənir. "Xəstənin razılığı psixiatrın xəstə haqqında malik olduğu biliyi və psixiatra xəstə üzərində xüsusi səlahiyyət verən güc differensialı ilə ləkələnmiş sayılır". Bilik — silah. Güc — rıçaq. Bu şəraitdə razılıq qəddar istismara bərabərdir. Gizli cinsi dinamika. O, hər hansı münasibətin kölgəsində için-için yanan fitil kimi döyünür. Amma xəstə terapevtin kabinetinə addım atan kimi bu gizli qığılcım alovlanır və aşkara çıxır. Əgər terapevt bu odu lazımınca idarə etməzsə, alov xəstəni içdən yandırır və onu əzaba məhkum edir. Terapevt həddi aşanda ağrı dözülməz olur. Yoldan çıxaran ifadələr işlədir. Yersiz baxışlar atır. Hər söz — zəhər, hər jest — ipəkdən kəmənd. Buna görə də bəyannamənin hökmü heç bir boşluq qoymur. Heç bir şəraitdə psixiatr xəstəsi ilə hər hansı formada cinsi davranışa girməməlidir. Heç bir bəraət yoxdur. Bu davranışın xəstə tərəfindən, yoxsa terapevtin özü tərəfindən başladılmasından asılı olmayaraq.

Bu — birbaşa və qəti normadır. Heç bir yozum yoxdur. Heç bir yarımton yoxdur. O, yalnız aktın özünü deyil, belə bir aktın mümkün ola biləcəyi atmosferin nəfəsini belə qadağan edir. Təkcə cari xəstə ilə deyil, bir sıra yurisdiksiyalarda keçmiş xəstə ilə də. Məsələn, ABŞ-da əksər ştatlarda psixiatr həkimin xəstəsi ilə cinsi əlaqəsi artıq etik xəta deyil, cinayət məsuliyyəti doğuran əməldir. Qanun onu cinsi zorakılığa bərabər tutur. Tapmaca nədədir? Niyə bu qədər sərt? Cavab terapiyanın öz təbiətində gizlənir. Güc asimmetriyası. Görünməz, amma mütləq olan əyilmə. Terapevtik münasibət — əsl razılığın sadəcə mövcud ola bilməyəcəyi bir tələdir. O mümkün deyil.

Evtanaziya, işgəncə, ölüm hökmü. Madrid Bəyannaməsi aydın mövqe tutur: psixiatr evtanaziyada iştirak edə bilməz (xəstənin xahişi ilə həyatın aktiv şəkildə dayandırılması mənasında — sənəd sonralar inkişaf edən müasir tibbi yardımlı

ölüm müzakirəsindən əvvəl hazırlanmışdı); işgəncələrdə iştirak edə bilməz; ölüm hökmünün icrasından əvvəl məhkumların qiymətləndirilməsində iştirak edə bilməz, əgər bu qiymətləndirmə onların "edama yararlılığının" müəyyən edilməsinə xidmət edirsə.

Cinsiyyət seçimi. 1996-cı ildə bu, yeni və kəskin bir məsələ idi. Madrid Bəyannaməsi, tibbi göstəriş olmadıqda (məsələn, cinsiyyətlə əlaqəli irsi xəstəliklərdə) embrionların cinsiyyətinə görə seçilməsi ilə bağlı hər hansı prosedurun psixiatrik müşayiətini açıq şəkildə qadağan edir.

Ailə ilə münasibətlər. Xəstənin ailəsi prosesin iştirakçısıdır. Onun maraqları nəzərə alınmalıdır, lakin prioritet xəstənin özünün maraqlarıdır.

Sonrakı illərdə Hamburqda (1999) və Yokoqamada (2002) keçirilən konqreslərdə əlavə bölmələr qəbul edildi: psixiatrların media ilə qarşılıqlı əlaqəsi, etnik və mədəni əsaslı ayrıseçkilik məsələləri, genetik tədqiqatlar və məsləhət xidmətləri, əczaçılıq sənayesi və sığorta şirkətləri ilə maraqlar toqquşması barədə.

Növbəti böyük addım 2020-ci ildə atıldı. WPA, Madrid Bəyannaməsinin bütün əsaslılığına baxmayaraq müasir etik problematikasının hamısını əhatə etmədiyini dərk edərək, yeni bir sənəd — Psixiatriya üçün WPA Etika Məcəlləsini qəbul etdi. 2021-ci ildə World Psychiatry jurnalında dərc olunan bu məcəllə dörd bölmə üzrə strukturlaşdırılıb:

— Klinik təcrübə; — Psixiatrik təhsil; — Tədqiqatlar və nəşrlər; — İctimai psixi sağlamlıq.

Məcəllə prinsipləri müsbət formada ifadə edir: psixiatrın nə etdiyini, yalnız nə etməməli olduğunu deyil. Burada ailənin və qayğı göstərən şəxslərin rolu, resursların ədalətli bölgüsü (xüsusilə inkişaf etməkdə olan ölkələrə və yardım çatışmazlığı olan regionlara diqqət yetirilməklə), həmçinin psixiatrın

bütün peşə həyatı boyu təhsilini davam etdirmək öhdəliyi vurğulanır.

Paralel olaraq daha bir mühüm sənəd qüvvədədir — BMT-nin Əlilliyi olan Şəxslərin Hüquqları haqqında Konvensiyası (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD), 2006-cı ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən qəbul edilmişdir. Konvensiya beynəlxalq hüquq tarixində ilk dəfə psixi pozuntusu olan şəxslərin hüquqlarını digər kateqoriya vətəndaşların hüquqları ilə bir səviyyəyə qoydu. O, dünyanın əksər ölkələri tərəfindən imzalanıb və ratifikasiya edilib. Azərbaycan Respublikası Konvensiyanı 2009-cu ildə ratifikasiya etmişdir.

Guya hər şey qaydasındadır. Bizdə Havay Bəyannaməsi var. Bizdə Madrid Bəyannaməsi var. Bizdə 2020-ci ilin WPA Etika Məcəlləsi var. Bizdə BMT Konvensiyası var. Bizdə həkimlərin milli etik məcəllələri var. Bizdə tənzimləyici orqanlar, imtahan komissiyaları, lisenziyalaşdırma strukturları, sığorta şirkətləri var.

Amma gözəl çərçivələrlə dolu bu otaqdan çıxıb real ölkələrdə real mütəxəssislərin real kabinetlərində nələr baş verdiyinə baxsanız, mənzərə tamam başqa cür olacaq.

On üçillik OKB-si olan xəstəyə "seksoterapiya" təklif edən həmin psixiatr — iyirmi üçüncü fəsildə onun işi barədə ətraflı danışacağam — Madrid Bəyannaməsinin klinik münasibətlərin sərhədlərinə aid bütün müddəalarını pozdu. Və nə məsuliyyətə cəlb edildi, nə lisenziyadan məhrum olundu, nə də heç açıq şəkildə adı çəkildi.

Psixiatr. Sovet sonrası məkanın ən nüfuzlu akademik qurumlarından biri. Ona 23-cü fəsildə qayıdacağıq. Halhazırda isə yalnız fakt. O, antipsixotiklər təyin edir, eyni zamanda xəstələrə dualar yazır və "təsiri müşahidə edirdi". Dayanaq. Bəs burada nə düz deyil? 2020 Kodeksi. Əsas prinsip. Sözləri ilə: "Psixiatrlar qəbul edirlər ki, onların kliniki şəraitdə

əsas öhdəliyi xəstələrin rifahını təmin etməkdir və bu, ən yaxşı mövcud sübutlar və klinik təcrübəyə əsaslanmalıdır." Ən yaxşı mövcud sübutlar. Klinik təcrübə. Dualar şizofreniyanın sübuta əsaslanan müalicə üsulu deyil. Bu mübahisə mövzusu deyil, məlum fakt. Onları sübuta əsaslanan müalicə ilə eyni klinik yanaşmada qarışdırmaq — etik pozuntudur. Nöqtə. O qarışdırırdı. Davam edirdi. Hər gün. Xəstə üstə xəstə. Və onu heç kəs dayandırmadı.

Mənim ölkəm Azərbaycanda və digər postsovet respublikalarının çoxunda milli psixiatr cəmiyyətlərinin etik kodları mövcuddur, amma onların tətbiq mexanizmləri ya zəifdir, ya da ümumiyyətlə yoxdur. Etik pozuntulara görə lisenziyalar nadir hallarda ləğv edilir. Komissiyalar nadir hallarda yığılır. Şikayət qeyd edən xəstələr isə tez-tez qaydanı pozmuş həkimin həmkarı ilə peşəkar həmrəylik qarşısında qalır.

Daha pisi isə budur ki, bütün beynəlxalq sənədlər — Qavay, Madrid, DPP 2020, BMT Konvensiyası — illüziyaya çevrilmişdir. Bu qalxan yalnız diplomlu psixiatrları və qismən psixoloqları qoruyur. İndi isə əsas kabus. Reqressoloqlar, tetahilerlər, ezoterik kouçlər, "unikal metodlar"ın müəllifləri — onları heç bir etik kodeks bağlamır. Heç bir. Ümumiyyətlə. Onlar heç kəsə məxfilik vəd etməyiblər. Onlar müştəriləri ilə cinsi əlaqəyə girməməyə and içməyiblər. Onlar metodlarından siyasi sui-istifadədən imtina etməyə borclu deyillər. Onlar həkim deyillər. Onlar heç bir peşə birliyinin intizam yoxlamasına tabe deyillər. Sadə bir səbəb üçün: onlar heç birində deyillər. Onlar qanunxaradırlar.

Dövrümüzün əsas paradoksu budur. Biz "Hippokrat andı" içənlər üzərində dəmir-beton etik nəzarət sistemi qurmuşuq. Həkimin hər addımı nəzarət altındadır. Hər səhv cəzalandırılır. Amma postsovet məkanında insanların ruh dərdi ilə ən çox məşğul olanlar — məyus müştərilərin yüz minlərlə axın etdiyi, ciblərinə milyonlarla rubl və manat dolduranlar — onlar heç bir and içməyiblər. Heç bir. Və heç kim, onların

xidmətlərinə baxaraq, onlardan hesab tələb edə bilmir. Heç kim.

Sonrakı fəsillərdə məhz onlara müraciət edəcəyik.

İkinci interlüd. Ana səsi

Monoloq real hekayələr əsasında bərpa olunub; adlar və detallar dəyişdirilib.

Bu başlayanda oğlum on doqquz yaşındaydı. Yatmağı dayandırdı. Gecələr mətbəxdə pəncərənin qabağında durub dinləyirdi. Soruşuram — nəyə qulaq asırsan? Deyir: ana, sən həqiqətən eşitmirsən, yoxsa hamınız sözləşmisiniz?

İndi sizə elə bir şey deyəcəyəm ki, ona görə utanıram, amma siz bunun üçün soruşursunuz. İlk fikrim "həkimə getmək lazımdır" deyildi. İlk fikrim bu idi — heç kim bilməsin.

Bizdə belədir: evdə bu olsa — tamam, ev damğalanıb. Onun bacısı ərə getməyib. Söz-söhbət düşsə, onu kim alacaq? Qayınanam dedi: bu xəstəlik deyil, bu edilmişdir. Cadu. Göz dəyib — insanlar axı paxıllıq edirlər. Və biz yola düşdük.

Əvvəlcə mollaya getdik. O, oğlanın üstünə oxudu, suya oxudu, dedi qoluna bağlayın. Sonra — bir ziyarətgaha, iki saat yol; orada bir qadın var, yanına bir ay əvvəldən yazılır; dedi — cin, amma zəifdir, çıxacaq. Orada gecələdik. Oğlum orada da yatmadı, sadəcə orada pəncərə yox idi — maşında oturub özünü dinləyirdi.

Dörd ay. Sonra təqvimlə saydım — dörd ay on bir gün bu işlə onu müqəddəs yerlərə aparıb-gətirdik. Arıqladı. Artıq demək olar heç yemirdi — deyirdi ki, yemək "emal olunub". Mən isə, axmaq, sevinirdim: oruc tutur, bəlkə təmizlənir, bəlkə ondan çıxır.

Həkimə düşməyimiz ağıllandığım üçün deyildi. Oğlum gecə yola qaçdığı üçün idi — ayaqyalın, yanvarda. Qonşu onu tutdu. Onda artıq təcili yardım, onda artıq hər şey.

Bilirsiniz, həkim mənə nə dedi? Gözləyirdim ki, məni danlayacaq. Dedi: siz nə birinci, nə də yüzüncüsü deyilsiniz, amma məndən aldığınız hər ayı mən indi xəstəlikdən illərlə geri qaytarmalı olacağam. Sözünü sözünə yadda saxladım. İllərlə geri qaytarmaq.

Oğlum indi iyirmi dörd yaşındadır. Dərman qəbul edir, kollecdə bərpa olunub, o qış barədə artıq onunla danışa bilirik. Bu yaxınlarda mənə dedi: ana, yadındadır, siz məni cini qovmağa necə aparırdınız? Və güldü. Mən isə mətbəxə çıxıb onun o vaxt dinlədiyi pəncərənin önündə durdum və ziyarətgahlarda heç vaxt ağlamadığım qədər ağladım.

Qayınanam hələ də deyir: “Gördün, kömək etdi — axı getdik, axı dua etdik”. Onunla mübahisə etmirəm. İndi sadəcə bilirəm kimin payı nədir. Dua — qoy olsun, mən də indi dua edirəm. Amma artıq başqa bir şey üçün dua edirəm: qoy növbəti ananın ilk fikri düzgün olsun. Çünki dörd ay — məlum olur ki, çox bahadır. Sadəcə qiyməti sonra deyirlər.

IV HİSSƏ. Bugünkü pandemiya: psixobazar

Fəsil 18. Bu niyə işləyir: möcüzənin anatomiyası

Adlarını çəkməyə keçməzdən əvvəl — Hellingeri, Stibahı, reqressoloqları, Hubbardı — bir suala cavab verməliyəm. Bu cavabsız qalsa, kitabın qalan hissəsi vicdansız olar.

Sual belədir. Əgər bu kitabda təsvir olunan metodlardan heç biri işləməyibsə — bəs niyə hamısı "işləyirdi"?

Xəstələr Zekelə təşəkkür edəndə ağlayırdılar. Səmimi. Göz yaşları ilə. İnsulin komalarına görə. Yaxınları oturub məktub yazırdılar — Frimenə, şəxsən — və kağıza köçürürdülər: lobotomiya "qızımızı bizə qaytardı". Betti əməliyyatından sonra qadınlar deyirdilər: yüngülləşdi. Şikayət etmirdilər. Deyirdilər — yüngülləşdi. İndi baxın. Bu gün. Zalda dayanmışdım və öz gözlərimlə gördüm. Yetkin qadın. Ağıllı. Savadlı. Düzəlişdən çıxır — üzü göz yaşından islanıb, amma gülümsəyir. Xoşbəxt. Və deyir: "Mənə kömək etdi. İçimdə nəyinsə azad olduğunu hiss etdim". Bütün sirr buradadır. O yalan danışmır. Zərrə qədər yox. O, doğrudan da bunu hiss edib.

Demək asandır: təlqin, cəfəngiyyat. Amma həkimin belə lovğalığa haqqı yoxdur. Əgər min illər boyu milyonlarla insan işləməyən metodlardan rahatlıq tapıbsa — deməli, hardasa nə isə həqiqətən işləyir. Sadəcə, lövhədə yazılan deyil.

Elə o "nə isə"ni indi mexanizmləri ilə birlikdə araşdıracağıq. Çünki oxucu möcüzənin hardan gəldiyini başa düşməyincə, o möcüzəni satan hər kəsin qarşısında müdafiəsiz qalır.

Birinci mexanizm. Plasebo.

Plasebo aldatma deyil. Boş qutu deyil. "Heç nə" deyil. Bu, real neyrofizioloji fenomendir — tibbdə ən çox öyrənilmiş hadisələrdən biri. Bəs rahatlıq gözləntisi necə fizioloji prosesə çevrilir? Cavab kəllənin içində gizlənir. Beyin əmr alır — və özünün gerçək proseslərini işə salır. Toxumaların dərinliyinə güclü boşalmalar çatır: endogen opioidlər, orqanizmin daxili ağrıkəsiciləri ifraz olunur. Damarlara xilaskar istilik yayılır. Dopamin sisteminin fəallığı dəyişir. Ağrının, narahatlığın, yorğunluğun qavranması dəyişir. Bədən illüziyaya güvənir və kimyasını yenidən qurur. Klassik təcrübə. Plasebo artıq ağrını kəsmiş adama nalokson vurulur — opioid reseptorlarını bloklayan dərman. Və ifşa baş verir: plasebonun ağrıkəsici təsiri yox olur. Ağrı qayıdır. Niyə? Çünki reseptorlar bloklanıb. Açar dönmür. Bu o deməkdir ki, təsir "xəyalda" deyildi. Beynin kimyasında idi.

Amma plasebonun sərt bir həddi var. İllüziyaların çırpılıb dağıldığı şüşə günbəz. O, insanın öz vəziyyətini necə yaşadığını dəyişir — xəstəliyin özünü isə dəyişmir. Plasebo subyektiv ağırlığı götürür — psixozu dayandırmır, şişi əritmir, mədəaltı vəzi bərpa etmir. Niyə? Cavab xəstəliyin toxumasının özündə gizlənir. Orta ağırlıqlı depressiyası olan adam "müalicəçi"dəki seansdan sonra həqiqətən bir həftə yüngüllük hiss edə bilər. Canlı, isti rahatlıq bədənə yayılır. Amma şizofreniyası olan adama yüngülləşməyəcək — heç vaxt. Bir həftə isə itiriləcək. Geri qaytarılmamaq üzrə.

Əsas qəddarlıq da budur: placebo gerçəkdir və elə də buna görə təhlükəlidir. O, müvəqqəti rahatlığı sağalmanın başlanğıcı kimi göstərir. Daxilində heç nə olmayan bir metod üçün ideal pərdədir.

İkinci mexanizm. Ritual.

Ritual — insanlığın tibbdən çox-çox əvvəl kəşf etdiyi, narahatlıqla məşğul olmağın qədim texnologiyasıdır. Ritualın quruluşu var: başlanğıc, ardıcıl hərəkətlər, sonluq. Xəstəlik səbəbilə qeyri-müəyyənləşən dünyada təxmini proqnoz

imkanı var. Əsası da budur: çarəsizlik əvəzinə fəaliyyət. Əzab çəkən insan ən çox ağrıdan deyil, çarəsizlikdən əziyyət çəkir. Ritual ona ediləcək bir iş verir.

Mama və dua — ritualdır. Otaqda düzülmüş fiqurlar — ritualdır. Gözləri yumaraq daxil olmalı olduğunuz "teta dalğası" — ritualdır. Hətta divan və ciddi şəkildə saatları qeyd edərək keçirilən əlli dəqiqə belə — ritual çərçivəsidir və dürüst psixoterapiya da bunu gizlətmir. Fərq ritualın olub-olmamasında deyil. Fərq çərçivənin daxilində ondan başqa bir şeyin olub-olmamasındadır.

Üçüncü mexanizm. Diqqət.

Biz bunu insulin komaları haqqında fəsildə də görmüşük: Zakelin xəstələri komatik şöbələrdə o dövrdəki psixiatriyanın digər sahələrindən aldıqlarından daha çox insani diqqət alırdılar və bu diqqəti insulinin təsiri kimi qəbul edirdilər. Bəs ya burada dərmanın heç rolu yoxdursa? Bəs ya həqiqi dərman özü iştirakdırsa? Müalicəçi sizi dinləyir. Bir saat. Davam etmədən gözlərinizə baxır. Xatirələri deşifrə edir: uşaqlıq, ana, yuxular haqqında. İndi müqayisə edin. Rayon həkimi. Səkkiz dəqiqə. Monitora ciddi şəkildə ilişmiş baxış. Belə qəbula alışmış insan üçün bölünməmiş bir saatlıq diqqət — terapevtik gücün zərbəsidir. İnsanlar müalicəçilərə pul ödəyirlər. Və çox baha ödəyirlər. Bəs nəyə görə? İstənilən tibbin pulsuz normalı olmalı olan şeyə görə. Sadəcə onları dinlədiklərinə görə.

Dördüncü mexanizm. Narrativ.

İnsan hekayəsiz ağrıya dözmür. Nə səbəbi, nə adı, nə də günahkarı olmayan əziyyət ikiqat dözülməzdir. Ağrıya xaos da əlavə olunur. Və onda o gəlir. Sizə gözlərinizə baxaraq deyən adam: — Mən bilirəm sizə nə olub. Fasilə. — Sizin depressiyanız sizin babababanızın bağışlanmamış küdürətidir. Küçülən həmin qadının. Düşünün. Bu saniyədə nə baş verdi? Ağrı ad aldı. Səbəb. Və günahkar. Üstəlik — siz deyil. Ardınca, dərhal, qiymət siyahısında — kefarət ritualı.

Bu pis izahdır. Lakin beyin dürüst qeyri-müəyyənlikdən çox, yalançı müəyyənliyi üstün tutur. Dürüst həkim deyir: "Depressiya çox amilli pozuntudur, bütün səbəblərini bilmirik, amma onu müalicə etməyi bacarıq." Narrativ satıcısı deyir: "Səbəb budur." Tahmin edin, kimin ifadəsi daha yaxşı yadda qalır.

Beşinci mexanizm. Barnum effekti.

1948-ci il. Psixoloq Bertram Forer auditoriyaya daxil olur və tələbələrə vərəqələr paylayır. Onların şəxsiyyətlərinin "fərdi" portretləri. Güya testin nəticələrinə əsasən tərtib edilmişdir. Tələbələr oxuyurlar. Özlərini tanıyırlar. Qiymət verirlər. Dəqiqlik orta balı — 5 üzərindən 4.26. Dörd tam iyirmi altı yüzə. Demək olar ideal uyğunluq. Demək olar. Çünki bir "lakin" var idi. Mətn hamıda eyni idi. Eyni. Hərfi-hərfinə. Hər kəsə uyğun gələn ifadələr toplusu: "Siz bəzən ictimai olsanız da, bəzən tənhalığa ehtiyac duyursunuz. Sizdə açılmamış potensial var. Dərin hisslərə qadirsiz, baxmayaraq ki, bunu hər kəsə göstərmirsiniz." Onlar özlərini oxuyurdular — olmayan bir güzgüdə.

Bu effekt — ümumi ifadələrin dəqiq şəxsi uyğunluq kimi qəbul edilməsi — dəfələrlə təkrar olunub. Bürclər, "fotoşəkilə görə diaqnoz", "nəsil oxuma" kimi şeylər və ezoterik mütəxəssisin ilk seansında müştərinin "o məni dəridən görür" kimi hiss etdiyi hər şeyin yarısı da məhz buna əsaslanır. Heç kəs sizi dəridən görmür. Sizə hər kəsin özündən bir şey tapdığı bir güzgü göstərirlər.

Altıncı mexanizm: Təbii gedişat və orta səviyyəyə qayıdış.

İnsan kömək üçün təsadüfi bir gündə deyil, ən pis günündə, zirvədə, artıq dözülməz olduqda müraciət edir. Və burada ilk tələ yatır. Əksər halların dalğaları var. Zirvədən sonra demək olar həmişə eniş gəlir — sadəcə xəstəliyin təbiəti belədir. Depressiya epizodu öz-özünə yumşalaya bilər. Narahatlıq azalır. Vəziyyətə bağlı böhran həll olunur. İndi təsəvvür edin ki, bu

anda insan müalicəçiyə gedibdir. Yaxşılaşmanı müalicəçiyə aid edəcəklər. Dalğaya deyil, zamana deyil, xəstəliyin təbiətinə deyil. Müalicəçiyə. Amma seçim var idi. Əgər o, eyni həftələrdə başqa müalicəçiyə getsəydi, nəticə eyni olardı. Falçıya getsəydi — eyni. Heç yerə getməsəydi — yenə eyni. İşin sirri budur: sağalma öz-özünə gələ bilərdi. Amma bu, zirvədə yanında olan adama nəsib oldu.

Buna sağ qalanların səhvi də əlavə olunur. "Kömək olan"lar bunu hər kəsə danışır — danışacaq şeyləri var. "Kömək olmayan"lar susurlar: utandıqları üçün, özlərini günahlandırdıqları üçün və ya artıq yeni müalicəçi axtarırdılar. Rəylərdə yalnız möcüzələr qalır. Uğursuzluqlar qəbiristanlığı Instagram-da paylaşım etmir.

Yeddinci mexanizm. Ödənilən pullar.

Kursa üç yüz min ödəyən insan seçim qarşısında qalır: metodun işləmədiyini etiraf etmək — yəni üç yüz min və bir il həyatını boşa xərcləmiş insan olmaq; ya da yaxşılaşma tapmaq — yəni özünə ağılla yatırım etmiş insan olmaq. Psixika demək olar ki həmişə ikincini seçir. Buna "sərf olunmuş xərclər səhvi" deyilir və onun gücü qiymət artdıqca artır: metod nə qədər bahalıdırsa, müştəri özündə nəticəni bir o qədər inadla tapır. Psevdoterapiyanın bahalığı yan effekt deyil. Bu mexanizmin bir hissəsidir.

Və son halqa: ictimai şahidlik. Müştəridən qrupda danışmaq, video-rəy çəkmək, "transformasiya"sını paylaşmaq tələb olunur. Aşkar söylənən sözlər, eşidiləndən daha çox danışanı inandırır. Şəxs sağalması haqqında danışaraq bunu öz bioqrafiyasına əlavə edir.

Gəlin hamısını bir araya gətirək.

Plasebo real bədən rahatlığı verir. Ritual narahatlığı aradan qaldırır. Diqqət istidir. Hekayə qarmaqarışıqlıqda nizam salır. Barnum effekti "məni gördülər" hissi yaradır. Təbii gedişat yaxşılaşmalar gətirir. Ödənilmiş pul inam möhkəmləndirir.

İnsan psixikasının yeddi dürüst mexanizmi — heç biri elan edilmiş metodla əlaqəsi olmayan.

Bütün bu fəslin yazılma səbəbi olan üç nəticə çıxarılır.

Birinci. Yalançı sağaldıcıların hiylələri — axmaqların işi deyil. Bu mexanizmlər hər birimizin psixikasına həkk olunub — mənim də daxil olmaqla. Ağıllı insan onlardan qorunmur; bəzən daha həssas olur, çünki qorunduğuna əmindir. Əgər özünüzü "bəlkə bunun içində nəsə var" fikri ilə tutmusunuzsa — bu ağılsızlıq deyil. Bu insanın quruluşudur.

İkinci. "Mənə kömək etdi". Üç söz. Tibbdə ən dürüst sübut — və ən yararsız. Bu sözləri deyən adam yalan danışmır. O, yaşadığını dəqiq təsvir edir. Amma bunun məhz nədən qaynaqlandığını bilə bilməz. Metodun əsl təsirini yeddi daxili mexanizmin kor oyunundan ayırmağa nə xəstənin özü, nə çarpayının üstünə əyilmiş həkim, nə də metodun dahi müəllifi qadirdir. Buna yalnız bir alət qadirdir. Nəzarətli tədqiqat. Bir qrup əsl metodu alır. Digəri — onun qüsursuz təqlidini. Və heç kim sona qədər kimin nə aldığını bilmir. Plasebo nəzarəti. Bu, elmin möcüzəni ayırd etdiyi yeganə üsuldur. Ayırd etdikdən sonra qalan hər şey — müalicənin özüdür.

Üçüncü. Yalançı sağaldıcı axmaqlıqdan yox — o, yüngülləşmənin əsl mexanizmlərini müalicədən qopararaq onlardan istifadə edir. Elə buna görə də onun metodu hər seansda "işləyir", amma heç vaxt sağaltmır. Və elə buna görə də təhlükəlidir: yeddi mexanizm xəstəyə həftələrlə subyektiv yüngülləşmə bəxş edərkən, xəstəlik də həmin həftələri özünə qazanc kimi qazanır.

Yaxşı, həkim də həmin yeddi mexanizmdən istifadə edir. Yaxşı həkim dinləyir, izah edir, çərçivə qurur, ümid verir — və bu düzgündür: yüngülləşmə varsa, onu xəstəyə təklif etməmək günah olar. Fərq bir tək məqamdadır: həkimin çərçivəsinin içində möcüzənin çıxılmasından keçmiş müalicə dayanır. Sağaldıcının çərçivəsinin içində isə — yalnız çərçivə.

Budur, indi hazırıq. Metodun hansı düsturla qurulduğunu bilirik. Onun "işləməsini" təmin edən yeddi mexanizmi bilirik. İndi bütün bunlardan bir sənaye quranlara baxmaq qalır.

Postsovet məkanına yad adamları otaqda düzüb onlara "baba" deməyi öyrədən adamdan başlayaq.

Fəsil 19. Yeni şamanlar: Bert Hellinger və ailə düzülüşləri

Adi bir axşam Moskvanın mənəvi inkişaf mərkəzlərindən birinin kiçik zalında təxminən qırx nəfər toplaşır. Əksəriyyət otuzəlli yaş arası qadınlardır. Bir günlük stulun qiyməti qırx beş min rubldur. Aparıcı — sərbəst geyimli, diqqətli və yumşaq baxışlı kişi ya qadın. Zalın mərkəzində boşluq var — indi oranı canlı insanlar dolduracaq.

Anna mərkəzə çıxır. Onu hərfi mənada əsir. Narahatlıq pozuntusu gicgahlarında döyünür, əri ilə həll olunmaz problemlər sinəsinə daş kimi oturub. Aparıcı düz ona baxır. Səsi sükutu yarır: “Qrupdan bu gün ananızı təmsil edəcək birini seçin. Atanızı. Ərinizi. Ölmüş bacınızı. Özünüzü”. Tapmaca atılıb. Anna titrək barmağı ilə digər iştirakçıları göstərir. Onlar itaətkarcasına irəli çıxırlar. Aparıcı canlı fiqurları məkanda düzməyə başlayır, sanki bir kod qurur: biri — kar divara üzü, digəri — Annaya arxası, üçüncüsü — diz üstə. Gizli mexanizmin sxemi açıq-aşkar ortadadır. Və sonra əsas cümlə səslənir — nəfəsi kəsən cümlə: “Qoy sahə danışsın”.

Mərkəzdəki insanlar hərəkətə gəlir. Cümlə qırıqları. Hıçqırıqlar. Kimsə ağlayır. Kimsə diz üstə çökür. “Mən qəzəb hiss edirəm”, — ananı təmsil edən qadın güclə deyir. Boynundakı damarlar qabarmış, yumruqları sıxılmış. “Nəfəs ala bilmirəm”, — digəri xırıldayır. Ölmüş bacını oynayan. O, boğulan kimi havanı udur. “Sənə baxmağa qorxuram”, — “ər” deyir. Aparıcı bir saniyə belə itirmir. Şərh edir. Yozur. Yenidən və yenidən bir nöqtəyə vurur, gizli mexanizmi açır. Nəsil sistemi

onu rədd edir. Ölmüş bacı sistemdə öz yerini almayıb. Və həll ritualdadır. Ona baş əymək lazımdır, bağışlanma diləyərək.

Bir-bir saat yarım sonra Anna ağlayır. Aparıcı dizilişi Hellingerin dilində təxminən belə səslənən bir cümlə ilə tamamlayır: "Səni qəbul edirəm. Sən mənim nəsilimin bir hissəsən. İndi öz yerinə qayıda bilərsən. Mən öz yerimdə qalıram". Qrup alqışlayır. Anna küçəyə çıxır — içində vacib bir şey yaşadığı hissi ilə. Nə olduğunu bilmir, amma böyük bir şey.

İki ay sonra onun narahatlıq pozuntusu yerindədir. Əri ilə münasibətləri də eyni gərginlikdədir. Amma o, artıq növbəti həftəsonu təliminə yazılıb.

Sən otaqda oturmusan. Qarşında — yad kişi. O, sənin içindən baxır və pıçıltı ilə deyir: "Babanın yerinə keç". Sən qalxırsan. Və on saniyə sonra ağlamağa başlayırsan — halbuki onu heç vaxt görməmisən. Bu, Bert Hellinger üzrə ailə dizilişləridir. Bugün rusdilli məkanda kütləvi sənayeyə çevrilmiş metod. Rəqəmlər. İri sahə portallarından biri bildirir ki, Rusiyada, Ukraynada, Belarusda və Qazaxıstanda təxminən min sertifikatlı "dizilişçi" var. Yalnız rəsmi qeydiyyatdan keçənlər. Bəs qeydiyyatsızlar nə qədərdir? Bir neçə dəfə çox. Təcrübə edənlərin ümumi sayı rəsmi siyahıdan xeyli artıqdır. Moskva. Sankt-Peterburq. Yekaterinburq. Bakı. Almatı. Hər il minlərlə təlim keçirilir. Bazar ildə milyardlarla rublla qiymətləndirilir. Və bu hələ başlanğıcdır.

Onu yaradanlar sözün əsl mənasında fırıldaqçı deyillər. Onların çoxu etdikləri işə inanır. Bahalı təlim proqramlarını keçiblər. Kitablar oxuyurlar. Konfranslarda çıxış edirlər. Özlərini kömək edən mütəxəssislər hesab edirlər.

Bütün bu sənaye isə bir nəfərin tərcümeyi-halından boy atıb. Elə bir adamın ki, həyatı və baxışları ayrıca araşdırılmağa layiqdir.

Anton Hellinger. Doğulanda ona bu ad verilib. 1925-ci il. Almaniyanın cənub-qərbindəki Laymen şəhəri. Dərindən

katolik ailə. Anton — Padualı Müqəddəs Antoninin şərəfinə. İman onun gizli qalxanına çevrilib. Sonralar o, belə iddia edəcək: məhz katolik tərbiyəsi onu nasional-sosializmin taunundan qoruyub. Bəs gənc ruhlara ideologiya təzyiq edəndə necə tab gətirməli? O, Hitler Yungendinə qoşulmaqdan boyun qaçırır. Həyatını təhlükəyə atır — qanunsuz katolik yığıncaqlarına gedir. Və hədəfə düşür. Gestapo onu izləməyə başlayır. 1942-ci il. On yeddi yaş. Vermaxta çağırış. Gənci Qərb cəbhəsinə, ətin dəyirmanına atırlar. O, sağ qalır. Amma 1945-ci ildə, iyirmi yaşında — əsirlik. Belçika. Hərbi əsirlər düşərgəsi, tikanlı məftil, ümidsizlik. Lakin Hellinger təslim olmur. Qaçır. İşğal altındakı Avropanı yarıb keçir və Almaniyaya qayıdır.

Müharibədən sonra Anton katolik ordeninə qoşulur. Ruhanilik rütbəsi alır. On altı ilini Cənubi Afrikada keçirir. Ucqar yerlər. Kvazulu-Natal vilayətinin kənd rayonları. Zulu xalqı. Onu yarım ömür orada qalmağa nə vadar etdi? Cavab qanda və torpaqda gizlənirdi. Hellinger sonralar iddia edirdi: onu heyrətə gətirən o idi ki, ənənəvi Afrika cəmiyyətlərində nəsil bağları necə döyünür. Əcdadlara ehtiram necə nəfəs alır. Soy iyerarxiyası necə sarsılmazdır. Bunlar sadəcə adət-ənənə deyil. Bu, elə bir sistemdir ki, orada ölülər diriləri boğazlarından tutub yana addım atmağa qoymur. Məhz bu mövzular — nəsillərin görünməz zəncirləri — onun metodunun əsasını qoydu. İfşa yaxınlaşırdı.

1970-ci illərdə Hellinger Avropaya qayıtdı, ordendən ayrıldı və evləndi. Anton adını Bertlə dəyişdi — bu, uşaqlıq ləqəbi idi. Psixoterapiyanı öyrənməyə başladı, qrup dinamikası, geştalt terapiyası, transaksional analiz və ailə terapiyası üzrə təlimlər keçdi. Xüsusilə Virciniya Satir və İvan Byosörmenyi-Nad onun üzərində güclü təsir bağışladı — hər ikisi XX əsrin ortalarının görkəmli ailə terapevtləri idi. Macar-amerikalı psixiatr Byosörmenyi-Nad “nəsillərarası hesablar” və “kontekstual terapiya” konsepsiyasını işləyib hazırlamışdı; burada nəsildənnəslə keçən ailə borcları və sadiqliklərin əhəmiyyəti

vurğulanırdı. Bu, həqiqətən də ailə terapiyasının mühüm və böyük ölçüdə elmi əsaslara söykənən bir sahəsidir.

1990-cı illərin əvvəllərində Hellinger öz metodunu hazırladı. Almaniyada seminarlar keçirməyə başladı. Metod Familienstellen — "ailə düzümü" adını aldı. Tez bir zamanda məşhurlaşdı. 1990-cı illərin sonunda Hellinger bütün dünyada təlimlərlə səfər edirdi. 2000-ci illərin əvvəllərində Rusiyada, Braziliyada, Meksikada, Cənubi Afrikada kütləvi tədbirlər keçirilməyə başlandı. Kitabları onlarla dilə tərcümə olundu. O, kult fiquruna çevrildi.

Ailə düzümü texniki olaraq nədir?

Hellingerin klassik variantında qrup iştirakçısı mərkəzə çıxır və digər iştirakçılardan onun ailə üzvlərini "təmsil etmələrini" xahiş edir. Düzümçü onları məkanda intuisiyaya və ya müştərinin göstərişinə əsasən yerləşdirir. Sonra, iddia olunur ki, "sahə" təmsilçilər vasitəsilə özü "danışmağa" başlayır: onlar duyğular hiss edir, cümlələr deyir, hərəkət edirlər — aktyor kimi rol oynayan şəxslər kimi deyil, guya müştərinin real nəsil sistemindən məlumat ötürən keçiricilər kimi.

Hellinger iddia edirdi: ailələr görünməz "sevgi nizamları" — Ordnungen der Liebe ilə bir-birinə bağlıdır. Bəs bu kövrək çərçivə çatlasa nə olar? Nəsildən kimisə kölgəyə itələyiblərsə? Unudublar. Yasını tutmayıblar. Yerindən məhrum ediblər, yaddaşdan siliblər ya da çox erkən uzaqlaşdırıblar. Hellinger cavabı bilirdi: pozuntu heç yerə yox olmur. Vaxtın içindən keçib növbəti nəsillərə soxulur. Simptomlar. Xəstəliklər. Uğursuzluqlar. Döşü tam açıb nəfəs ala bilməmək və xoşbəxt ola bilməmək. Nəsil lənəti? Xeyr, — deyir Hellinger. Sistemin sıradan çıxması. Düzümün vəzifəsi bu ölü düyünü açmaqdır. Nizamı bərpa etmək. Kənarlaşdırılmışı tapmaq. Ona baş əymək. Tanımaq. Öz yerinə qaytarmaq. Və o zaman, Hellingerə görə, ailə sirri açılacaq: "sevgi enerjisi" yenidən düzgün axacaq və müştəridə şəfa baş verəcək.

Kağız üzərində bu gözəl səslənir. Hətta təsirli. Əcdadlarımızla bağlı olduğumuz, ailənin unudulmuş faciələrinin həyatımıza təsir etdiyi fikri — bu fikrin bəşər mədəniyyətində dərin kökləri var. Qədim xalqlar bunu bilirdilər. Əcdadları anma mərasimləri demək olar ki, bütün ənənəvi cəmiyyətlərin ayrılmaz hissəsidir.

Lakin ailə düzümünə əsas sual "bu gözəl fikirdirmi?" deyil. Əsas sual "bu işləyirmi? Dəlillər varmı?" sualıdır.

Bu sualın cavabı sadə və birmənalıdır.

Ailə düzümü. Bir dənə də randomizə edilmiş nəzarətli tədqiqat yoxdur. Bir dənə də. Bütün elmi tibbi ədəbiyyat — quraq bir səhradır: metodun hər hansı konkret pozuntu zamanı plasebodan daha yaxşı işlədiyini göstərən böyük resenziyalı jurnalda bir dənə də nəşr yoxdur. Sıfır. Bəs niyə minlərlə insan hələ də kor-koranə ona can atır? Alternativ cəbhəyə nəzər salaq — bir neçə diplom işi və kiçik tədqiqat. Görünür, budur sübut işığı? Xeyr. Bu araşdırmaları kim aparır? Metodun tərəfdarları özləri. Harada dərc edirlər? Ailə düzümü üzrə ixtisaslaşmış jurnallarda. Qapalı dairə. Və onlardan elmi görkəm maskasını çıxaranda şok edici həqiqət üzə çıxır: bu tədqiqatların metodologiyası əksər hallarda sübuta əsaslanan tibbin əsas meyarlarına görə tənqidə tab gətirmir. İfşa effekti — terminlərin nazik qatı altında tam bir boşluq uçurum kimi açılır.

Alman Sistem Düzənləmələri Cəmiyyəti (Deutsche Gesellschaft für Systemische Aufstellungen) — Almaniyada fəaliyyət göstərən peşəkar təşkilat — hələ 2000-ci illərin əvvəllərində Hellingerdən açıq şəkildə məsafə saxladığını bəyan etmişdi. 2004-cü ildə iki yüzə yaxın sertifikatlaşdırılmış düzənləmə mütəxəssisi bir deklarasiya imzalayaraq Hellingerdən uzaqlaşdıqlarını bildirdi və onun sistem terapiyasının əsas prinsiplərindən sapdığını iddia etdi.

Hellingerin əsas konsepsiyası — guya real ailədən gələn məlumatı nümayəndələr vasitəsilə ötürən "bilən sahə" (wis-

sendes Feld) — nə fizikada, nə biologiyada, nə də psixologiyada təsdiqini tapmır. Zalın ortasında dayanan tanımadığı insanların həyatında ilk dəfə gördükləri bir adamın ailəsi haqqında məlumatı necə "qavradığını" izah edən heç bir fiziki mexanizm yoxdur.

Bəs düzənləmələrdə əslində nə baş verir? Elmi cavab sadəliyi ilə amansızdır: təlqin, rol oyunu, emosional ekspressiya. İştirakçı mərkəzə çıxır. Bədəni gərgindir, nəbzi sürətlənib. O, artıq hipnoza bənzər vəziyyətə düşüb — vəhy gözləntisinin iflic edən gücü altındadır. Və bu trans halında "nümayəndələri" heç də təsadüfən seçmir. Gizli assosiasiyalar, xarici oxşarlıq. Beyin hiss etdirmədən obrazları oxuyur və proyeksiya edir. Bəs bu tamaşanı kim idarə edir? "Nümayəndələr" işarələr alır. Aparıcıdan gələn gizli, demək olar ki, tutulmaz siqnallar. Müştərinin özündən gələn çətin sezilən jestlər. Və budur, onlar artıq oynayırlar — qızğın, həyəcanlı, emosional rolları son damlasına qədər sıxıb çıxararaq. Bəzən bu ekstaz müştəriyə nəyisə yaşamağa kömək edir — teatrda katarsis və ya art-terapiya kimi. Bəzən isə yox. Burada fövqəltəbii heç nə baş vermir. Heç bir mistik sahə yoxdur. Düzənləmələrin təsirinin adi terapevtik plasebodan güclü olduğuna dair bir dənə də sübut yoxdur. İllüziya ifşa olunub.

İndi isə daha narahat edici məsələyə keçək.

2000-ci illərin əvvəllərində Hellinger bir sıra açıq bəyanatlar verdi ki, bunlar hətta öz şagirdlərinin çoxunu da şoka saldı.

Qurbanlar və zorakılar haqqında. Hellinger metodik və amansız şəkildə israr edirdi. Zorlama və ya inseks qurbanı zorakıya "baş əyməlidir". Onu öz nəsil sisteminin bir hissəsi kimi qəbul etməlidir. Bağışlamalıdır. Özünə "bərabər" tanımalıdır. Hellingerə görə, bu cür "qəbuldan" imtina şəfanı ölüməcən bloklayır. Bəs necə? Sənin iradəni tapdalayan və ən dəhşətli kabusunu gerçəkləşdirən adamı necə özünə bərabər tanıyasan? Bu, müasir psixotravmatologiya ədəbiyyatının dediklərinə birbaşa ziddir. Sübuta əsaslanan travma terapiya-

sında — istər EMDR olsun, istər uzunmüddətli təsir terapiyası, istərsə də koqnitiv-prosessual terapiya — dəmir kimi birinci qayda budur: qurbanı zorakını bağışlamağa məcbur etməmək. Bağışlama, əgər ümumiyyətlə gəlirsə, həmişə gec gələn və dərin fərdi bir prosesdir. Onu zorla qəbul etdirmək şəfa deyil. Bu, təkrar viktimləşdirmədir. Artıq açıq olan yaraya bir zərbə də vurmaqdır.

Hitler. Norveç, 2007-ci il. Hellinger səhnəyə çıxır — və elə söz deyir ki, tənqidçilər dərhal onu apologiya adlandırırlar. O, Hitler haqqında şeir oxuyub. Öz şeirlərini. Onlarda akademik dissertasiyalarda qeydə alınmış bir misra var: Hitler "hər hansı bir insandan nə yaxşı, nə də pis idi". Yaxşı deyil. Pis deyil. Sadəcə — hamı kimi. Sonrası daha da betər. Hellinger "Hitleri qəbul etmək" zərurətindən danışır. Mühakimə etmək yox. Lənətləmək yox. Qəbul etmək. Alman "nəsil sistemi"nin bir hissəsi kimi. Və dərhal elə bir müqayisə gəlir ki, qan donur: necə ki, qurban təcavüzkarı qəbul etməlidir. Bir cümlə. Bir obraz. Və bütöv bir uçurum sual. Bu sözlərin arxasında nə dayanır — barışıq fəlsəfəsi, yoxsa şərin bəraəti? Qəbul etməklə bağışlama arasındakı sərhəd haradadır? Və bu xətti çəkmək hüququnu kim verir?

Homoseksuallıq haqqında. Bir sıra ictimai çıxışlarında Hellinger iddia edirdi ki, homoseksuallıq "sistem pozuntusu"dur və adətən insanın ailədə unudulmuş ölmüş bir qohumunun yerini tutması ilə bağlıdır. Müasir elmi psixiatriya homoseksuallığı pozuntu kimi deyil, normanın bir variantı kimi təsnif edir (diaqnoz hələ 1973-cü ildə DSM-dən, 1992-ci ildə isə ICD-10-dan çıxarılıb). Homoseksuallığın düzülmə ilə "sağaldığı" təsəvvürü konversiya terapiyasının bir növüdür ki, əksər inkişaf etmiş ölkələrdə zərərli psevdomedisina kimi qadağan olunur və ya pislənir.

İnsest haqqında. Bir sıra əsərlərində Hellinger iddia edirdi ki, insest bəzən ailədə "sistem funksiyası" yerinə yetirir — məsələn, "nizamı" qorumağa xidmət edir və ya çatışmayan

kişinin "kompensasiyası"dır. Bu, yumşaq desək, şübhəli bir şərhdir. Sərt desək — uşaqlara qarşı cinsi zorakılığı sistemin "zərurəti" ilə potensial olaraq bəraətləndirən təhlükəli bir fikirdir.

Qadınlar haqqında. Hellinger sistematik olaraq iddia edirdi ki, "düzgün" qurulmuş ailədə qadın kişini izləyir; onun yeri kişidən "aşağı"dır; bu "nizamın" pozulması ailə bədbəxtliyinə gətirib çıxarır. Bu — psixoterapiya deyil, patriarxal ideologiyadır.

Açıq demək lazımdır: ailə düzülmələrini tətbiq edənlərin hamısı bu baxışları bölüşmür. Çoxları, xüsusən Rusiyada və Qərbdə, metodun daha yumşaq və dəyişdirilmiş versiyaları ilə işləyir. Çoxları Hellingerin açıq-aşkar mizogin və ya homofob ifadələrini təkrarlamır. Çoxları deyir: "Biz texnikadan istifadə edirik, ideologiyadan yox".

Amma burada mühüm bir sual ortaya çıxır. Əgər texnika müəllifin ideologiyasından ayrıla bilirsə, onda mahiyyət etibarilə onun içində texniki nüvə nə qalır? Fiqurların məkanda düzülməsi və onların "cavablarının" oxunması? Lakin bu üsul klassik ailə psixoterapiyasında (Virciniya Satir, Minuxinin struktur ailə terapiyası) mistik üstqurum olmadan istifadə olunur. Bu sübuta əsaslanan metodlar "bilən sahə"yə və ya "sevgi nizamları"na inam tələb etmir. Onlar tanınmış psixoloji mexanizmlər vasitəsilə işləyir: vizuallaşdırma, rol oyunu, kommunikativ təlim, sistemli yenidən düşünmə.

Hellingerin tələbələri "texnikanı" onun "ideologiyası" olmadan qoruduqlarını deyəndə, əslində metodun mistik əsasını saxlayır, ictimaiyyətcə qəbuledilməz ifadələrini isə atırlar. Lakin məhz bu mistik özəyi psixoterapiyanı yalançı elmə çevirir. Onu çıxardıqda isə sadəcə rollar oyunu qalır ki, bunu da həftəsonu üçün 45 min rubla satmağa ehtiyac yoxdur.

Müasir elmi ədəbiyyatda ailə yerləşdirmə metodunun peşəkarlar tərəfindən qiymətləndirilməsi bir neçə əsas tezislə xülasələnir.

Birincisi: Metod psixoterapiyanın əsas meyarlarına uyğun gəlmir: strukturlaşdırılmş diaqnostika prosesi yoxdur, dəqiq müqavilə, superviziya, məxfilik standartları (yerləşdirmələr ictimai şəkildə, qrupda, yad insanlar qarşısında həyata keçirilir), effektiv olmadıqda alternativ üsullar, razılıq mexanizmi mövcud deyil.

İkincisi: Metod ağır psixi pozuntusu olan şəxslər üçün təhlükəlidir. Şizofreniya, bipolyar pozuntu, ağır depressiya və PTSR olan iştirakçılar heç bir psixiatrik dəstək olmadan güclü emosional stimulyasiya alırlar. Yerləşdirmələrdən sonra kəskin dekompensasiya halları, o cümlədən psixotik epizodlar və nadir hallarda intihar cəhdləri qeydə alınıb.

Üçüncüsü: Metod psixoterapiyanın əsas etik kodeksini pozur. Yerləşdirici özünə kvaziterapevt maskası geyinir, həqiqi psixoterapevt ixtisası olmadan. Nə edir? Müştərinin ən gizli ailə sirlərini üzə çıxardır. Və kimin qarşısında? Qrupdakı yad insanların. Xarici gözlər çılpaq yaralara baxır. Amma bununla da bitmir. O, hökm çıxarır. Birbaşa tapşırıqlar verir: “Anana səcdə et!”, “Atandan keç!”, “Əvvəlki yoldaşından vaz keç!” Bu sərt hökmlər nəyə əsaslanır? Yalnız subyektiv “sahə görməsinə”. Bu üsulların heç biri dəlillərə əsaslanan psixoterapiya çərçivəsində işləmək şansına malik deyil.

Dördüncüsü: Metodun kommersiya uğuru qazanmasının səbəbi məhz işləməməsidir. Paradoks? Xeyr, soyuq bazar məntiqi. Təsəvvür edin: yerləşdirmə problemi bir dəfəyə həll etsəydi, müştəri həmişəlik gedərdi. Gizlinə çəkilib yox olardı. Amma həll etmir və müştəri geri qayıdır. Yenidən və yenidən. Niyə? “Görünür, nəslimiz üzərində daha çox işləmək lazımdır” — deyir daxili səs. “Görünür, unudulmuş əcdadlar var”. “Görünür, digər nümayəndələrlə yerləşdirmə aparmaq lazımdır”. Hər ifadə — yeni qarmaq. Hər şübhə — yeni dövr. İştirak çoxil-

lik yerləşdirici asılılığına çevrilir. Asılılıq isə onun sabit və tükənməz gəlir mənbəyinə çevrilir.

Və nəhayət, ən ağrılı olanı — psixiatrik pasiyentlər üçün nəticələri.

Onlar təcrübəmə dəfələrlə gəlirlər. İllərlə yerləşdirmələrə getmiş insanlar. Otuz beş yaşlı qadın. Bipolyar pozuntunun ilk əlamətləri. O, üç il ardıcıl treyniqlərə qatılıb. Üç il onun "nəsli üzərində işləyiblər". Üç il ona deyiblər: "Əcdadlarını qəbul etməlisən. Ananı bağışlamaq lazımdır. Sistemdə öz yerini tutmalısan". Bəs əgər simptomlar qanın çağırışı deyilsə? Hipomaniyaların maniyaya çevrilmə riski. Depressiv epizodlar. Yuxu pozuntuları. Bütün bunlar amansızlıqla "nəsli mesajlar" kimi şərh edilib. Üç il ərzində onun həqiqi xəstəliyi mistika pərdəsinə bürünüb. Nəhayət psixiatrik kabinetin astanasını keçəndə artıq tam inkişaf etmiş manik epizod idi. Tənqidi idrakın olmaması. İş üçün real risk. Ailəsi üçün real təhdid. O, həyatında ilk dəfə diaqnoz eşitdi.

Onun 35 yaşı var. Üç il əvvəl ona litium və ya başqa normotimik təyin edilib, vəziyyətini sabitləşdirib normal həyat sürməsini və işləməsini təmin etmək olardı. Əvəzində bütün bu müddət ona "nəsili proqramlar"dan danışıblar. O, mənim kabinetimdən resept və üç illik həyatının oğurlanmış kimi hiss etməsi ilə çıxdı.

Bert Hellinger 2019-cu ildə, 93 yaşında vəfat edib. Onun kommersiya imperiyası fəaliyyətini davam etdirir. Metodu satılmaqdadır — xüsusilə də rusdilli məkanlarda, psixoloji xidmətlərin zəif tənzimlənməsi bu bazarı xüsusilə gəlirli edir.

Hər dəfə "Hellinger metodu ilə nəsili çəkişmələr — bir həftəsonunda nəsili proqramınızı dəyişdirin!" kimi təlim reklamını gördükdə həmin xəstə xatırıma düşür. Onun itirilmiş üç ili. Hələ mənə çatmayan digər xəstələr. Və heç vaxt çatmayacaq olanlar...

Bu fəsili heç bir konkret "nəsili çəkişmə" praktikini təhqir etmək üçün yazmıram. Onların əksəriyyəti — öz işinə səmimi inanan, bahalı təlimlər keçmiş və özlərini köməkçi mütəxəssis hesab edən insanlardır. Bu sətri xəstələr və onların ailələri üçün yazıram. Psixoloji problemləri, narahatlığı, depressiyası və ya ailə çətinlikləri olanların "hara müraciət etməli?" sualı qarşısında durduqları üçün.

Əgər bu sətirləri oxuyursunuzsa — dayanın. "Nəsili çəkişmə"çiyə getməyin. Bu tələdir. Klinik psixoloqa gedin. Hazırlığı sübuta əsaslanan sənədlərlə təsdiqlənən mütəxəssisə. Koqnitiv-davranış, sistem-ailə, psixodinamik və ya digər elmi əsaslı üsullarla işləyən psixoterapevta müraciət edin. Daxil olacağınız kabinetin sahibinə etibarınız yoxdur? Yoxlayın. Dövlət nümunəli diplomunu, peşə assosiasiyasında üzvlüyünü, nəşrlərinin siyahısını tələb edin. Həqiqi mütəxəssis sakitcə sənədləri uzadacaq. İtirazsız. Hiyləsiz. Saxta mütəxəssis isə incizəcək. Üzü seyrişəcək. Və dərhal söhbəti yönləndirmə yolunu tapacaq. Əsas mövzudan uzaqlaşdıracaq. Bu kölgədən uzaq durun.

"Nəsili çəkişmələr" nəsili proqramınızı sağaltmayacaq. Onlar mövcud deyil. Sizin psixikanız, bədəniniz, aileniz, bu günkü ətrafınız var. Onlarla — real işləmək olar. "Nəsili proqram"la — olmaz. Çünki "nəsili proqram" mövcud deyil.

> QIRMIZI BAYRAQ. *Əgər mütəxəssis bu günkü simptomlarınızı əcdadlarınızın həyatındakı hadisələr — "nəsili travma", "sistemik dolaşıqlıqlar", "nəsildə bağışlanmayan" ilə izah edirsə — qarşınızda terapiya deyil. Vəziyyətinizin səbəbləri ölmüş insanların tərcümeyi-halında yoxdur. Çıxın oradan.*

Fəsil 20. ThetaHealing: Vianna Stibalın vəhyi

1995-ci il. ABŞ-ın Aydaho ştatındakı balaca Aydaho-Folls şəhərciyi. Qırx yaşlı Vianna Stival həkim kabinetinin qapısından keçdi. Ağrı — inadcıl, dartıcı, düz sağ budunda yuva salmış — bədənə sancıldı, əl çəkmədi. Vurdursun, ya vurdurmasın? İynə ətin içinə girdi. Biopsiya aparıldı. İllər ötdü. Və sonra məhkəmə təhqiqatçıları Viannanın tibbi kartlarını eşələyərkən təkcə bir sözlə üzləşdilər. Açar. Hər şeyi dəyişən. "Şübhə". Biopsiyanın nəticələri bədxassəli prosesə işarə edirdi, amma qeyri-dəqiq qalırdı. Diaqnostik deyildi. Şəkildəki kölgə. Xəstəliyin xəyalı. Dünyada heç bir həkim Vianna Stivala təsdiqlənmiş xərçəng diaqnozu qoymadı. Heç kim kimyaterapiya təyin etmədi. Heç kim ayağın amputasiyasını təklif etmədi.

Bunu 2016-cı ildə Aydaho ştatının Ali Məhkəməsi müstəqil ekspert doktor Kristian Şallın ekspertizası, keçmiş ərinin and içərək verdiyi ifadəsi və işə əlavə edilmiş tibbi sənədlərin təhlili əsasında müəyyən edəcəkdi.

Amma 1995-ci ildə, Vianna Stibalın danışdığına görə, ona "bud sümüyü xərçəngi" diaqnozu qoyulmuşdu. Guya ona demişdilər ki, kimyaterapiya və ya amputasiya olmadan öləcək. Stibal — tibbi təhsili olmayan naturopat — standart müalicədən imtina etdi və əvəzində dua və meditasiya ilə məşğul olmağa başladı. Onun iddiasına görə, bir neçə dəqiqə ərzində sağaldı — "doqquz düym" (təqribən iyirmi üç santimetr) ölçüsündə şiş, "beynin dalğa aktivliyi teta diapazonuna keçdikdən" və o, "Hər Şeyin Mövcud Olan Yaradanı ilə birbaşa əlaqə qurduqdan" sonra dərhal yox oldu.

Bu hekayədən ThetaHealing adlı dünya miqyaslı sənaye başladı. Yaxud, rəsmi desək, ThetaHealing® — 2006-cı ildə ABŞ-da qeydiyyatdan keçmiş ticarət markası.

"Təlimin meditasiya texnikası" sözlərinin arxasında gizlənən budur. "Ağıl, bədən və ruh" üçün "mənəvi fəlsəfənin" arxasında. Vianna Stibalın rəsmi saytındakı gözəl lövhənin arxasında. Teta dalğaları. Dərin rahatlama vəziyyəti. Stibalın iddiasına görə, praktikant beynini məhz ora qərq etməlidir. Və onda — budur, vəhy — "Yaradanla birbaşa qoşulma" mümkün olur. Sonrası daha da irəli gedir. Bu vəziyyətdə, deyir o, müştərinin DNT səviyyəsində inancları bir anda dəyişdirmək olar. "Məhdudlaşdırıcı qurğuları" silmək. Fiziki xəstəlikləri müalicə etmək. "Nəsil proqramlarını" təmizləmək. Amma bu da hamısı deyil. Onun Britaniyadakı mühazirələrindən birində elə bir bəyanat səsləndi ki, zal yəqin ki, donub qaldı. Amputasiya olunmuş ətraf üzvlərini yenidən bitirmək. Çıxarılmış yumurtalıqları bərpa etmək. Metafora deyil. Təşbeh deyil. Hərfi mənada. Bax belə: rahatladın, teta dalğalarına girdin, Yaradana qoşuldun — və əl yerindədir. Yumurtalıq yenidən işləyir. İnanclar birbaşa DNT spiralının içində yenidən yazılır. Vianna Stibal buna meditasiya deyir.

Teta dalğaları. 4-8 Hz tezliyi. Elektroensefaloqraf ilə qeydə alınır — bu faktdır. Yuxuda. Dərin meditasiya zamanı. Güclü emosional həyəcan zamanı. Hamısı təsdiqlənib. Hamısı ölçülə bilər. Amma Stibal bununla kifayətlənmir. O iddia edir ki, teta ritmi vasitəsilə insan "Hər Şeyin Yaradıcısı" ilə birbaşa əlaqə qurur. Və bu əlaqə müştərinin DNT-sini yenidən yazır. Dayan. DNT? Genetika dəqiq bir elmdir. Neyronauka da elə. Onların heç biri teta ritminin genetik kodu necə dəyişə biləcəyinə dair heç bir mexanizm bilmir. Heç bir təcrübə yoxdur. Heç bir nəşr yoxdur. Heç bir məlumat sətiri yoxdur. Həqiqi ritm. Həqiqi 4–8 Hz. Həqiqi yuxu. Həqiqi meditasiya. Nəticə isə boşluqdur. Mif üzərində elmi görünüşlü qabıq. Və müştəri inanır: rəqəmlər həqiqətən də doğrudur.

“Teta dalğaları” kvan mexanikasına (müasir yalançı elmin ümumi hiyləsi), cazibə qanununa, epigenetikaya istinadlarla tamamlanır. Bütün bu sözlər təsir edici səslənir. Onların hamısı elmi kontekstdən qoparılıb heç bir əlaqəsi olmayan ifadələrə tətbiq edilir.

Stibalın İmperiyası kiçik deyil. Bunu xatırlayın. ThetaHealing Institute of Knowledge. Qısaca — THInK. Aydaho-Follda qeydiyyatdan keçib. Yalnız bir qanuni ünvan — əlavə olaraq bütün dünya. Kurslar. Sertifikatlı “teta müalicəçiləri”. Onlarla ölkə: Rusiya, Ukrayna, Qazaxıstan, Azərbaycan. Siyahı uzundur. İndi isə hər şey necə qurulub. Əsas kurs. Təcrübə etmək istəyirsən — ödə. Başqalarına öyrətmək istəyirsən — daha çox ödə. İrəliləmiş səviyyə. Yuxarı səviyyələrdə dərs demək istəyirsən — daha bahalı ödə. Ppiramida. Və onun zirvəsində — tək bir qadın. Stibalın özü. O, müntəzəm olaraq “Yaradıcıdan yeni məlumat alır” və seminarlar vasitəsilə bu məlumata girişi satır. Hər yeni səviyyə, hər yeni təlim, hər yeni “yuxarıdan məlumat” — qiymət etiketi ilə. Sual sadədir. Həqiqətən vəhyə kim pul ödəyir — Yaradıcı yoxsa şagirdlər?

2008-ci ildə Stibal onun üçün facievari olan addım atdı. Onun institutu ThetaHealing-də “doktorluq dərəcəsi” təklif etməyə başladı. Bu dərəcə “PhD”, “Ministry Doctorate” və ya sadəcə “Doctorate” kimi təqdim olunurdu. Tələbələr bu diplomu almaq üçün lazım olan əlavə kurslar üçün əhəmiyyətli məbləğlər ödəyirdilər.

Kara Aleksandr. Gənc amerikalı qadın. Sadə bir insan deyil. Təsadüfi bir qurban deyil. O, “doktorluq” üçün real pul ödədi. Arxasında iki ixtisas üzrə bakalavr dərəcəsi var: incəsənət və biologiya. Tibbi illustrator. Bundan əlavə, qismən bitirilmiş neyronauka üzrə magistr dərəcəsi. Və sonra o, Nyu-Yorku tərk etdi. Aydaho-Follsa köçdü. Nə üçün? Bir insan üçün. Stibal üçün. Və inandı. Səmimi olaraq. Xərçəngdən şəfa tapmaq hekayəsinə.

2008-ci ilin payızında Aleksandr və digər tələbələr "doktorluq dərəcəsi"nin qanuniliyi ilə bağlı suallar verməyə başladılar. Məlum oldu ki, ThetaHealing doktorluğu heç bir dövlət təhsil müəssisələri reyestrində mövcud deyil. Aleksandrın aldığı diplomun sadəcə divarda asılı bir lövhə olduğu ortaya çıxdı.

Aleksandr məhkəməyə müraciət etdi. Onun iddiasında üç əsas məqam var idi: saxtakarlıq, müqavilənin pozulması və cəzalandırıcı ziyan təzminatı (punitive damages) tələbi.

2013–2015-ci illərdə Aydaho ştatının məhkəmələrində "Alexander v. Stibal" işi dinlənildi. Söz-sözə, səhifə-səhifəyə. Hakimin masasına Stibalın öz tibbi qeydləri — xüsusilə də 1995-ci ildəki "bud sümüyü xərçəngi" ilə bağlı olan qeydlər qoyuldu. Və sonra heç kimin gözləmədiyi bir şey baş verdi. Doktor Kristian Şallın ekspert rəyi qəti bir hökm kimi səsləndi: bu qeydlərdəki biopsiya nəticələri yalnız zəhərli prosesin şübhəsini göstərir. Şübhə. Diaqnoz deyil. Heç vaxt — diaqnoz deyil. Heç bir həkim. Heç bir sənəddə. Stibalın bütün xəstəlik tarixi boyunca heç bir dəfə xərçəng diaqnozu təsdiqlənməyib. İndi isə ən dəhşətli hissə — amputasiya və ya kimyaterapiya tövsiyəsi. Məhz bu tövsiyə, o insanların müxtəlif tribunalarda, minlərlə çıxışında danışdığı tövsiyə. Ancaq bu tövsiyə heç bir tibbi sənəddə mövcud deyil. Heç bir imza. Heç bir cümlə. Boşluq.

Stibalın keçmiş həyat yoldaşı da and içərək ifadə verdi: 1995-ci ildə onun arvadına "heç vaxt açıq şəkildə xərçəng olduğu söylənmədiyini" təsdiqlədi.

Aleksandr iddiasının əsas hissəsini qazandı. Əlavələr ona müqavilə iddiası üzrə yüz on bir min dollar, saxtakarlıq iddiası üzrə on yeddi min dollar və beş yüz min dollar cəzalandırıcı ziyan təzminatı məbləğində kompensasiya təyin etdi. Sonuncu məbləğ daha sonra Aydaho qanunvericiliyinə uyğun olaraq dairə məhkəməsi tərəfindən üç yüz səksən dörd min dollara endirildi.

2016-cı il. Aydaho ştatının Ali Məhkəməsi. Hər kəsin istifadəsinə açıq olan sənədlər və qovluqlar — "Alexander v. Stibal", 160 Idaho 10, 368 P.3d 630 işi. Quru sətirlərin arxasında yalanın hökmü gizlənir. Məhkəmə aşağı instansiyanın müqavilə iddiası üzrə qərarını qismən ləğv edir. Ancaq saxtakarlıq və cəzalandırıcı ziyan təzminatı baxımından — çəkicin zərbəsi. Dəmir dəstək. İnandırıcı hissəni açırıq. Stibalın nə iddiası var idi? O, özünü ThetaHealing vasitəsilə xərçəngdən sağaldığını iddia edirdi. Pausa. Xərçəng. Sağalma. Ancaq məhkəmə maşını sözə inanmır. Fikrin gücü ilə xərçəngi məğlub etdiyini iddia edən şəxs özü həqiqət tələsinə düşdü. Məhkəmə açıq şəkildə qeyd edir ki, bu qəsdən edilmiş yalan ifadədir. Fraudulent misrepresentation. Sübut edilibmi? Bəli. Necə? Aydın və inandırıcı sübutlarla. Heç bir yarımtar. Mask düşdü.

Məhkəmə daha sonra qeyd etdi ki, Stibal öz xərçəngdən sağalma hekayəsindən istifadə edərək kurslarını "aqressiv şəkildə marketinq etmişdir"; bu hekayənin Aleksandrın təlim üçün əhəmiyyətli məbləğ ödəmək qərarında əsas rol oynamışdır; və THInK-in kommersiya atmosferi cəzalandırıcı ziyan təzminatının təyin edilməsini əsaslandırır.

Stibalın bu qərara ictimai reaksiyası onun öz veb saytında görünür. Orada o iddia edir ki, "məhkəmə sadəcə olaraq 'diaqnoz' sözünün sübutunu istəyirdi", "qərar qismən dindarlıq səbəbləri ilə ona qarşı qərəzli idi", "90% işi o qazandı", "ThetaHealing heç vaxt saxtakarlıqda cinayət ittihamı üzrə məhkəməyə çıxmayıb". Sonuncu iddia texniki olaraq doğrudur (iş mülki xarakter daşıyırdı), lakin mahiyyəti dəyişmir: məhkəmə saxtakarlıq faktını müəyyən etdi.

Müstəqil elmi ekspertlər ThetaHealing-i necə qiymətləndirirlər?

Makqill Universitetinin Elmi və Cəmiyyət üçün Elmlər Ofisi (McGill Office for Science and Society) — Kanadada nüfuzlu bir elmi kommunikasiya mərkəzi — ThetaHealing-i psevdoelmi kimi təsnif edir. Ofisin veb saytında ThetaHealing

“vudu” (woo) sözü ilə xarakterizə olunur — bu termin elmi skeptik cəmiyyət tərəfindən özünü elm kimi təqdim edən mistik praktikalara aid etmək üçün istifadə olunur.

Edzard Ernst nə haqda danışdığını yaxşı bilir. Alman əsilli britaniyalı həkim, Ekzeter Universitetində dünyada ilk dəfə tamamlayıcı tibb kafedrasını yaradan şəxs. Minlərlə elmi nəşrin müəllifi. O, ömrü boyu alternativ müalicə üsullarını araşdırıb. Nə nəzəriyyəçi, nə də həvəskar. Onilliklər boyu “möcüzə şəfalar”ın qabığı altında duran boşluğu açıb ortaya qoyan bir insan. Və bu adam ThetaHealing-i ələ alır. Və bir söz deyir. Cinayət. “Nə şübhəli”, nə “sübutsuz”, nə “mübahisəli”. Cinayət. Niyə? Çünki metodun ekran arxasında fiziki olaraq mümkün olmayan “şəfalar”ın satışı durur. Kimə? Ağır xəstəliyə tutulan insanlara. Son ümiddən yapışanlara. Hər şeyini verməyə hazır olanlara. Və Ernst nöqtə qoyur: bu sadəcə qeyri-əxlaqi davranış deyil. Bu cinayət əməllidir. Hər bir adekvat yurisdiksiyada.

RationalWiki, müstəqil elmi skeptik mənbə, sadə bir hesablama aparır: Stibalın öz fikrincə, o “təxminən qırx min müştəri qəbul edib”, və onun sertifikatlı praktikantları isə daha minlərlə. Əgər metod plasebo effekti səviyyəsində belə işləsəydi, açıq mənbələrdə ağır xəstəliklərdən şəfalara dair minlərlə sənədləşdirilmiş hal olardı. Onlar yoxdur. Sadəcə veb saytda yoxlana bilməyən şəkildə verilən anekdotlar və — daha çox — ödədikləri halda vədlərini yerinə yetirməyən müştərilərin şikayətləri var.

Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Ukrayna və Azərbaycanda ThetaHealing sürətlə yayılır. Rusdilli Instagramda on minlərlə “sertifikatlı praktikant” var. Mesenclerdəki qruplar, burada “teta-hellerlar” təcrübələrini paylaşırlar. ThetaHealing-i qrup düzümü, regressiv terapiya, “nəsil ağacı işi”, astrologiya və tarotla birləşdirən koçlar.

Qiymətlər standartdır: sessiya — saatına beş ilə on beş min rubl arası. Əsas səviyyə üzrə təlim — üç günlük seminar üçün

qırx ilə səksən min rubl arası. İrəliləmiş səviyyələr — yüz ilə üç yüz min rubl arası. “Vianna Stibalın şəxsən keçirdiyi ustalıq dərsi” — formatdan asılı olaraq bir milyon rubla qədər.

Əslində müştəri nə alır? Seans. Praktikant qarşısında oturur. Gözlərini bağlayır. Nəfəsində dayanma, üz əzələlərində rahatlıq — sözdə teta vəziyyətinə keçid. Görünür, məhdudlaşdırıcı inancları oxuyur. Dodaqları bir ritual ifadəni pıçıldayır: “Bütün Var Olanların Yaradanı, X inancını Y inancına dəyiş.” Və qəti: təkrarlayın. Müştəri tabe olaraq təkrarlayır. Amma bu teta vəziyyətinin dəyəri nədir? Və möcüzəni ümumilikdə ölçmək mümkündürmü? 2016-cı ildə alimlər bunu araşdırmağa qərar veriblər. Real təcrübə. “Healerların” başlarına EEG elektrodlu başlıqlar qoyulub — elmi görünüş üçün və son yoxlama üçün. Soyuq keçiricilər dəriyə basır. Beyin fəallığının oxunması başlayır. Teta ritminin yüksəlməsini gözləyirlər. Sübutu gözləyirlər. Nəticə? Dağıdıcıdır. Praktikantlarda heç bir xüsusi teta vəziyyəti qeyd olunmayıb. Sıfır. Boşluq. Müştərilərə gəldikdə? Elektroensefaloqrafiyada adi dəyişikliklər. Hər hansı meditasiya və ya divanda sadəcə rahatlama zamanı olduğu kimi. Heç bir möcüzə yoxdur. Yalnız illüziya.

İndi isə — kitabımız üçün, xüsusilə də bu fəsil üçün ən vacib olan məsələyə keçək.

Mən psixiatr həkiməm. ThetaHealing praktikasının illər boyu sındırdığı pasiyentləri görmüşəm. Otuz səkkiz yaş. Qadın. Ağır depressiv pozğunluq. İki il ərzində antidepresanlara başlamaq və psixoterapiya almaq əvəzinə “teta-hiler”ə gedib. İki illik ömür, qaranlığa verilmiş. Ona nə deyiblər? “Üçüncü çakrada enerji bloku”. “Keçmiş təcəssümdən gələn travma” ilə bağlıdır. Biz bunu “yenidən formatlayırıq”. Sehr oxuması kimi səslənir? Elə də belədir. Və hər söz üçün — ödəniş. Hər həftə on beş min rubl ödəyirdi. Həftə ardınca həftə. On beş min. Boşluğa doğru bir addım. O, öz məhvi üçün pul ödəyirdi. İki ildən sonra bu qadın mənim kabinetimin qapısını açdı. İntihar fikirləri ilə.

Bir başqa hal. Ana. Yeniyetmə. Psixozun ilk epizodu. Həftələr boşluğa gedirdi. Oğlunu psixiatra yox, "teta-hiler"ə aparırdı. İnanırdı ki, o, sadəcə enerji kanallarını təmizləyəcək. Amma kanallar təmizlənmirdi. Xəstəlik beyinə diş keçirirdi. Nəhayət onu xəstəxanaya gətirəndə vaxt artıq itirilmişdi. Psixoz bütün gücü ilə açılmışdı. Kəskin deliryum şüuru qandal kimi sıxmışdı. Erkən başlanğıcda neyroleptiklərin bir həftəyə aradan qaldıracağı şeyi indi iki aylıq stasionar müalicə yandırıb təmizləyirdi. İki uzun palata həftəsi. Kor umid üçün ödənilən qiymət.

Bunlar tək-tək hallar deyil. Bu sistemli bir hadisədir. Hər gün, postsovet məkanının yüzlərlə şəhərində insanlar əsl tibb əvəzinə "teta-hiler"lərə güvənərək vaxt, pul və həyat itirirlər.

Bunu Vianna Stibal haqsız olduğunu anlasın deyə yazmıram. O, anlamayacaq. Onun metodun saxlanmasında öz iqtisadi marağı həddindən artıq böyükdür. Bunu pasiyentlər və onların ailələri üçün yazıram. Seçim qarşısında duranlar üçün: "Bütün Varlığın Yaradıcısı ilə seans" üçün pul ödəmək, yoxsa psixiatr həkimə yazılmaq.

Heç bir ThetaHealing seansı heç bir psixi pozğunluğu sağaltmayıb. Heç birini. Niyə? Gurular pıçıldayır: metod "tam açılmayıb". Usta başını bulayır: "müştəri kifayət qədər açılmayıb". Müridlər bəhanə axtarır: "enerji hələ gəlməyib". Amma bu səs-küyü bir kənara atın. Budur cavab. Sağalma bir şey tələb edir: etdiyiniz iş heç olmasa pozğunluğunuzun yaranma və müalicə mexanizmlərinə toxunmalıdır. Giriş nöqtəsi. Konkret hədəf. Sərt fizioloji əlaqə. ThetaHealing bu mexanizmlərdən sadəcə uzaq deyil. Onların heç biri ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Heç bir. Tək bir yoxlanıla bilən əlaqə belə.

ThetaHealing seanslarında yoxa çıxan şişlər? Tapmaca. Amma hər tapmacanın rasional açarı var. Birinci variant: heç vaxt mövcud olmamış şişlər — Stibalın özündə olduğu kimi. İllüziya. Sərin su. İkinci variant: şişlər yalnız ona görə əriyir ki, paralel olaraq əsl, həqiqi tibb işləyir. Kimyaterapiya. Skalpel.

Möcüzə olmur. Bir seansda aradan qaldırılan depressiya? Təsir edicidir. Amma ipi dartırsan — yenə boşluq. Bunlar sadəcə yüngül vəziyyət reaksiyalarıdır. Onlar səhər dumanı kimi özözünə əriyib gedir, əzab çəkən bədəndə heç bir iz qoymadan. Bəs "geriyə çəkilən" şizofreniya? Üçüncü fokus. Ya o heç vaxt orada olmayıb — sadəcə "hiler"in ölümcül diaqnostik səhvi, — ya da bu, şüurun dərinliyində yatan təbii remissiyadır. Sağalma adı altında əvvəldən öz sərt bioloji qanunları ilə yaşayan şeyə aid edilir.

Bağlı bölmə. Divarlarda donub qalmış kölgələr. Çarpayıda gənc bir qadın. Anası altı ay boyunca onu "enerji müalicəçisi" adlandırdığı şəxsə aparmışdı. Altı ay. Antipsixotik dərmanların yerinə. İtirilmiş altı ay. Və indi... pəncərə qabağında dəmir şəbəkə. Pəncərənin qarşısında qırx yaşlı bir kişi. Gözlərini belə qırpmır. Baxışları bir nöqtəyə ilişib. Səssiz. İki ildir ki, bununla yaşayır: "Hər Şeyin Yaradıcısı onun DNT-ni dəyişəcək". İki il. Allah gəlmədi. DNT dəyişmədi. Divarların o tərəfində isə ümidsizliyə qapılmış OKR xəstəsi bir qadın üç yüz min rubl ödədi. Üç yüz min. Əvəzində heç nə almadı. Onu xilas edə biləcək heç bir şey. Niyə? Çünki xilasedici üsullar bu pullara satılmırdı.

Bu, kolbasa satışı deyil. Kolbasa öz göstərilən xüsusiyyətlərinə uyğun gəlmirsə, satıcı məsuliyyət daşıyır. "Hər Şeyin Yaradıcısı ilə əlaqə" yalandan ibarətdirsə, keçmiş Sovet məkanının heç bir hüquqi sistemində satıcı heç bir məsuliyyət daşımır.

Bu asimmetriyaya hələ qayıdacağıq.

> *QIRMIZI BAYRAQ. Əgər sizə diaqnoz qoyulmuş xəstəliyinizdən — hansısa olursa olsun — "enerji", "niyyət", "DNT-nin yenidən qurulması" və ya "Yaradıcı ilə əlaqə" vasitəsilə sağalacağını vəd edirlərsə, xüsusilə də dərmanları "buraxmağı" tövsiyə edirlərsə, siz heç də müalicəçi ilə danışmırsınız. Siz gələcək relapsın səbəbkarları*

ilə üzbəüzsünüz. Oradan uzaqlaşın — və dərman qəbulunu dayandırmayın.

Fəsil 21. Keçmiş həyatlar bazarı: reqressologiya və “müəllif metodları”

Instagram-da özünü “psixoloq, pedaqoq, şəxsi onlayn məktəbin və ‘unikal müəllif metodu’nun yaradıcısı”, öz şousunun aparıcısı və bestseller kitabın müəllifi kimi təqdim edən rusdilli mütəxəssisin səhifəsi — sosial şəbəkələrdə yüz minlik auditoriyası var.

Yüz mindən çox insan.

Müqayisə üçün: həmin rusdilli məkanda “Psixiatriya və Psixofarmakoterapiya” elmi tibbi jurnalının çap variantı cəmi bir neçə yüz nüsxə tirajla buraxılır. Rusiyanın ən böyük peşəkar psixiatr assosiasiyasının təxminən üç min aktiv üzvü var. Ən böyük klinik psixologiya jurnalının internet saytında bir neçə min abunəçi var.

Sertifikatlaşdırılmamış metodu olan bir insanın bir bloqunun auditoriyası bütün Rusiya peşəkar psixiatriyasının auditoriyasından onlarla dəfə böyükdür. Və bu, rusdilli məkanda onlarla bənzər fiqurdan yalnız biridir.

Bu, müasir dildə sosial şəbəkələr dövründə nüfuz inflyasiyası adlanan şeyin nümunəsidir. Bu barədə sosial şəbəkə pandemiyasına həsr olunmuş fəsildə daha ətraflı danışacağıq. İndi isə bu nüfuzun istehsal etdiyi və satdığı konkret bazar seqmentindən bəhs edəcəyik.

Reqressiv terapiya, yaxud reqressologiya — müştərinin guya hipnotik və ya “trans” vəziyyətinə salındığı bir metoddur. Məqsəd? Keçmiş hadisələri, çox vaxt əvvəlki həyat-

lardan olanları "xatırlamaq". İdeya adamı üşüdəcək qədər cəlbedicidir: bu həyatdakı həll olunmamış problemlər — anlaşılmaz qorxular, xroniki xəstəliklər, münasibətlərdə çətinliklər, maliyyə uğursuzluqları — əvvəlki təcəssümlərdə alınan travmaların "əks-sədası"ndan başqa bir şey deyil. Bəs o qaranlığa nüfuz etsək nə olar? Həmin travmaları xatırlayıb "işləsək", sonra travmalar əriyib yox olar, indiki həyat da qaydasına düşər.

Bax bunun arxasında nə dayanır. Minilliklər boyu uzanan bir zəncir. Hindistan və Buddist reinkarnasiya konsepsiyaları. XIX əsr fransız-ispan spiritualist ənənələri — Allan Kardek. XX əsrin ortalarında Amerika new-age cərəyanı. Üç axın. Bir ideya. Bəs qədim inancı Qərb texnologiyasına kim çevirdi? Amerikalı hipnoterapevt Maykl Nyuton. Yaşadığı illər: 1931–2016. İki kitabın müəllifi — "Ruhun səyahətləri" və "Ruhun təyinatı". Məhz o, müasir reqressologiyanın qərb formasının əsas nəzəriyyəçisi oldu. Və burada — ən gözlənilməz məqam. Nyuton iddia edirdi: reqressiv hipnoz zamanı pasiyentlər yalnız keçmiş həyatları təsvir etmirlər. Onlar başqa bir şeydən danışırlar — "həyatlar arası məkanlar"dan. Onların sözlərinə görə, orada ruhlar növbəti təcəssümü planlaşdırır, "ruhani müəllimlər"lə görüşür və "ağsaqqallar şuraları"nın qarşısına çıxırlar. Keçmiş həyat — sadəcə girişdir. Qapının arxasında — növbəti həyatın planı.

Digər nüfuzlu sima Dolores Kennon (1931–2014) idi — britaniyalı-amerikalı hipnoterapevt, "Kvant şəfa hipnoterapiyası" metodunu — Quantum Healing Hypnosis Technique (QHHT) — inkişaf etdirən.

Rusdilli məkanda reqressologiya 2000-2010-cu illərdə daha geniş bir hərəkatın — "ezoterik psixologiya"nın tərkib hissəsi kimi yayıldı. Tədricən o, öz iyerarxiyası, təlim mərkəzləri və sertifikatlaşdırma strukturları olan ayrı bir sənayeyə çevrildi.

Ciddi elm reqressiv terapiya haqqında nə deyir?

Reinkarnasiya — mifdir? Yoxsa elmi reallıq? Cavab dumandanlı peyğəmbərliklərdə deyil, ciddi laboratoriyalarda yatır. Alimlər illərlə keçmiş həyatlar haqqında məlumatı saxlaya və ötürə biləcək fiziki, bioloji, genetik və ya neyron mexanizmlər axtardılar. Bir dənə də yox. Sıfır. Boşluq. Heç bir təsdiq. Heç bir ipucu. Reinkarnasiya tərəfdarlarına qalan tək şey — inamdır. Və bu onların haqqıdır. Amma elm başqa şey deyir: beyin, yaddaş, genlər — onlar haqqında bildiyimiz hər şey ruhların köçməsi ideyasına ziddir. Reinkarnasiya? Gözəldir. Amma bu elm deyil.

Və ən təhlükəlisi elə buradan başlayır. Reqressiv hipnoz — elmi psixologiyada çoxdan və rəsmi olaraq yüksək riskli təcrübə sayılan, yalançı xatirələr (false memories) yarada bilən bir prosedurdur. Bu təxmin və ya fərziyyə deyil. Bu yaxşı öyrənilmiş bir fenomendir. Onun arxasında bir ad dayanır — İrvayndakı Kaliforniya Universitetinin professoru Elizabeth Loftus. Onilliklər boyu o, bir-birinin ardınca təcrübələr aparırdı və bu təcrübələr klassikaya çevrildi. O nə göstərdi? İnsan beyni hipnotizyorun, psixoterapevtin və ya istintaqçının yönləndirilmiş təzyiqi altında xatirələr — tamamilə uydurma, heç vaxt baş verməmiş hadisələr yarada bilir. Və qanı donduran bir paradoks var: insanın özü üçün bu xatirələr tamamilə həqiqidir. O yalan danışmır, simulyasiya etmir. O həqiqətən xatırlayır.

1980-ci illərdə — 1990-cı illərin əvvəllərində Şimali Amerikada satanist ritual sui-istifadələri haqqında sözdə “bərpa edilmiş xatirələr”in əsl epidemiyası baş verdi. Minlərlə yetkin qadın psixoterapevt-reqressoloqların rəhbərliyi altında uşaqlıqda valideynlərinin satanist ayinlərində iştirak etdiklərini, uşaqları qurban verdiklərini və ritual zorlamalar həyata keçirdiklərini “xatırladılar”. Bu “xatirələr” əsasında ailələr dağıldı, cinayət işləri qaldırıldı və günahsız valideynlər həbsxanalara salındı. Sonradan bu işlərin əhəmiyyətli hissəsi yenidən baxıldı, ittiham hökmləri ləğv edildi və “xatirələrin bərpası” metodu təhlükəli psevdoterapiya kimi tanındı. Amerika Psixo-

loji Assosiasiyası 1990-cı illərdə onun tətbiqindən çəkindirən rəsmi sənəd dərc etdi.

Əgər bu, indiki həyat haqqında "bərpa edilmiş xatirələrə" aiddirsə — bu, keçmiş həyatlar haqqında "xatirələrə" daha çox aiddir. Burada hətta travmanın mümkün reallığı haqqında mübahisənin mənası yoxdur: reallığın özü yoxdur.

Reqressiv terapiya seansında əslində nə baş verir?

Müştəri hipnotik rahatlama vəziyyətinə salınıb. Bədəni ağırdır, nəbzi ləngiyib. Və bu anda bir sıra yönləndirici suallar gəlir: "Ayaqlarınıza baxın — ayağınızda hansı ayaqqabı var? Ətrafınızdakı qumdur, yoxsa daş döşəmə? Üstünüzdə nə var — paltar, yoxsa zireh? İndi kişisən, yoxsa qadın? Hansı dövrdür?" Bu suallarla stimullaşdırılmış beyin dərhal obrazlar yaratmağa başlayır. Çox vaxt — parlaq, emosional, qorxulu dərəcədə təfərrüatlı. Bu nədir? Anlayış? Unudulmuş həyatların dirilməsi? Xeyr. Buna konfabulyasiya deyilir. İnandırıcı, lakin tamamilə yalan xatirələrin amansız istehsalı.

Sonra "reqressoloq" bu obrazları istədiyi istiqamətə yönəldir: "İndi baxın, bu həyatınızda su qorxusu niyə var? Bunu sizə kim edir? Nə deyir?" Və müştəri "xatırlayır" ki, keçmiş həyatında boğulub, boğdurulub, ya da kimisə boğub. "Reqressiya" bitdikdən sonra reqressoloq izah təklif edir: "Hazırkı su qorxunuz bu travma ilə bağlıdır. Biz onu işlədik. İndi qorxu keçməlidir."

Bəzən qorxu həqiqətən keçir — bir müddətlik. Bu effekt sübuta əsaslanan psixoterapiya mütəxəssislərinə yaxşı tanışdır: öz qorxunuz haqqında ardıcıl bir hekayə yaşamaq müvəqqəti rahatlıq gətirə bilər. Plasibo belə işləyir. Etiraf belə işləyir. Dostla söhbət belə işləyir. Bu rahatlıqda reqressiv terapiyanın spesifik effekti yoxdur.

Sonra isə qorxu qayıdır. Çünki onun yaranmasının real mexanizmlərinə toxunulmayıb. Və müştəri növbəti seansa qayıdır. "Yəqin ki, daha dərinə getmək lazımdır." "Daha

əvvəlki travma var, daha uzaq bir həyatda." Bu proses illərlə davam edə bilər.

Rusdilli məkanda son on beş ildə bu sxem üzərində biznes quran bütöv bir "mütəxəssis" nəsli yetişib. Onların arasında bir neçə tipi ayırd etmək olar.

Birinci tip — dar bir müştəri dairəsində işləyən, geniş tanınmağa can atmayan nisbətən təvazökar praktiklər. Xidmətlərinin qiyməti seans başına üç minlə on beş min rubl arasındadır. Onlar nadir hallarda ictimai müstəviyə çıxırlar.

İkinci tip — sosial şəbəkələrdə minlə yüz min arası izləyicisi olan orta bloqerlər. Onlar Instagram hesabları aparır, onlayn vebinarlar keçirir, müstəqil öyrənmə kursları satırlar. Qiymətlər — kurs üçün iyirmi mindən yüz min rubla qədər.

Üçüncü tip — iri influenserlər. Yüz min və daha çox izləyici. İcarəyə götürülmüş zallarda minlərlə iştirakçının toplaşdığı tədbirlər. Bestseler kitablar. Şəxsi "məktəblər". Bəzən — YouTube-da və ya digər mediada şou. Gəlirlər — ildə on milyonlarla rubl.

Üçüncü tipin parlaq nümayəndəsi yuxarıda qeyd etdiyim rusiyalı fiqurdur. Onun öz sosial şəbəkələrində və açıq mənbələrdə təqdim edildiyi qədər ictimai tərcümeyi-halı belə görünür. Karyerasına reqressoloq kimi başlayıb — yəni klassik mənada "keçmiş həyatları xatırlama" praktiki. Sonra daha geniş fəaliyyətə keçib: "Hellinger üzrə dizaynlar", "nəsil proqramı ilə iş", müəllif təlimləri. Bir məqamda rebrendinq baş verib: "keçmiş həyatlar"a birbaşa istinaddan imtina və "müəllif metodu"na keçid.

O, öz metodunu "unikal müəllif texnologiyası" adlandırır. Dərc etdiyi yazılara görə, metodun mahiyyəti müştəriyə "öz reallığını yaratmaqda rolunu dərk etməyə", "özü haqqında həqiqəti qəbul etməyə", "həyatının səbəbi olmağa" kömək etməkdir. O, "həyatının səbəbini qəbul etmək" haqqında bestseller kitab yazıb; hər həftə müəllif şousu yayımlanır.

Formullaşdırma səviyyəsində bu o qədər də pis səslənmir. "Rolunu qəbul et", "həyatının səbəbi ol" — bunlar sübuta əsaslanan psixoterapiyada da eşidilə biləcək tezislərdir (koqnitiv-davranış terapiyası həqiqətən də müştərinin öz qərarlarına görə məsuliyyəti mövzusu ilə işləyir; qəbul və məsuliyyət terapiyası isə daha da birbaşa). Problem formullaşdırmalarda deyil. Problem konkret seansların məzmununda, metodlarda, ixtisasda, nəticələrdədir.

Bu mütəxəssisin seanslarının konkret məzmunu — özünün açıq çıxışlarında və açıq girişə yerləşdirilmiş fraqmentlərdə göründüyü kimi — tez-tez "keçmiş həyatlar", "nəsil proqramları", "kollektiv şüursuzluq" ilə işi əhatə edir. Müştəriyə deyilir ki, onun indiki problemi "karma", "nəsil ssenarisi", "ruhun yerinə yetirilməmiş vəzifəsi"dir. Sonra bunu vizuallaşdırmalar, "daxili uşaq"la söhbətlər, "nəsil bağışlanmaları" vasitəsilə "işləyirlər". Hər hansı reqressoloqun etdiyi elə həmin şeydir, sadəcə yeni brend altında.

İdeal trayektoriya. Ssenari millimetrinə qədər dəqiqləşdirilib. Metodun ictimai qavranışı çatlayır. "Hellinger düzülüşləri" ya da "reqressiv terapiya" — bu adlar artıq heyrət doğurmur. Onlar ikrah doğurur. Mətbuatda tənqid görünür. Skeptiklər dişlərini qınayır. İfşaedici məqalələr bir-birinin ardınca dəqiq hədəfə zərbə endirir. Bəs praktikantlar nə edir? Adı dəyişirlər. Ani rəng dəyişməsi. "Düzülüşçülər" köhnə etiketi qoparıb atır və "sistem-fenomenoloji terapevt" olurlar. "Reqressoloqlar" dərilərini dəyişərək "X metodu üzrə mütəxəssis"ə çevrilirlər. Mahiyyət? Metod eyni qalır. Yalnız qablaşdırma dəyişir.

Bu, artan tənqid şəraitində sənayenin sağ qalma strategiyasıdır. Bənzər yanaşma kommersiya sahəsində tətbiq olunur: məhsul pis reputasiya qazandıqda onu yenidən adlandırır, dizaynını dəyişir, reklamını düzəldirlər. Yalnız bu halda satılan şey peçenye deyil, ruhi ağrı çəkən insanlar üçün psixoloji xidmətlərdir.

Burada son dərəcə aydınlıq lazımdır. Mən bu mütəxəssisə qarşı iddia qaldırmıram. Cinayət ittihamı irəli sürmürəm. Amma faktlara baxaq. Onun üsullarının bütün zənciri — açıq mənbələrə yerləşdirilmiş, hər kəs üçün əlçatan olan — elmi bazaya malik deyil. Sıfır. Boşluq. Bəs onda niyə minlərlə insan ona pul gətirir? Cavab amansızdır: onun kommersiya modeli dəqiq hədəfə zərbə endirir. O, soyuqqanlılıqla psixoloji həssaslıqdan istifadə edir. İnsanları öz qorxuları və ağrıları ilə qarmağa keçirirlər. Bu — mənim peşəkar qiymətləndirməmdir. Və o, dedi-qodulardan yoğrulmayıb. Onun təməli bütün dünyaya açıq olan materiallardır. Amma təsəvvür edin: bir gün mütəxəssis başqa seçim edəcək. "Keçmiş həyatlar" mistikasını kənara atacaq. Okkult "nəsil proqramları"nı kəsib atacaq. Sübuta əsaslanan psixologiyaya — elmi həqiqətə keçəcək. Mən buna ilk sevinən olacağam.

Problem konkret bir adamda deyil. Problem sənayedədir. Eyni sxemlərlə işləyən yüzlərlə, minlərlə adamdadır. Tənzimləmənin olmamasındadır. Dövlət universitetinin ali psixoloji təhsili olan şəxslə "X metodu" üzrə üç günlük ödənişli kurs keçmiş şəxsin hüquqi baxımdan bərabər şəkildə özünü "psixoloq" adlandırmaq və "konsultasiya"lar üçün pul almaq hüququna sahib olmasındadır.

Bir konkret klinik hal danışmaq istəyirəm. Anonimliyi qorumaq üçün təfərrüatlar dəyişdirilib, amma mahiyyət saxlanılıb.

Qəbuluma otuz səkkiz yaşlı bir qadın gəldi. Onu Aygün adlandıraq. Onda panik ataklarla müşayiət olunan tipik narahatlıq pozuntusu var idi. İlk epizod otuz iki yaşında, boşanmadan sonra baş vermişdi. Sonra isə artaraq davam etdi: panik ataklar, ictimai nəqliyyatdan qaçma, aqorafobiya, yuxusuzluq, ürəkbulanma.

Mənimlə görüşməkdən altı il əvvəl Aygün psixiatra müraciət etməmişdi. Əvvəlcə, onun sözlərinə görə, o, "həblərə düşmək istəmirdi". Rəfiqəsi ona "yaxşı reqressoloq-psixoloq"

məsləhət görmüşdü. Bir seansın qiyməti səkkiz min rubl idi. İki il ərzində Aygün təxminən qırx beş seans keçmişdi. Ümumi məbləğ təqribən üç yüz altmış min rubl təşkil etmişdi.

Həmin seanslarda Aygün özünün ən azı altı "keçmiş həyatını" "xatırlamışdı". O, XIV əsr Fransasında kəndli qadın, Yaxın Şərqdə tacir kişi, çayda boğulmuş qız və döyüşdə həlak olmuş döyüşçü olmuşdu. Bu həyatların hər biri əzablı bir ölümlə sona çatmışdı. Bu "xatirələrin" hər birini reqressoloq onun indiki simptomlarına bağlayırdı. Tapmaca qorxunc bir mənzərəyə çevrilirdi. "Bax bu üzdən küçəyə çıxmaqdan qorxursunuz — keçmiş həyatınızda sizi orada öldürüblər". Bir kəlmə — və beyni tanımağın buz kimi sancması deşib keçir. "Bax bu üzdən boğulma tutmalarınız olur — keçmiş həyatınızda siz boğulmuşsunuz". Xəyali su boğazı doldurub boğur. Bəs necə? Yəni bədən xatırlayır? Yoxsa kiminsə ölümü sadəcə onun qorxusuna yedizdirilir?

Panik ataklar keçmirdi. Hər seansdan sonra bir neçə günlük "yüngülləşmə" olurdu — sonra yenidən üstünü basırdı. Reqressoloq deyirdi: "Siz hələ ən dərin qatı keçməmisiniz. Davam etmək lazımdır".

Aygün yanıma gələndə tükənmiş vəziyyətdə idi. Klinik olaraq — panik ataklarla müşayiət olunan narahatlıq pozuntusu, müalicə almırdı. Nə şizofreniya, nə keçmiş həyatlar. Kognitiv-davranış terapiyası ilə, ağır formalarda isə SSRI dərmanları ilə mükəmməl müalicə olunan adi bir pozuntu.

Müalicəyə başladıq. Altı aydan sonra — əhəmiyyətli yaxşılaşma. Bir ildən sonra — demək olar tam remissiya. Qiymət — həqiqi müalicənin adi qiyməti, Aygünün reqressoloqa ödədiyinin təxminən onda biri qədər.

Bu üç yüz altmış min rublu qaytarmaq mümkün deyil. Bu altı il ömrü də.

Və burada mən bu kitabın əsas fikrinə qayıdıram.

Ayqun dəli deyil. Ayqun — sadə bir insandır. Təhsilli, işləyən, ailəli bir qadın. O, kömək axtarırdı. Ona tövsiyə etdilər. O da getdi.

Ona tövsiyə edən dostu dəli olarsa? Xeyr. O, özü də oxşar təcrübədən keçmiş və səmimi qəlbdən kömək etmək istəyən mehriban bir dostdur.

Regressoloq dəli olarsa? Maraqlı sual. Formal olaraq — yoxdur, onun psixiatrik diaqnozu yoxdur. Lakin o, ciddi qaydada öz müştərilərinin keçmiş həyatlarını xatırlayır və onların indiki simptomlarını Fransanın XIV əsri ilə əlaqələndirir — bu ifadələr elmi praktikadan daha çox psixotik yaşantılara yaxındır. Yalnız o ziyan görmür. O, qazandırır.

Bu kitabın hər səhifəsində elektrik şoku kimi qabarıq duran bir sual: bunlardan hansı dəlidir? Biri — xəstəxananın kəskin şöbəsindədir. Diaqnoz: şizofreniya. O, həkimlərə pıçıldayır ki, öz əcdadının səsini eşidir. Reaksiya ani olur: antipsixotik dərmanlar. İynə. Onun dünyası sürətlə dörd xəstəxana divarına sıxışır. Digəri — Moskvanın mərkəzindədir. Açıq şəkildə bəyan edir: "Mən müştərilərimin keçmiş həyatlarının səslərini kanallaşdırıram". Sosial şəbəkələrdə yüz minlərlə gözlər onu həvəslə izləyir. Bir seans üçün qonorar — səkkiz min rubl. Psixiatrik xəstəxana — heç vaxt. Diaqnoz — heç vaxt. İnzibati cəza — heç vaxt. Biri əcdadının səsini eşidir — və iynə alır. Digəri başqalarının keçmiş həyatlarının səslərini eşidir — və pul qazanır. Burdakı hansı mənasızlıq vəziyyətindədir?

Bu ritorik sual deyil. Bu — müasir dünyada mənasızlıq pandemiyası zamanı qanuni cavabı olmayan bir sualdır. Amma olmalıdır.

QIRMIZI BAYRAQ. *Əgər problemlərinizin səbəbi "keçmiş həyatlar"da və ya hipnoz altında "xatırlamağınız" təklif edilən "sıxılmış xatirələr"də axtarılarsa — bilin ki, yaddaş elmi göstərib ki, belə üsullarla xatirələr tapa bilməz, yaradılır. Siz seansdan başqasının bioqra-*

fiyası və öz əvvəlki diaqnozunuzla çıxacaqsınız. Tez gedin.

Fəsil 22. Hubbard və dianetika: qondarma xoşbəxtliyin satıcıları

1950-ci il sentyabrın 3-də "New York Herald Tribune Book Review" jurnalında bir kitab haqqında rəy dərc olundu ki, həmin kitabın müəllifinin sözlərinə görə, "insanlıq üçün əsas daş idi, odun kəşfi ilə müqayisə edilərdi və təgər ilə ox icadından daha əhəmiyyətli idi".

Otuz doqquz yaş. Amerikalı. Lafayet Ronald Habbar. İnitiallarla gizlənməyə üstünlük verirdi — L. Ron Habbar (1911-1986). Ticari donanmanın keçmiş dənizçisi. Orta populyarlıqda elmi-fantastika yazıçısı, yüzlərlə hekayə və povest: elmi fantastika, macəra, vesternlər. İndi isə bu adam tamam başqa bir şey iddia edirdi. Kitabın adı idi — "Dianetika: Ruhi Sağlamlığın Müasir Elmi". Bəs bütün şərin tək kökü tapılıbsa? Habbar iddia edirdi: o, tək mənbəni kəşf etmişdir. Bütün nevrozlara. Psixozlara. Cinayətkarlığa. Psixosomatik xəstəliklərə. Sonsuz insan əzabının tək mənbəyi — və o, aşkara çıxarılıb. Lakin əsas şey daha irəlidə idi. Aşkarlamanın təsiri: Habbar elan edirdi ki, bütün pozuntuları tamamilə sağaltmaq üsuluna malikdir. Tamamilə hamısına.

Bu kitabı rəy üçün götürən adam adi bir tənqidçi deyildi. Erich Fromm. 1900–1980. O vaxta qədər — dünya psixoanalizində ən məşhur adlardan biri idi. Alman yəhudisi. 1934-cü ildə Almaniyanı əbədi olaraq tərk etdi — nasist rejimindən qaçdı. Neo-Freydizmin, Freudun ideyalarını sosial və mədəniyyət nəzəriyyəsi ilə birləşdirən istiqamətin qurucularından biri idi. Artıq çıxan kitabların müəllifi: "Azadlıqdan Qaçış" (1941), "Özü Üçün İnsan" (1947). Onun psixoanalizdəki erudisiyası? Demək

olar ki, təkidi yox idi. Ruhi sağlamlıq sahəsindəki nüfuzu? Nəşr zamanı demək olar ki, mütləq idi. İndi isə belə bir adı, belə bir bioqrafiyası və belə bir ağırlığı olan bu adam — rəy yazmaq üçün oturdu.

Frommun dianetika haqqında rəyinin adı açıq-aşkar idi: "Uydurulmuş xoşbəxtlik axtaranlara".

Fromm öz rəy yazısını cəmiyyətdəki vəziyyətin təsviri ilə başlamaqdadır. O yazırdı ki, əvvəllər insanlar heç vaxt XX əsrin ikinci yarısında olduğu qədər psixologiya və həyat sənətinə belə fəal maraq göstərməmişdilər. Dünya müharibəsinin dəhşətlərindən, əvvəlki dəyərlərin çoxunun məhv olmasından, ideologiyalara olan inamsızlıqlardan sonra milyonlarla insan həyatın mənası, öz xoşbəxtliyi, münasibətlərin qurulması və özünü inkişaf etdirmək yolları ilə bağlı suallara cavab axtarır. Bu, qəlbin təbii hərəkətidir və prinsipcə yaxşıdır.

Lakin bu ehtiyaca cavab verən kitablar arasında iki fərqli növ seçilir. Birinci növ — ağıllı, ciddi və real biliklərə əsaslanan kitablar insana öz üzərində işləməyə kömək edir, həqiqi inkişafın zamana, səylərə və özünə qarşı düzgünlük tələb etdiyini başa düşməyə yardımçı olur. İkinci növ isə tənbəlliyə yaltaqlıq edən, az bir qiymətə və qısa müddətdə uydurma xoşbəxtlik vəd edən kitablardır. Fromm yazırdı ki, "Dianetika" belə kitablar sırasında sonuncudur. Və onun müəllifi Habberd isə "uğur formulunun" bütün komponentlərindən, üstəlik heç bir utanc hissi duymadan, istifadə edir.

Habbard nə vəd edir? Hər şeyi. Tamamilə hər şeyi. İstənilən psixi pozuntu. İstənilən psixosomatik ağrı. O iddia edir ki, kökü tapıb. Bütün xəstəliklərin tək səbəbini. Onları "enqram" adlandırır. Görünməyən yara izləri. Keçirilmiş qorxunun izləri. Onlar "reaktiv ağıl"da tələ kimi donub qalıb, "analitik ağıl"ın işini iflic edir. Düşünün: bir mexanizm — həm psixoz üçün, həm mədə xorası üçün, həm də miqren üçün. Bütün insan xəstəliklərinin tək səbəbi. Amma onun texnikası ilə bu enqramları bədəndən və ağıldan "təmizləyib" yandırsan —

zəncir qırılır. Qarşınızda "klir" dayanır. Clear. Xəstəliklərdən azad olmuş insan. Nevrotik reaksiyaları yaddan çıxarmış insan. İntellekt — ortalamanın üzərində. Yaddaş — qüsursuz. Psixi sağlamlıq — nöqsansız. İdeal maşın. İdeal nəzarət.

Habbardın kitabı, yazırdı Fromm, ən müxtəlif mənbələrdən — qədim hindlilərdən, erkən yunan və romalılardan (Lucretius də daxil olmaqla), Frensis Bekonun əsərlərindən, Darvinin tədqiqatlarından, Herbert Spenserin fərdi fikirlərindən gələn "fəlsəfi əsaslar"a istinad edir. Lakin dianetika ilə bu təlimlər arasındakı əsl əlaqə, Fromm qeyd edirdi ki, demək olar sıfırdır. Dianetika "şübhəsiz ki, bu təlimlərdən doğulmayıb".

Bunun əvəzinə, Fromm qeyd edirdi ki, "Dianetika" tamamilə fərqli bir şeydir: anlaşılmamış və tərsinə çevrilmiş freydizm, yeni sözlər və hipnotizm dövrünün reqressiya təcrübələri ilə zövqləndirilmişdir. Dianetikada insan — nə böyük Şərq və Qərb ənənələrində təsvir edilən mürəkkəb, çoxölçülü, azadlığa açıq varlıq, nə də Hubbarda görə mexaniki bir qurğu, mühəndislik sistemi. Onunla iş düymələr basmaqdan ibarətdir. "Dianetika kimi mühəndislik elmində biz düymələrə basaraq işləyirik" — deyə Hubbard öz metodunu belə xarakterizə edirdi. Heç nə bilməyə və ya başa düşməyə ehtiyac yoxdur; sadəcə Hubbardun enqramlər nəzəriyyəsini tətbiq etmək kifayətdir.

Fromm ağır bir hökm qərarı çıxardı. "Habbardın kitabı, — yazırdı o, — insan haqqında elmə töhfə kimi ciddi qəbul edilə bilməz. Lakin onu bütün ciddiyyətlə təhlükəli bir tendensiyanın simptomu hesab etmək lazımdır. Əgər bu, sadəcə Freydin erkən nəzəriyyələrinin ifrat sadələşdirilmiş populyarlaşdırılması olsaydı, bu zərərsiz bir şey olardı. Lakin 'Dianetika' Freydin təliminə tam əks olan bir ruhun ifadəsidir".

Frommun rəyi — 1950-ci il sənədi. O vaxt Habbard sadəcə "özünə kömək" mövzusunda kitablar yazan məşhur müəllif-

lərdən biri idi. Onun hərəkatının on il sonra nəyə çevriləcəyini heç kəs təxmin də etmirdi.

1952-ci il. Habbar hərəkətə keçir. Dianetika sadəcə eskiz idi. İndi səhnəyə onlar çıxır — "ruhi varlıqlar". Tetanalar. Sonsuz yenidən doğulma dövrü. Və əsas zərbə: ələ keçirmə. Pis əcnəbi sivilizasiyalar onları milyonlarla il əvvəl əsarət altına almışdı. Qan donur. Biz kosmik həbsxananın kuklalarıyıq? Habbar zərbə endirdi. Yeni təlim ad qazandı: "Sientologiya". Scientology. Tərcümə çəkic kimi zərbə endirir: "bilik haqqında elm". 1953-cü il. Növbəti addım. Habbar Sientologiya Kilsəsini qeydiyyata aldırır. Formal olaraq — dini təşkilat. Reallıq? ABŞ-da vergi güzəştləri. Mükəmməl örtük. Pul çay kimi axmağa başladı. Onilliklər keçdi. Doktrina kimi başlayan şey nəhəng bir canavara çevrildi. Beynəlxalq korporasiya. Minlərlə işçi. On minlərlə əməkdaş. Öz donanması. Öz "təhsil mərkəzləri". Əmlak və kapitalın əhəmiyyətli hissəsinə nəzarət. Tetanalar və vergi güzəştləri üzərində qurulan imperiya əzələlərini sıxdı.

1950-ci ildə Fromm hələ bunu gözləyə bilməzdi. Lakin, 2005-ci ildə Frommun arxiv tapıntısını — özü də yarım əsr unudulmuş rəyini nəşr edən bioqrafı Rayner Funkin qeyd etdiyi kimi, Frommun firasəti heyrətamiz oldu. O, dianetikada o zaman görmüşdü ki, nəyin bir neçə onillik sonra dünyanın ən münaqişəli dini korporasiyalarından birinə çevriləcəyi.

Bu kitabda Sientologiyanı təşkilat kimi ətraflı təhlil etməyəcəm. Bu — özünə məxsus monoqrafiyaları haqq edən ayrı bir mövzudur. Onlardan artıq kifayət qədər var: oxucunu Lorens Raytın "Going Clear", Aleksandr Skorodumovun "Anti-sientologiya: habbardizm doktrinal əsaslarının və texnologiyalarının tənqidi" və digər əsərlərinə istinad edirəm. Amma bu siyahıya diqqətlə baxın. Məhkəmə prosesləri. Cinayət işləri. Daxili qalmaqallar. Keçmiş müridlərin qaçışları. Dağıdılmış ailələr. Dünyanın müxtəlif ölkələrindəki maliyyə manipulyasiyaları. Tarixi bu cür faktlardan toxunan imperiya nəyi gizlədir? Cavabı məhkəmələr bilir. Fransa və Belçika onu

məhkəmə səviyyəsində cinayət təşkilatı kimi tanıyıb. Almaniya ona din statusu verməkdən imtina edir. Rusiya 2015-ci ildə Məhkəmənin qərarı ilə mərkəzi "Moskva Sientologiya Kilsəsi"ni ləğv edib.

Lakin bizim kitab üçün əsas olan bu deyil. Əsas olan odur ki, sientologiya və dianetika cinnət pandemiyasının strukturunda müəyyən bir niş tutur. Və bu nişi başa düşmək vacibdir.

Nişə Habbard Hellinger və Vianna Stibalın nişəsindən fərqli şəkildə qurulub.

Hellinger və Stibal fərdi xidmət formatında çalışırlar. Müştəri seans üçün ödəniş edir, gəlir, seans alır və gedir. Əlaqələr bitir — ya da müştəri geri qayıtmaq qərarına gəlsə, yenidən bərpa olunur.

Xabbard başqa bir şey yaratmışdı. Total bir təşkilat. Ardıcıl addımlarla tərəfdarın həyatını udan və onun yeganə məzmununa çevrilən bir maşın. Bu necə başlayır? Aldadıcı sadəlikdən. Ucuz yemlə. İstənilən mərkəzdə pulsuz "şəxsiyyət testi" — yumşaq, zərərsiz, çiyinə yüngülcə qoyulan əl kimi. Birinci kurs — "Diaqnostika" — cüzi bir məbləğə başa gəlir. Yarığa düşən sikkə və mexanizm sakitcə klik etdi. Sonra — "Ünsiyyət" kursu. Addım. Daha bir addım. İnsan artıq içəridə. Daha sonra — qabaqcıl səviyyələr. "Körpünün pillələri". The Bridge to Total Freedom. Tam azadlığa aparan körpü. Hər bir sonrakı pillə əvvəlkindən baha başa gəlir. Başqalarının pulunun iyi artıq qorxutmur. Hər biri daha çox vaxt alır. Nəbz yeni ritmə alışır. Hər pillə — kəsilmiş bir daha ip. Ailə. Dostlar. İş. Xarici həyat incəlir, əti-tərini itirir, ölü dəri kimi tökülür. Görünməz sap isə getdikcə daha çox gərilir. Və bağlayır. Ölümə. Təşkilata.

Müəyyən bir səviyyədə adept "gizli doktrina" ilə tanış olur — bu, Qsenu haqqında mifdir: 75 milyon il əvvəl Yer üzərinə milyardlarla əcnəbi varlığın ruhunu gətirərək onları vulkanların kraterlərində yandıran və səpələnmiş "tetaları" indi də

yaşayan insanlara yapışaraq bütün bədbəxtliklərimizə səbəb olan şər qalaktik diktator haqqında hekayədir. Bu doktrina 1980-ci illərdə jurnalistlər tərəfindən açıqlanana qədər yalnız "körpü" üzərində illərlə və on minlərlə dollar xərcləyən adeplərə ötürülürdü. Sayentoloqlar onun mövcudluğunu inkar edir; çoxsaylı məhkəmə proseslərinə əlavə edilmiş sənədlər isə onun varlığını dəqiq şəkildə təsdiq edir.

Mövzumuz üçün vacibdir: dianetika bu piramidanın təməlidir. Adeptin yolu məhz ondan başlayır. Və məhz Frommun resenziyası bu təməlin ilk ciddi akademik məhkumudur. Həmin resenziya, Səentologiyanın bir təşkilat kimi meydana çıxmasından üç il əvvəl yazılmışdır.

İndi, bunların hamısı niyə "Cinnət pandemiyası" kitabı üçün əhəmiyyətlidir?

Çünki Habberd müasir saxta psixologiyanın ruhi sağlamlıq sahəsində istifadə etdiyi başqa bir üsulu da nümayiş etdirir.

Birinci mexanizm — mistikdir. Hellinger və Stibal bunu istifadə edirlər. Müştəriyə deyilir: "Sizin irsi bir proqramınız / DNT-də bloklayıcı bir inancınız var və biz bunu sahə / Yaradanla əlaqə vasitəsilə işləyəcəyik". Hamısı görünməyən, yoxlanıla bilməyən qüvvələrə istinad edir.

Budur ikinci mexanizm. Psevdoelm. Habbbard — onun baş operatoru. Fikir verin: o demək olar ki, heç vaxt "ruh" sözünü teləffüz etmir. "Enerji" haqqında danışmır. Lüğət başqadır. "Mühəndislik elmi". "Reaktiv zehn". "Analitik zehn". "Enqramlar". Və — vurğu ifadəsi — "bütün nevrozların yeganə mənbəyi". Bu nədir? Dildir. Amma hansı? Mimikriya. Elmi görünüş. Texniki görünüş. Müasir görünüş. İndi isə — detal. Cihaz. "E-metr". Qulp. Korpus. İlkin qalvanometrə oxşayır. Elmi cihaz kimi təqdim olunur. Bəs nə edir? "Enqramları ölçür". Düşünün. Ölçür. Enqramları. Bir sual. Sübutlar haradadır?

Mistika və psevdoelmi fərqləndirən əsas amil onların nişət aldığı auditoriyadır. Mistika özünə artıq "ruhani" dilə açıq olanları, inanmağa hazır insanları cəlb edir. Psevdoelm isə daha dəqiq zərbə endirir. Onun hədəfi — məntiqə söykənən, lakin əsl elmi onun saxtasından ayırmaq üçün kifayət qədər hazırlığı olmayan rasional insanlardır. Onlar "ruhani" olan dan üz çevirir, onunla lağ edir və məhz buna görə də psevdoelm dilinə qarşı tamamilə müdafiəsizdirlər. Mühəndis, maliyyəçi, proqramçı — məhz bu kateqoriyalı insanlar belə fırıldaqların qurbanı olurlar. Falçı? "Bunlar hamısı xurafatdır" — deyə üz çevirər mühəndis. Ora getməz. Bəs saentoloji mərkəz? "Elmə bənzəyir" — deyə başını yelləyəcək. Və düz qapana düşəcək.

Üçüncü mexanizm — bunu növbəti fəsildə görəcəyik — sosial şəbəkələrin nüfuzudur. Burada artıq nə mistika, nə də elm görüntüsü altında yalan lazım deyil. Xarizma və çoxlu abunəçi kifayətdir.

Hər üç mexanizm eyni təməl üzərində qurulub: elmi psixiatriyanın buraxıldığı boşluqlar — keyfiyyətli və əlçatan yardımın çatışmazlığı, həkim növbələrinin uzunluğu, "həblərə" güvənməmək, diaqnozdan qorxmaq və mürəkkəb suala tez və sadə cavab əldə etməyin təbii arzusu.

Və bir daha bir vacib fikir ki, onu düz deyim…

Xabbard da, Hellinger kimi, Stibal kimi, heç yerdən peyda olmayıb. O, həqiqi bir problemin cavabı olaraq meydana çıxıb. Bu problem onun dövrünün elmi psixiatriyasının zəifliyi və məhdudluğudur.

1950-ci il. "Dianetika" artıq yazılıb. Psixiatriya isə xarabalıqda. Xəstəxanalar dolub-daşıb. Yaralılarla deyil. Təcili hallarla da deyil. Xroniki xəstələrlə. Getməyən insanlarla — onları aparmaq üçün heç bir yer yoxdur. Onlar sadəcə uzanıb qalır. İllərlə. Lobotomiya? Elmi cəhətdən tanınmış müalicə. Bir neçə ay sonra Egaş Moniş buna görə Nobel mükafatını

alacaq. Tibb sahəsində. Beyni kəsməyə görə. İnsulin koması. Standart prosedur. Xəstəni qəsdən komaya salırlar — saatlarla — psixozdan çıxarmaq üçün. Ya da çıxarmamaq üçün. Elektroşok. Anesteziya olmadan. Bədən qövs şəkli alır. Dişlər parçalanır. Bu müalicədir. İlk antipsixotik dərman — xlorpromazin — hələ sintez edilməyib. Ona iki il qalıb. Psixoterapiya? Bəli. Psixoanalitik. Uzun müddətli. Bahalı. Təsiri müəyyən olmayan. Bütün bunlar belə bir çuxurdan yaranıb. Gündəmdə belə bir alternativ var idi.

İnsan, narahatlıq, depressiya, ailə problemləri, psixosomatik şikayətlərlə üzləşərək psixiatrın qapısını döyürdü — və ya heç nə alırdı, ya da lobotomiya. Seçim — demək olar ki, yox idi.

Bu boşluğa Habberd gəldi. Dedi: “Gəlin yanıma. Mən eləm. Hər şeyi müalicə edirəm. Tez. Etibarlı. Ucuz (əvvəlcə)”. Və minlərlə insan gəldi. Axmaq olduqları üçün deyil. Əsl tibb onlara heç nə təklif edə bilmədiyi üçün.

Bu, vacib bir dərsdir. Cinnət pandemiyası yalnız qurbanların naümidliyindən və təbiblərin tamahından qidalanmır. O, həqiqi bir boşluqdan — elmi təbabətin geridə qoyduğu qara dəlikdən bəslənir: inkişafdan qalmış, maliyyə baxımından kasad, təşkilatçılığı zəif, etik cəhətdən problemli bir təbabətdən.

Bu odlu kim körükləyir? Xəstə qarşısında əli-qolu düşən hər bir psixiatr. İnsanların altı ay mütəxəssis gözləyə-gözləyə sönüb getdiyi hər bir səhiyyə sistemi. Psixi sağlamlıq proqramlarından üz döndərən hər bir dövlət. Psixi gigiyena haqqında susan hər bir məktəb.

Onların hər biri — günah ortağıdır.

Bizim cavabımız yalnız dələduzları ifşa etmək deyil. Bizim cavabımız həqiqi, əlçatan, elmi, etik və vaxtında psixiatriya qurmaqdır. Yalnız o zaman boşluq yaranmayacaq. Yalnız o

zaman minlərlə "uydurulmuş xoşbəxtlik" təklifinə bazar qalmayacaq.

Erich Fromm həmin rəydən sonra daha otuz il yaşadı. O, 1980-ci ildə İsveçrədə vəfat etdi. O, Sayentologiyanın çiçəklənmə dövrünü görə bildi, lakin onun çöküşünü görməyə ömrü çatmadı — həmdə ki, bu çöküş hələ də baş verməyib. Onun 1950-ci ildəki xəbərdarlığı bu gün də aktualdır. Və insanlarda xoşbəxt olmaq üçün tez və sadə bir yol axtarışı olduğu müddətcə də aktual qalacaq.

Cavab yoxdur. Ancaq yol var. Bu yol isə Habard, Stibal, Hellinger, reqressoloqlar və onların minlərlə müasir təqlidçilərinin təqdim etdiyi şey deyil.

Yol — bu sübuta əsaslanan tibb, sübuta əsaslanan psixoterapiya, öz üzərində vicdanlı iş və ruhi həyatın mürəkkəb olduğunu və mühəndis optimallaşdırmasına gəlmədiyini qəbul etməkdir. Bu, "düymələrə basmaq"dan daha az gözəl səslənir. Amma faydalıdır.

QIRMIZI BAYRAQ. Əgər metod "səviyyələr", "pillələr" və "təqdis mərasimləri" tələb edirsə, hər növbəti mərhələ əvvəlkindən bahadırsa; əgər təlimin tam mənzərəsi yalnız "irəliləmişlərə" açılırsa; əgər metoddan uzaqlaşanları düşmən elan edirlərsə — qarşınızda nə məktəb var, nə terapiya. Qarşınızda bir hunidir. Hunidən ya dərhal çıxırsan, ya da heç çıxmırsan.

Fəsil 23. Peşənin öz içində: keyfiyyətə nəzarət olmadıqda

Bu hissədə mən elmi psixiatriyaya aid xarici təhlükələrdən danışırdım: elmdən əvvəlki dövrlərdən qalma sənayəyə çevrilmiş praktikalardan və tibbin yanında boy atan saxta tibbi istiqamətlərdən.

Bu fəsildə daxili təhlükədən danışmalıyam. Peşənin özündən çıxan təhlükədən. Bu, kitabın mənim üçün ən ağrılı hissəsidir. Çünki burada yad adamlardan, hellingerlər və stibalardan deyil, öz həmkaralarımdan yazıram. Eyni ordinaturada oturduğum insanlardan. Mənim dərs aldığım şəxslərdən. Formal olaraq mənimlə eyni diplom və vəzifəyə malik olanlardan.

Lakin bunu deməmək olmaz. Çünki problemin susqunluqla keçirilməsi onun mövcud olmasının əsas səbəblərindən biridir. Daha da əhəmiyyətlisi, bu cəhalət pandemiyası təkcə xarici dələduzlar deyil, həm də peşənin öz daxili zəifliyi ilə qidalanır.

Üç halı nümunə gətirəcəyəm. Hamısı öz təcrübəmdəndir. Anonimliyi qorumaq üçün detallar dəyişdirilib. Mənası isə olduğu kimi qalıb.

Birinci hadisə. Neyroleptik əvəzinə dua

2001–2003. Mən V. M. Bexterev adına Sankt-Peterburq Elmi-Tədqiqat Psixonevroloji İnstitutunun klinik ordinaturasında təhsil almışam. Bu, ən qədim müəssisələrdən biridir. Bütün postsovet məkanında ən nüfuzlu akademik psixiatriya mərkəz-

lərindən biri. Bu divarların arxasında bir sirr gizlidir: bu institut necə davam gətirdi? Cavab tarixdə gizlidir. 1907-ci il. Qurucusu Vladimir Mixayloviç Bexterevdir. Dünya səviyyəsinin ən böyük nevromorfoloqlarından və psixiatrlarından biri. Beynin ən dərin qatlarına nəzər salan insan. O özündən nə qoyub? Bu gün bu Milli Tibbi Tədqiqat Mərkəzidir (NMTM). Çoxsaylı elmi şöbələr. Dünya jurnallarında nəşrlər. Mütəxəssislər arasında tanınma. Zehinin sirləri burada saxlanılır.

İkinci şöbə. Qapı arxamda bağlandı və mən professor Viktor Davıdoviç Vida'nın domeninə daxil oldum — SSRİ sonrası məkanında hörmətlə qəbul edilən bir ad. Psixoanalitik oriyentasiyalı ən tanınmış psixiatr-psixoterapevtlərdən biri. Amma niyə məhz o? Bu nüfuzun arxasında nə dururdu? Viktor Davıdoviç — böyük mədəniyyətə, nəhəng klinik təcrübəyə və beynəlxalq tanınmışlığa malik insan. Şizofreniya psixoterapiyası, psixodinamika ilə bağlı kitabları rusdilli psixiatrların bütün bir nəsli üçün dərs vəsaitinə çevrilib. Hər bir səhifə — bir koddur. Hər bir nəzəriyyə — uçuruma sürüşən ağla açılan bir açardır. Ondan dərs almaq — bir imtiyazdır. Mən bunu bu gün də qiymətləndirirəm.

Amma həmin şöbədə başqa bir həmkar da işləyirdi — onu doktor S. adlandıraq. Yetkin, bir qədər yaşlı, institutda çox illərdir çalışan bir insan idi. Diplomuna görə psixiatr idi. Təcrübəli klinisist. Xəstələr tərəfindən diqqətli və ləyaqətliliyi ilə hörmət görürdü.

Doktor S. dərin dindar bir xristian idi. Bunun heç bir xüsusiyyəti olmazdı — hər bir insanın şəxsi inancı onun hüququdur. Məsələ ondaydı ki, Doktor S. öz imanını klinik praktikası ilə necə birləşdirirdi.

O dua yazırdı. Öz əli ilə. Kağız vərəqinə. Və xəstəyə verirdi — tapşırıqla birlikdə: gündə filan qədər oxu. Ruhani praktika kimi yox. Müalicəyə əlavə kimi yox — bunun dua olduğunu, tablet olmadığını anlayan insanın razılığı ilə. Xeyr. Elə bu olmalı idi ki, adamı sayıqd saxlasın. Hər şey elə buradan

başladı. Doktor S. — keşiş deyil, şəfa verən deyil, meydandakı şarlatan deyil. Həkimdir. Diplomu var. Əlində xəstəlik tarixçəsi. Və o, duanı bu tarixçəyə yazırdı. Resept kimi. Doza kimi. Terapevtik alət kimi. Sətir-sətir — milliqramların və qəbul tezliyinin yazılmalı olduğu yerə. Onun öz ifadəsi bütün sübuta əsaslanan tibbə hökm kimi səslənir: — Mən effekti görürəm. Fərqi görürəm. Xəstə dua edəndə — özünü yaxşı hiss edir.

Bu, aparıcı akademik müəssisələrdən birində baş verirdi. 2002-ci ildə. Şizofreniya şöbəsində. Diaqnozu təsdiqlənmiş psixotik pozğunluqları olan xəstələrdə.

Mən gənc ordinatura idim. Bununla nə edəcəyimi bilmirdim. Baxırdım və susurdum.

O, heç bir bəndi pozmadı. Heç birini. Postsovet etik məcəllələrini açın — duanın qadağan edilməsi haqqında bir kəlmə yox. "Dua terapiyasının" qadağan edilməsi haqqında bir sətir yox. Boşdur. Nöqtə. İyirmi beş il fərq. Dörddə bir əsr klinik təcrübə mənim nəzəriyyəmə qarşı. Onun intuisiyası — daha müdrik. Belə güman edilirdi. Xəstənin çarpayısı başında onu görən hər kəsin şüuraltına belə həkk olunub: hər hansı kitabdan daha çox xatırlayan bu əllər. Bəs əgər bu işləyirsə? Əgər xəstələr həqiqətən palatadan başqa cür çıxırsa — plasebo vasitəsilə, dəstəkləyici ünsiyyət vasitəsilə, nə vasitəsilə olursa olsun — onda nə? Xəta haradadır? Pozuntu haradadır? Budur sual. Budur tapmaca. Üç quru "formal olaraq" — və bir dənə də cavab yox.

Bəladır ki...

Psixiatr dua ilə neyroleptiki bir sıraya qoyanda, elmi tibbin öz statusunu sarsıdır. Xəstəyə deyir: "Haloperidol qəbul etmək — bir təsirdir, dua isə — başqa. İkisi də işləyir". Xəstə mesaj alır: elm və dini praktika eyni terapevtik statusa malikdir. Və sonra xəstənin qaçılmaz olaraq özü inkişaf etdirdiyi məntiq başlayır: əgər dua kömək edirsə — bəlkə tək başına da kifayət-

dir? Əgər fəal dua etsəm — bəlkə dərmanlara ehtiyacım olmayacaq?

Biz indi şizofreniyası olan xəstələrdən danışırıq. Kəskin fazada antipsixotiklərlə müalicə aparılmasa, vəziyyətin getdikcə pisləşməsi, sosial dezadaptasiya, reallıqla əlaqənin itirilməsi və intihar təhlükəsi olan insanlardan. Onların sübuta əsaslanan farmakoterapiya ilə əlaqəsini zəiflədən hər hansı mesaj — son nəticədə ölümə gətirib çıxaran mesajdır.

Amma daha pisi başqa idi. Doktor S.-i gənc həmkarlar müşahidə edirdilər: internlər, ordinaturalar, aspirantlar. Onlar üçün Belxteyev ilk həqiqi klinik təcrübə olurdu. Burada səhvlərin qiyməti başqasının psixikası idi. Və onlar görürdülər: professor həmkarı birbaşa klinikada "dua terapiyası" tətbiq edir. Heç kim onu dayandırmır. Heç kim əlindən tutmur. Yeni başlayan üçün bu nə deməkdir? Bu normaldır? Elmi tibbi ruhani praktikalarla qarışdırmaq normaldır? Öz subyektiv dini intuisiyasını neyroelmlə eyni dəyərdə saymaq normaldır? Onilliklərlə klinik tədqiqatlar? Yandır. At. Görməzdən gəl. Axı əsas olan — öz gözünlə "effekti görməkdir".

İnanıram ki, həkim S. — cinnət pandemiyasının strukturunu onun əsas düşməni daxilində, akademik psixiatriya daxilində yenidən yaradırdı. Bu — elmi tibbin daxilən xəyanət formasıdır. Qəsdli deyil — o yaxşı insan idi. Ancaq bundan zərəri heç də az deyil.

Ən narahatedicisi isə odur ki, belə həkim tək deyildi. Behterev adına institutda və digər post-sovet məkanlarındakı müəssisələrdə onlarla var idi. Kimi dualar yazırdı, kimi "keşişə getməyi" tövsiyə edirdi, kimi "bioenergetik" üsullardan istifadə edirdi, kimi xəstələrə mantralar oxuyurdu, bəziləri isə "nəsili yaddağa görə mütəxəssislərə" yönləndirirdi (!). Bunlar heç də istisna deyildi. Post-sovet psixiatriyasının bir hissəsi üçün bu, normal həddaxilində baş verirdi.

Buna görə də bu fəslin mövzusunu sosial şəbəkələrdəki saxta müalicəçilər mövzusundan daha az əhəmiyyətli hesab etmirəm. Əgər elmi psixiatriyanın qalasının özündə belə çatlar varsa — qalanın xaricində saxta elmlərlə mübarizənin heç bir faydası olmaz.

İkinci hal. On üç illik OKR və "seksoterapiya"

Mənim qəbuluma 33 yaşlı bir qadın gəldi. Adını Leyla qoyaq. Ali təhsilli, daimi işi olan, iqtisadi cəhətdən müstəqil. Heç evlənməyib. Dindar ailədən olsa da, ciddi dini əməllər yerinə yetirmir.

Onun problemi 16 yaşından başlayıb. Obsessiv-kompulsiv pozuntu. Çirklənmə ilə bağlı nahaq qorxular. Saatlar boyu əl yuma. Kompulsiv şəkildə sobun söndürülüb-söndürülmədiyini, qapıların bağlı olub-olmamasını yoxlamaq. Onu əzəbləndirən və qurtula bilmədiyi takrarçı düşüncələr. Davamlı narahatlıq. Gecələri yalnız 4-5 saat yatırdı. Həyatının öz beyni ilə mübarizədə keçdiyini hiss edirdi.

Bizim görüşümüzdən 13 il əvvəl — 16 yaşından 29 yaşına qədər — Leyla mütəxəssislərə müraciət edib. Əvvəlcə doğma şəhərində psixiatrlara. Sonra Moskvada. Daha sonra valideynləri onu "ən yaxşı həkimi" görmək üçün İstanbula aparıblar.

On üç il. Tam on üç il — buna qarşılıq nə aldı? Demək olar ki, heç nə. Yalnız bir ovuc həblər. Birinci psixiatr. Fluoksetin. Doza aşağı idi. Altı aydan sonra bir az yüngülləşdi. Sonra hər şey yenidən qayıtdı. Qaranlıq yenidən onu əhatə etdi. İkinci. Paroksetin. Əvəzedici. Üçüncüsü kvetyapin əlavə etdi. Narahatlıq üçün. Dördüncüsü klonazepam yazdı. Yatmaq üçün. Beşincisi — risperidon. Kiçik dozalarda. 28 yaşına çatanda Leyla artıq eyni vaxtda dörd preparat qəbul edirdi: antidepressanat, atipik nevroleptik, benzodiazepin və yuxu dərmanı. İşgəncə çəkən bədənin hər hücrəsinə açılan dörd kimyəvi açar. Bu dərmanların hər biri ona vaxtı ilə verilibdi. Hər biri qısa

müddət kömək edibdi. Hər biri ya işləməyi dayandırıb, ya da yan təsirlər veribdi. Və sonra amansızcasına növbəti ilə əvəz olunubdu.

Bu psixiatrların heç biri ona psixoterapiya təklif etməyib.

Bu şoka salardı — əgər təəssüf ki, tipik hal olmasaydı.

Obsessiv-kompulsiv pozuntunun (OKP) müalicəsi üzrə beynəlxalq protokollar — Amerika Psixiatriya Assosiasiyası, NICE (Böyük Britaniya) və Dünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələri — bir məsələdə hamılıqla razıdır: OKP-də birinci xətt terapiya reaksiyanın qarşısını almaqla ekspozisiya (exposure and response prevention, ERP) adlanan, xüsusi kognitiv-davranış terapiyası növüdür. Bu terapiya düzgün tətbiq edildikdə xəstələrin təxminən səksən faizində əhəmiyyətli yaxşılaşma təmin edir. Dərmanlar terapiyanı tamamlaya bilər; yüngül hallarda bəzən ERP olmadan təkbaşına SSRI dərmanları kifayət edir; lakin psixoterapiya olmadan yalnız dərmanlə müalicə etmək səhiyyə standartlarının pozulmasıdır.

Bəs niyə Leyla 13 il ərzində psixoterapiya ala bilmədi?

Səbəblər boğucu bir çələngə dönüb. Birincisi — postsovet məkanında həqiqi ERP üsullu kognitiv-davranış terapiyasına praktiki olaraq çatmaq mümkün deyil. Dünya standartlarında təlim keçib bu üsulu tətbiq edən mütəxəssislərin sayı hər böyük şəhərdə ələ sayılırdır. Digərlərinin "kognitiv-davranış terapiyası" adlandırdığı şey nədir? Ümumiyyətlə, hər şey. "Pozitiv düşün" kimi templi məsləhətlərdən tutmuş ezoterika qatılmış şarlatanlıqlara qədər. Xilasetmə yerində saxtakarlıq. İkinci səbəb daha dəhşətlidir: psixiatrların özləri çox vaxt ERP-nin real effektivliyindən xəbərsizdirlər. Onlar biomedikal paradiqmanın dəmir qapıları arxasına kilidlənibiər, yeganə çarə tabletkanı dozunu düzəltməkdir. Resept yazmaq. Simptomu boğmaq. Üçüncü səbəb isə ürəyinə enən zərbədir — sırf iqtisadiyyat. Psixiatr qəbulu sığorta tərəfindən ödənilir. Psixoterapevt qəbulu ya ödənilmir, ya da cüz'i məbləğdir. Psixiatr

xəstəni 15 dəqiqəyə qəbul edir. Psixoterapevt həftədə bir saat vaxt ayırmalıdır. Uzun aylar boyu. İqtisadiyyat amansızcasına dərman həllinə sövq edir. Sistem insanları həblər dəyirmanında əzir.

13 il Leyla gəldi. Dərman qəbul etdi. Gözlədi. "Bəlkə bu dərman fayda eləyəcək". Fayda eləmədi. Ya da iki-üç ay kömək etdi, sonra effekti bitdi.

Sonra — və bu onun hekayəsinin ən ağır hissəsinin başlanğıcıdır — müalicə edən psixiatrlarından biri, dərmanların faydasız olduğunu görüb, ona başqa bir "müalicə" təklif etdi. Bu həkimin dilində buna "seks-terapiya" deyilirdi.

Təklif belə idi: "Siz otuz yaşınızı keçmisiniz. Heç yaşadığınız cinsi əlaqə olmayıb. Freyd göstərib ki, nevrozların çoxu basdırılmış cinsi istəklə bağlıdır. Əgər cinsi əlaqəyə girəsənsə, OKP-dən xilas olacaqsan". Daha sonra psixiatr özünü cinsi tərəfdaş kimi təklif edirdi — "əyləncə üçün deyil, müalicə prosesinin hissəsi kimi". İzah edirdi ki, məhz buna görə "seks-terapiya" etibarlı mütəxəssis tərəfindən, hər hansı kimsə tərəfindən deyil, aparılmalıdır.

Leyla razılaşdı.

Gəlin burada dayanaq. Bəs niyə razılaşdı?

O axmaq deyildi. Yüngülxasiyyət də deyildi. On üç il nəticəsiz müalicə onu tükənmişdi. Həkimə inanırdı — bu, onun ilk psixiatrı deyildi, bu konkret şəxslə bir neçə aydır əlaqədə idi. Ümidsizliyə qapılmışdı. Peşəkar hesab etdiyi bir adam ona son çarəni təklif edirdi. Onun etnik və dini görüşləri nikahdan əvvəlki münasibətlərə zidd idi, lakin xəstəlikdən qurtulmaq istəyi hər şeydən ağır gəldi. Daxili müqavimətini qıraraq razılaşdı — necə ki, insan cərrahiyyə əməliyyatına razılaşır.

Nəticələr elə oldu ki, olmalı idi. Leyla bu psixiatrla intim münasibətə girdi — əvvəlcə bir dəfə, sonra bir daha. Onun OKB-si heç yerə getmədi. Psixiatr bir neçə görüşdən sonra marağını itirdi və onun vəziyyətinin adi dərman müalicəsinə

qayıtdı. Özünə hörmət, dini özünü dərk etmə, tibbə inam — hamısı dağıdıldı.

Bir neçə ay sonra isə — o, baş verənləri dərk etdi. Bu "terapevtik proses" deyildi. Bu — müalicə maskası altında cinayət idi.

Gəlin indi bu hadisəyə beynəlxalq etika baxımından baxaq.

Madrid. 1996-cı il. Artıq bəhs etdiyimiz mətn — Madrid Bəyannaməsi — qanı donduran bir düstur həkk edir. Yavaş oxuyun. Sətirlər arasında oxuyun. Niyə burada xəstənin razılığı müdafiə deyil, hökmdir? Çünki bəyannamə hakimiyyətin dəhşətli anatomiyasını açır. Bilik. Psixiatrın xəstə haqqında malik olduğu bilik əvvəlcədən qüsurludur — hələ heç bir toxunuş olmadan. Bəs hakimiyyət fərqi? O, həkimə başqasının iradəsi və başqasının bədəni üzərində xüsusi güc verir. Və bu şəraitdə razılıq artıq razılıq olmaqdan çıxır. O, istismara çevrilir. Təmiz. Amansız. Və o zaman bəyannamə şillə kimi vurur. Heç bir halda — eşidirsinizmi? — heç bir halda psixiatr xəstəsi ilə hər hansı formada cinsi davranışa girməməlidir. Heç bir halda. İlk addımı kimin atmasının əhəmiyyəti yoxdur. Bunu xəstənin, yoxsa terapevtin təşəbbüs etməsinin əhəmiyyəti yoxdur. Sərhəd möhürlənib.

"Kimin təşəbbüs etməsinin əhəmiyyəti yoxdur" düsturu — əsas məqamdır. O, adi məntiqi parçalayan çəkicə çevrilir. O, pozucuların klassik bəhanəsini kökündən qoparır: "o özü razılaşdı", "o özü birinci təklif etdi", "bunlar yetkin insanlar idi". Zərbə. Bir zərbə də. Psixiatrik etika məcəllələri amansız həqiqəti üzə çıxarır: terapevtik münasibətlərdə hakimiyyət asimmetriyası əsl razılığı qeyri-mümkün edir. Təsəvvür edin: nəzarətçi məhbusa güzəşt müqabilində "könüllü" cinsi əlaqə təklif edir. Formal olaraq razılıq mümkündür. Reallıqda — bu zorlamadır. Niyə? İmtina məhbusun üzərinə ağır nəticələr yağdırır. Terapevtik münasibətlərdə vəziyyət struktur baxımından eynidir.

ABŞ-da ştatların əksəriyyətində psixiatrın pasiyenti ilə cinsi əlaqəsi cinayət məsuliyyətinə səbəb olan əməl kimi qiymətləndirilir. Bir sıra Avropa ölkələrində də vəziyyət eynidir. Peşə assosiasiyası belə bir hadisədən xəbər tutan kimi həkimin lisenziyasını birdəfəlik ləğv edir.

Azərbaycan. Rusiya. Keçmiş İttifaqın qırıntıları olan daha onlarla ölkə. Heç bir sanksiya işə yaramadı. Heç biri. Bu psixiatr — o, indi də kabinetdədir. Pasiyent qəbul edir. Resept yazır. İmza atır — o geniş, arxayın imzanı. Onun soyadı heç bir intizam işində hallanmadı. Bir dəfə də. Bütün bu illər ərzində. Bəs Leyla? Leyla susur. Ailəsi bilmir. Nə anası, nə atası, nə qardaşı — heç kim. Və o, bilməmələri üçün əlindən gələni edəcək. İman ona danışmağa qadağan edir. İman qəzəbdən də güclüdür, ağrıdan da, o kabinetdən sonra ondan qalan hər şeydən də. Bəs səhiyyə sistemi? O hadisədən sonra onun sistemə inamı — sıfırdır.

O, mənə tövsiyə ilə gəldi. Bir il müalicə etdiyim qadın — klassik KPT, oxşar pozuntu — ona nömrəmi verdi. Leylanın otuz üç yaşı vardı. Otuz üç yaş — və bir dənə də düzgün diaqnoz yox. Bir dənə də adekvat müalicə yox. İl yarım. Klassik koqnitiv-davranış terapiyası. Ekspozisiya. Reaksiyanın qarşısının alınması. Tədricən — milliqram-milliqram — dərman yükünün azaldılması. Onun hər gün yerinə yetirdiyi ritualar, saatları oğurlayan kompulsiyalar — yox oldu. Takıntılı fikirlər — illərlə beynini dəmir qandallarda saxlayan o fikirlər — sadəcə yaşamağa imkan verən səviyyəyə qədər geri çəkildi. Normal yaşamağa. Dərman dozasını azaltdı. Sonra böyük hissəsini tamamilə dayandırdı. Otuz üç yaşında Leyla ilk dəfə pozuntusuna adekvat müalicə aldı.

Terapiyanın aktiv mərhələsi bitdikdən bir il sonra Leyla çətin bir qərar verdi. Ölkədən getdi. İqtisadi səbəblərdən deyil — yaxşı işi vardı. Ona görə getdi ki, doğma şəhərində "müalicə" tarixini bilən insanlar arasında artıq yaşaya bilmirdi.

Başqa ölkədə, başqa mədəniyyətdə həyata yenidən başladı və bu gün — mənə məlum olduğu qədər — xoşbəxtdir.

Üçüncü hal. Psixoterapiyasız farmakoloji rutin

Üçüncü hadisəni qısa danışacağam, çünki strukturu əvvəlkinə bənzəyir, sadəcə cinsi komponenti yoxdur.

Qırx iki yaşlı qadın. Ona Mehrə deyək. Orta ağırlıqlı depressiv pozuntu, ilk epizod otuz iki yaşında, boşanmadan sonra. O vaxtdan — on il fasiləsiz dərman müalicəsi. Bu on il ərzində ardıcıl olaraq: mirtazapin, sertralin, venlafaksin, essitalopram, duloksetin, vortioksetin, bupropion qəbul edib. Cəmi yeddi antidepressan. Buna müxtəlif dövrlərdə müxtəlif preparatlar da əlavə olunurdu: "yatmaq üçün" kvetiapin, "təsiri gücləndirmək üçün" litium, "dincəlmək üçün" modafinil.

Effektivlik? Müvəqqəti. Hər yeni dərman bir neçə ay yaxşılaşma verirdi, sonra yenidən üstünə gəlirdi. Psixiatrlar bunu rezistent depressiya kimi yozur və növbəti kombinasiya axtarırdılar.

Psixoterapiya — on il ərzində bir dənə də seans yox. Nə BDT, nə şəxsiyyətlərarası, nə davranış aktivasiyası — depressiyanın sübuta əsaslanan müalicə üsulları. Hətta vəziyyətinin səbəbləri ciddi müzakirə belə olmayıb: boşanma şəraiti, analıqdan məhrum olma (qızı keçmiş əri ilə yaşayırdı), tənhalıq, peşə fəaliyyətinin dayandırılması.

O, yanıma xroniki depressiya və ümidsizlik fikirləri ilə gəldi. Kəskin faza deyil — uzun sürən, sabit pis vəziyyət. İş qabiliyyəti var, amma həzz yox. Yaşayır, amma iştirak etmədən.

İşə başladıq. İlk iki ay — artıq dərmanların tədricən ləğvi (biri adekvat dozada saxlanıldı), paralel olaraq — davranış aktivasiyası ilə həftəlik BDT seansları. Fokusda — onun konkret koqnisiyaları, real münasibətləri, gününün planlaşdırılması, sosial əlaqələri.

Bir ildən sonra — remissiya. Tam. İki ildən sonra — son antidepressant da ləğv edildi. Üç ildən sonra — peşəsinə qayıtdı, yeni partnyor tapdı, qızı ilə münasibətlərini bərpa etdi.

On il onun həyatının dərman karuselində keçməsi — təkcə onun itirilmiş illəri deyil. Bu — belə on ilin mümkün olduğu bütün sistemə sualdır.

Bu üç halı nə birləşdirir?

Hər üç hal postsovet məkanında və dünyanın bir sıra digər regionlarında müasir psixiatriyanın ümumi sistem qüsurunu göstərir.

Bu qüsur — xidmətin keyfiyyətinə nəzarət mexanizminin olmamasıdır.

Xəstə psixiatra gəlib illərlə işləməyən müalicə alanda — heç bir mexanizm işə düşmür ki, sual qaldırsın: bu müalicə düzgündürmü? Müasir standartlara uyğundurmu? Niyə nəticə vermir?

Akademik müəssisədə həmkar psixiatr qeyri-rasional metodları tətbiq edib onları tibbi metodlarla qarışdıranda — heç bir mexanizm işə düşmür ki, onu düzəltsin və ya dayandırsın.

Diplomlu psixiatr cinayət məsuliyyəti ilə həmsərhəd olan ən kobud etik pozuntu törədəndə — heç bir mexanizm işə düşmür ki, o məsuliyyət daşısın.

Bu — keyfiyyətin təminatı sisteminin iflasıdır. Və bunun çox səviyyələri var.

Birinci səviyyə — təhsil. Postsovet ölkələrində psixiatrlara və klinik psixoloqlara çox vaxt psixoterapiyadan qat-qat çox dərman müalicəsinin tətbiqi öyrədilir. Sübuta əsaslanan psixoterapiya metodlarının — ERP, BDT, DBT, şəxsiyyətlərarası, travma-fokuslu — tədrisi çox vaxt mühazirələrlə məhdudlaşır;

real superviziyalar və uzunmüddətli təlimlər nadir hallarda keçirilir və adətən mütəxəssislərin öz hesabına olur.

İkinci səviyyə — tənzimləmə. Psixiatr həkimin lisenziyası bir dəfə verilir və praktiki olaraq müddətsizdir. Davamlı tibbi təhsilə tələblər formal xarakter daşıyır. Lisenziyanın ləğvi mexanizmləri zəif işləyir — hətta kobud etik pozuntulara görə belə.

Üçüncü səviyyə — peşə assosiasiyaları. Amerikanın APA və ya Britaniyanın Royal College of Psychiatrists təşkilatından fərqli olaraq, postsovet məkanında psixiatrların peşə birlikləri əsl etibarı ilə şikayətləri araşdıra və sanksiya tətbiq edə bilən etik komitələrə malik deyil. Xəstə həkimə şikayət etdikdə, bu adətən Səhiyyə Nazirliyinə göndərilir və orada bürokratiyanın dərinliklərində itib gedir.

Dördüncü səviyyə — xəstə. Keyfiyyətsiz xidmət alan xəstə çox vaxt öz hüquqlarını bilmir və onları qorumaq üçün vasitələrə malik olmur. Keyfiyyətsiz məhsul aldıqda — istehlakçı hüquqlarını qoruyan qanunların, ekspertlərin, məhkəmələrin və anlaşılan prosedurların kömək etdiyi vəziyyətdən fərqli olaraq, keyfiyyətsiz tibbi xidmət halında xəstə özünü sistemlə üz-üzə qoyulmuş və qarşısında qüvvətli tərəf olan vəziyyətdə tapır.

Beşinci səviyyə — sosial. Həkimə, xüsusilə psixiatra şikayət. Xüsusilə də həssas məsələlərə görə. Bütün bunlar stiqmatizasiyaya məruz qalır. Səsini qaldırmağa cürət edən xəstə dərhal etiket alır: “Psixi problemləri var, buna görə şikayət edir”. Sistem ideal bir tələyə çevrilir. Sükut sui-qəsd effekti yaranır. İngilisdilli tibbi etikada bunun dəqiq bir adı var — conspiracy of silence. Qurbanlar dəhşətdən lal qalıb. Və buna görə qaydaları pozanlar öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Çünki onların qurbanları danışmaqdan qorxurlar.

Kitabın əsas mövzusu ilə əlaqə

İndi — niyə bu fəsil cinnət pandemiyası haqqında kitabda təsadüfi deyil.

Rəsmi psixiatriya sistemində keyfiyyətsiz xidmət alan hər bir xəstə qaçılmaz şəkildə saxta şəfalar bazarının qurbanına çevrilir. On üç il. On üç il insan dərman qəbul edir, amma OKR bir addım belə geri çəkilmir. Tibbdən ümidin kəsilməsi ürəyə zərbə endirir. Ya da başqa bir hal: akademik müəssisə, elmi dərəcələr — və budur, psixiatr təyinatlarla yanaşı dua oxuyur. Elm harada bitir? Ezoterika haradan başlayır? Sərhəd bulanıb. Üçüncüsü. Xəstəsi ilə cinsi istismar edən psixiatr. Bədən ağ gödəkçə altında yad əlləri xatırlayır. Artıq heç bir həkim yoxdur. Heç vaxt.

Bütün bu insanlar — ThetaHealing, Hellinger aranjimanları, regressiv hipnoz üçün hazır auditoriyadır. Narazı, ümidi qırılmış, çarəsiz qalanlar — "tez cavab" satanlar üçün ideal hədəf qrupudur. Və onlardan bəziləri həqiqətən də oraya yönələcəklər — axmaq olduqları üçün yox, rəsmi sistem onları satdığı üçün.

Cinnət pandemiyası yalnız yardım sahəsindəki boşluqlardan deyil, həm də mövcud yardımın birbaşa səhvlərindən qidalanır. Və elm psixiatriyası öz evində nizam-intizam yaratmayınca — xəstələri dələduzların qucağına itələməyə davam edəcək.

Peşənin özünütəmizlənməsi — zəruridir. Bunun üçün bir neçə şey lazımdır.

Birincisi. Araşdırma və sanksiya səlahiyyətlərinə malik real etik komitələr.

İkincisi. Mütləq davamlı tibbi təhsil sistemi və imtahanlar keçirilməlidir ki, onun nəticələrinə görə həkim lisenziyasını itirə bilər.

Üçüncüsü. Həkimlərin ictimai reyestrləri olmalıdır ki, orada təsdiq olunmuş bütün intizam cəzaları qeyd edilsin.

Dördüncüsü. Xəstələr üçün təhlükəsiz şikayət yolları yaradılmalıdır — anonimlik və qisas qorxuşundan mühafizə zəmanətləri ilə.

Beşincisi. Peşə daxilində mədəni dəyişiklik — qaydaları pozanlarla həmsədrliyi dayandırmaq və peşənin nüfuzunun qorunmasının şəffaflıq, məsuliyyət, problemləri gizlətməkdən yox, üzə çıxarmaqdan keçdiyini qəbul etmək.

Bu tələblərdən heç biri yerinə yetirilməz deyil. Bir sıra Qərb ölkələrində bunlar müxtəlif dərəcələrdə həyata keçirilib. Postsovet məkanında isə onlar sadəcə bəyanat səviyyəsində qalır.

Bunlar həyata keçirilməyincə, cəhalət pandemiyası artmağa davam edəcək. Peşənin daxilində. Onun ətrafında. Hər yerdə.

Üçüncü ara oyun. Xəstənin səsi

Bu monoloq həqiqi hekayələr əsasında qurulub; adlar və detallar dəyişdirilib.

On üç il — sonradan hesabladığım müddətdir. İçində yaşayarkən saymırsan, orada zaman başqadır: illə ilə deyil, rituallarla ölçülür.

Mənimkisi belə idi: əgər sobanı altı dəfə yoxlamasam — ev yanacaq, və günahkar mən olacağam. Bilirdim ki, soba söndürülüb. Yanlış başa düşməyin, bilmədiyimdən deyil. Əzab da elə burdadır ki, hər şeyi bilirsən — yenə də yoxlamağa gedirsən, çünki narahatlıq nə bildiyini soruşmur. Altı dəfə soba. Sonra əllər. Sonra yatmazdan əvvəl "düzgün" düşüncələr, əgər "səhv" düşüncə gəlsə — hər şey başdan.

On üç il ərzində dörd həkimə getdim. Birincisi dərman yazdı. Bir ay sonra gəlməyimi dedi. Dərmanlar səsi kəsirdi — çalar saatın üstünə qoyulmuş yastıq kimi: çalır, amma boğuq. İkincisi dərmanları dəyişdi. Üçüncüsü ödənişli idi. Bahalı. O mənimlə "uşaqlıqla işləyirdi". Üç il uşaqlıqla işlədik. Uşaqlığım haqqında hər şeyi öyrəndim. Amma sobanı yenə də altı dəfə yoxlayırdım. Dördüncüdən danışmaq istəmirəm. Haqqında bu kitabda artıq yazılıb. Bir şey deyim: həkim xəstəliyinə baxıb sənə belə bir şey təklif edəndə — əllərini altı deyil, daha çox yumağa davam edirsən.

Sonra — otuz dörd yaşımda — bir həkimi tapdım ki, ilk görüşdə on üç ildir heç eşitmədiyim üç hərf dedi. Dedi: sizi necə müalicə ediblər — OKR-ni elə müalicə etmirlər; OKR-da konkret üsul işləyir, adı EPRdir; çətin olacaq, yanınızda olacağam, asanından başlayaq.

“Asanından başlayaq” necə olur bilirsinizmi? Sobanı söndürürsən. Bir dəfə yoxlayırsan. Və mətbəxdən çıxırsan. Geri qayıtmırsan. Otaqda oturursan. Və o basır — narahatlıq. Qalın, isti, bədənində qalxır, su basmış zirzəmidə qara su kimi. Ürək qabırğalara döyür. Həkim telefonun o ucundan sistemin şifrəsini sındıran parolu deyir: “Döyüşməyin. Sadəcə gözləyin. Baxın nə edəcək”. Və siz gözləyirsiniz, dəri ilə hiss edirsiniz ki, bu dalğa zirvəyə çatır, donur... və enir. Özü-özünə. Ritualsız. On üç ildir ilk dəfə mənlə narahatlıq arasında sehr yox idi — və mən yanmadım, ev də yanmadı.

Birinci axşam ocağı bir dəfə yoxladığım an yaddaşımda elə qaldı ki, insanlar toy gününü xatırlayır. Dəhlizdə dayanıb ucadan gülürdüm. Təkbaşına, axmaq kimi. On üç il — və belə çıxır ki, bir üsul varmış. Bu üsul bütün bu müddət ərzində mövcud imiş. Dərsliklərdə, protokollarda, üç hərfdə imiş — mən uşaqlarla işləyib, oyaq qalmaq üçün həb udduğum vaxtlarda.

Pis deyiləm, heç kimi mühakimə etmək istəmirəm. Sadəcə bunun bir yerə böyük hərflərlə yazılmasını istəyirəm: əgər OKR-niz varsa — mütəxəssisinizdən soruşun ki, EPR nədir. Və onun üzünə baxın. Üzündən hər şey aydın olacaq.

İndi sobanı bir dəfə yoxlayıram. Hamı kimi. Təsəvvür belə edə bilməzsiniz nə böyük xoşbəxtlikdir — sobanı hamı kimi yoxlamaq.

V HİSSƏ. Sərhədsiz Pandemiya

Fəsil 24. Klinikanın divarlarından kənarda: sərhədsiz formula

Oxucu bu səhifəyə qədər cinnət pandemiyasının yalnız bir ərazidə yayıldığını düşünmək haqqına malik idi. Onun yalnız psixiatriya ilə "psixologiyaya bənzər" şeylər arasında yaşadığını zənn edirdi: aranjimanlar, teta-hilinq, reqressiyalar, dianetika. Ruh bazarına yaxınlaşmamağın kifayət olduğunu, beləliklə, təhlükəsiz olduğunu düşünürdü.

Bu, elə deyil. Və bu fəsil — kitabın adının niyə pandemiyadan bəhs etdiyi barədədir.

Dəliliyin formulasi intizam sərhədlərini tanımır. Bu, hər yerdə işləyir, harada üç şərt bir araya gəlir: əzab çəkən insan, bir qəpik həqiqət və bu qəpiki panaseyaya çevirməyə hazır olan satıcı. Onkologiya. Qastroenterologiya. Dietologiya. Pediatriya. Din. Nümunələrlə göstərəcəyəm — və görəcəksiniz ki, hər birinə artıq rast gəlmisiniz. Bəlkə də öz qohumlarınızın mətbəxində.

Köpək balığı qığırdağı məsələsi.

Bir az həqiqət: qığırdaq demək olar ki qan damarlarından məhrum olan bir toxumadır və laboratoriyada qığırdağın komponentləri həqiqətən də damarların böyüməsini əngəlləyə bilər. Bəs şişlərin böyüməsi üçün isə damarlara ehtiyac var.

1990-cı illərin əvvəli. Kitab dükanlara hücum edir. Onun adı bir hökm kimi təng səslənir: "Köpəkbalıqları xərçəng xəstəliyinə tutulmur". Satıcının məntiqi uşaqlar kimi aydın, amanməxrəcdir. Köpəkbalıqlarının çox qığırdağı var. Köpəkbalıqları xərçəng xəstəliyinə tutulmur. Köpəkbalıqlarının qığırdağını yeyin, xərçəngdən qorunun. Hiyləni hiss edirsiniz?

Şırıməgəl məntiq işə düşdü. Düstur milyonların beynini sarsıtdı. Metod: toz halına gətirilmiş qığırdaq kapsulları. Sənaye: yüz milyonlarla dollarlıq qlobal əlavə bazarı. Nəticə: milyonlarla köpəkbalığının məhv edilməsi. Və boş əmək...

Və indi — faktlar. Yalnız faktlar. Birincisi. Köpəkbalıqları xəstələnir. Xərçəng xəstəliyinə. Sənədləşdirilib. Təsdiq edilib. Protokollaşdırılıb. Və burada — taleyin amansız istehzası ilə vurduğu zərbə. Köpəkbalıqlarında xərçəng xəstəliyi qığırdağın özünə hücum edir. Minlərlə insanın şifa ümidi ilə udduğu elə qığırdaq. Düşünün. İnsanlar xərçəngin köpəkbalığında məhv etdiyini udurlar. İkincisi. Fərziyyə quralım. Bir anlıq fərz edək ki, köpəkbalıqları xərçəngə tutulmur. Bəs onda? Heç nə. Mətləb elə heç nə. Çünki udulan qığırdaq mədənin turşu hovuzuna gedər. Fermentlər onu aminturşulara parçalayar. Hər hansı bir zülal kimi. Bir parça ət kimi. Xərçəngə heç bir effektiv molekul çatmaz. Üçüncüsü. Əsas zərbə. Nəhayət, hipotez lazımınca yoxlanıldı — xərçəng xəstələrində nəzarətli klinik təcrübələrlə. Həqiqətən yoxlanıldı. Nəzarət qrupu ilə. Protokol ilə. Rəqəmlərlə. Və nə oldu? Köpəkbalığı qığırdağının heç bir təsiri olmadı. Nə şişə. Nə də sağ qalmağa. Sıfır.

Bu işin qurbanları təkcə köpəkbalıqları deyil. Bunlar həm də "təbii vasitə işlədiyi müddətdə" kimyaterapiyanı təxirə salan xəstələrdir. Onkologiyada gecikmə həyatla ölçülür.

Bağırsaqdan gələn serotonin məsələsi.

Bu iş — ən ibrətamizdir, çünki burada həqiqətin bir çimdiyi xüsusilə böyükdür. Bəli, bədəndəki serotoninin təxminən doxsan beş faizi həqiqətən də beyində deyil, bağırsaqda — enteroxromafin hüceyrələrində sintez olunur. Bu fizioloji dərslikdən götürülmüş həqiqətdir.

Görün bu həqiqətlə formul nə edir. "Serotonin — xoşbəxtlik hormonudur. Onun doxsan beş faizi bağırsaqdadır. Deməli, depressiya bağırsaqdan gəlir. Deməli, bağırsağı təmizlə — depressiya keçəcək." Və ardınca — detokslar, "şlak-

lardan" təmizləmələr, "depressiya və narahatlıqdan" qurtulmaq üçün müəllif protokolları, dördüncü həftəyə antidepressantları ləğv etmək vədi ilə "sağlam bağırsaq" marafonları.

Bu zəncirdəki qırılma ikinci addımdadır. Və bu qırılma təməl xarakter daşıyır. Bağırsaq serotonini beyinə keçmir. Heç vaxt. Onun yolunu qan-beyin baryeri kəsir — kar bir divar. Bağırsaq serotonini aşağıda qıfıllıdır. O öz qaralama işi ilə məşğuldur: bağırsaq hərəkətini tənzimləyir, damarların tonusunu saxlayır, qanın laxtalanmasını işə salır. Bəs beyin? Beyin öz serotonini özü sintez edir. Yerindəcə. Triptofandan. Satıcının yellədiyi o doxsan beş faizin əhvalınıza aidiyyəti təqribən istilik radiatorundakı suyun fincandakı çaya aidiyyəti qədərdir. Maye oxşardır. Sistemlər — fərqli.

Bağırsaq beyinə pıçıldayır. Bu şeir deyil. Bu anatomiyadır. Azan sinir — canlı naqildir. İmmun mexanizmlər — gizli dişli çarxlar. Mikrobiom — trilyonlarla bakteriya, həqiqətən də davranış iplərini dartıb oynadan. Canlı, nəbz vuran, yarımçıq qalmış elm. Burada hər şey dürüstdür. İndi isə baxın. "Ox var və öyrənilir" faktından satıcı tək bir nəticə çıxarır. Tək bir addım. "Klizma depressiyanı müalicə edir." Hamısı bu. Fikirləşin, indi nə baş verdi. Müşahidə hökmə çevrildi. Aralarında — uçurum. Və onu bir tullanışla keçdilər. Bu artıq olub. Yada salın: "qızdırma spiroxeti öldürdü." Müşahidə? Bəli. Buyurun, sülfozinin xaçı — qızdırma silah kimi, xəstə yandırılmış döyüş meydanı kimi. Eyni kobud tikiş. Eyni məntiq. Görülənlə hökm verilən arasında eyni uçurum. Depressiya sınaqdan keçmiş üsullarla müalicə olunur. Psixoterapiya ilə. İlk növbədə — koqnitiv-davranış terapiyası ilə. Antidepressantlarla. Göstərişlərə uyğun. Nöqtə. Heç bir "təmizləmə" protokolu bu sınaqdan keçməyib. Heç biri.

Sidik məsələsi.

London. 1944. Pəncərənin arxasında müharibə ulayır, Con Armstronq isə dünyaya bomba kimi bir kitab buraxır — partlayışı planeti yalnız yarım əsr sonra bürüyəcək. "Həyat suyu" —

bütün xəstəliklərdən qurtuluş təlimatına belə ad qoyur. Vasitə? Öz sidiyi. Amma bu absurdun əsl zəfəri hələ qabaqda idi. 1990-cı illər. Postsovet məkanı. Kitab mağazalarının rəfləri "urinoterapiya" haqqında bestsellerlərin ağırlığı altında çatıldayır. Milyonluq tirajlar. Ən adi dərmanların belə çatışmadığı poliklinikalarda insanlar yavaş səslə "qəbul sxemlərini" müzakirə edirlər. Dağılma yaşayan ölkə bu saman çöpündən var gücü ilə yapışır. Özgə qoxusunu içinə çəkir. İçir. Ümid edir. Fakt: sidik həqiqətən sterildir... amma yalnız sağlam insanın sidik kisəsində qıfıllı olduğu müddətcə. Hamısı bu. Burada elm bitir. Ondan sonrası — aldatmadır. Dəqiq hesablanmış sxem: metod, sənaye, milyonlarla aldadılmış insan. Bu orta əsrlər cəhaləti deyil. Bu — sizin 90-cı illərinizdir. Sizin qonşularınızdır. Bəlkə də — sizin valideynlərinizdir. Şeytan detallarda deyil, unutduğumuz bir şeydə gizlənir: dəlilik keçmişdən gəlmir. O həmişə yanımızdadır.

"Psixosomatik yeddilik" işi.

1950-ci ildə psixoanalitik Frans Aleksander yeddi xəstəliyin siyahısını dərc etdi və onları boğulmuş emosional konfliktlərin törətdiyini hesab edirdi: bronxial astma, mədə xorası, hipertoniya, tireotoksikoz, revmatoid artrit, xoralı kolit, neyrodermit. "Çikaqo yeddiliyi", "psixosomatikanın müqəddəs yeddiliyi" — bu adlarla siyahı günümüzə qədər gəlib çıxdı və bütöv bir sənayenin müqəddəs kitabına çevrildi.

Burada həqiqət dənəsi var, həm də az deyil: stress həqiqətən də bu xəstəliklərin gedişinə təsir edir. Narahatlıq fonunda astmanın kəskinləşməsi — klinik reallıqdır. Hipertoniya ilə xroniki stress bağlıdır. Hamısı belədir.

Amma formula həmişəki kimi "gedişinə təsir edir"i "səbəbdir"ə çevirir, "səbəbdir"i isə "emosionu götür, xəstəlik də çıxıb gedəcək"ə. Və artıq müasir "psixosomatoloq" cədvəllərlə qəbul aparır — hər xəstəliyə bir emosiya yazılıb: astma — "boğulmuş ağlama", xora — "yeyib-dağıdan narahatlıq", onkologiya —

“içəridə gizlədilmiş kin”. Meditasiya et, bağışla, rahatla — xora sağalacaq.

Budur iyirminci əsrin tibbində ən gözəl hekayələrdən biri saydığım sonluq. Mədə xorası. Psixosomatikanın əsas nömrəsi. “Narahat və iddialıların” xəstəliyi. İnfeksiya olduğu ortaya çıxdı. 1980-ci illər. Avstraliya. İki nəfər — Barri Marşall və Robin Uorren — xora xəstələrinin mədələrini açır və orada bir bakteriya tapırlar. Helicobacter pylori. Xlorid turşusunun içində. Bütün dərsliklərə görə həyatın mümkün olmadığı yerdə. Onlara inanmırlar. Hansı bakteriya mədə şirəsində sağ qalacaq? Axı hamı bilir: xora — sinirdən. Stressdən. Xarakterdən. Bu psixosomatikadır, mikrobioloqiya deyil. Onda Marşall hər kəsin cürət edə bilməyəcəyi bir şey edir. Bakteriya kültürünü içir. Öz bədəni — son arqument. Və qastrit alır. Canlı. Əsl. Sınaq şüşəsindən çıxmış iltihablı mədə. Sonra onu antibiotiklərlə müalicə edir — qastrit keçib gedir. 2005-ci il. Hər ikisi — Nobel mükafatı. Bu gün xoranı bir neçə həftəyə antibiotik kursu ilə müalicə edirlər.

Baş verənləri bir düşünün. Elm onillərlə xoranın psixosomatik hipotezinə bağlı qaldı — öz hipotezinə, hörmətli, kafedralarda tədris olunan. Məlumatlar ortaya çıxdı — elm onu kənara atdı. Səhvini qəbul etdi, yenidən öyrəndi, dərslikləri yenidən yazdı, onu təkzib edənləri mükafatlandırdı. Düzəliş mexanizmi iş başında belə görünür.

İndi isə 2026-cı ildə “psixosomatika” sənayesinə baxın. Xora qırx ildir infeksiyadır — amma “psixosomatoloqların” cədvəllərində hələ də “yeyib-dağıdan narahatlıq”dır. Məlumatlar gəldi — və heç nəyi dəyişmədi. Çünki cədvəl düzgün olmaq üçün tərtib edilməyib. O, satılmaq üçün tərtib edilib.

Budur xətt. İncə. Amma mən onu həkim kimi çəkəcəyəm — skalpel dəqiqliyi ilə. Bir tərəfdə — faktlar. Somatik xəstələrə psixoloji yardım sadəcə lazım deyil. O, sübut edilib. Stresslə iş keyfiyyəti yaxşılaşdırır, müalicəyə sadiqliyi artırır. Bəzən — xəstəliyin gedişinə təsir edir. Relaksasiya, şüurluluq — hamısı

sınaqlardan keçib. Klinik. Nəzarətli. Kor. Amma — yalnız müalicəyə əlavə kimi. Yalnız belə. Digər tərəfdə — inhalyator əvəzinə tənəffüs gimnastikası, antibiotik əvəzinə meditasiya, kimyaterapiya əvəzinə kinləri bağışlamağı təklif edənlər. Onlar qaydaları dəlilik tərəfindən yazılmış oyunu oynayırlar. Xüsusilə onkologiyada. Orada bu formula öldürür. Hərfi mənada. "Xərçəng — kindir. Bağışla — və o, yox olacaq". Bu sözlər "şəfaçıların" kabinetlərində hər gün səslənir. Hər gün. Belə "kinlə iş"dən bir il sonra onkoloqa gələn xəstələrdən nə qaldığını görmüşəm. İnsan deyil. KÖLGƏ. Və çox gec.

Pəncərədən gördüyüm iş.

İndiyə qədər verdiyimiz nümunələr ümumdünya miqyasında idi. İndi isə yaşayıb işlədiyim yerdə müşahidə etdiklərimdən bəhs edəcəyəm.

Azərbaycanda və ümumilikdə regionda pandemiyanın qədim, kökləşmiş bir kanalı var — xalq-dini şəfaçılıq. Ailələr xəstələri müqəddəs yerlərə — pir və ocagahlara aparırlar ki, nəsildən-nəsilə deyilir: burda naxış çıxardırlar, burda cinlər qovarlar, burda "qorxu" müalicə edirlər. Psixozu olan insanın üzərində dualar oxuyurlar. Ona naxışlar bağlayırlar. Tüstüləyir, müxtəlif şərbətlər içirir, müqəddəs yerdə gecələtməyə məcbur edirlər. Bunu deyərkən inanca istehza etmək məqsədi güdmürəm: inac xəstəlik deyil, din də özü-özlüyündə bu kitabda mənim qarşımda duran deyil. Qarşı çıxdığım şey əvəzedicilikdir: müalicə yerinə mərasim təklif edildiyində, diaqnoz yerinə "cin çarpması" deyildiyində.

İşdə bu əvəzediciliyin qiyməti. Mən onu zamanla ölçürəm. Psixozun ilk epizodu olan xəstə mənə səsləri eşitməyə başladıqdan bir həftə sonra deyil, aylar sonra çatır. Bu ayları ailə pirlərə, molla və şəfaçılara verib. Səslər hələ diaqnoz deyil. Səslər işləyən saatdır. Psixiatriyanın bu saatlar üçün sayğacı var: müalicəsiz keçən psixozun müddəti. Bu müddət nə qədər uzun olsa, uzunmüddətli proqnoz bir o qədər pisdir. Bu fikir deyil — göstəricidir. Şəfaçı yanında keçirilən hər ay neytral "sınadıq,

kömək etmədi" deyil. Bu, irəliyə uzanan illər üçün pisləşən proqnozdur.

Ailələr niyə belə edir? Axmaqlıqdan deyil. Stigmadan. Ənənəvi ailədə psixiatrik diaqnoz damğadır. Nəsil üçün utanc. Arxadan pıçıldaşma: "bu evdə dəli var". Belə adama qız verməzlər. Beləsi ilə qohumluq etməzlər. Cin — utanc deyil. Cin xarici gəlib. Cini qovmaq olar. Ailə təmiz qalar. Şəfaçı müalicə satmır. O, ailəyə xəstəliyi tanımamaq imkanını satır. Və bu baxımdan Moskvalı reqressoloqdan fərqi yoxdur — o da müştərisinə depressiyanı tanımamaq imkanını təklif edir, axı onun depressiyası yoxdur, "yaşanmamış keçmiş həyatı" var.

Düstur eynidir. Yalnız geyim dəyişir: təsbeh, ağ gödəkçə, lavanta rəngli kardigan.

Son mexanizm: niyə daşıyıcı əmindir.

Bir şeyi izah etmək qalır — intonasiyanı. Niyə həqiqi onkoloq deyir: "Biz bu şişin mexanizmlərini tam başa düşmürük, terapinin üç variantı var, hər birinin öz şansı var", yemək qabı satan isə deyir: "Xərçəngin səbəbi aşkar edilib, al bu banka"? Niyə əminlik biliksizliklə bu qədər əks mütənasibdir?

1999-cu ildə psixoloqlar Deyvid Danning və Castin Kruqer indi onların adını daşıyan effekti təsvir etdilər: müəyyən sahədə ən az səriştəli insanlar sistemli şəkildə öz qabiliyyətlərini olduğundan çox qiymətləndirirlər — çünki öz çatışmazlıqlarını anlamaq üçün elə biliklər lazımdır ki, onların özündə yoxdur. Cahillik sadəcə cavablardan məhrum etmir. O, cavab olmadığını görmək imkanından da məhrum edir.

Zoolog, kökürək toxumasının hər bir xeyrə qədər öyrənmiş olsa belə, heç vaxt "Köpek balıqları xərçəng xəstəliyinə yoluxmur" yazmazdı. Bunu ancaq tək bir fəsli oxuyan yaza bilər. Gastroenteroloq, ömrünü serotonin fiziologiyasına həsr etmiş həkim heç vaxt depressiyanın düzgün qəbzləşmə ilə müalicə olunacağını vəd etməz. Bunu yalnız serotonin haqqında bir abzas udan vəd edə bilər. Satıcının əminliyi — bilik əlaməti

deyil. Tibbdə bu, demək olar ki, həmişə insanın həqiqi sualların başladığı həddə çatmayıb deməkdir.

Bu tonu yadda saxlayın. “Bütün xəstəliklərin səbəbini bilirəm” — düstur belə səslənir. “Biz bunu bilirik, bunu bilmirik və bundan sizin üçün nə çıxır” — elm belə səslənir. Onları məzmunundan əvvəl tonundan fərqləndirmək olar.

İndi bütün mənzərə aydındır. Dəliçilik pandemiyası tək bir bazarın epidemiya deyil. Bu, insanlığın anlamadığı hər bir əziyyətlə ünsiyyət üsuludur və bu kitabda psixiatriya yalnız bir prizma rolunu oynayıb — ən açıq şəkildə görünən formulun sahəsini, çünki burada satıcının üzünə vurula biləcək ən az sübut və onun qidalandığı ən çox ümidsizlik var.

Hər bir pandemiyada patogen var — biz onu təsvir etdik: formula. Həssas qruplar var — biz onları gördük: əziyyət çəkənlər və sevənlər. Yoluxma mexanizmləri var — sayı on səkkizinci fəsildə izah edilmiş yeddi növə bərabərdir.

Keçid yolu qaldı. O haqda — növbəti fəsildə. Çünki son on beş ildə bəşəriyyət bu pandemiya üçün ideal ventilyasiya sistemi qurdu — və onu cibində daşıyır.

Fəsil 25. Sosial şəbəkələrdə pandemiya: ekranın kafedraya çevrildiyi zaman

Mətbəə dəzgahı ixtira edilənə qədər fikir insan bədəninin əsiri idi. Onu dünyaya çatdırmaq istəyirsən? Fiziologiyanın hökmünə boyun əy. Barmaqların qıcolub tutulana qədər əl ilə yaz, ya da üzbəüz dayandığın kütləyə səsin bata-bata hayqır. Fiziki məhdudiyyətlər hər addımda qarşıya dəmir sədd çəkirdi. Bir vaiz — rupora söylənən cəmi bir neçə yüz söz. Bir müstənsix — bütöv bir il sürən taqətdən salan əmək müqabilində cəmi bir neçə on nüsxə. Fikirlər yavaş yayılırdı. Lakin bu yolda onları amansız süzgəclər gözləyirdi: ilahiyyat məktəbləri, senzura, bir-biri ilə çəkişən rəylər. Son sədd isə dinləyicilərin soyuqqanlı sağlam düşüncəsi idi.

Gutenberg ölçüləri dəyişdi. çap maşını basılmış bir kitab minlərlə nüsxəyə çıxa bilərdi. Bu, yaxşı və pis bütün fikirlərin yayılmasını sürətləndirdi. çap maşını elmi inqilaba və Reformasiyaya kömək etdi; eyni zamanda “Cadugərlərin Çəkici” və digər onlarla təhlükəli mətnlərin yayılmasına da şərait yaratdı.

Radio və televiziya inkişafın növbəti mərhələləri oldu. XX əsrin ortalarında bir fikri eyni anda milyonlarla insana çatdırmaq mümkün idi. Ancaq bu texnologiyalarda da qapıçılar var idi: redaktorlar, senzuraçılar, kanal sahibləri və dövlət tənzimləyiciləri. Fikrini efirə çıxarmaq üçün filtrlərdən keçmək lazım idi. Filtrlər fərqli idi — sərt totalitar və yumşaq demokratik — lakin onlar mövcud idi.

2010-cu illərdə mobil internetin yayılması və Instagram, TikTok, YouTube və Telegramın meydana çıxması ilə tamamilə yeni bir mühit yarandı. Bu mühitdə smartfonu olan hər bir insan vasitəçisiz fikirlərini milyonlarla izləyiciyə çatdıra bilən potensial vəizə çevrildi. Əslində filtrlər artıq yoxdur. Alqoritm var, amma o elmi əsaslandırılmışdan çox emosional reaksiya doğuran şeyə üstünlük verir.

Bu, fikirlərin yayılması üçün yeni mühitdir. Yeni media. Və bizim mövzumuza gəldikdə — cəhalət pandemiyasının yayılması üçün yeni mühit.

Bir neçə rəqəm, miqyası göstərmək üçün.

2024-cü ildə Current Opinion in Psychology jurnalında dərc olunan bir araşdırmada psixi sağlamlıqla bağlı TikTok-da təsadüfi seçilmiş min video analiz edildi. Nəticələr: — Videoların 6,3%-i dezinformasiya, yəni doğrudan yalan və ya elmi olaraq təsdiqlənməmiş məlumatlar təqdim edir; — Videoların 15,7%-i qismən təsdiqlənmiş və ya təhrif olunmuş məlumatlar (misinformasiya) təqdim edir; — Kognitiv-davranış terapiyası (KDT) ilə bağlı videoların təxminən dörddə biri araşdırmalarla dəstəklənməyən mənfi ifadələr, xüsusilə "KDT effektiv deyil", "psixoloji qiymətləndirmə formasıdır" və "trauması olan insanlar üçün zərərlidir" kimi fikirlər təqdim edir.

2023-cü ildə JAMA-da dərc olunan başqa bir araşdırmada sosial media vasitəsilə tibbi dezinformasiya yayan və böyük auditoriyaya malik əlli iki tanınmış həkim müəyyən edildi. Bu, marjinal insanlar deyil — tibbi diplomları olan və peşəkar statusunu yanlış məlumatların yayılması üçün istifadə edən insanlardır.

Amerika Psixoloji Assosiasiyasının 2024-cü ildə dərc etdiyi rəsmi nəşrdə aydın qeyd olunub: dezinformasiya yayanlar tez-tez verdikləri məsləhətlərdən birbaşa maliyyə marağı güdürlər. Onlar kitablar, kurslar, qida əlavələri, seanslar,

kanal abunəlikləri satırlar. Maliyyə marağı — yayılmanın əsas hərəkətverici qüvvəsidir.

İndi isə ictimai şəbəkələrin "cinnət" pandemiyasını xüsusilə effektiv şəkildə yaymasını təmin edən mexanizmlərə keçək.

Birinci mexanizm — emosional intensivliyə görə alqoritmik seçim.

Instagram, TikTok və YouTube alqoritmləri bir göstərici üzrə optimallaşdırılıb: istifadəçinin platformada sərf etdiyi vaxt. Nə qədər çox baxsa, bir o qədər çox reklam görəcək və platforma daha çox qazanacaq. Diqqəti saxlamaq üçün alqoritm güclü emosiyalar doğuran məzmunu üst sıralara qaldırır: həyəcan, qorxu, təəccüb, heyranlıq.

Elmi həqiqət adətən cansıxıcıdır. "OKR-nin müalicəsi altı ilə on iki ay arası davam edən ekspozisiya və reaksiyanın qarşısını alan kognitiv davranış terapiyası tələb edir; effektivliyi təxminən 80% təşkil edir" — bu, əsl elmin dayandığı məlumatdır, amma heç bir emosional reaksiya doğurmur. Belə bir videoya heç kim uzun baxmaz.

Amma bu tam başqa məsələdir: "Sizə bütün həyat boyu səhv diaqnoz qoyulub! Narahatlığınızın əsl səbəbi — nəsil proqramıdır! Mənim müştərim bir seansda xilas oldu!" — bu viral hekayədir. Təəccüb, ümid, rəsmi tibbin "ədalətsizliyi" ilə bağlı hiddət, tez həll vədi — hamısı bir qısa videoda. Alqoritm onu üstə qaldırır. Milyonlar bunu görəcək; sadəcə on minlərlə insan cansıxıcı KDT haqqında videoya baxacaq.

Quruluş baxımından belə nəticə çıxır: effektiv, cansıxıcı, əsl elm — ictimai şəbəkələrdə effektiv olmayan, maraqlı, saxta elmə uduzur. Bunun səbəbi istifadəçilərin axmaq olması deyil. Sistem elə qurulub ki, məhz ikincisini irəli çəkir.

İkinci mexanizm — kvalifikasiyasız etibarlılıq.

Ənənəvi kütləvi informasiya vasitələrində — qəzetdə, televiziyada, akademik jurnalda — çıxış edən şəxs öz səlahiyyətini

sübut edən sənədlər təqdim etməli idi. Diplom, vəzifə, nəşrlərin siyahısı, redaktorun təsdiqi. İctimai şəbəkələrdə isə bunlardan heç biri tələb olunmur. Yalnız xarizma və qısa videoları montaj etmək bacarığı kifayətdir.

Nəticədə qəribə bir hadisə baş verir: Moskva Universitetinin diplomu və otuz illik klinik təcrübəsi olan adam Instagramda üç min abunəçi toplayır, "müəllif metodu" adlı ödənişli üç günlük kurs keçən şəxs isə yarım milyon. Auditoriya abunəçi rəqəmlərinə baxaraq məntiqi nəticə çıxarır: ikincisinin daha çox abunəçisi varsa, deməli onun məlumatı daha faydalıdır.

Media tədqiqatçılarının etibarlılıq inflyasiyası adlandırdığı məhz budur. Etibarlılıq artıq keyfiyyətlə əlaqələndirilmir. O, auditoriyanın ölçüsündən asılı funksiyaya çevrilib. Auditoriyanın ölçüsü isə öz növbəsində alqoritmlə oynamaq bacarığından asılı funksiyadır.

Üçüncü mexanizm — sosial dəlil və eko-kamera.

İnsan sosial bir varlıqdır. Biz başqalarının inandıqlarına inanmağa meylliyik. Əgər bir videonun altında minlərlə insanın həyəcanla "təşəkkür edirəm, həyatımı dəyişdiniz", "üç günə sağaldım" kimi şərhlər yazdığını görürəmsə, bu məlumata klinikada növbədə oturub və diaqnozunu otuz saniyəyə izah edə bilməyən cansıxıcı həkimdən daha çox inanmağa meyil edirəm.

Şərhlərə girirsən. Həyəcan dəryası. "Həyatımı xilas etdi", "inanılmaz effekt", "əbədi minnətdarlıq". Bir anlıq fasilə. Niyə postun altında hər kəs birdən-birə xoşbəxtdir? Birincisi, placebo heç işləmədiyi zaman belə işləyir. On nəfərdən biri hər halda "Kömək oldu!" deyəcək. İkincisi, soyuq əlləri olan moderator #aldatmaq teqli şərhi artıq silib. Yalnız "təşəkkürlər" qalıb. Üçüncüsü, platformanın özü nəhəng bir filtdir. Alqoritm səni oxşar fikirdə olanların bəyənmələri ilə qidalandırır, müxalifətçilər isə rəqəmsal vakuumda izsiz yox olur. Səssizlik.

Hər kəs xoşbəxtdir. Sən bilmədən irəliləyirsən, artıq nəyi görmədiyini də bilmədən.

"Teta-hilinq" İnstagram hesabını açan bir insan minlərlə həyəcan dolu rəy görür. Ödəniş edib və heç bir effekt görməyən, lakin bu barədə heç nə yazmayan minlərlə insanı görmür — çünki onlar lentdə alqoritm tərəfindən göstərilmir.

Dördüncü mexanizm — etik qaydaların aradan qaldırılmasıdır.

Etika bölməsində gördüyümüz kimi, müasir beynəlxalq etik standartlar tibb və psixologiyada sağalma effektlərinin birbaşa reklamını, konkret nəticələrin vəd edilməsini, müştərinin həssaslığından istifadəni, cinsi və ya asılılıq yaradan ünsiyyəti qadağan edir. Bu qadağalar diplomlu mütəxəssislər üçün qüvvədədir — pozuntunun cəzası lisenziyanın ləğvidir.

Nizamlanmayan mütəxəssislər üçün bu qadağalar tətbiq olunmur. Sosial şəbəkələrdə "kouç", "reqressoloq" və ya "tetahiler" "bir seansda depressiyadan qurtulan müştərilərin rəylərini" yayımlamaqda, "ağır xəstəliklərdən möcüzəvi şəkildə sağalma hekayələrini" danışmaqda və kurslarını tanıtmaq üçün insanların əzablarından istifadə etməkdə azadlıq hiss edir. Bunun heç bir cəzası yoxdur. Belə reklamın effektivliyi əsl psixoterapevtin etik cəhətdən düzgün və təvazökar reklamından dəfələrlə yüksəkdir.

Rəqabət ədalətsizliyi yaranır. Etik normalara zidd hərəkət edən şəxs auditoriyanın diqqətini cəlb etmək baxımından etik normalara əməl edən diplomlu mütəxəssisdən üstün olur. Bazar pozuntuları pul, şöhrət və tərəfdarlarla mükafatlandırır.

Bunun ən ağır nəticələri gənc auditoriya üçündür.

Onaltı yaş. Qan hormon fırtınasında qaynayır. Əhvalruhiyyə dalğalanır — bu yaş üçün təbiidir, lakin ikiqat təzyiq altında: məktəb stresi və ailə münaqişələri. Yeniyetmə TikTok-u açır. Donub qalır. Ekranda videodur. İlk sözlər hökm kimi zərbə vurur: "Əgər belə əlamətləriniz varsa — bipolyar

pozuntu yaşayırsınız!". Sonra siyahı. "Əhval-ruhiyyənin ani dəyişməsi". "Həyəcan". "Yuxusuzluq". Ümumi, aydın olmayan əlamətlər. Bunlara planetdəki hər hansı yeniyetmə düşər. Lakin artıq beyin işə başlayıb. Yeniyetmə videonu yadda saxlayır. Bənzərlərini axtarır. Alqoritm marağı oxuyur. Tələ işə düşür. Lent daha çox göstərməyə başlayır.

Bir ay sonra yeniyetmə əmindir ki, onda bipolyar pozuntu var. Özünə diaqnoz qoyur. Bu diaqnoza uyğun davranmağa başlayır. Özünü onun vasitəsilə kimlikləşdirir. Bu hadisə Amerika psixiatriyasında TikTok psixiatriyası adını alıb — sosial şəbəkələr vasitəsilə özünə diaqnoz qoyma.

Tədqiqatçılar 2020-ci ildən — TikTok-un bu yaş qrupunda ən populyar platformaya çevrildiyi vaxtdan — yeniyetmələr arasında özünə diaqnoz qoyulmuş DEHB, autizm, bipolyar pozuntu, dissosiativ identifikasiya pozuntusu hallarının sürətlə artdığını qeyd edirlər. Əlbəttə, bu özünədiaqnozların bir qismi klinik müayinə zamanı təsdiqlənir. Böyük hissəsi — yox. Amma yeniyetmənin həkimə simptomlarla deyil, TikTokdan hazır diaqnozla gəlməsi faktı klinik işi xeyli çətinləşdirir.

Daha pisi — yeniyetmənin həkimə deyil, "onun" diaqnozunda "ixtisaslaşmış" həmin influenserə düşməsidir. O, diaqnozu təsdiqləyir, "öz müəllif metodunu" təklif edir, "kurs" üçün pul tələb edir. Yeniyetmə və valideynləri pul ödəyirlər. Kursu keçirlər. Yeniyetmənin vəziyyəti yaxşılaşmır — çünki bəlkə də əvvəldən onda özündə gördüyü şey yox idi. Amma o, "xəstə" kimi kimlik təsdiqi alır və bu kimlik uzun müddət onunla qalır.

Bu hekayənin xüsusilə kədərli tərəfi — ezoterik peşəsini seçən yeniyetmələr fenomenidir.

2023-cü ildə Rusiya KİV-i on altı-on yeddi yaşlı qızların taroloji "düzəlişlər" və "oxuyuşlarla" öz Instagram hesablarını açması barədə məlumat verirdi. Yüzlərlə izləyici, ilk ödənişli seanslar, ilk qazanılmış minlər. Onlar görürlər: böyüklər

bundan milyonlar qazanırlar — bəs niyə onlar da sınamasınlar. Təhsil? Lazım deyil. Başqasının karmasına baxış: "Məndə uşaqlıqdan vergi var".

Bunlar qızlar deyil, sistemin göt ləridir. Onlar yetkin həyata elə bir dövrdə qədəm qoydular ki, ciddi peşə yolu (tibb, elm, mühəndislik) illərlə təhsil tələb edir, başlanğıcda az ödənilir və ictimai şöhrət gətirmir; "ekstrasens" yolu isə təhsil tələb etmir, ani status verir və tez pul vəd edir.

On altı yaşlı qızı bu seçimə görə günahlandırmaq olarmı? Cavab — yox. Bu karyera trayektoriyasını mümkün və hətta prestijli edən cəmiyyəti günahlandırmaq olar.

Və nəhayət, Ekstrasenslər Döyüşü və bu kimi şoular.

"Ekstrasenslər Döyüşü". 2007-ci ildən. TNT kanalı. Rusiya televiziyası tarixində ən uğurlu əyləncə şoularından birinə çevrilmiş layihə. Konsepsiya aldatıcı dərəcədə sadədir. Paranormal qabiliyyətləri olduğunu iddia edən iştirakçılar döyüşə girirlər. Onlar amansız sınaqlarda bir-biri ilə yarışırlar. Bu ritualar nəyi gizlədir? Cinayətlərin qurbanlarını. Yoxa çıxmış insanları. Dəfn yerlərini. Kameralar donmuş üzləri tutanda, studiyadakı hava deyilməmiş dəhşətdən ağırlaşanda dəri üşüdür. Bu reytinq nə ilə qidalanır — başqasının ağrısıyla, yoxsa sirrlə? Qalib pul mükafatı və "ilın ekstrasensi" adını alır. Amma bu sirr oyununda əslində kim qalib gəlir?

Şou bir tamaşa idi. İlk kadrdan son kadra qədər. Realiti libasına bürünmüş illüziya fabriki. Bir fakt: kameralar söndürüləndə iştirakçılar düzünü danışırdılar. İkinci fakt: müsahibələrində etiraf edirdilər — tapşırıqlar əvvəlcədən məşq olunurdu. Üçüncü fakt: studiyadakı "cinayətlərin qurbanları"? Kirayəyə götürülmüş aktyorlar. Məlumatın sirli "oxunması"? Əvvəlcədən brifinqlər. Hamısı budur. İfşa. Amma sirr burada deyil. Sirr daha dərindədir. Saxtakarlıq necə milyonluq reytinq toplayır? Bu hiyləyə inananlar kimlərdir? Baxın. Şounun qalibləri ictimai şəxsiyyətə çevrilir. Ət-ətdən,

sümükdən olurlar. Status qazanırlar. Onları şəxsi məsləhətlərə dəvət edirlər — qiymətlər on minlərlə rubla qalxır. Kitab çap edirlər. Öz onlayn məktəblərini idarə edirlər. İllüziya udulur. İllüziya pul qazandırır.

Milyonlarla tamaşaçı üçün — xüsusilə televiziya məhsulunu tənqidi təhlil etməyi bacarmayanlar üçün — şou bir hiss yaradır: "fövqəltəbii qabiliyyətlər mövcuddur". Əgər mövcuddursa, özünü pis hiss etdiyin vaxt həmin qabiliyyətə malik adama müraciət etmək məntiqlidir. Həkimə yox. Ekstrasensə.

Bu — əyləncəli şou deyil. Bu — elmi olmayan dünyagörüşünün normallaşdırılması üçün güclü bir kanaldır. Və bu kanal reklamla maliyyələşir, yəni son nəticədə belə bir məhsulda heç bir problem görməyən adi kommersiya fəaliyyəti ilə.

Bəs bununla nə etməli?

Dürüst cavab budur — biz bilmirik. Dünyada elmi ictimaiyyət problemin miqyasını dərk etməyə və cavab axtarmağa yeni başlayır.

Birinci istiqamət — gigiyenik markalanma. Sosial şəbəkələr artıq mexanizmi işə salıb. "Ekspert tərəfindən yoxlanılıb" nişanı — birinci qalxan. "Sağlamlıqla bağlı yoxlanılmamış iddialar var" işarəsi — ikinci. Nüfuzlu mənbələrə keçidlər — üçüncü. Görünüşcə müdafiəsiz görünür. Bəs işləyirmi? Bu tədbirlərin effektivliyi hələlik ürək açan dərəcədə məhduddur. Və burada heç bir platforma tərtibatçısının bir kənara atmayacağı bir sual ortaya çıxır: heç kim başını belə çevirmirsə, xəbərdarlıq lövhəsinin nə faydası var? Markalanma işləyir, amma yalnız bir sərt şərtlə: istifadəçi onu fiziki olaraq görürsə və şüurlu şəkildə ona diqqət yetirirsə. İki "əgər" — xəbərdarlıqla canlı insan arasında iki kar baryer.

İkinci istiqamət — həkimləri sosial şəbəkələrdə ünsiyyətə öyrətmək. Harvard İctimai Səhiyyə Məktəbi tibb mütəxəssislərinə inandırıcı qısaformatlı kontent yaratmağı öyrədən xüsusi proqramlar başladıb. TikTok dilini, Instagram Reels tempini,

diqqəti saxlama üsullarını öyrədirlər. Bir neçə yüz sertifikatlı mütəxəssis artıq bu kursları keçib. Onların auditoriyası artır, lakin psevdo-şəfaçı influenserlərin auditoriyası ilə müqayisədə hələ də kiçikdir.

Üçüncü istiqamət — tənzimləyici. Avropa İttifaqında 2024-cü ildə Rəqəmsal Xidmətlər Aktı qəbul ediləcək və bu, iri platformaları tibbi dezinformasiyanın yayılmasına qarşı konkret tədbirlər görməyə məcbur edəcək. 2023-cü ildə Fransada müştərinin psixoloji həssaslıq vəziyyətindən maddi mənfəət məqsədilə sui-istifadəyə görə cinayət məsuliyyəti tətbiq edildi — bu, ümidsiz insanları istismar edən "ruhani şəfaçılar" və "kouçlar"ın fəaliyyətini ilk dəfə birbaşa cinayətkarlıq kimi tanıyan qanundur. Rusiyada, Qazaxıstanda və Azərbaycanda belə qanunlar yoxdur.

Dördüncü istiqamət — təhsil sahəsidir. Məktəb sinifləri indi mübarizə meydanına çevrilmişdir. Tədris proqramlarında mediada oxur-yazarlığın ilk elementləri peyda olur: yeniyetmələrə sübuta əsaslanan mənbələri şübhəlilərdən ayırd etmək, "xeyirxah məsləhətlər" pərdəsi altında gizlənən kommersiya məqsədlərini fərqləndirmək, populyarlıqla nüfuzu qarışdırmamaq öyrədilir. Amma belə proqramlar hələ çox azdır. Dəryada damla. Məktəblilər təhsillərini başa vurub həyata qədəm qoyanda, informasiya təsiri qarşısında silahsız qalırlar. Onların başları — hədəf, sığınacaqları isə yoxdur. Kim onlara qorunmağı öyrədəcək? Bu sual cavabsız qalır.

Bu fəsildə əsas vurğulamaq istədiyim budur ki, sosial şəbəkələr köhnə pandemiyanın yayıldığı yeni mühit deyil. Bu, onun yayılması üçün daha güclü, sürətli və hərtərəfli yeni mexanizmdir. Və bu mexanizm elmi psixiatriyaya qarşı struktur şəkildə işləyir — ayrı-ayrı insanların pis niyyəti ilə yox, platformaların öz arxitekturası ilə əlaqədardır.

Instagramda milyon abunəçisi olan bir "teta-hilinq" ustası bir il ərzində Volter Frimenin iyirmi ildə etdiyi yüz lobotomiya əməliyyatından daha çox insanın şüurunu zəhərləyə bilər.

Nəticələr fiziki deyil, amma psixoloji, sosial, maliyyə baxımından, ailələr üçün dağıdıcıdır.

Və — ən dəhşətlisi budur ki, Tredvell canavarı Frimen heç olmasa pislənirdi. Peşədaşları tərəfindən. Açıq şəkildə. Nifrətlə. Tarix onu qara səhifələrə — Volter Frimen və onun lobotomiya işlərinin yazıldığı yerə salıb. Bunu isə heç kəs pisləməyəcək. "Teta-hiler". Kəlləsəri və taleləri qıran insan. Onu mükafatlandıracaqlar. Mükafatlarda. "İlin ən yaxşı psixoloqu" — titreyən əllərdə soyuq qızıl heykəlciyi. Onu populyar şoulara dəvət edəcəklər — və o, kor edən kamera obyektivinə gülümsəyəcək. Forumlarda çıxış edəcək, zal alqışlayacaq. Abunəçilərindən, onun həyatlarını dəyişdiyinə içdən inanan qadınlardan heyranlıq dolu rəylər alacaq. Heç kəs ona qarşı çıxmayacaq. Açıq şəkildə.

Və minlərlə gənc "koleq" onun karyerasına baxaraq öz yollarını onun nümunəsində quracaq.

Bu — müasir dövrün lobotomiyasıdır. Qansızdır, amma zərərsiz deyil. Əməliyyatxanalarda deyil, milyonlarla smartfonlarda, milyonlarla yataq otaqlarında, milyonlarla yeniyetmə beynində həyata keçirilir.

Bununla bir şey etmək lazımdır. Və bu bizi növbəti fəsildəki suala gətirir: nə üçün iddia edilən xüsusiyyətlərinə görə kolbasalar, yanğın söndürmə qurğuları, avtomobillər və şampunlar ciddi şəkildə nəzarət olunanda, "karmanın təmizlənməsi" və "nəsil proqramları ilə iş" xidmətləri heç bir nəzarət olunmadan qalır?

> QIRMIZI BAYRAQ. *Əgər metod haqqında xəbəriniz sosial şəbəkə lentində olubsa; əgər müəllifin yüz minlərlə abunəçisi, amma elmi jurnallarda sıfır nəşri varsa; əgər rəylər tamamilə "həyatımı dəyişdi" ifadələrindən ibarətdirsə, amma heç bir məlumat yoxdursa — unutmayın: alqoritm sizə bunu onun işlədiyi üçün deyil, ekranda qalmağınıza xidmət etdiyi üçün göstərir. Len-*

tdən "müalicə almaq" elə bir şeydir ki, diaqnozu alqış səslərinə görə qoymaqla eynidir.

Fəsil 26. Hüquqi asimmetriya: səssiz razılıq pandemiyası

Təsəvvür edək ki, belə bir ssenari baş verir.

Sabah mən, həkim-psixiatr Kənan Rəhimov, Bakıda kiçik bir ət mağazası açmaq qərarına gəlirəm. Xammal alıram, kolbasa hazırlayıram. Qablaşdırmaya tərkibini yazıram: "Mal əti 80%, donuz əti 20%". Əslində kolbasada ətdən daha çox soya var. Satıram.

Nə olacaq?

Bir neçə həftə və ya ay sonra onlar gələcək. Sanitariya-epidemioloji xidmət nümunələr götürəcək. Laboratoriya analiz aparacaq. Yalnız bir sual: ya tərkib elan ediləndən fərqlidirsə? Onda — protokol dərhal, inzibati məhkəmə, böyük cərimə, müəyyən müddət satış qadağası. Və mənim adım etibarsız satıcılar siyahısına düşəcək — hamının görməsi üçün. Amma bu ancaq bağlanan ilk qapıdır. Əgər hallar təkrarlanarsa, ikinci açılacaq. Cinayət işi. Fırıldaqçılıq maddəsi. Belə. Addım-addım. Laboratoriya probirqasından — məhkəmə skamyasına qədər.

Bu hüquq sisteminin normal işləyidir. İstənilən müasir ölkədə məhsul keyfiyyətinə çoxsəviyyəli nəzarət infraquruluşu var: istehlakçı hüqlarını qoruma qanunları, uyğunluq standartları, laboratoriya yoxlamaları, cərimələr və sanksiyalar. Bunlar kolbasa, süd, benzin, uşaq oyuncaqları, avto hissələri və şampun üçün də tətbiq olunur.

İndi isə başqa bir ssenarini təsəvvür edək.

Sabah mən ət mağazası açmıram. “Kənan Rəhimov adına Ruhani Təcrübələr Mərkəzi” açıram. Binanı kirayəyə götürürəm. Qapıya nişan asıram. Instagramda — ağ geyimdə gözəl şəkillər. Yazı: “Mən — nəsildən-nəsilə enerji müalicəçisiyəm. Nəslimin ənənəsi XVII əsrdən gəlir. Karmanı təmizləyə bilərəm. Bir seansla qədim nəsibəti aradan qaldıra bilərəm. Zəmanət. Qiymət — saatına qırx min rubl”. XVII əsr. Üç yüz illik ənənə. Bir seans. Qırx min. Yoxlayın: bir dəfə belə sənəd, diplom, şahid yoxdur — ağ xələt və Instagramın hamar lentindəki şəkillərdən başqa. Və bu işləyir. Mütləq işləyir.

Bir neçə rəy dərc edəcəyəm (yaxud dostlarım yazacaq): “Kənan həyatımı xilas etdi! Depressiyam bir seansda keçdi!” — “On il sonsuzluq yaşadım, Kənanla işlədikdən sonra hamilə qaldım!” — “Kənan nəsillik proqramımı təmizlədikdən dərhal sonra arzuladığım işi tapdım!”

Nə baş verəcək?

Heç nə.

Heç bir dövlət xidməti yoxlama üçün gəlməyəcək. Heç bir laboratoriya “xidmətlərimin” göstərilən xüsusiyyətlərə uyğunluğunu araşdırmayacaq — çünki belə laboratoriya yoxdur. Heç bir inspektor “karmanın fiziki olaraq təmiz və ya çirkli ola bilməyəcəyi, təbiətdə nəsibətlərin mövcud olmadığı” barədə protokol tərtib etməyəcək. Heç bir məhkəmə satışımı dayandırmayacaq. Adım heç bir etibarsız müalicəçilər siyahısına düşməyəcək, çünki belə siyahı yoxdur.

Mən sərbəst şəkildə praktika edəcəyəm. Pul qazanacağam. Biznesimi genişlədəcəyəm. Bir ildə onlarla, beş ildə yüzlərlə, on ildə minlərlə müştərim olacaq. “Müalicəçilər” forumlarında çıxış edəcəyəm. Kitablar yazacağam. Məni məşhur şoulara çıxışçı kimi dəvət edəcəklər. Instagramda üç yüz min abunəçim olacaq. Və heç kim, heç vaxt, post-sovet məkanının heç bir yurisdiksiyasında — mənə heç bir günah ittiham etməyəcək.

Budur — hüquqi asimmetriyanın mahiyyəti.

Kolbasanı elan olunmuş tərkibə uyğunsuz satmaq olmaz. "Karmanın təmizlənməsi"ni isə satmaq olar. Və bu, bir az sonra bəhs edəcəyim epiqrafda deyildiyi kimi, hamımızın sükutla razılaşmasıyla dəstəklənən absurdur.

Bu asimmetriyanı ətraflı nəzərdən keçirməyə dəyər, çünki bu kitabın bütün mövzusunun açarı məhz buradadır.

Keyfiyyətsiz mallardan hüquqi müdafiə əksər ölkələrdə bir neçə əsas prinsip əsasında işləyir.

Birincisi — elan olunmuş xüsusiyyətlərə uyğunluq prinsipi. Əgər etiketdə "təbii alma şirəsi" yazılıbsa, qablaşdırmada məhz təbii alma şirəsi olmalıdır, konsentrat və ya alma ətirli şirinləşdirici deyil. Əgər məhsul təsvirə uyğun gəlmirsə — satıcı məsuliyyət daşıyır.

İkincisi — obyektiv yoxlanıla bilmə prinsipi. Şirənin tərkibini laboratoriyada yoxlamaq olar. Standartlar var. Metodlar var. Ekspertlər var. Cihazlar var. Mübahisə olarsa — laboratoriya müstəqil rəy verir.

Üçüncüsü — məsuliyyət prinsipi. Vicdansız satıcı maliyyə (cərimələr, pulun qaytarılması, zərərin ödənilməsi) və inzibati (lisenziyanın ləğvi), xüsusilə ağır hallarda isə cinayət məsuliyyəti daşıyır.

Keyfiyyətsiz psixoloji və "mənəvi" xidmətlərdən hüquqi müdafiə postsovet ölkələrinin əksəriyyətində bu prinsiplərin heç birinə görə işləmir.

Birinci prinsip toz olub dağılır. Çünki aydın deyil — əslində nə "elan olunub"? "Karmanın təmizlənməsi". Bu nədir? Müəyyən edilə bilməyən xidmət. "Nəsil proqramı ilə iş". Bu nədir? Müəyyən edilə bilməyən xidmət. "Teta vəziyyəti vasitəsilə məhdudlaşdırıcı inanclardan azad olma". Bu nədir? Yenə də — müəyyən edilə bilməyən xidmət. Üç lövhə. Üç boşluq. Sözlərə düzülmüş sözlər — arxasında hər şey dayana bilən konstruksiyalar. Ya da heç nə. İndi isə — sual. Satıcıya etiraz

etməyə çalışın: sizin "karmanın təmizlənməsi" elan olunana uyğun deyil. Çalışın. Hüquqi baxımdan — qeyri-mümkündür. Niyə? Çünki heç kim — nə məhkəmə, nə ekspert, nə satıcının özü — "uyğundur"un nə mənaya gəldiyini müəyyən edə bilməz. Etalon yoxdur. Ölçü yoxdur. Başlanğıc nöqtəsi yoxdur. Və tərif olmayan yerdə — pozuntu da yoxdur. Yalnız sözlər. Və onların arxasında sükut.

İkinci prinsip işləmir, çünki bu xidmətlər obyektiv olaraq yoxlanıla bilməz. Karmanın təmizliyini ölçə biləcək laboratoriya yoxdur. "Nəsil proqramı"nın mövcudluğunu qeydə ala biləcək cihaz yoxdur. Bu sahələrdə ekspertlər yoxdur — çünki bu sahələr elmi biliyə aid deyil. Onlar tərifinə görə elmin xaricindədir.

Üçüncü prinsip — dalana dirənmə. İlk ikisindən irəli gələn qaçılmaz tələ. Təsəvvür edin: əlinizdə qəbzi sıxaraq şikayətə gedirsiniz, ədalət tələb edirsiniz. Amma ədalət susur. Niyə? Sizə göstərilən xidmət — bir xəyalətdir. Onu nə ölçmək, nə qiymətləndirmək olar. Məhkəmənin qarşısında dayanırsınız, cavabdeh isə yalnız çiyinlərini çəkib deyir: "Bəs sizə tam olaraq nə xoşagəlməz oldu? Sizə məşq vəd etdilər — onu aldınız. Onun işləmədiyini sübut etmək istəyirsiniz? Bəs meyarlar haradadır?" "Teta şəfaçısı"nın qurbanı iddia verə bilməyəcək: "Mənə bir seansda sağalma vəd etdilər". Hakim soyuqqanlıqla cavab verəcək: "'Sağalma' nədir? Siz şəxsi inkişaf üçün meditasiya aldınız. Məşq keçirildi? Keçirildi. Deməli, xidmət göstərildi". Və qıfıl şaqqıldayır. Siz qapının arxasında qalırsınız. Əliboş. İfadə olunmamış qəzəblə. Və havada asılı qalan bir sualla: "Bəs mən əslində nə almışdım?"

Bu məntiq formal olaraq zəif deyil. Məhz bu məntiq sayəsində heç bir nəzarətə tabe olmayan milyardlıq sənaye mövcuddur.

Oxucuya çatmaq istədiyim əsas fikir budur: fiziki cəhətdən mümkün olmayan xidmətlər satılmamalıdır.

Bu, öz vətəndaşlarının ruhi sağlamlığını ciddi qəbul edən hər bir ölkənin müasir qanunvericiliyinə daxil edilməli olan fundamental prinsipdir.

Qarşına oturub deyir: "Mən karmanı oxuyuram". Yaxşı. Hansı cihazla? Ölçmələr jurnalında sətir haradadır? Fotoşəkil üzərində iz, qrafikdə pik, statistik əhəmiyyəti yoxlana bilən rəqəm haradadır? Deyir: "Mən sənin taleyini yenidən yazıram." Yaxşı. Orijinal haradadır? Qaralama əlyazmasını kim əlinə almışdır? Düzəlişləri kim görmüşdür? Talehin mətnini düzəltmək üçün loqarifmli xəttxar haradadır? Arxiv göstərin. Deyir: "Mən nəslin enerji sahəsini təmir edirəm." Yaxşı. Texniki pasport. Gərginlik vahidi nədir? Tezlik diapazonu neçədən neçəyədir? Udma əmsalı neçədir? Rəqəmsız bu fizika deyil. Bu fantastikadır. Ağ ağdır, qara qaradır. Elmi saxta elmdən ayıran bir qayda var: Əgər hadisə reallıqda varsa, onu ölçmək olar. Yoxdursa, onda deyin ki, bu sehrdir.

Bunların heç biri təqdim edilə bilməz. Çünki müşahidə olunan reallıqda bunlardan heç biri yoxdur. Nəticə etibarilə, bu "xidmətlər" reallıqda mövcud olmayan şeyin, mövcud olan adı altında satışıdır. Bu quruluşlu aldatmadır. Lakin müasir hüquq sistemlərində bu çox vaxt aldatma kimi tanınmır, çünki:

- Zərər görmüş şəxs təklif olunan xidmətə subyektiv olaraq inanmışdır (razılıq var), — Heç bir tərəf obyektiv şəkildə xidmətin göstərilmədiyini sübut edə bilməz (xidmət obyekti sübut edilə bilməz), — Satıcı satdığı şeyə vicdanla inanır (aldatmada subyektiv istiqamət yoxdur).

Sonuncu bənd xüsusilə maraqlıdır. Bir çox "şəfa verənlər" reallıqda etdiklərinə inanırlar. Müasir saxta elmin ən qorxunc sirlərindən biri burada gizlənir. Klassik dələduz bilir ki, yalan danışır. Gözləri açıqdır. Lakin müasir "teta-hiler"? O, müqəddəs şəkildə şəfa verdiyinə əmindir. Bu necə mümkündür? Onu ödənişli kurslardan keçirmişlər. Orada addım-addım onun şübhələrini pozmuşlar. Metodun reallığına onu özü də

inandırmışlar. O, illüziyanı möhkəmləndirən parlaq kağız — sertifikat almışdır. Sonra görür ki, "müştərilər" yaxşılaşır. Bədənləri rahatlaşır, üzlərində rahatlıq əmələ gəlir. Subyektiv olaraq bu, metodun tam təsdiqi kimi görünür. Lakin pərdənin arxasına baxın. Əslində nədir? Plasebo effekti. Üstəlik, müvəqqəti pisləşmədən sonra orqanizmin normal vəziyyətinə qayıtması. Heç bir möcüzəvi şəfa yoxdur. Yalnız bioloji qanunauyğunluq var ki, şəfa verən özünün zəfər sehrini sanır.

Bu səmimi özünüaldatma insanı məsuliyyətdən azad etmir. Gündə yüz milliqram haloperidolin yüngün narahatlıq üçün faydalı olduğuna içdən inanan həkim (həqiqi terapevtik doza bundan dəfələrlə azdır və yüngün narahatlıqda antipsikotik ümumiyyətlə göstərilmir) bu "səmimiyyəti" ilə haqlı sayılmaz. O, tibbi yardım standartlarını pozub və bunun fərqində olub-olmamasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur.

Eyni məntiqlə, "Hər Şeyin Sahibi" ilə əlaqədə olmağa inanan teta-hilerin səmimi inancı standartlara əməl etməməsinə bəhanə ola bilməz. Burada standart aydındır: xidmət müstəqil təsadüfi araşdırmalarla təsdiq edilmiş, plasebo effektindən yüksək empirik effektivliyə malik olmalıdır. Yoxdursa, satmaq olmaz.

Fransanın son iyirmi il təcrübəsi göstərir ki, bu problemlə mübarizə üçün hüquqi vasitələr mövcuddur, baxmayaraq ki, çətindir.

Fransa 2001-ci ildən "zəiflikdən sui-istifadə" (abus de faiblesse) anlayışını tətbiq edən Əbu-Pikar qanununa malikdir. Bu, psixoloji texnikalardan istifadə edərək zəif vəziyyətdə olan insanı özünə zərər verən hərəkətlərə təşviq etmək deməkdir. Qanun əsasən kult liderlərinə qarşı yönəlmiş olsa da, bəzi saxta müalicəçilərə də şamil edilir.

2024-cü ildə Fransa daha sərt dəyişiklik edərək Cinayət Məcəlləsinə "psixoloji tabeçilik" (assujettissement psychologique) anlayışını daxil etdi. Bu cinayət üç ilədək azadlıqdan məh-

rumetmə və 375 min avroya qədər cərimə nəzərdə tutur; ağırlaşdırıcı hallarda (qurbanın yetkinlik yaşına çatmayan və ya sağlamlıq durumu zəif olan şəxs olması, onlayn vasitələrlə və ya təşkilat qrupu tərəfindən törədilməsi) isə cəza yeddi ilə qədər azadlıqdan məhrumetmə və bir milyon avroya qədər cərimə ola bilər.

Fransanın yanaşmasının əsas xüsusiyyəti budur ki, inancın məzmunu cinayət sayılmır. Fransız qanunu istənilən şeyə inanmağı qadağan etmir. Lakin psixoloji tabeçilik texnikalarını, xüsusən də kult liderləri və ya etikasız "kouç"ların izdəşərlərini istismar etmək üçün istifadə etdiyi üsulları cinayət hesab edir.

Fransanın yanaşması ziddiyyətlidir və insan hüquqları təşkilatları tərəfindən qurbanları qorumaqla inanc azadlığını məhdudlaşdırma arasında təhlükəli sərhədin aradan qalxmasına görə tənqid olunur. Lakin Avropanın ən böyük dövlətlərindən birinin bu problemə qarşı hüquqi vasitələr axtarması özü də göstəricidir.

Bir çox postsovet ölkələrində buna bənzər heç nə yoxdur. İstehlakçı hüquqlarını qoruma qanunları ezoterik xidmətlərə şamil edilmir. Cinayət Məcəlləsi "klassik" firikçilikləri (Rusiya Federasiyası CM-nin 159-cu maddəsi, Azərbaycan, Qazaxıstan, Belarusda oxşar maddələr) cəzalandırır, lakin bu maddəni üsuluna həqiqətən inanan teta-hilerlə qarşı tətbiq etmək texniki cəhətdən çox çətindir.

Nəticə: ildə yüzlərlə milyard rubl dövriyyəsi olan, milyonlarla insana sənədləşdirilmiş ziyan vuran xidmətlər ətrafında tam hüquqi boşluq hökm sürür.

İndi isə bu fəslin ən vacib məqamına — məsələnin mənəvi tərəfinə keçək.

Martin Lüter Kinqə aid edilən (tam dəqiq deyil, amma mahiyyətcə doğru) bir ifadə var: "Ən böyük faciə pis adamların dəhşətli sözləri deyil, yaxşı adamların dəhşətli sükutudur."

Bu, tam da bizim vəziyyətimizə uyğundur.

Bu gün psixoloji, mənəvi, enerji yardımı adı altında görülən dəhşətli işlər cəmiyyətdə çoxlu pis insan olduğuna görə deyil. Bunları nisbətən az sayda insan edir. Amma onlar "işləyir", çünki yaxşı, ağıllı, peşəkar səviyyədə uğurlu insanların böyük əksəriyyəti susur.

Susurlar. Hamısı, istisnasız. Qanunvericilər susur. Nizamlayıcı orqanlar susur. Psixiatr və psixoloqların peşə birlikləri susur. Universitetlər susur. Halbuki orada, psixologiya fakültələrində bilirlər. Müəllimlər bilir. Dəqiq bilirlər: məzunlarının əksəriyyəti elmi standartlara uyğun olmayan bir sahədə işləməyə gedir. Bilirlər. Və susurlar. Tələbələrə demirlər. Bir kəlmə də. Jurnalistlər susur. Onlara asandır — "yeni metodlar" haqqında əyləncəli materiallar. Parlaq başlıqlar. Reytinqlər. Analitik ifşaları isə kimə lazımdır? Psixiatr həkimlər susur. Elə onlar görürlər. Yalançı müalicəçilər tərəfindən şikəst edilmiş xəstələri görürlər. Görürlər — və susurlar. "Bu bizim mövzumuz deyil." "Biz siyasətçi deyilik." "Qoy hər kəs özü qərar versin." Sükut. Divar kimi sıx.

Və milyonlarla adi insan susur — yalançı müalicədən zərər çəkmiş xəstələrin yaxınları. Onlar çox vaxt nə edəcəklərini bilmirlər. Utancaqlıq çəkirlər. "Dini hissləri təhqir etməkdən" qorxurlar (halbuki bunun həqiqi dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur). Danışmağa haqları olduğuna əmin deyillər.

Bu səssizlik — cinnət pandemiyasıdır.

Virus təkcə yoluxanlar və yoluxmağa həssas olanlar olduğuna görə yayılmır. O, "dayan!" deyən olmadığına görə yayılır. Heç kim peyvənd başlatmır. Heç kim karantin tətbiq etmir. Hamı ümid edir ki, "öz-özünə keçər", "bizim problemimiz deyil", "qoy başqaları həll etsin".

Öz-özünə keçmir. Və hər birimiz bununla məşğul olmalıyıq.

Konkret olaraq nə təklif edirəm.

Qanunvericilər üçün. Milli qanunvericiliyə fiziki cəhətdən mümkün olmayan xidmətlərin satılmasının yolverilməzliyi konsepsiyasının daxil edilməsi. Bu, inanclara qadağa deyil — hər kəs istədiyinə inanmaqda sərbəstdir. Bu, sübut bazası olmayan xidmətlərin kömək edən xidmət adı altında kommersiyalaşdırılmasına qadağadır. Ezoterik inancları şəxsi mənəvi praktika kimi pulsuz tətbiq etmək olar. Onları pul müqabilində sağlamlığı yaxşılaşdıran xidmət kimi satmaq olmaz, çünki bu, istehlakçı hüquqlarının müdafiəsinin əsas prinsipini pozur.

Nizamlayıcı orqanlar üçün: sanitar-epidemioloji xidmətlərin, istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi xidmətlərinin, vergi orqanlarının "alternativ xidmətlər" sahəsində səlahiyyətlərinin genişləndirilməsi. Dövlət imtahanı ilə psixoloji xidmətlərin məcburi lisenziyalaşdırılması. Sertifikatlaşdırılmış mütəxəssislərin təhsili və iş statusu göstərilməklə açıq reyestri.

Peşəkar psixiatr və psixoloq assosiasiyaları üçün. Elmi olmayan metodlara qarşı açıq mövqe. Cəmiyyəti anlaşılan, sadə dildə maarifləndirmək. Kommersiya "metodikaları"nın elmi əsaslılığını qiymətləndirmək üçün birgə ekspert şuralarının yaradılması təşəbbüsü.

Media üçün. "Psixoloji" və "şəfaverici" nəşrlərə tibbi məqalələrə tətbiq olunan fakt-yoxlama standartlarının tətbiqi. Effektivliyi sübut olunmamış xidmətlərin reklamından imtina. Fövqəltəbii qabiliyyətləri normallaşdıran əyləncə formatlarından imtina (məsələn, "Ekstrasenslər döyüşü" — bu cür verilişlər xəbər yayımlanan kanalların efirindən yox olmalıdır).

Təhsil sistemi üçün. Məktəb proqramına elmi savadlılıq və tənqidi düşüncə üzrə məcburi kursun daxil edilməsi. Yeniyetmələrə elmi iddianı qeyri-elmi iddiadan, sübutu sadəcə iddiadan, kommersiya reklamını tibbi məsləhətdən ayırd etməyi öyrətmək.

Hər birimiz üçün şəxsən: danışmaq, yazmaq, dərc etmək, müzakirə etmək, yaxınları xəbərdar etmək. Qonşu qadın "enerji şəfavericisinə getməyə başladım" deyəndə susmamaq. Tanış həkim xəstələrini "nəsil yaddaşı mütəxəssisi"nə yönləndirəndə susmamaq. Məktəb yoldaşı Instagram-da "tarodüzülmələr" satanda susmamaq.

Yumşaq, hörmətli danışmaq — amma danışmaq. İzah etmək. Faktlar gətirmək. Alternativlər tövsiyə etmək — əsl psixiatrları, əsl psixoterapevtləri, əsl tibb mərkəzlərini.

Susmaq — neytrallıq deyil. Susmaq — tərəf seçməkdir. Pandemiyanın tərəfini.

Bu fəsilə sənayenin necə reaksiya verəcəyini bilirəm.

Deyəcəklər: "Müəllif dözümsüzdür. Müəllif öz fikrini zorla qəbul etdirir. Müəllif azadlığa qarşıdır. İnsanlar istədiklərinə inana bilməzmi? Mütəxəssisləri sərbəst seçə bilməzmi? Biz demokratiyada yaşayırıq, elmi monopoliyanın totalitar cəmiyyətində deyil."

Bunlar standart arqumentlərdir. Onlara aydın cavab vermək lazımdır.

Etqad azadlığı — müzakirə mövzusu deyil. Karmaya inanırsınızsa — sizin haqqınızdır. Reinkarnasiyaya inanırsınızsa — sizin haqqınızdır. Tanrının dualarınızı şəxsən dinlədiyinə inanırsınızsa — sizin haqqınızdır. Heç nəyə inanmırsınızsa — bu da sizin haqqınızdır. Mən, psixiatr kimi, bu dünyagörüşü mövqelərindən heç birinə iddia irəli sürmürəm, bir şərtlə ki, onlar insanın şəxsi işi olaraq qalsın.

Kommersiyalaşma tənzimlənir. Hər hansı fəaliyyət ödənişli xidmətə çevrilən kimi, avtomatik olaraq tənzimləmə sahəsinə düşür. Möcüzələrə inam — hər kəsin şəxsi işidir. "Möcüzə yaratma seansları"nın satışı — kolbasa, avtomobil və ya hər hansı digər məhsul və ya xidmətin satışı kimi keyfiyyət nəzarətinə tabe olan kommersiya fəaliyyətidir.

Xüsusilə söhbət psixi sağlamlıqdan gedəndə. Depressiyalı, narahatlıq pozğunluğu olan, psixozlu, borderline vəziyyətində olan xəstə — o, artmış həssaslıq tələsinə düşür. Onun şüuru avtomobil alan sağlam alıcının etdiyi kimi manipulyasiyalara rasional müqavimət göstərə bilmir. Dövlət avtomobil alıcısını vicdansız satıcıdan qızğın şəkildə qoruyur, amma həmin depressiyalı xəstəni vicdansız "şəfaverici" ilə təkbaşına buraxır. Bu ikiüzlülük deyilmi? Bu məntiqlidirmi? Qarşımızda açıq-aşkar bir ziddiyyət var. Çıxış yolu yalnız birdir: ya istehlakçı hüquqlarının müdafiəsindən tamamilə imtina etmək, ya da onu istehlakçının həqiqətən həssas olduğu bütün sahələrə yaymaq.

"Saxta elmin azadlığı" deyə bir şey yoxdur. Saxta elm nə dindir, nə fəlsəfə, nə incəsənət, nə də şəxsi inamdır. Saxta elm — elmi əsası olmayanı yalançı elmi terminlərə bürünərək satmaq cəhdidir. Ona qarşı eyni alətlərlə mübarizə etmək lazımdır: saxta dərmanlara, qondarma kosmetikaya, investisiya piramidaları ilə fırıldaqçılığa qarşı mübarizə alətləri ilə.

Və son bir şey. Bu fəsildə həkəm kimi yazıram, amma vətəndaş kimi müraciət edirəm — postsovet məkanının vətəndaşlarına, Rusiyada, Azərbaycanda, Qazaxıstanda, Ukraynada, Belarusda, Gürcüstanda və regionumuzun digər ölkələrində yaşayan oxuculara.

Ümumi məsuliyyət. Danışdığımız region cəhalət pandemiyasının əsas hədəflərindən birinə çevrilib — milyonlarla insan bundan ziyan görür, bu heç də mübalağa deyil. Bu nə lənətdir, nə təbiət, nə də tale. Bu — cəmin nəticəsidir. Zəif nəzarət — birinci. Sovet dövrünün travmatik təcrübəsi — ikinci. Ən əsası isə budur: rəsmi tibb özünü cəmiyyətin bir hissəsi üçün diskredit edib və bu çatlıq onilliklərlə sağalmır. Sosial şəbəkələrin sürətli inkişafı — üçüncü. Media savadsızlığının paralel inkişaf etməməsi — dördüncü. İqtisadi bərabərsizlik — beşinci. Əsl faciə məhz burada baş verir: saxta müalicəçilərin ucuz xidmət-

ləri həqiqi həkimlərin bahalı xidmətləri ilə rəqabət aparır. Bu rəqabətdə biliklilər deyil, qiyməti aşağı olanlar qalib gəlir.

Bütün bunlar düzəldilə bilər. Ancaq düzəliş əmək tələb edir. Peşəkarların həmrəyliyi tələb edir. Siyasi iradə tələb edir. Cəmiyyətin müzakirəsini tələb edir. Nəhayət, susmayacaq hər bir fərdi tələb edir.

Əgər ətrafınızda "enerji tənzimləyicilərə", regressoterapiyalara, teta-healerlara inanan biri varsa, ona deyin. Nəzakətlə, amma açıq. Alternativ təklif edin. Bu kitabı göstərin. Digər elmi mənbələri göstərin.

Əgər özünüz qohum sahənin mütəxəssisisinizsə (jurnalist, hüquqşünas, müəllim, inzibatçı, siyasətçi), peşənizdən istifadə edin. Məqalə dərc edin. Qanun layihəsini dəstəkləyin. Forumda çıxış edin. Sosial şəbəkələrdə yazın.

Əgər sadəcə bu mühitdə yetişmiş oxucusanızsa, pandemiyanın sakit tərəfdaşı olmağı dayandırın. Danışmağa başlayın. Heç olmasa evdə. Heç olmasa dostlarla. Heç olmasa bir dəfə olsun açıq danışın.

Səssiz razılıq bu pandemiyanın əsas enerji mənbəyidir. Ona qida verməyi dayandırın.

VI HİSSƏ. QAYIDIŞ

Fəsil 27. Bir sağalmanın hekayəsi

Bu kitab demək olar ki, bütünlüklə “necə etmək lazım deyil” hekayələrindən ibarətdir. Kəllə açma, komalar, buz baltası, sülfozin, “düzülüşlər”, “nəsil oxuma”. Əgər kitabı əvvəlki fəsildə bağlasan, oxucunun cavab verməyə haqqım olmayan bir sualı qalar: bəs necə etmək lazımdır? Bu səhifələrin yazılmasına səbəb olan həmin sübuta əsaslanan psixiatriya necə görünür — bəyannamələrdə deyil, konkret bir insanın həyatında?

Danışacağam. Hekayə real pasiyentlərimin hekayələrindən toplanıb — bu kitabda hər yerdə olduğu kimi, adlar və təfərrüatlar dəyişdirilib, mahiyyət saxlanılıb. Nə ən asan, nə də ən ağır halı seçdim. Tipik olanı seçdim. Onda möcüzə olmayacaq. Elə əsas da budur.

Elçinin iyirmi yaşı vardı. Üçüncü kurs, proqramlaşdırma fakültəsi, dəqiqəbədəqiqə planlanmış həyat. Payız. Sadəcə dərslərə artıq getmirdi. Valideynlərinə dişinin arasından deyirdi: “Yorulmuşam”. Amma həqiqət başqa idi. Üç həftə və altı gün. Elçin bunu artıq elə bu qədər müddətdir bilirdi. Kurs yoldaşlarının qapalı çatı. Onun adı — hər ikinci sətirdə. Auditoriyalardakı kameralar — hamısı, istisnasız olaraq — hiss olunmadan onun tərəfə çevrilib. Və səs. Kişi səsi. Sakit. Aydın. Sağ çiyninin arxasından gəlirdi, sanki kimsə əyilmişdi ki, pıçıldasın: “Ayağa qalxdı”. “Fincanı götürdü”. “Yenə oturdu”. Nə hədə, nə əmr. Yalnız təsbit. Söndürə bilmədiyin radio kimi. Elçin susurdu. Ağıllı oğlan. Bu hekayənin necə səslənəcəyini yaxşı bilirdi.

Sonrasını artıq bilirsiniz, çünki üçüncü hissədən sonrakı ara fəsli oxumusunuz — bu yol bizim regionda çoxdan

döyülüb. Nənə dedi: “Edilib”. Mollası oldu, qorxunu çıxaran qadın oldu, bir də tumar — Elçin onu, yeri gəlmişkən, sözə baxıb gəzdirirdi, ona fərqi yox idi, nənəyə isə rahatlıq gətirirdi. Beş ay keçdi. Çiyninin arxasındakı səs yaza doğru bir deyildi artıq.

Onu yanıma atası gətirdi — səssiz, dirsəyindən tutub, uzun sürən ailə məğlubiyyətindən sonra adamı belə gətirirlər. Elə buradan da fəslin yazılmasına səbəb olan hissə başlayır. Baxın, metod necə görünür — addım-addım, sehirsiz.

Birinci — bir baxışda qoyulmayan diaqnoz. İlk qəbulda “şizofreniya” sözünü demədim. Bir dəfə də. Başqa cür dedim: təsvir etdiyiniz şey psixoz adlanır. Psixozun səbəblərinin siyahısı var — biz də o siyahını başdan-başa keçməliyik. Sona qədər. Müayinə. Analizlər. MRT. Maddələrlə bağlı suallar. İyirmi yaşda psixotik başlanğıc olanda onları mütləq soruşurlar. Həmişə. Buna inciməyin də yeri yoxdur. Yalnız qalanını istisna etdikdən sonra. Yalnız mənzərəyə dinamikada — hərəkətdə, inkişafda, simptomun gizləndiyi, yalan danışdığı, başqa bir şeyin maskası altına girdiyi o həftələrdə baxdıqdan sonra. Elə o zaman diaqnozu ucadan dedim. Formula satan diaqnozu bir dəqiqədə qoyur. Onun diaqnozu da həmişə birdir — müalicə etdiyi diaqnoz. O, “özünü” tapıb, artıq axtarmır. Həkim həftələrlə yoxlayır ki, səhv etməyibmi. Hər gün. Hər görüşdə. Əlindəki hər analizdə. Bu yavaşlıq deyil. Elə peşə budur.

İkinci mərhələ — müalicə. Onun adı və planı var: doza. Biz antipsixotik dərman verməyə başladıq. Tək preparat. Minimal effektiv doza. Və heç nəni gizlətmədən açıq danışıq: nəyi gözlədiyimizi, nə qədər vaxt lazım olduğunu, hansı yan təsirlərin ola biləcəyini — və onlarla necə mübarizə aparacağımızı izah etdim. Səslər üçüncü həftədə geri çəkilməyə başladı. Yox olmadı — yox, sadəcə geri çəkildi. Daxili “radio” daha sakitləşdi. Sonra daha seyrək oldu. Sonra isə Elçin özünü elə

bir düşüncəyə qapılmış gördü ki, dərisini ürpətmələr bürüdü: axşam şərhçisiz keçdi.

Üçüncüsü. Və bu barədə — heç nəyi ört-basdır etmədən. Mənim səhvim. İkinci ay.

Elçin ayaqdan-ayağa keçir. Mənzilin içində dolanır. Qəfəsdəki vəhşi heyvan. "Ayaqlarda narahatlıq"dan şikayət edir — sıx, əzələləri dartan bir narahatlıq.

Mənim diaqnozum? Narahatlıq pozuntusu.

Və — bunu yazmaq fiziki ağrı qədər utandırıcıdır, amma dürüstlük vəd etmişdim — korrektoru tətbiq etmədim.

Xeyr.

Antipsixotikin dozasını artırdım. Məntiq dəmir kimi görünürdü: proses tam müalicə olunmayıb — daha güclü vur.

Daha pis oldu. Qat-qat pis.

Çünki bu narahatlıq deyildi.

Bu akatiziya idi. Əzabverici hərəki narahatlıq. Dərmanın özünün yan təsiri.

Fikirləşin. Mən, həkim, öz əllərimlə zəhəri onun qurduğu tələyə tökürdüm. Klassik tələ. Hər dərslikdə təsvir olunub. Tələbəlik illərindən bəri bilirdim — və yenə də açıq ağzın içinə addım atdım.

Elçin mənim korluğumun əvəzini üç bəd həftə ilə ödədi.

Bəs niyə mən bunu sağalma barədə olan fəsildə danışıram? Çünki tam bu nöqtədə dəlilik formulundan və tibbdən nəyin

fərqləndiyini görə bilərsiniz. Səhvlərin olmamasında deyil. Sonra baş verənlərdə. Mən gördüm ki, xəstənin vəziyyəti pisləşdi. Bunu fərq etmək mənim vəzifəm idi: bizim nəzarət görüşlərimiz var idi. Mən şkalalar üzrə qeydlər aparırdım. "Yaxşı, yaxşılaşırsan?" deyə soruşmadım, konkret və maddələrlə soruşdum. Mən akatiziyanı tanıdım. Səhvimizi səsli şəkildə etiraf etdim — Elçinə və onun atasına. Dozanı azaltdım. Dərmanı dəyişdim. On gün sonra "ayaqlardakı narahatlıq" yox oldu. İndi mənim yerimdə şəfaçının olduğunu təsəvvür edin. O heç nəyi fərq etməzdi. Onun nəzarət görüşləri yoxdur. Şkalalar yoxdur. "Sizin metodunuzdan pisə getdim" kateqoriyası yoxdur — onun sistemində pisə getmək yalnız xəstənin "müqaviməti" və ya "negtiv enerjisi" səbəbilə baş verə bilər. Budur fərq nöqtəsi. Həkimin səhvi — müalicənin gedişatını dəyişən hadisədir. Şəfaçının səhvi — heç olmayan hadisədir.

Dördüncü. Müalicənin bir hissəsi kimi ailə. Diaqnozdan daha tez marağı öldürən bir söz var. Psixotəhsil. Yorucu. Bürokratik. Bunu səslə deyin — otaqdakı işıqların söndüyünü eşidəcəksiniz. Amma bu sözün arxasında rəqəmlər durur. Və bu rəqəmlərə inanmaq çətindir. Araşdırmalar eyni şeyi göstərir: valideynlərlə işləmək residivləri azaldır. Nə qədər ki, biz bunu qəbul etməyə hazırıq. Nə qədər ki, bunu etiraf etmək rahatdır. Özümüzün inandığından daha çox. Mən Elçinin valideynləri ilə ayrıca işlədim. Və onlar bunları öyrəndilər: Psixoz nədir. Remissiya nədir. Niyə "özünü ələ almaq" üsul, məsləhət və ya dərman deyil. Niyə danlama və həddindən artıq qayğı eyni dərəcədə incidir. Və vaxtında hərəkət etmək üçün erken əlamətlərə nəzər salmaq lazımdır. Nənə öz fikrində qaldı. Olsun. Biz bir şey barədə razılaşdıq: nərdivan və tabletlər uyğundur. Bir şərtlə: nərdivan inhisar iddiasında deyil. Mən xəstələrimin inancı ilə müharibə etmirəm. Mən mübarizə aparıram ki, inanc müalicəni ləğv etməsin.

Beşinci. Həyatın qaytarılması. Həb bir şey edir — simptomları söndürür. Düz bir şey. O, buraxılmış ili geri qaytarmır.

Özünəinamı qaytarmır. Onun yerinə dərslərə oturmur. Sonra — iş. Universitetdə bərpa. İkinci cəhddən. Koqnitiv məşqlər: psixozdan sonra ilk növbədə diqqət və iş yaddaşı sıradan çıxır — və onları qırılmış bağ kimi yenidən bərpa etmək lazım gəlir. Psixoterapiya: Elçin "siqnalları" düşüncələrdən ayırmağı öyrənir — və diaqnoz faktı ilə yaşamağı, onu bioqrafiyaya çevirmədən. Bir ildən çox. Bu ilin heç bir ayı möcüzəyə bənzəmirdi. Sınıqdan sonrakı fizioterapiyaya bənzəyirdi: az-az, geri dönüşlərlə, darıxdırıcı.

Altıncı — residiv. Bu sözü yadda saxlayın. Lazım olacaq. Üçüncü il. Remissiya — yaxşı, dayanıqlı, dərslik üzrə. Elçin çoxlarının etdiyini etdi: sağlam olduğuna qərar verdi. Və dərmanı sakitcə dayandırdı. Heç kimə demədi. Sadəcə içməyi dayandırdı. İki aydan sonra şərhçi qayıtdı. Bu fəsli yazmaya bilərdim. Residivsiz hekayə daha yaxşı satılardı — hamar, qələbəli, finalda alqışlarla. Amma şizofreniya haqqında həqiqət belədir: bu xroniki xəstəlikdir. Bu fəsildə "sağalma" sözü "xəstəlik yox oldu" demək deyil. O deməkdir: xəstəlik idarəolunandır, insan öz həyatını yaşayır. Residivi ilk epizoddan daha tez aradan qaldırdıq. Niyə? Birincisi: ailə erkən əlamətləri Elçinin özünün fərqinə varmasından iki həftə əvvəl tanıdı. İki həftə — idarəolunan pozğunluqla fəlakət arasındakı uçurumdur. İkincisi: kabinetimin qapısını beş ay axtarmaq lazım deyildi. O artıq tapılmışdı. Bir dəfə. Əbədi. İndi o, dəstəkləyici terapiyadadır. Kiçik doza. Və bilir ki, bu nə üçündür — mən ona toxunmağı qadağan etdiyim üçün deyil. Bir dəfə özü yoxladığı üçün. Yetkin qərar itaətkar qərardan baha başa gəlir.

Beş il. Zaman xəttində — rəqəm. Arxasında — uçurum. Qarşısında — möhkəm torpaq. Aralarında — Elçin. O, ixtisası üzrə işləyir. Elə bir şirkətdə ki, diaqnozu barədə yalnız özünün pərdə arxasına baxmağa icazə verdiyi adamlar bilir. Sirr qorunub. Amma kölgə heç yerə getməyib. Sağ çiyninin arxasındakı səs hələ də qayıdır. Yalnız güclü stress dövrlərində yaranır. Sakitcə. Eşitmə həddinin lap sərhədində. Görünməz

xordan gələn pıçıltı kimi. Elçin ondan mənimlə sakit danışır. Guya bu şeytan deyil. Guya bu, sadəcə ocağa baş çəkən qoca qonşudur. Son gəlişində cəmi iki sual verdi. Dostlarla dağlara gedə bilərmi? Və saat fərqi olanda həblərlə nə etməli? Hamısı bu. Yarım il ərzində onun bütün psixiatrik sualı bu idi.

Sağalma belə görünür. Nə "DNT sağlamlaşdırması". Nə qrup seansında hönkürüb "babanın müavini" ilə qucaqlaşmaq. Analizlər, titrləmə həftələri, həkimin bir səhvi — tanınıb düzəldilmiş, — darıxdırıcı psixotəhsil, bir il reabilitasiya, bir residiv, dəstəkləyici doza. Və dağlar barədə soruşan bir insan.

Qarşınıza iki şəkil qoyun. Birinci. Parlaq reklam: "Şizofreniya? Bir seansda sağaldırıq!". Yanında gülərüz bir qadın — bioenergetika qurusunun müştərisi. Altı ay sonra — həmin qadın. Amma indi xüsusi müəssisənin kafes arxasında, üzü boşalmış, baxışları heç bir yerə dikilmiş. İkinci. Ağ xalatlı, qaşqabaqlı həkim: "Tam sağalma yoxdur". Onun pasiyenti — əlləri əsən oğlan — beş il sonra. Elbrusun ətəyində bel çantasını bağlayır. Gözləri alovlanır. Dəlilik formulu uduzur. Gözəl sözlərdə yox — orada o kraliçadır. O burada uduzur, reallığın tikan-tikan saniyələrində, vədlərin toza çevrildiyi yerdə. Yalnız işləyənin qaldığı yerdə. Elm — təmtəraqsız, zəmanətsiz — yavaş-yavaş, qaçılmaz şəkildə qalib gəldiyi yerdə.

Möcüzənin həmişə reklamı yaxşıdır. Metodun isə katamnezi yaxşıdır.

Və əgər bütün bu kitabdan bir cümlə yadda qalacaqsa — qoy bu olsun.

Fəsil 28. Nəticə: əslində kim dəlidir?

Kitab bir fikirlə başlamadı. O, bir iynə ilə başladı. Bakı. İkinci psixiatriya xəstəxanası. İki mininci il. Otaq ki, orada mən — o vaxt gənc həkim-ordinator — dayanıb sülfozin inyeksiyasının hazırlanmasına baxırdım. Xroniki şizofreniyalı pasiyent. Dünya elmi tərəfindən onilliklər əvvəl rədd edilmiş üsul. Onilliklər keçdi. Dünya elmi "yox" dedi — burada hələ də "bəli" deyirdilər. Özündən başqa heç kimə real təhlükə törətməyən bir insan. Budur, o, qarşımda uzanıb. İynə parıldadı. İndi başlayacaq ağrı. İndi baş verəcək mənasızlıq. Bu otağı yadda saxlayın. Çünki sonra oxuyacağınız hər şey məhz buradan boy atır.

Özümə sual verdim: burada kim dəlilik vəziyyətindədir?

İndi, bütün bu kitabı arxada qoyub, bu suala qayıtmaq istəyirəm. Və ona cavab vermək. Daha doğrusu — etiraf etmək ki, bu sualın tək cavabı yoxdur, və bu sadə cavabın mümkünsüzlüyündə — əsas dərsdir.

Dəlilik halında kim olub?

O, burada öz iradəsi ilə uzanmamışdı. Bədənini görünməz qısqaclar sıxırdı. Xəstəliyin qısqacları. Real danışıqla əlaqəni qıran elə həmin şizofreniyanın. Onun iltihablı baxışının arxasında nə baş verirdi? Səslər? Görüntülər? Həkimlər cavabı bilirdilər. O — yox. Beyni ona yalan deyirdi. Qorxusu sinapslarda kimyəvi fırtına idi. Hezeyanı — metafora deyildi. Sınmış neyron zənciri. Dəlilik? Xeyr. Bu, iblis tutması haqda nağıl

deyil. Ümidsizliyin seçimi deyil. Bu diaqnozdur. Quru. Dəqiq. Amansız. Belə də olur. Beyin sıradan çıxır. Ağciyərlər sətəlcəmdə olduğu kimi. Mədəaltı vəzi diabetdə olduğu kimi. Damarlar insultda olduğu kimi. Yalnız burada hədəf — realığın özüdür. Və "mən"lə dünya arasındakı sərhəd yavaş-yavaş əriyir. Xəstəliyin turşusunda.

Yanında dayanan həkimlər deyil. Onlar da mənim kimi mütəxəssis idilər. Diplomları vardı. Təhsil almışdılar. Etdikləri işə inanırdılar. Onlar klinik dəlilik vəziyyətində deyildilər — heç bir psixiatr onların heç birinə "psixoz" diaqnozu qoymazdı.

Amma onlar dəliliyə struktur baxımdan yaxın bir şey edirdilər — elmi əsası olmayan bir üsulu sistemli şəkildə tətbiq edirdilər və onun faydalılığına tam əmin idilər. Universitetlərdə öyrədilənlərlə praktikada etdikləri arasındakı ziddiyyəti görmürdülər. Dünya elmi ictimaiyyətinin nöqteyi-nəzərindən anomaliya olanı onlar normal sayırdılar.

Bu — ayrı bir beynin dəliliyi deyil. Bu — sistemin dəliliyidir. İllər boyu təkrarlanan, özünü düzəltməyə qadir olmayan, korporativ həmrəylik və institusional ətalətlə qorunan kollektiv səhv.

Pəncərə yanındakı mən, gənc ordinator deyil. Mən təcrübəsiz, gənc idim, baş verənləri dayandırmaq hüququm və imkanım yox idi. Baxırdım və susurdum. Sükutum, ən kiçiyi və ən zəifi olduğum sistemdə sağ qalma aktı idi.

Amma mənim susmaqım da həmin sistemli xəstəliyin bir hissəsi idi. Hər bir gənc həkim, hər bir rezident, hər bir gənc işçi köməyin standartları pozulanda susaraq kollektiv xəstəliyə töhfə verir. O zaman mənim susmağım bağışlanıla bilərdi, çünki nə edəcəyimi bilmirdim. Amma bu gün, bilə-bilə susmaq qəbul olunmazdır. Buna görə də bu kitabı yazıram.

Bu günlərdə dəlilik

Bu səhnə iyirmi beş il əvvəl baş verdi. O vaxtdan bəri çox şey dəyişdi.

Yaxşı ki, çox şey dəyişdi: sovet sonrası klinikaların əksəriyyətində sülfozin artıq tarixə qarışdı. Psixiatrik köməyin beynəlxalq standartları tədricən bizim regionda tətbiq olunur. Gənc həkimlər dünya ədəbiyyatına daha geniş çıxış əldə edirlər. Xəstələr getdikcə öz hüquqlarını daha yaxşı bilirlər. Etik kodekslər, Madrid bəyannaməsi, WPA 2020 Kodeksi — bunların hamısı istəyən hər kəs üçün əlçatandır. Şizofreniya üçün farmakoterapiya inkişaf edib: ikinci və üçüncü nəsil antipsixotiklər daha az yan təsirlə tətbiq olunur.

Lakin pis dəyişdi: keçmiş sistemli çılğınlıq — sovet psixiatriyasının çılğınlığı — yerini yenisinə verdi. Bu çılğınlıq tibbdən kənar olsa da, eyni xəstələrə yönəlmişdir. "Yerləşdiricilər", teta-hilerlər, reqressologlar, "benzərsiz metodların müəllifləri", "əsil şəfaçılar", "nəsli yaddaş üzrə mütəxəssislər", "tez xoşbəxtlik vəd edən körfərlər". Sosial şəbəkələrdə milyonlarla abunəçi. İllik milyardlarla rubl. Yüz minlərlə xəstə, əvəzinə müalicə alaraq, onların həqi vəziyyətini daha da pisləşdirən saxta müalicə alırlar.

Çılğınlığın pandemiyası formasını dəyişdi, amma azalmadı. Daha geniş yayıldı. Daha dərin nüfuz etdi. Daha çevik oldu. Daha aldadıcı hala gəldi.

Oxucuya üç sual

İndi isə — bu kitabı bağlayarkən özünüzə cavab verməyinizi istədiyim üç sual.

Kim daha çox təhlükədədir: bağlı palatada səslər eşidən, antipsixotik qəbul edən və bir neçə həftədən sonra reallığa qayıdan adam — yoxsa hər gün yüz minlərcə izləyiciyə "nəslin sahəsini oxuduğunu" bildirən və onun vəziyyəti heç vaxt

remissiyaya çıxmayacaq adam — çünki bu diaqnoz qoyulmur, uğur kimi görünür və hər yeni müştəri ilə daha da güclənir?

Cəmiyyət üçün hansı daha təhlükəlidir: həftədə qırx beş dəqiqə öz hisslərini peşəkar ilə müzakirə edən depressiv xəstə — yoxsa milyonlara "rəsmi tibbin bir hiylə olduğunu" bildirən və bu milyonları əhatə edən qanunlar qəbul edən hakimiyyətli insan?

Yaxınlar üçün kim daha təhlükəlidir: dərman qəbul edən və həkim müayinəsində olan şizofreniya xəstəsi — çox vaxt əla həyat yoldaşı, valideyn, işçi — yoxsa sosial şəbəkələrdən gördüyü məsləhətlərə əsasən ilk psixozlu uşağı psixiatr yerinə reqressolog aparan "normal" valideyn?

Bu üç cütün hamısında cavab eynidir. Və hər üçündə bu cavab minilliklər boyu cəmiyyətin yanlış şeydən qorxmaq vərdişinə ziddir.

Təqdim etdiyim dəlilik tərifi

Bu tərifi birinci hissənin intermediyosunda vermişdim — bütün diplomlardan, mükafatlardan və qiymət siyahılarından əvvəl. İndi, arxasında bütöv bir kitab dayandığı üçün burada onu təkrarlayıram.

Dəlilik — klinik mənada — insanın reallıqla əlaqəsini və adekvat fəaliyyət qabiliyyətini pozan bir sindromdur.

Dəlilik — bu kitabın adında istifadə etdiyim geniş mənada — reallığın sistematik, davamlı, özünü düzəltməyə məruz qalmayan inkarıdır ki, bu da həm daşıyıcısına, həm də ətrafındakılara zərər vurur.

İkinci — geniş — tərifə görə, hər kəs dəlidir: — göstərilməsi fiziki cəhətdən qeyri-mümkün olan xidmətləri sistematik şəkildə satan; — sübutlardan asılı olmayaraq, öz inanclarının xeyrinə elmi faktları sistematik şəkildə inkar edən; — öz təcrübələri ilə başqa insanlara zərər vuran, lakin bunu "öz missiyası", "istedadı", "peşəsi" ilə əsaslandıran; — ətrafında onu

tənqiddən qoruyan ardıcıllar dairəsi yaradan; — öz səhv ehtimalını nəzərdən keçirməyə qadir olmayan.

Bu tərifə görə — psixiatrik klinikaların bəzi pasiyentləri dəli deyillər. Onlar xəstədirlər, amma xəstə olduqlarını bilirlər. Müalicəni qəbul edirlər. Öz reallıqlarını düzəldirlər. Öyrənirlər.

Lakin psixiatrik klinikalardan kənarda olan bəzi insanlar — sərbəst yaşayan, uğurlu, məşhur, varlı — bu sözün tam mənasında dəlidirlər. Onlar tibbi meyarlara görə xəstə deyillər. Amma reallığa ağıllı münasibət meyarlarına görə qeyri-normaldırlar. Və onlar — klinika pasiyentlərindən fərqli olaraq — öz vəziyyətlərini fəal şəkildə başqalarına yoluxdururlar.

Mənim öz mövqeyim

Mən psixiatr həkiməm. Xəstəlikləri müalicə edirəm. Mən siyasətçi deyiləm. Məsih deyiləm. Bütün suallara cavabım yoxdur.

Yalnız bir şeyi bilirəm. Hər gün qarşımda eyni dram oynanılır. Artıq son ümiddən başqa hər şeyini itirmiş insanlar qarşımda otururlar. Həyatları dağıdılmışdır — amma xəstəlik tərəfindən deyil. Yalan tərəfindən. Təqlid tərəfindən. Aldatma tərəfindən. On il. On beş il. İyirmi il. İki onillik onlar korlar kimi dairəvi şəkildə gəzib, yanlış qapıları döydülər. Görünməz saatlar saniyələri, dəqiqələri, illəri sayırdı. Yüz minlərlə. Milyonlarla rubl — tər və qanla qazanılmış pullar — boşluğa getdi. İşləməyən xidmətlər ödənildi. Dünyada heç bir güc bu illəri geri qaytara bilməz. Heç vaxt. Yanlarında isə — onların övladları. Taleləri yumruqda əzilmiş kağız kimi əyilib-bükülmüş uşaqlar. Onları ezoterik təcrübələrin zəhəri ilə zəhərlədilər — valideynlər özləri də anlamadan ailələrini bu zəhərlə zəhərləyirdilər. İtirilmiş illər. Onlar əbədi olaraq getdi. Artıq onları qaytarmaq mümkün deyil. Heç vaxt.

Və bu insanların hər birinin arxasında — onları "müalicə edən" həmin influenserlərin yüz minlərlə izləyicisi dayanır. Və hər gün yeni izləyicilər qazanan minlərlə başqa eyni influenser.

Bu — bir epidemiyadır. Metaforik deyil. Real, real həyat itkiləri və real iqtisadi zərərlərlə. Və real, lakin hələ ki həyata keçirilməmiş dayandırma imkanı ilə.

Oxucuya xahişim

Bu səhifəni gözünüzün önündə tutursunuz. Oxuyub bitirdiniz. Bəs niyə? Bu kitab sizi buraxmadı. Deməli, nəsə sizi dərindən yaraladı. Dərinizə işlədi. Bəlkə siz özünüz bu qaranlıqdan keçmisiniz. Burada təsvir olunanların içdən necə yandırdığını hiss etmisiniz. Bəlkə yaxınınız bu uçuruma düşüb — siz isə onun genişlənmiş göz bəbəklərinə baxıb orada bir səs axtarmısınız. Bəlkə də siz həmkarısınız. Psixi sağlamlıq sahəsində peşəkarsınız. Hər gün onların arxasınca qapını bağlayan adamsınız. Ya da yeniyetməsiniz — daha yolun əvvəlindəsiniz, amma yaxınlaşan dumanın soyuğunu artıq duyursunuz. Siz valideynsiniz — əllərinizi arxanızda yumruq düyünləyib övladınız üçün narahat olan. Siz jurnalistsiniz, siyasətçisiniz, müəllimsiniz. Onların yaşayacağı dünyanı formalaşdıran adamsınız.

Bu mövqelərin hər hansında olsanız da, nəsə etmək imkanınız var. Ən sadəsi — bu kitabı bir adama danışmaq: ona, kimin üçün bu kitab bir neçə il ömür qazandıra və ciddi məyusluqlardan xilas edə bilər. Daha çətini — açıq çıxış etmək: auditoriyanız varsa, hətta ən kiçiyi olsa da, onunla elmi baxışı paylaşın. Daha da çətini — öz peşə sahənizdə fəaliyyət göstərmək: həkimsinizsə — daha yaxşı müalicə edin, müəllimsinizsə — daha dəqiq öyrədin, jurnalistsinizsə — daha hərtərəfli yoxlayın, hüquqşünas və siyasətçisinizsə — qaydaları dəyişin.

Ən çətini isə müqavimətlə üzləşəndə geri çəkilməməkdir. Və siz onunla mütləq üzləşəcəksiniz. Pandemiya dəliliyi sənayesi nəhəng və gəlirli bir sahədir. Onun müdafiəçiləri fəal və aqressivdirlər. Sizi dözümsüzlükdə, hissləri təhqir etməkdə, totalitarizm, yalan elm (ironikdir — məhz bunda) və cəhalətdə ittiham edəcəklər. Əllərindən gələn bütün ritorik üsulları işə salacaqlar. Çünki onların iqtisadi modeli sükuta bağlıdır.

Geri çəkilməyin. Sadəcə — danışmağa davam edin.

Son söz — xəstələrə

Və son olaraq, ən əsası...

Bu kitabda yazdığım o insan sizsinizsə: narahatlıq, depressiya, OKB, psixoz, ailə problemləri və ya travma ilə yaşayan xəstə. Elə bir xəstə ki, indi düşünür: "Mən pisəm. Hara getdiyimi bilmirəm. Bu kitabı oxumuşam və psixiatr Kenan Rəhimov deyir ki, əsl mütəxəssisə getmək lazımdır. Bəs mən necə bilim kim əsl mütəxəssisdir?"

Qısaca cavab verməyimə icazə verin — tam cavabı isə bu kitabın sonundakı əlavədə tapın. Orada "Əsl mütəxəssisi necə tanımaq olar" adlı yoxlama siyahısı və qırmızı xəbərdarlıq işarələrinin siyahısı toplanıb. O, fotoşəklini çəkmək, göndərmək və divardan asmaq üçün yazılıb.

Burada əsas olanı deyim. Əsl mütəxəssis möcüzə vəd etmir və tələsmir. Onun diplomu dövlət reyestrində yoxlanıla bilər; onun metodları elmə aiddir, şəxsən özünə yox; onun kabinetində nəsil proqramlarına, enerjilərə və keçmiş həyatlara yer yoxdur. O, yan təsirlər barədə açıq danışır, sizi qorxu içində saxlamır və sizdə vəhyə ehtiyacı olan birini deyil, tərəfdaş görür.

Əgər belə bir insan tapmısınızsa, bu böyük bəxtiyarlıqdır. Onunla işləyin. Əgər ilk cəhdində tapmasanız da, axtarışı davam etdirin: ikinci, üçüncü dənəmə normal haldır.

Amma "yerləşdirmə" ustasına getməyin. Reqressoloqa getməyin. Teta-müaliciyə getməyin. "Nəsil yadigarlığı mütəxəssisi"nə getməyin. "Ekstrasenslər Döyüşü" şoumeninə getməyin.

Sənin həyatın onların biznes modeli deyil.

Son səhnə

Mən Bakının iki nömrəli xəstəxanasına qayıdıram. 2000-ci ilə. Bu kitabın başlanğıc səhnəsinə.

Xəstəyə iynə vurdular. O, üzüstə uzanıb gözlərini sıxacaq — sonrakıları bilir, burda ilk ili deyil. Bir neçə saatdan sonra qızdırma başlayacaq. Sonra isə üç gün ərzində sızısı keçməyən dörd ağrı nöqtəsi. Palata kafur və xlor iyi ilə dolub. Pəncərənin altında isə adi bir Bakı günü, xəstəxana həyətində kimsə paltar asır.

Pəncərədə gənc həkim dayanıb. İyirmi dörd yaşı var. Başa düşür — artıq başa düşür ki, indi ediləcək şeyin tibblə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bunu demək üçün lazım olan bütün sözlər ondadır. Amma heç birini demir.

İyirmi altı il. İyirmi altı ildir ona baxıram — və iyirmi altı ildir ki, yaxınlaşıb soruşa bilmirəm: niyə susursan? Cavabı bilirəm. Həmişə bilirdim. Cavab — mənəm. O susur, çünki kiçikdir. Çünki qaydalar belədir. Çünki bu sistemdə sual — küstahlıqdır. Küstahlıq isə cəzalandırılır. Nöqtə. Cinnət düsturu budur. Bunu yadda saxlayın, çünki o, yalnız əməl edənlərin üzərində deyil, yanında duranların, baxanların və səssiz qalanların üzərində qurulub. Səssizlik — onun oksigenidir.

O palata artıq yoxdur — tanış olduğum formasında. Sülfozin bizim şöbələrdən çıxıb; hər yerdə dəyil, dərhal yox, amma çıxıb. O xəstənin isə çoxdan dünyasını dəyişdiyinə əminəm. Onun adını bilmirəm. Bu kitabı ona həsr etdim — onun üçün edə biləcəyim yeganə şey budur və bu utanc doğuracaq qədər

azdır, amma o palatada duranlardan heç kimin onun üçün etdiyindən daha çoxdur.

Yaxınlarda öz klinikamızda, təhlil zamanı gənc həkim-klinikant əlimi qaldırıb, hamının qarşısında, sakitcə, meydan oxumaqdan uzaq şəkildə soruşdu: "Bəs ikinci preparatı nə əsasla əlavə etdiniz? Hansı məlumatlara əsasən bu halda kombinasiya monoterapiyadan üstündür?"

Yaddaşımın dəhlizində qəribə bir sakitlik hökm sürürdü...

Hiss etdim ki, o sistemdən gələn reflekslə içinə anlıq bir qəzəb qalxır: necə cürət edir. Və sonra, onu örtüb basdıran, iyirmi altı il çalışdığım hədəf budur: cürət etməlidir. Kiçiyin böyükdən soruşması küstahlıq deyil. Bu, tibbin immun sistemidir. Klinikanı sektadan, kafedranı dindarlıq dərnəyindən, üsulu düsturdan ayıran yeganə şeydir.

Onunla məlumatları müzakirə etdik. Bir nöqtədə haqlı olduğunu gördük və sxemi düzültdik. Xəstə bunu heç vaxt öyrənməyəcək — sadəcə bir az daha tez yaxşılaşacaq.

Bu, 2000-ci ilə cavabımdır. Bu kitab deyil — kitab yalnız izahdır. Cavab — səslə soruşulan həmin sualdır. Pəncərədəki gənc həkim nəhayət danışdı. Buna iyirmi altı il çoxdu və o, mənim səsimlə danışmır — bu isə daha düzgündür.

Otuz əsr. Otuz əsr boyu bəşəriyyət kəllədə deşik açıb — əzab çəkənin başından orada olmayan bir şeyi çıxarmaq üçün. Trepan. Xaç. Skalpel. İnsulin. Buz baltası. Kükürd. Fiurkalar. Efirlər. Səkkiz alət. Bir nəticə. Deşik yanlış yerdə açılırdı. Hər dəfə — yanlış yerdə. Çünki çıxarılmalı olan xəstənin beynində oturan şey deyildi. Müalicə edənin beynində oturan şey idi. Əminlik. Yoxlanılmadan.

Nəhayət onun üçün bir çıxış yolu tapıldı. Bu yol trepan tələb etmir. Uca səslə verilən sual və ona verilən dürüst cavab tələb edir.

Sual verin. Əsas tələb edin. Pəncərənin önündə susmayın.

Və o zaman kəllədəki deşiklər — hamısı, hər cürü, bütün formaları ilə — nəhayət lazımsız olacaq.

Kenan Rəhimov psixiatr, psixoterapevt Bakı, 2026

Əlavə. Əsl mütəxəssisi necə ayırd etmək olar

Bu çek-list — kitabı elə bu məqsədlə açan oxucular üçündür. Kitabda danışılanların hamısı burada toplanıb. Özünüz istifadə edin, başqaları ilə də bölüşün — tam olaraq, dəyişiklik etmədən.

Həqiqi mütəxəssis:

Heç kəsə möcüzə vəd etmir. “Sizi üç seansda sağaldacağam” demir — “Bir aylığına sınayaq, nəticəyə baxaq” deyir.

Metodun yan təsirləri və məhdudiyyətləri barədə açıq danışır, yalnız müsbət cəhətlərini reklam etmir.

Dövlət tərəfindən tanınan diplomu var — yoxlanıla bilən, ölkənin reyestr sistemi ilə təsdiqlənə bilən. Həftəsonu kurslarının verdiyi “sertifikat” deyil.

“Nəsil karması”, “negativ enerji”, “keçmiş həyatlar”, “təmizləmələr” və “proqramlar” barədə heç bir şəraitdə danışmır. Belə bir söz eşitsəniz — getməyiniz üçün kifayətdir.

Tanınmış terapiya üsulları ilə işləyir — kognitiv-davranış terapiyası, ritualın qarşısını almaqla ekspozisiya, psixodinamik terapiya, sistemli ailə terapiyası, EMDR, DBT. Onun üsulu elmi ənənənin bir hissəsidir, sıfırdan yaradılmış “müəllif metodu” deyil.

Təcrübəsinə yox, beynəlxalq klinik tövsiyələrə istinad edir: “APA, NICE, WHO təşkilatları sizin pozğunluq üçün belə yanaşma tövsiyə edir”.

Sizi qorxu ilə saxlamaq istəmir. Başqa mütəxəssis yoxlamaq və ya fasilə vermək qərarına hörmət edir.

Hər seans və ya kiçik blok üçün ayrıca ödəniş alır — aylarla öncədən ödəniş etməyə, istənilən anda dayandırmaq mümkündür.

Münasibətləri peşəkar çərçivədə saxlayır. Seans ödənişindən kənar romantika, dostluq, biznes razılaşmaları yoxdur.

Ən əsası — sizə iş şəriki kimi yanaşır, yalnız onun bildiyi "həqiqətə" ehtiyacı olan biri kimi yox.

Belə adam tapdınızsa — bəxtiniz yaver gedib. İşə başlayın. Birinci cəhddə tapmasanız da — axtarın: ikinci, üçüncü cəhdlər normaldır, mütəxəssis sizə şəxsi uyğun gəlməlidir.

Qırmızı bayraqlar — qısa siyahı:

Simptomlarınızın səbəbini babalarınızın həyatında və ya "keçmiş həyatlarınız"da axtarırlar.

Diaqnoz qoyulmuş xəstəliyin enerji, niyyət və ya imanla sağalacağı vədləri verib, dərmanları "buraxmağınızı" tövsiyə edirlər.

Metod mərhələlidir, hər biri əvvəlkindən baha başa gəlir, "təkmil" olanlara yalnız tam bilik verilir.

Diaqnozu ilk on dəqiqədə qoyublar — və bu, həmin şəxsin yeganə müalicə etdiyi şeylə eynidir.

Diplom, peşə assosiasiyası üzvlüyü ya da metodun effektivliyi barədə məlumat istəyəndə həyəcana gəlir və ya mövzunu dəyişdirirlər.

Yaxşılaşma metodun, pisləşmə isə sizin "xətiniz"dir: "müqavimət", "az inam", "tam işləməmisən".

Mütəxəssis barədə sosial şəbəkələrdən öyrənilib — yüzminlərlə izləyicisi, lakin heç bir elmi nəşri yoxdur.

Bu siyahıdan hər hansı bir maddə — ehtiyyatlı olmaq üçün səbəb. İkisi — getmək üçün. Sizin həyatınız — onların biznes modeli deyil.

Ədəbiyyat və mənbələr

Bu siyahıda monoqrafiyada istinad edilən əsas mənbələr və müəllifin mətn hazırlanmasında istifadə etdiyi ədəbiyyat göstərilir. Siyahı mövzular üzrə bölmələrə ayrılmış, hər bölmədə isə tarixi əsərlər xronoloji, müasir materiallar isə əlifba sırası ilə düzülmüşdür. Açıq mənbələrdə əlçatan olan sənədlər üçün əlyazma hazırlanan zaman etibarlı olan birbaşa keçidlər verilmişdir.

Əsas sitatlar beynəlxalq məqbul elmi ədəbiyyatdan, peşəkar assosiasiyaların (WPA, APA, NICE, WHO) sənədlərindən, məhkəmə qərarlarından və açıq arxiv materiallarından götürülmüşdür. Tarixi məqamlar üçün isə alman, fransız və ingilis dillərindəki orijinal ilkin nəşrlərdən istifadə edilmişdir.

Beynəlxalq etik və hüquqi sənədlər

Гиппократов корпус. Клятва // Гиппократ. Избранные книги / пер. с греч. В. И. Руднева. — М.: Сварог, 1994. — С. 87–88.

Percival T. Medical Ethics, or a Code of Institutes and Precepts Adapted to the Professional Conduct of Physicians and Surgeons. — Manchester: S. Russell, 1803.

American Medical Association. Code of Medical Ethics. — First edition. — Chicago, 1847.

Nürnberq Kodeksi (1947) // Müharibə Cinayətləri Məhkəməsi Nürnberq Hərbi Tribunalı qarşısında Nəzarət Şurasının 10 nömrəli Qanununa əsasən, 2-ci cild. — Vaşinqton: ABŞ Hökuməti Nəşriyyat Bürosu, 1949. — S. 181–182.

World Medical Association. Declaration of Geneva. — 1948 (2017-ci ilə qədər düzəlişlərlə).

World Medical Association. Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. — 1964 (2013-cü ilə qədər düzəlişlərlə).

World Psychiatric Association. Declaration of Hawaii. — 1977.

United Nations. Resolution 46/119: Principles for the Protection of Persons with Mental Illness and the Improvement of Mental Health Care. — 1991.

World Psychiatric Association. Madrid Declaration on Ethical Standards for Psychiatric Practice. — 1996 (1999, 2002, 2005 və 2011-ci illərdəki düzəlişlərlə).

United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). — 2006.

Appelbaum P. S. The WPA Code of Ethics for Psychiatry. World Psychiatry, 2021, Vol. 20, No. 2. — P. 295–296.

World Psychiatric Association. Code of Ethics for Psychiatry. — 2020. URL: https://www.wpanet.org/policies.

Okasha A. The Declaration of Madrid and its implementation. An update. World Psychiatry, 2003, Vol. 2, No. 2. — P. 65–67.

Kingdon D., Jones R., Lönnqvist J. “Psixi pozğunluğu olan insanların insan hüquqlarının müdafiəsi: Avropa Şurasından yeni tövsiyələr.” British Journal of Psychiatry, 2004, Cild 185, № 4. — Səh. 277–279.

Psixiatriyanın klassikləri: ilkin nəşrlər

Emil Kraepelin və nozologiyanın doğuşu

Kraepelin E. Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Studirende und Ärzte. — 6. Auflage. — Leipzig: Johann Ambrosius Barth, 1899.

Hecker E. Die Hebephrenie. Ein Beitrag zur klinischen Psychiatrie. Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medizin, 1871, Bd. 52. — S. 394–429.

Kahlbaum K. L. Die Katatonie oder das Spannungsirresein. — Berlin: Verlag August Hirschwald, 1874.

Eugen Bleyler və şizofreniya anlayışı

Bleuler E. Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien. — Leipzig und Wien: Franz Deuticke, 1911.

Bleuler E. Die Prognose der Dementia praecox (Schizophreniegruppe). Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, 1908, Bd. 65. — S. 436–464.

Ziqmund Freyd və Şreber hadisəsi

Schreber D. P. Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. — Leipzig: Oswald Mutze, 1903.

Freud S. Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia (Dementia paranoides) [Der Fall Schreber]. Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen, 1911, Bd. 3. — S. 9–68.

Freud S. Die Traumdeutung. — Leipzig und Wien: Franz Deuticke, 1900.

Karl Gustav Yung

Jung C. G. Über die Psychologie der Dementia praecox: ein Versuch. — Halle a.S.: Carl Marhold, 1907.

Jung C. G. Das Rote Buch — Liber Novus. — Düsseldorf: Patmos Verlag, 2009. [Yunqun Qırmızı Kitabı: 1913–1930-cu illərin qeydlərinin ölümündən sonra nəşri]

Jung C. G. Symbole der Wandlung. Analyse des Vorspiels zu einer Schizophrenie. — Zürich: Rascher, 1952.

Fenomenoloji məktəb

Jaspers K. Die phänomenologische Forschungsrichtung in der Psychopathologie. Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 1912, Bd. 9. — S. 391–408.

Jaspers K. Allgemeine Psychopathologie: Ein Leitfaden für Studierende, Ärzte und Psychologen. — Berlin: Julius Springer, 1913.

Minkowski E. La Schizophrénie. Psychopathologie des schizoïdes et des schizophrènes. — Paris: Payot, 1927.

Minkowski E. Le Temps vécu. Études phénoménologiques et psychopathologiques. — Paris: Collection de l'Évolution psychiatrique, 1933.

Binswanger L. Drei Formen missglückten Daseins: Verstiegenheit, Verschrobenheit, Manieriertheit. — Tübingen: Max Niemeyer, 1956.

Husserl E. Logische Untersuchungen. — Halle: Niemeyer, 1900–1901.

Tarixi müalicə üsulları: ilkin mənbələr və tənqidi əsərlər

Trepanasiya

Broca P. Sur la trépanation du crâne et les amulettes crâniennes à l'époque néolithique. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris, 1876, T. 83. — P. 1041–1045.

Prioreschi P. Possible reasons for neolithic skull trephining. Perspectives in Biology and Medicine, 1991, Vol. 34, No. 2. — P. 296–303.

Alt K. W., Jeunesse C., Buitrago-Téllez C. H. et al. Evidence for Stone Age cranial surgery. Nature, 1997, Vol. 387. — P. 360.

Ekzorsizm, Bedlam, dini psixiatriya

Goodman F. D. The Exorcism of Anneliese Michel. — Garden City, N.Y.: Doubleday, 1981. (1976-cı ilin məşhur hadisəsinin klinik təhlili.)

Andrews J., Briggs A., Porter R. et al. The History of Bethlem. — London: Routledge, 1997.

Rituale Romanum: De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam. — Editio typica. — Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 1999.

Associazione Internazionale degli Esorcisti — 2014-cü ildə Müqəddəs Taxt-tac tərəfindən rəsmi tanınması barədə sayt materialları.

Betti əməliyyatı və “isteriya”

Battey R. Normal ovariotomy — case. Atlanta Medical and Surgical Journal, 1872, Vol. 10. — P. 321–339.

Longo L. D. The rise and fall of Battey’s operation: a fashion in surgery. Bulletin of the History of Medicine, 1979, Vol. 53, No. 2. — P. 244–267.

Scull A. Hysteria: The Biography. — Oxford: Oxford University Press, 2009.

Charcot J.-M. Leçons sur les maladies du système nerveux faites à la Salpêtrière. — Paris: Adrien Delahaye, 1872–1887.

Piroterapiya və sülfozin

Wagner-Jauregg J. Über die Einwirkung fieberhafter Erkrankungen auf Psychosen. — Jahrbücher für Psychiatrie und Neurologie, 1887, Bd. 7. — S. 94–131.

Wagner-Jauregg J. The treatment of general paresis by inoculation of malaria. Journal of Nervous and Mental Disease, 1922, Vol. 55. — P. 369–375.

Wagner-Jauregg J. The Treatment of Dementia Paralytica by Malaria Inoculation. [Nobel mühazirəsi.] — Stockholm, 1927.

Беккер Р. А., Быков Ю. В. Сульфозиновая терапия: исторический очерк. В мире научных открытий, 2017, Т. 9, № 4. — С. 71–90. [Metodun müasir tənqidi icmalı.]

İnsulin koması

Sakel M. Schizophreniebehandlung mittels Insulin-Hypoglykämie sowie hypoglykämischer Schocks. Wiener Medizinische Wochenschrift, 1934, Bd. 84. — S. 1211–1215.

Sakel M. The Pharmacological Shock Treatment of Schizophrenia. — New York: Nervous and Mental Disease Publishing, 1938.

Bourne H. The insulin myth. The Lancet, 1953, Vol. 262, No. 6793. — P. 964–968.

Ackner B., Harris A., Oldham A. J. Insulin treatment of schizophrenia: a controlled study. The Lancet, 1957, Vol. 269, No. 6969. — P. 607–611.

Lobotomiya

Moniz E. Tentatives opératoires dans le traitement de certaines psychoses. — Paris: Masson, 1936.

Freeman W., Watts J. W. Psychosurgery: Intelligence, Emotion and Social Behavior Following Prefrontal Lobotomy for Mental Disorders. — Springfield, Ill.: Charles C. Thomas, 1942.

El-Hai J. The Lobotomist: A Maverick Medical Genius and His Tragic Quest to Rid the World of Mental Illness. — Hoboken, N.J.: Wiley, 2005.

Pressman J. D. Last Resort: Psychosurgery and the Limits of Medicine. — Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Shorter E., Healy D. Shock Therapy: A History of Electroconvulsive Treatment in Mental Illness. — New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 2007.

Sovet cəza psixiatriyası

Bloch S., Reddaway P. Psychiatric Terror: How Soviet Psychiatry Is Used to Suppress Dissent. — New York: Basic Books, 1977.

Van Voren R. On Dissidents and Madness: From the Soviet Union of Leonid Brezhnev to the “Soviet Union” of Vladimir Putin. — Amsterdam: Rodopi, 2009.

Plyushch L. History’s Carnival: A Dissident’s Autobiography. — New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1979.

Глузман С. Ф. О советской судебной психиатрии (Samizdat, ca. 1971; Qərbdə 1975-ci ildə nəşr olunub)

Снежневский А. В., Вартанян М. Е. Вопросы классификации психических заболеваний. Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова, 1971, Т. 71, № 12.

Elektroşok terapiyası

Cerletti U., Bini L. Un nuevo metodo di shockterapia: “l’elettro-shock”. Bollettino e Atti della Reale Accademia Medica di Roma, 1938, Vol. 64. — P. 136–138.

Kesey K. One Flew Over the Cuckoo’s Nest. — New York: Viking Press, 1962.

UK ECT Review Group. Efficacy and safety of electroconvulsive therapy in depressive disorders: a systematic review and meta-analysis. The Lancet, 2003, Vol. 361, No. 9360. — P. 799–808.

Bioloji nəzəriyyələr və farmakologiya

Delay J., Deniker P., Harl J.-M. Utilisation en thérapeutique psychiatrique d'une phénothiazine d'action centrale élective (4560 RP). Annales Médico-Psychologiques, 1952, T. 110. — P. 112–117.

Laborit H., Huguenard P., Alluaume R. Un nouveau stabilisateur végétatif (le 4560 RP). La Presse médicale, 1952, T. 60. — P. 206–208.

Carlsson A., Lindqvist M. Effect of chlorpromazine or haloperidol on formation of 3-methoxytyramine and normetanephrine in mouse brain. Acta Pharmacologica et Toxicologica, 1963, Vol. 20. — P. 140–144.

Seeman P., Lee T. Antipsychotic drugs: direct correlation between clinical potency and presynaptic action on dopamine neurons. Science, 1975, Vol. 188, No. 4194. — P. 1217–1219.

Owen M. J., Sawa A., Mortensen P. B. Schizophrenia. The Lancet, 2016, Vol. 388, No. 10039. — P. 86–97.

Kahn R. S., Sommer I. E., Murray R. M. et al. Schizophrenia. Nature Reviews Disease Primers, 2015, Vol. 1. — Article 15067.

Ripke S., Neale B. M., Corvin A. və b. (Psixiatrik Genomika Konsorsiumunun Şizofreniya üzrə İşçi Qrupu). 108 şizofreniya ilə əlaqəli genetik lokusdan əldə edilən bioloji anlayışlar. Nature, 2014, Cild 511. — S. 421–427.

Sistemli yanaşmalar və antipisxiatriya

Bateson G., Jackson D. D., Haley J., Weakland J. Toward a theory of schizophrenia. Behavioral Science, 1956, Vol. 1, No. 4. — P. 251–264.

Bateson G. Steps to an Ecology of Mind. — New York: Ballantine Books, 1972.

Laing R. D. The Divided Self: An Existential Study in Sanity and Madness. — London: Tavistock Publications, 1960.

Laing R. D., Esterson A. Sanity, Madness and the Family: Families of Schizophrenics. — London: Tavistock, 1964.

Cooper D. Psychiatry and Anti-Psychiatry. — London: Tavistock, 1967.

Basaglia F. L'istituzione negata: rapporto da un ospedale psichiatrico. — Torino: Einaudi, 1968.

Legge 13 maggio 1978, n. 180 — "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori" (Bazalya qanunu). İtaliya Respublikası.

Foot J. The Man Who Closed the Asylums: Franco Basaglia and the Revolution in Mental Health Care. — London: Verso, 2015.

Barbui C., Papola D., Saraceno B. Forty years without mental hospitals in Italy. International Journal of Mental Health Systems, 2018, Vol. 12. — Article 43.

d'Avanzo B., Barbato A., Erzegovesi S. və b. Psixiatriya inqilabının kəmiyyət analizi: Bazaliya Qanununun intiharlara təsiri üzrə kvazi-təbii eksperiment. Avropa İctimai Səhiyyə Jurnalı, 2020, Cild 30, №3. — S. 492–498.

Biopsixososial model və tənqidi

Engel G. L. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science, 1977, Vol. 196, No. 4286. — P. 129–136.

Engel G. L. The clinical application of the biopsychosocial model. American Journal of Psychiatry, 1980, Vol. 137, No. 5. — P. 535–544.

Ghaemi S. N. The Rise and Fall of the Biopsychosocial Model: Reconciling Art and Science in Psychiatry. — Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2010.

Lugg W. The biopsychosocial model — history, controversy and Engel. Australasian Psychiatry, 2022, Vol. 30, No. 1. — P. 55–59.

Kendler K. S. The dappled nature of causes of psychiatric illness: replacing the organic–functional/hardware–software dichotomy with empirically based pluralism. Molecular Psychiatry, 2012, Vol. 17. — P. 377–388.

Müasir psevdoelm: ailə düzülüşləri, ThetaHealing, reqressologiya, dianetika

Hellinger və ailə düzülüşləri

Hellinger B. Ordnungen der Liebe. Ein Kurs-Buch. — Heidelberg: Carl-Auer-Systeme Verlag, 1994.

Hellinger B., Weber G., Beaumont H. Love's Hidden Symmetry: What Makes Love Work in Relationships. — Phoenix, Ariz.: Zeig, Tucker & Theisen, 1998.

Deutsche Gesellschaft für Systemische Aufstellungen. Abgrenzungserklärung zu Bert Hellinger. — 2004. [Peşə assosiasiyasının özünü məsafələndirmə bəyannaməsi.]

Jelinek L. Bert Hellinger və onun Ailə Yerləşdirmələri: Tənqidi təhlil. [Dissertasiya.]

Nelles W. Das Hellinger-Prinzip: Heilende Liebe in Schicksalsbeziehungen. — München: Kösel, 2004.

Cohen D. B. Family Constellations: An Innovative Systemic Phenomenological Group Process from Germany. // The Family Journal, 2006, Vol. 14, No. 3. — P. 226–233.

ThetaHealing: məhkəmə və elmi qiymətləndirmələr

Alexander v. Stibal, 160 Idaho 10, 368 P.3d 630 (Idaho 2016). [Aydaho ştatının Ali Məhkəməsinin Vianna Stibalın dələduzluğu ilə bağlı qərarı.]

Alexander v. Stibal, 161 Idaho 253, 385 P.3d 431 (Idaho 2016). [Əlaqəli iş.]

Stibal V. ThetaHealing: Introducing an Extraordinary Energy Healing Modality. — Carlsbad, Calif.: Hay House, 2010.

Jarry J. ThetaHealing®: The Money You'll Spend Never Existed. McGill Office for Science and Society, August 2019. URL: https://www.mcgill.ca/oss/article/pseudoscience/thetahealingr-money-youll-spend-never-existed.

Ernst E. Alternative Medicine: A Critical Assessment of 150 Modalities. — Cham: Copernicus Books / Springer, 2019.

Reqressiv terapiya və saxta xatirələr

Newton M. Journey of Souls: Case Studies of Life Between Lives. — St. Paul, Minn.: Llewellyn Publications, 1994.

Cannon D. The Convoluted Universe. — Huntsville, Ark.: Ozark Mountain Publishing, 2001.

Loftus E. F. The reality of repressed memories. American Psychologist, 1993, Vol. 48, No. 5. — P. 518–537.

Loftus E. F., Ketcham K. The Myth of Repressed Memory: False Memories and Allegations of Sexual Abuse. — New York: St. Martin's Press, 1994.

Spanos N. P. Multiple Identities and False Memories: A Sociocognitive Perspective. — Washington D.C.: American Psychological Association, 1996.

American Psychological Association Working Group on Investigation of Memories of Childhood Abuse. Final Report. — Washington D.C.: APA, 1998.

Habbard və Dianetika

Hubbard L. R. Dianetics: The Modern Science of Mental Health. — New York: Hermitage House, 1950.

Fromm E. Dianetics: Seekers of Fabricated Happiness. New York Herald Tribune Book Review, September 3, 1950.

Funk R. (ed.) Erich Fromm: On Being Human. — New York: Continuum, 2000. [Frommun Dianetikaya rəyinin yenidən nəşri.]

Wright L. Going Clear: Scientology, Hollywood, and the Prison of Belief. — New York: Alfred A. Knopf, 2013.

Atack J. A Piece of Blue Sky: Scientology, Dianetics and L. Ron Hubbard Exposed. — New York: Carol Publishing, 1990.

Sosial şəbəkələr və tibbi dezinformasiya

Grimes D. R., Greenhalgh T. Tackling physician-peddled health misinformation. Journal of the Royal Society of Medicine, 2024, Vol. 117, No. 5. — P. 157–161.

Sule S., DaCosta M. C., DeCou E. və b. ABŞ-də həkimlərin sosial mediada COVID-19 haqqında yalan məlumatlar yayması. JAMA Network Open, 2023, Cild 6, № 8. — e2328928.

Lorenzo-Luaces L., Dierckman C., Starvaggi I. Mental health misinformation on social media: review and future directions. Current Opinion in Psychology, 2024, Vol. 56. — 101738.

Motta M., Liu Y., Yarnell A. “Influencing the influencers”: a field experimental approach to promoting effective mental health communication on TikTok. Scientific Reports, 2024, Vol. 14. — 5864.

Hudon A., Perry K., Plate A.-S. və b. Psixi xəstəliklərə aid sosial media dezinformasiyası labirintində oryentasiya və psixi sağlamlıq mütəxəssisləri üçün etibarlı məlumat yollarının müəyyən edilməsi: TikTok videolarının müşahidə tədqiqi. Journal of Medical Internet Research, 2025, Cild 27. — e64225.

Abrams Z. Addressing misinformation about mental health with patients. American Psychological Association News, November 6, 2024.

European Union. Digital Services Act (Regulation (EU) 2022/2065). — Official Journal of the European Union, 2022.

“Mənəvi” xidmətlərin tənzimlənməsinə dair hüquqi mənbələr

12 iyun 2001-ci il tarixli 2001-504 nömrəli Qanun (About-Picard Qanunu) — insan hüquqları və əsas azadlıqlara zərər vuran sektant hərəkatlara qarşı qarşıdurmanın gücləndirilməsi və profilaktikasına həsr olunmuşdur. — Fransa Respublikasının Rəsmi Qəzeti. Bu qanun “zəiflikdən sui-istifadə” hallarına nəzarət etmək məqsədi daşıyır.

Qanun № 2024-420, 10 may 2024-ci il tarixli — sektantlıq sui-istifadələri ilə mübarizəni gücləndirmək və zərərçəkmişlərə dəstəyin yaxşılaşdırılması haqqında (Fransada psixoloji tabeçilik barədə qanun). — Fransa Respublikasının Rəsmi Qəzeti.

Palmer S. J. The New Heretics of France: Minority Religions, la République, and the Government-Sponsored “War on Sects”. — New York: Oxford University Press, 2011.

MIVILUDES (Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires). Rapports annuels. — République Française, 2002–2024.

Müalicə standartları və klinik tövsiyələr

American Psychiatric Association. Practice Guideline for the Treatment of Patients with Obsessive-Compulsive Disorder. — 2nd ed. — Arlington, Va.: APA Publishing, 2007.

National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Obsessive-compulsive disorder and body dysmorphic disorder: treatment. Clinical guideline [CG31]. — United Kingdom: NICE, 2005, updated 2023.

World Health Organization. mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings. — Version 2.0. — Geneva: WHO, 2016.

Hezel D. M., Simpson H. B. Exposure and response prevention for obsessive-compulsive disorder: A review and new directions. Indian Journal of Psychiatry, 2019, Vol. 61, Suppl. 1. — S85–S92.

Gartrell N., Herman J., Olarte S. və b. Psixiatr-xəstə cinsi əlaqələri: millî araşdırmanın nəticələri, I: Prevalens. Amerika Psixiatriya Jurnalı, 1986, Cild 143, № 9. — S. 1126–1131.

World Health Organization. World mental health report: Transforming mental health for all. — Geneva: WHO, 2022.

18 və 24-cü fəsillər üçün: “möcüzə”nin mexanizmləri və psixiatriyadan kənar pandemiya

Forer, B. R. (1949). The fallacy of personal validation: A classroom demonstration of gullibility. Journal of Abnormal and Social Psychology, 44(1), 118–123.

Kruger, J., & Dunning, D. (1999). Bacarıqsız və bunun fərqində olmayanlar: Öz bacarıqsızlığını tanımaqda çətinliklərin özünü qiymətləndirmədə şişirdilməyə necə gətirib çıxardığı. Şəxsiyyət və Sosial Psixologiya Jurnalı, 77(6), 1121–1134.

Benedetti, F. (2008). Placebo Effects: Understanding the Mechanisms in Health and Disease. Oxford University Press.

Marshall, B. J., & Warren, J. R. (1984). Unidentified curved bacilli in the stomach of patients with gastritis and peptic ulceration. The Lancet, 323(8390), 1311–1315.

Alexander, F. (1950). Psychosomatic Medicine: Its Principles and Applications. W. W. Norton.

Lane, I. W., & Comac, L. (1992). Sharks Don't Get Cancer. Avery Publishing. (Mifin ilk mənbəyi; tənqidi təhlili — aşağıda.)

Loprinzi, C. L., et al. (2005). Evaluation of shark cartilage in patients with advanced cancer. Cancer, 104(1), 176–182.

Ostrander, G. K., et al. (2004). Shark cartilage, cancer and the growing threat of pseudoscience. Cancer Research, 64(23), 8485–8491.

Gershon, M. D. (1998). The Second Brain. HarperCollins. (Bağırsaq serotonin sistemi.)

Ruh sağlamlığının statistikası

GBD 2019 Mental Disorders Collaborators. Global, regional, and national burden of 12 mental disorders in 204 countries and territories, 1990–2019. The Lancet Psychiatry, 2022, Vol. 9, No. 2. — P. 137–150.

World Health Organization. Mental health atlas 2020. — Geneva: WHO, 2021.

Patel V., Saxena S., Lund C. et al. The Lancet Commission on global mental health and sustainable development. The Lancet, 2018, Vol. 392, No. 10157. — P. 1553–1598.

Psixiatriya tarixinə dair ümumi əsərlər

Shorter E. A History of Psychiatry: From the Era of the Asylum to the Age of Prozac. — New York: John Wiley & Sons, 1997.

Porter R. Madness: A Brief History. — Oxford: Oxford University Press, 2002.

Whitaker R. Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental Illness in America. — New York: Crown, 2010.

Каннабих Ю. В. История психиатрии. — М.: Государственное медицинское издательство, 1929. (Репринтные переиздания: М.: ЦТР МГП ВОС, 1994; Минск: Харвест, 2002.)

Юдин Т. И. Очерки истории отечественной психиатрии. — М.: Медгиз, 1951.

Морозов Г. В. (ред.) Судебная психиатрия. — М.: Медицина, 1990.

Вид В. Д. Психотерапия шизофрении. — СПб.: Питер, 2001. (Müəllifin V. M. Bexterev adına NİPNİ-də klinik ordinatura keçdiyi dövrdə bilavasitə müəlliminin əsəri.)

Тиганов А. С. (ред.) Руководство по психиатрии. В 2 т. — М.: Медицина, 1999.

Elmi skeptisizmin açıq mənbələri

Ernst E. Edzard Ernst: A Leading Expert on Complementary Medicine. — URL: https://edzardernst.com. (Alternativ metodların tənqidi təhlilinə həsr olunmuş müntəzəm bloq.)

McGill Office for Science and Society. — URL: https://www.mcgill.ca/oss.

RationalWiki. Theta healing. — URL: https://rationalwiki.org/wiki/Theta_healing.

The Skeptic's Dictionary (ed. R. T. Carroll). — URL: https://skepdic.com.

Müəllifin qeydi

Bu siyahı kitabda toxunulan mövzuların hər biri üzrə tam biblioqrafiya iddiasında deyil; kitabın hazırlanmasında əhəmiyyətli dərəcədə daha geniş mənbələr dairəsindən istifadə edilmişdir. Siyahıya ya birbaşa mətndə sitat gətirilən əsərlər, ya təsvir olunan hadisələrin ilkin sənədlərini özündə əks etdirən materiallar, ya da mövzunu daha dərindən öyrənmək istəyən oxucu üçün akademik cəhətdən etibarlı istinad nöqtəsi sayılan işlər daxil edilmişdir.

Oxucular, təqdim olunmuş materialla bağlı məsləhət almaq və ya mülahizə bildirmək istəyənlər, kolofonda göstərilən ünvanlar üzrə müəllifə müraciət edə bilərlər.

Kenan Rəhimov — psixiatr-psixoterapevt Bakı, 2026

Müəllif və əlaqə haqqında

Kenan Rəhimov — psixiatr, psixoterapevt.

Tibbi hazırlıq: 2 nömrəli Klinik Xəstəxana, Bakı (2000–2001); V. M. Bexterev adına Elmi-Tədqiqat Psixonevroloji İnstitutu, Sankt-Peterburq (2001–2003, professor V. D. Vidanın rəhbərliyi ilə klinik ordinatura).

Bakıda təcrübə. İxtisaslaşma: narahatlıq pozğunluqları, OKR (obsesif-kompulsiv pozğunluq), depressiyalar, psixotik pozğunluqlar, ailə terapiyası, kognitiv-davranış terapiyası.

Əlaqə: ragimoff.org · t.me/ragimoff · Bakı, 2026.